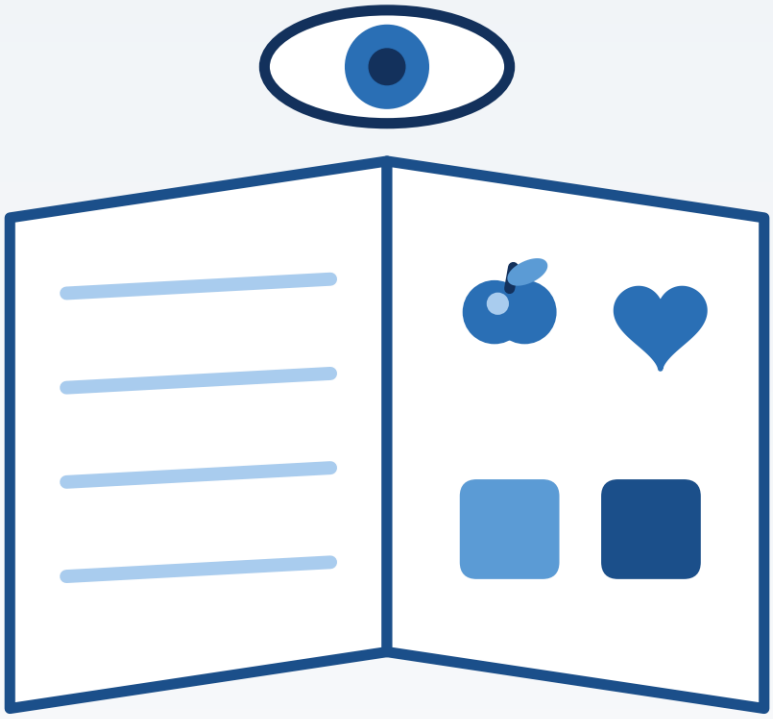
DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 5

Littératie en santé

Mots-clés : Littératie en santé, Repérer, Adapter, Vérifier la compréhension

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 5 · Littératie en santé · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 104

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 123 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 105 à 227

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 33 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 228 à 260

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

5.1 Compétences mobilisées 6
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
5.3 Cours 8
5.4 Approfondissements 69
5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79
5.7 L'essentiel à retenir 84
5.8 Entraînement 85
5.9 Glossaire 95
5.10 Renvois bibliographiques par notion 96
5.12 Bibliographie numérotée 96

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 5 100
1. Les définitions à savoir 100
2. Chiffres-clés 101
3. La formule à connaître 101
4. Les règles d'écriture claire 101
5. Faire dire 101
6. Les pièges 101
7. Auto-test 101
8. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102
Fiches-outils du chapitre 5 102
O5.1 – Grille de vérification d'un support écrit 102
O5.2 – Calcul de l'indice de lisibilité 103
O5.3 – Audit « littératie » d'une structure 103
O5.4 – Guide du faire dire 103
O5.5 – Test d'un support auprès du public 104

3 • Cahier d'exercices **105**

Cahier d'exercices – Chapitre 5 108
Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire 110
Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique 126
Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic 140
Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité 153
Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible 168
Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie 181
Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible 196
Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet 212
Bilan : grille d'auto-évaluation 227

4 • Annales E5 ..... **228**

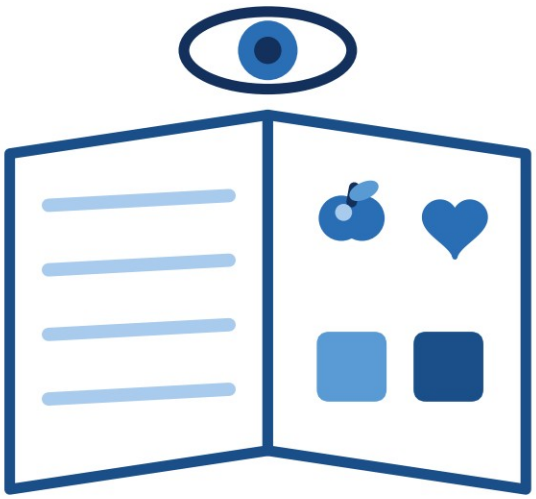
Cahier d'annales E5 – chapitre 5 230
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 231
Partie II – Les corrigés détaillés 242
Grille d'auto-évaluation 260

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

5.1 Compétences mobilisées ... 6
5.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 6
5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 7
5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 7
5.3 Cours ... 8
5.3.1 Définir la littératie en santé ... 8
5.3.2 Les données en France ... 15
5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique ... 19
5.3.4 Repérer sans stigmatiser ... 22
5.3.5 Adapter les messages et les supports ... 26
5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire » ... 35
5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet ... 38
5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire ... 40
5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé ... 45
5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique ... 50
5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones ... 54
5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet ... 58
5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles ... 60
5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type ... 62
5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls ... 64
5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie ... 65
5.4 Approfondissements ... 69
5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé) ... 69
5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat ... 70
5.4.3 Les organisations « amies de la littératie » ... 72
5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations ... 73
5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes ... 75
5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école ... 76
5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 78
5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 79
Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet ... 80
Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve ... 81
Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve ... 82
Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours ... 83
5.7 L'essentiel à retenir ... 84
5.8 Entraînement ... 85
5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 85
5.8.2 Exercices ... 86
5.8.3 Questions de réflexion ... 90
5.8.4 Étude de cas ... 91
5.8.5 Mises en situation express ... 91
5.8.6 Exercices complémentaires ... 94
5.9 Glossaire ... 95
5.10 Renvois bibliographiques par notion ... 96
5.12 Bibliographie numérotée ... 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la littératie en santé et la littératie alimentaire, et en décrire les dimensions (accéder, comprendre, évaluer, appliquer) et les niveaux (fonctionnel, interactif, critique) ;
- présenter les données françaises disponibles (enquête HLS19, illettrisme, illectronisme) et les relier aux inégalités sociales de santé (chapitre 2) ;
- expliquer les conséquences d'un faible niveau de littératie sur la santé et sur l'efficacité des actions de prévention ;
- repérer, sans stigmatiser, les difficultés de littératie d'un public (approche des « précautions universelles ») ;
- adapter un message écrit, oral ou numérique au niveau de littératie du public (guide « Communiquer pour tous », facile à lire et à comprendre – FALC –, pictogrammes, lisibilité) ;
- vérifier la compréhension par la technique du « faire dire » (teach-back) ;
- intégrer la littératie dans la conception, l'animation et l'évaluation d'un projet de santé publique.

5.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Prendre en compte la littératie dans le diagnostic et dans chaque étape du projet	Analyse et diagnostic de situation posé ; démarche d'évaluation construite
C3.2	Rendre les ateliers culinaires accessibles (recettes en images, quantités concrètes, démonstration)	Besoins et spécificités du public identifiés ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés
C3.5	Cœur du chapitre : adapter les supports écrits, oraux et numériques, repérer la précarité numérique, vérifier la compréhension	Précarité numérique repérée et prise en compte ; supports et contenus adaptés au public ; écoute active mobilisée ; posture adaptée

5.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Littératie en santé : définitions, dimensions	Définir ; citer les 4 compétences et les 3 domaines	Modèle de Sørensen ; niveaux de Nutbeam
Données épidémiologiques	Connaître les ordres de grandeur en France	Données datées et sourcées (HLS19, ANLCI, Insee)
Littératie et inégalités sociales de santé	Expliquer le lien avec le gradient social	Lien avec le chapitre 2 et l'universalisme proportionné
Repérage des difficultés	Identifier des signaux sans stigmatiser	Pas d'évaluation « scolaire » du public ; précautions universelles
Adaptation des messages et des supports	Appliquer les règles de communication accessible	« Communiquer pour tous » (Santé publique France), FALC, pictogrammes
Vérification de la compréhension	Utiliser le « faire dire »	Posture : c'est le professionnel qui vérifie sa propre clarté

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Littératie numérique et alimentaire	Prendre en compte l'illectronisme ; développer les compétences alimentaires	Lien avec les chapitres 4, 14 et 15 (communication)

5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Littératie en santé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61 pour les notions, p. 24 et 25 pour le lien avec le bloc 1, p. 122 pour les ressources). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 5.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Définition de la littératie en santé	5.3.1 (définitions datées, modèles de Sørensen et de Nutbeam)
Guide 2025, p. 61	Déterminants de la littératie en santé	5.3.2 (gradient social, données HLS19, PIAAC, Insee, DEPP) ; 5.3.3
Guide 2025, p. 61	Concept et enjeux	5.3.3 (conséquences pour la santé, inégalités) ; 5.4.3 et 5.4.4 (organisations)
Guide 2025, p. 61	Freins et leviers pour augmenter le niveau de littératie	5.3.4 à 5.3.14 (repérer, adapter, faire dire, numératie, numérique, allophones, outils)
Guide 2025, p. 24-25	Améliorer la littératie des personnes prises en soin (lien avec le bloc 1) ; littératie numérique	5.3.6 ; 5.3.10 ; 5.4.1
Guide 2025, p. 122	Ressources : « Communiquer pour tous » (mise à jour 2025), avis de la CNS (2017), Van den Broucke (2017), Le Brun et coll. (2025)	5.3.5 ; 5.12 (références 10, 25 à 27)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.5	Publics, supports adaptés, communication accessible	5.3.12 à 5.3.15 ; 5.6

5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Aucun des fascicules du CNED disponibles (*Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année ; *Synthèse du cours en bref*, 1re année ; fascicules d'hygiène et d'atelier) ne traite la littératie en santé : la notion est récente dans le référentiel de 2024. Le chapitre s'appuie donc sur le guide de 2025 et sur ses ressources. Les passages du CNED qui s'en rapprochent sont reliés au cours ci-dessous.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)	Éducation pour la santé, promotion de la santé, éducation thérapeutique	5.3.1 (niveaux de Nutbeam et éducation pour la santé) ; chapitre 1
Synthèse 1re année M3 S1 §2 (p. 29)	Information nutritionnelle : étiquetage et Nutri-Score	5.3.8 (lire une étiquette)
Synthèse 1re année M2 S2 §6 (p. 18)	Précarité et pauvreté	5.3.3 (littératie et inégalités sociales de santé) ; chapitre 4

Attention – données mises à jour – Ce qui a changé depuis les premières versions du cours

- **Illectronisme** : le chiffre de 15,4 % des 15 ans ou plus (2021) est remplacé par la dernière enquête de l'Insee : en 2025, **7 %** des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme (10 % en 2021) et **34 %** ont des

difficultés numériques (publication du 19 février 2026). Attention, la tranche d'âge n'est plus la même.

- **Compétences des adultes** : les résultats de PIAAC 2023 sont maintenant chiffrés : **28 %** des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit et 27 % du calcul (Dares, décembre 2024).
- **Lecture des jeunes** : à la Journée défense et citoyenneté 2025, **14 %** des jeunes sont en difficulté de lecture, dont 6 % en très grande difficulté (DEPP, octobre 2026).
- **Illettrisme** : le chiffre de 7 % des 18-65 ans (enquête IVQ 2011) reste la dernière mesure nationale publiée.
- **HLS19** : les résultats de 2021 restent les derniers pour la France ; le cycle HLS24 recueille ses données jusqu'en juin 2026.
- **Nutri-Score** : l'algorithme révisé s'applique en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025, et non « depuis 2024 ».
- **« Communiquer pour tous »** : le guide de 2018 a été mis à jour en février 2025.

5.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

5.3.1 Définir la littératie en santé

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Des définitions qui se sont élargies

Le mot **littératie** (de l'anglais *literacy*) désigne d'abord la capacité à lire, écrire et compter pour fonctionner dans la vie quotidienne. Appliquée à la santé, la notion s'est élargie : il ne s'agit plus seulement de savoir lire une notice, mais de **trouver**, **comprendre**, **juger** et **utiliser** les informations pour prendre des décisions favorables à sa santé, dans les soins comme dans la vie de tous les jours.

Définition – Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012)

« La littératie en santé est liée à la littératie et englobe les **connaissances**, la **motivation** et les **compétences** permettant d'**accéder**, de **comprendre**, d'**évaluer** et d'**appliquer** l'information en santé, afin de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne en matière de **soins**, de **prévention** des maladies et de **promotion de la santé**, pour maintenir ou améliorer la qualité de vie tout au long de la vie. » Cette définition, issue d'une revue de 17 définitions et 12 modèles, est la plus utilisée en Europe (consortium HLS-EU).

Définition – Littératie en santé organisationnelle

Capacité d'une **organisation** (hôpital, centre social, service de restauration, site internet) à rendre l'information et les services **faciles à trouver, à comprendre et à utiliser** pour tous. Elle déplace la responsabilité : la littératie n'est pas seulement une compétence de la personne, c'est aussi une **qualité de l'environnement** (signalétique, documents, accueil, démarches en ligne).

Attention – La littératie n'est pas l'intelligence ni le niveau d'études

Une personne très diplômée peut avoir une littératie en santé limitée dans une situation stressante (annonce d'un diagnostic, langue étrangère, fatigue, deuil) ou dans un domaine nouveau (lire un tableau nutritionnel). La littératie dépend de la **personne**, de la **situation** et de la **complexité de l'information**. On parle donc de **situations de littératie limitée** plutôt que de « personnes illettrées en santé ».

Les 12 dimensions du modèle de Sørensen

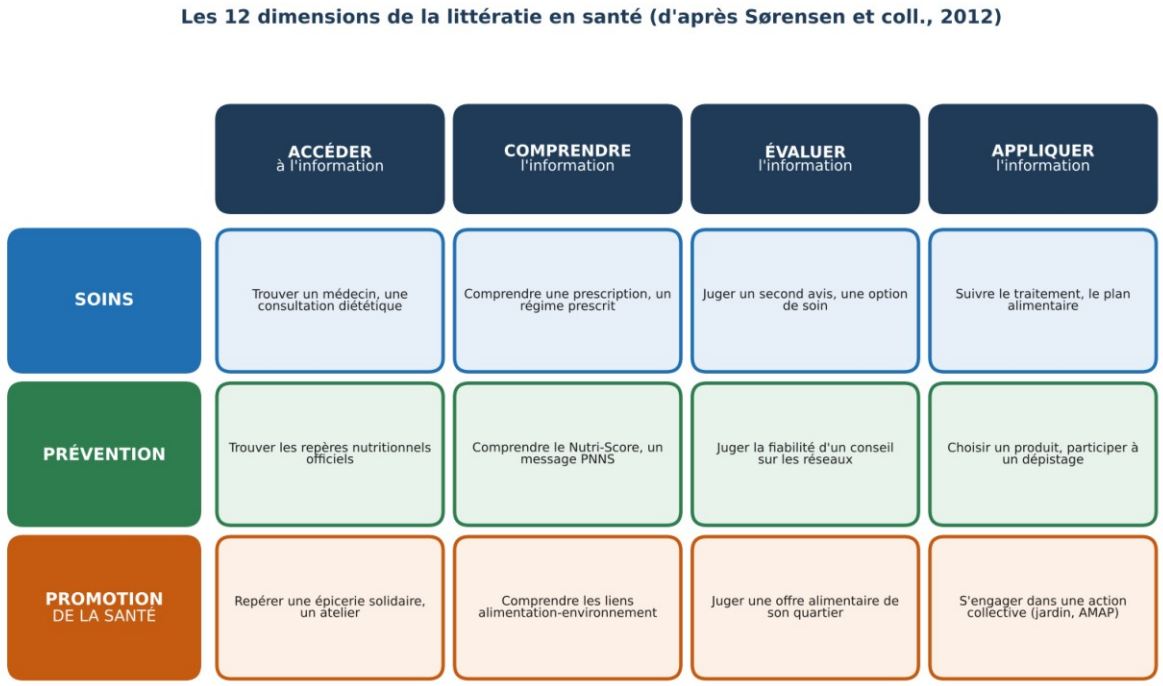


Figure 5.1 – Les 12 dimensions de la littératie en santé

Comprendre le schéma – Figure 5.1

1. Les **colonnes** représentent les quatre **compétences** de traitement de l'information : **accéder** (rechercher, trouver, obtenir), **comprendre**, **évaluer** (interpréter, juger, filtrer) et **appliquer** (communiquer, décider, agir).
2. Les **lignes** représentent les trois **domaines** de la santé : **soins** (être malade, patient), **prévention** (être à risque), **promotion de la santé** (être citoyen dans son milieu de vie).
3. Le croisement donne **12 dimensions** ; l'enquête européenne HLS-EU les mesure par 47 questions du type : « Sur une échelle de très facile à très difficile, à quel point est-il facile pour vous de… comprendre les informations sur les emballages des aliments ? »
4. Exemples alimentaires : *accéder* aux repères du PNNS sur *mangerbouger.fr* ; *comprendre* le Nutri-Score ; *évaluer* un conseil de régime lu sur un réseau social ; *appliquer* en choisissant un produit au magasin.
5. Intérêt pour le diététicien : ce modèle sert de **grille** pour diagnostiquer les besoins d'un public (à quelle étape la difficulté se situe-t-elle ?) et pour construire des objectifs pédagogiques précis.

Les trois niveaux de Nutbeam

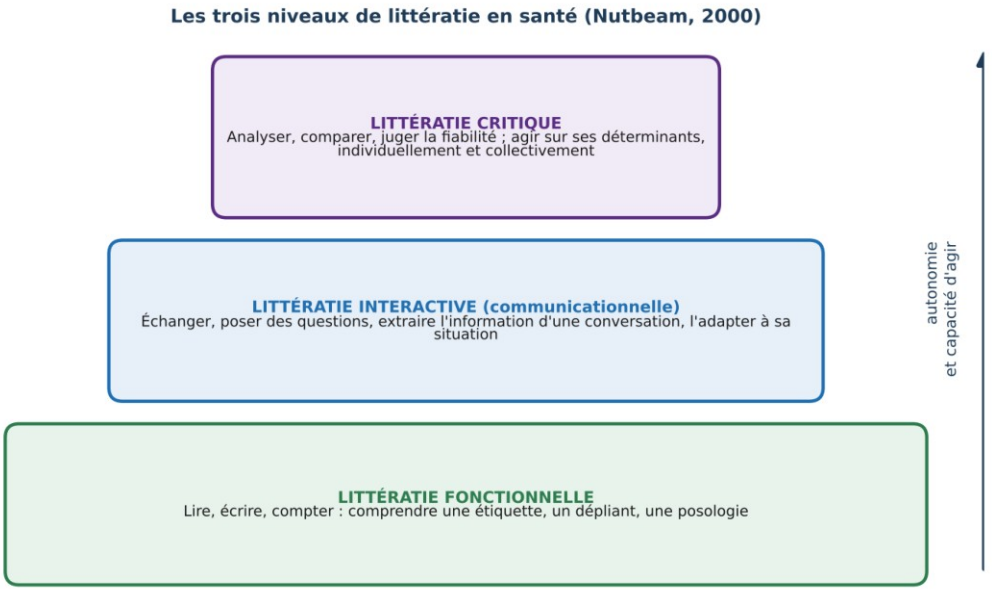


Figure 5.2 – Les trois niveaux de littératie en santé

Comprendre le schéma – Figure 5.2

1. Littératie fonctionnelle : compétences de base en lecture, écriture et calcul permettant de comprendre une information simple (une étiquette, une date limite de consommation, un dépliant). L'information « descend » vers la personne.

2. Littératie interactive ou communicationnelle : compétences cognitives et sociales permettant d'**échanger** (poser des questions au médecin, au diététicien), d'extraire l'information d'une conversation et de l'adapter à sa situation.

3. Littératie critique : capacité à **analyser** les informations, à en juger la fiabilité (publicité, réseaux sociaux, « fausses informations ») et à agir sur les **déterminants** de sa santé, individuellement et collectivement (association de parents qui obtient une meilleure offre à la cantine).

4. Plus on monte, plus la personne gagne en **autonomie** et en **pouvoir d'agir** (*empowerment*, chapitre 3). L'éducation pour la santé vise les trois niveaux ; la promotion de la santé (Charte d'Ottawa) vise particulièrement le niveau critique.

La littératie alimentaire

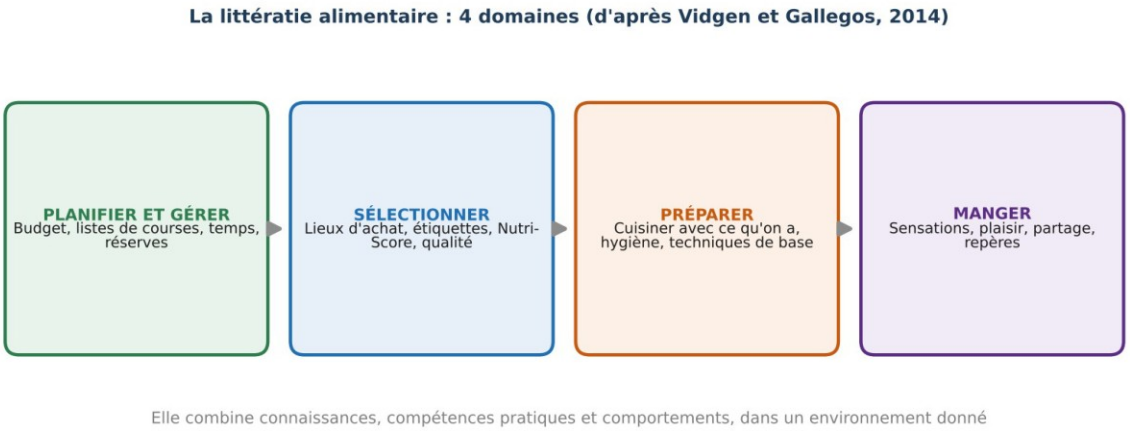


Figure 5.3 – Les quatre domaines de la littératie alimentaire

Définition – Littératie alimentaire (food literacy)

Ensemble de **connaissances**, de **compétences** et de **comportements** interreliés, nécessaires pour **planifier, gérer, sélectionner, préparer et manger** des aliments afin de répondre à ses besoins et d'en déterminer les apports (Vidgen et Gallegos, 2014, qui décrivent 4 domaines et 11 composantes).

Comprendre le schéma – Figure 5.3

1. Planifier et gérer : prévoir les repas, faire une liste, gérer un budget et des réserves, organiser son temps.

2. Sélectionner : savoir où acheter, lire une étiquette (liste d'ingrédients, Nutri-Score, dates), juger la qualité et la fraîcheur.

3. Préparer : cuisiner avec ce que l'on a, appliquer les règles d'hygiène, maîtriser des techniques de base (cuire des légumes secs, faire une soupe).

4. Manger : écouter ses sensations, partager, connaître les repères de consommation.

5. Lien avec le BC3 : un atelier culinaire en centre social développe directement la littératie alimentaire ; elle est un **objectif** à part entière, que l'on peut évaluer (« sait lire une étiquette », « sait cuisiner les lentilles »).

D'où vient la notion : quatre définitions datées

L'expression *health literacy* apparaît en 1974 dans un article de Scott Simonds sur l'éducation pour la santé à l'école : il proposait déjà de fixer des niveaux minimaux de connaissances en santé à atteindre, comme on le fait pour la lecture ou le calcul. La notion se développe ensuite dans les années 1990, d'abord aux États-Unis dans le monde du soin, puis en Europe dans celui de la promotion de la santé. Les définitions successives montrent comment elle s'est élargie.

Année	Auteur ou institution	Ce que la définition met en avant
1998	Nutbeam, glossaire de la promotion de la santé de l'OMS	Les compétences cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des personnes à accéder à l'information, à la comprendre et à l'utiliser pour maintenir une bonne santé
2004	Institute of Medicine (États-Unis), rapport *Health Literacy: A Prescription to End Confusion*	La capacité à obtenir, traiter et comprendre l'information et les services de santé de base nécessaires pour prendre des décisions appropriées

Année	Auteur ou institution	Ce que la définition met en avant
2012	Sørensen et coll., consortium HLS-EU	Connaissances, motivation et compétences ; quatre compétences et trois domaines (définition du cours)
2021	Glossaire de la promotion de la santé de l'OMS (mise à jour)	Les connaissances et compétences personnelles qui s'acquièrent par les activités quotidiennes, les interactions sociales et les générations, et qui sont soutenues par les organisations et les ressources disponibles

La dernière définition ajoute deux idées importantes : la littératie s'apprend aussi dans la vie de tous les jours et dans la famille, et elle dépend des **organisations** qui rendent l'information accessible ou non.

Définition – Ne pas confondre trois notions voisines

- **Alphabétisation** : apprentissage de la lecture et de l'écriture par des adultes qui ne les ont jamais apprises.
- **Éducation pour la santé** : action organisée qui aide les personnes à acquérir des connaissances et des compétences pour leur santé (chapitre 1). C'est un **moyen** ; la littératie en est l'un des **résultats**.
- **Littératie en santé** : ce que la personne sait faire avec l'information de santé, dans une situation donnée, compte tenu de l'information qu'on lui donne.

Lien diététique – Ce que cette évolution change pour le diététicien

Avec les premières définitions, on cherchait surtout à repérer les patients qui comprenaient mal. Avec les définitions récentes, on se demande aussi : mes supports, mon accueil et mes démarches sont-ils faciles à comprendre ? Le diététicien agit donc à deux niveaux : il développe les compétences du public (ateliers, éducation) et il simplifie ce que sa structure produit (menus, fiches, inscriptions).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.1

Classez les trois actions suivantes selon qu'elles développent les compétences des personnes ou qu'elles rendent l'organisation plus accessible : a) un atelier où les participants comparent des étiquettes ; b) la réécriture du règlement de la cantine avec des pictogrammes ; c) un groupe de parents qui apprend à préparer une question pour la réunion avec la mairie.

Corrigé

a) Compétences des personnes (littératie fonctionnelle et critique). b) Organisation plus accessible (littératie organisationnelle). c) Compétences des personnes, au niveau interactif et critique : le groupe apprend à échanger et à agir sur un déterminant.

La littératie distribuée : on ne comprend pas toujours seul

Dans la vie réelle, beaucoup de personnes ne traitent pas seules l'information de santé. Un enfant lit le courrier à ses parents, une voisine explique l'ordonnance, un collègue montre l'application de la mutuelle. Edwards et coll. (2015) ont appelé ce phénomène la **littératie en santé distribuée** : les compétences utiles sont réparties entre la personne et son entourage, qui joue le rôle de **médiateur**.

Définition – Littératie en santé distribuée

Ensemble des compétences de littératie mobilisées par une personne **et** par les membres de son réseau (famille, amis, voisins, aidants) pour trouver, comprendre, juger et utiliser une information de santé. La littératie d'un foyer n'est donc pas celle de son membre le moins à l'aise.

Atout	Risque	Ce que fait le professionnel
L'entourage aide à comprendre et à agir	Le médiateur peut se tromper ou déformer le message	Vérifier ce qui a été compris par la personne elle-même (faire dire)
L'aide est disponible au quotidien, dans la langue de la famille	La personne perd son autonomie et ses choix	S'adresser d'abord à la personne, demander son accord pour associer un proche
Le groupe d'entraide crée de la confiance	Un enfant porte une responsabilité qui n'est pas la sienne	Ne pas utiliser un enfant comme interprète ; proposer un adulte relais ou un interprète professionnel
Le proche aidant connaît les habitudes	Le secret des informations personnelles n'est plus garanti	Demander à la personne ce qu'elle accepte de partager

Exemple – Un atelier qui s'appuie sur l'entourage

Dans une résidence pour personnes âgées, une diététicienne invite chaque résident à venir à l'atelier « petit-déjeuner » avec la personne qui fait ses courses (enfant, aide à domicile, voisin). Les deux repartent avec la même liste de courses en images. Trois semaines plus tard, elle demande au résident, puis à l'accompagnant, ce qui a changé. L'atelier développe ainsi la littératie du « binôme » sans retirer au résident ses choix.

La littératie en santé mentale

La notion a été étendue à d'autres domaines. Jorm et coll. (1997) ont défini la **littératie en santé mentale** comme les connaissances et les croyances sur les troubles psychiques qui aident à les reconnaître, à les prendre en charge ou à les prévenir. Pour le diététicien, elle concerne en particulier les troubles des conduites alimentaires (chapitre 4) : savoir reconnaître les signes, savoir à qui s'adresser, et ne pas croire que « c'est un caprice ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.2

Un père vient à un atelier avec sa fille de 11 ans, qui traduit tout ce que dit l'animatrice. Citez un atout et deux risques de cette situation, puis proposez une solution pour la séance suivante.

Corrigé

Atout : le père peut participer et la fille apprend aussi. Risques : la fille peut mal traduire des mots techniques ; elle porte une responsabilité d'adulte et entend des informations qui ne la concernent pas (par exemple sur la santé de son père). Solution : demander au père dans quelle langue il est à l'aise et prévoir une médiatrice ou un interprète pour les consignes importantes ; s'appuyer sur la démonstration et les images ; laisser la fille participer à l'atelier comme enfant, sans rôle de traductrice.

Les onze composantes de la littératie alimentaire

Vidgen et Gallegos (2014) ont construit leur définition à partir d'entretiens avec des experts et avec de jeunes adultes de milieux défavorisés en Australie. Ils décrivent, dans les quatre domaines, **onze composantes** qui sont autant d'objectifs possibles pour un atelier. Le tableau en donne une version simplifiée en français.

Domaine	Composante (d'après Vidgen et Gallegos, 2014)	Exemple d'objectif d'atelier
Planifier et gérer	1. Donner une place à l'alimentation dans son budget et son temps	Savoir prévoir un budget alimentaire pour la semaine
	2. Prévoir ses repas et ses achats	Savoir écrire ou dessiner une liste de courses pour 5 repas

Domaine	Composante (d'après Vidgen et Gallegos, 2014)	Exemple d'objectif d'atelier
	3. Faire des choix réalistes qui tiennent compte de ses besoins et de ses contraintes	Savoir adapter un menu quand l'argent manque en fin de mois
Sélectionner	4. Connaître les lieux où se procurer des aliments et leurs avantages	Savoir comparer le marché, le supermarché et l'épicerie solidaire
	5. Savoir ce que contient un aliment, d'où il vient, comment le conserver et l'utiliser	Savoir lire une liste d'ingrédients et une date
	6. Juger la qualité d'un aliment	Savoir choisir des fruits mûrs et repérer un emballage abîmé
Préparer	7. Faire un plat bon avec les aliments disponibles et le matériel de la maison	Savoir cuisiner un plat complet avec une seule plaque
	8. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité	Savoir refroidir et conserver un reste
Manger	9. Comprendre le lien entre l'alimentation et le bien-être	Savoir dire pourquoi un petit-déjeuner aide un enfant à l'école
	10. Ajuster ses consommations à ses besoins	Savoir reconnaître sa faim et choisir une portion
	11. Partager les repas et manger avec les autres	Savoir organiser un repas partagé

Attention – Littératie alimentaire et pauvreté

La littératie alimentaire ne suffit pas quand l'argent, le temps ou l'équipement manquent. Une personne peut savoir cuisiner les lentilles mais ne pas avoir de cuisine dans un hôtel social. Le diététicien évite donc de présenter le manque de compétences comme la cause principale d'une alimentation déséquilibrée : il agit aussi sur l'accès aux aliments et sur l'environnement (chapitre 2).

Lien diététique – Ce que l'on sait de l'effet des ateliers cuisine

Les revues de la littérature sur les interventions de cuisine chez l'adulte (par exemple Reicks et coll., 2014) rapportent des effets favorables sur la confiance en cuisine, les attitudes et certains comportements alimentaires, mais les études sont souvent courtes, sans groupe témoin et sur de petits effectifs. Il faut donc évaluer ses propres ateliers (chapitre 9) et ne pas promettre des résultats que l'on ne mesurera pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.3

Un centre social prévoit trois ateliers : « cuisiner les restes », « faire ses courses avec 30 € », « le goûter des enfants ». Pour chacun, indiquez le domaine de la littératie alimentaire principal et une composante du tableau.

Corrigé

« Cuisiner les restes » : préparer, composantes 7 (faire un plat avec ce que l'on a) et 8 (conserver un reste en sécurité). « Faire ses courses avec 30 € » : planifier et gérer, composantes 1 à 3, et sélectionner, composante 4. « Le goûter des enfants » : manger, composantes 9 et 10, et planifier, composante 2.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.1 – Définir la littératie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre compétences et les trois domaines de la définition de Sørensen et coll. (2012).

2. Nommez les trois niveaux de Nutbeam et donnez un exemple alimentaire du niveau critique.
3. Qu'ajoute la définition de l'OMS de 2021 par rapport aux premières définitions ?
4. Définissez la littératie en santé distribuée.
5. Citez les quatre domaines de la littératie alimentaire.
6. Pourquoi parle-t-on de « situations de littératie limitée » ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.1

1. Accéder, comprendre, évaluer, appliquer ; soins, prévention, promotion de la santé.
2. Fonctionnel, interactif, critique ; par exemple un groupe d'habitants qui obtient un marché de fruits et légumes à prix solidaires dans le quartier.
3. La littératie s'acquiert aussi dans la vie quotidienne et dans la famille, et elle dépend des organisations et des ressources disponibles.
4. Les compétences de la personne et de son entourage (famille, voisins, aidants) mobilisées ensemble pour utiliser une information de santé.
5. Planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger.
6. Parce que la littératie varie selon la personne, la situation (stress, langue, fatigue) et la complexité de l'information.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

5.3.2 Les données en France

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

L'enquête HLS19

L'enquête **HLS19** (*Health Literacy Survey 2019-2021*) a été conduite dans 17 pays européens par le réseau **M-POHL** de l'OMS Europe, avec un questionnaire commun. En France, elle a porté sur un échantillon représentatif d'adultes ; les résultats ont été publiés en 2021.

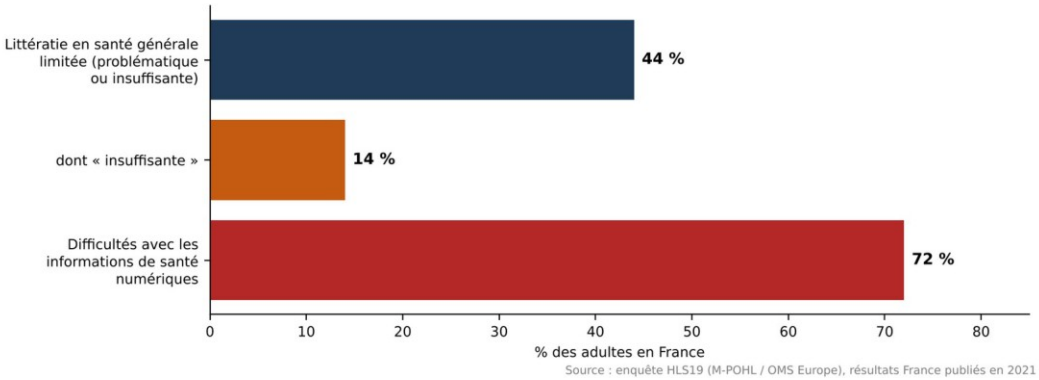


Figure 5.4 – La littératie en santé des adultes en France (HLS19)

Comprendre le schéma – Figure 5.4

1. Environ **44 %** des adultes ont une littératie en santé générale **limitée** : « problématique » (environ 30 %) ou « insuffisante » (environ 14 %) ; autrement dit, plus de **4 adultes sur 10** déclarent des difficultés à trouver, comprendre, juger ou utiliser les informations de santé.

2. Les difficultés sont encore plus fréquentes pour les informations **numériques** (environ 72 % déclarent au moins des difficultés), ce qui interroge les campagnes « tout en ligne ».
3. Comme ailleurs en Europe, le niveau suit un **gradient social** : il est plus bas chez les personnes ayant des difficultés financières, un faible niveau d'études, chez les plus âgés et chez les personnes en mauvaise santé.
4. Les tâches jugées les plus difficiles concernent l'**évaluation** (juger la fiabilité d'une information dans les médias, savoir si un conseil s'applique à soi).
5. Prudence : ces données sont **déclaratives** (difficulté ressentie) ; elles se comparent dans le temps et entre pays parce que l'instrument est commun.

Illettrisme et illectronisme

Indicateur	Donnée	Source
Illettrisme	7 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France, soit environ 2,5 millions de personnes ; plus de la moitié sont en emploi	ANLCI, enquête Information et vie quotidienne (Insee), 2011
Compétences des adultes	En 2023, 28 % des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit et 27 % du calcul ; scores de la France (255 en littératie, 257 en numératie) inférieurs à la moyenne de l'OCDE (261 et 264)	OCDE, PIAAC 2e cycle ; Dares Analyses n° 73, décembre 2024
Illectronisme	En 2025, 7 % des 16-74 ans n'utilisent pas internet ou n'ont aucune compétence numérique (10 % en 2021) ; 34 % sont en difficulté numérique, illectronisme ou compétences faibles	Insee, enquête TIC ménages 2025, publiée le 19 février 2026
Langue	Une part des publics des quartiers prioritaires maîtrise peu le français écrit (primo-arrivants)	Diagnostics locaux, structures d'apprentissage du français

Définition – Illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère (FLE)

- **Illettrisme** : situation de personnes qui ont été **scolarisées en France** mais n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante (définition de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ANLCI).
- **Analphabétisme** : personnes qui n'ont **jamais été scolarisées** et n'ont pas appris à lire et à écrire.
- **Français langue étrangère** : personnes scolarisées dans une autre langue, qui apprennent le français ; elles peuvent avoir une bonne littératie dans leur langue.
- **Illectronisme** : difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques et internet, par manque d'équipement ou de compétences.

Attention – Les chiffres ne se résument pas

L'illettrisme (7 %), l'illectronisme (7 % des 16-74 ans), les difficultés numériques (34 %) et la littératie en santé limitée (44 %) mesurent des choses **différentes** : on ne les additionne pas. Une personne peut lire parfaitement et avoir du mal à juger une information de santé ; une autre peut lire difficilement mais très bien échanger avec un professionnel.

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **HLS19** : dernières données françaises publiées (2021) ; le cycle suivant, **HLS24**, auquel participe la France, recueille ses données de juillet 2024 à juin 2026 ; son rapport international n'était pas publié au 26

octobre 2026.

- **PIAAC 2023** : résultats publiés en décembre 2024 ; en France, 28 % des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit (Dares, 2024).
- **Illectronisme** : dernière enquête TIC ménages de l'Insee (2025, publiée le 19 février 2026) : 7 % des 16-74 ans.
- **Communiquer pour tous** : guide de Santé publique France (mai 2018, mis à jour en février 2025), cité par le guide d'accompagnement de 2025.
- **PNNS 5 (2026-2030) / SNANC** : le PNNS 5, lancé le 8 avril 2026, met l'accent sur les milieux de vie et sur la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition (voir le chapitre 1).

Comment se calcule le niveau de littératie dans l'enquête HLS19

Pour lire correctement les chiffres de HLS19, il faut savoir comment le niveau de chaque personne est obtenu. La version courte utilisée dans de nombreux pays, le questionnaire **HLS19-Q12**, pose 12 questions du type « À quel point est-il facile pour vous de… ». Chaque question a quatre réponses possibles : très facile, facile, difficile, très difficile.

Méthode pas à pas – Du questionnaire au niveau de littératie (HLS19-Q12)

1. On compte les réponses valides (on retire les « je ne sais pas »). Un score n'est calculé que si la personne a répondu à la grande majorité des questions.

2. On compte les réponses « facile » ou « très facile ».

3. Score = réponses faciles ou très faciles / réponses valides × 100 (de 0 à 100).

4. On classe le score : plus de 83,3 = excellent ; plus de 66,7 à 83,3 = suffisant ; plus de 50 à 66,7 = problématique ; 50 ou moins = insuffisant. Les niveaux « problématique » et « insuffisant » forment la littératie **limitée**.

Calcul détaillé – Trois personnes interrogées (données fictives)

- Mme A. répond « facile » ou « très facile » à 9 questions sur 12 : 9 / 12 × 100 = **75,0** : niveau **suffisant**.
- M. B. répond facilement à 8 questions sur 12 : 8 / 12 × 100 = **66,7** : niveau **problématique**.
- Mme C. répond « je ne sais pas » à une question et facilement à 6 des 11 autres : 6 / 11 × 100 = **54,5** : niveau **problématique**. Si l'on avait divisé par 12, on aurait trouvé 50,0 et classé à tort Mme C. au niveau insuffisant.

Leçon : un pourcentage se calcule sur les réponses valides, et une valeur placée juste sur un seuil doit être classée avec soin.

Attention – Ce que mesure vraiment ce score

Le score mesure la **difficulté ressentie** face à des tâches d'information, pas une compétence testée. Deux biais sont possibles : une personne peut surestimer sa facilité par fierté, ou la sous-estimer par manque de confiance. Les niveaux servent à comparer des groupes et des pays, pas à juger un individu.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.4

Lors d'un diagnostic, un questionnaire inspiré du HLS19-Q12 donne les résultats suivants pour quatre personnes : a) 12 réponses valides dont 11 faciles ; b) 12 réponses valides dont 7 faciles ; c) 10 réponses valides dont 5 faciles ; d) 12 réponses valides dont 9 faciles. Calculez les scores et classez chaque personne.

Corrigé

a) 11 / 12 × 100 = 91,7 : excellent. b) 7 / 12 × 100 = 58,3 : problématique. c) 5 / 10 × 100 = 50,0 : insuffisant (50 ou moins). d) 9 / 12 × 100 = 75,0 : suffisant. Deux personnes sur quatre (b et c) ont une littératie limitée. On rappelle que, sur un si petit nombre, le résultat ne décrit pas un public : il sert seulement à s'entraîner au calcul.

D'autres sources pour décrire les compétences d'un public

L'enquête HLS19 n'est pas la seule source utile pour préparer un diagnostic. Trois autres sources aident à situer les compétences de base d'une population, à condition de bien savoir ce que chacune mesure.

Source	Ce qu'elle mesure	Ce que l'on retient pour un projet
Enquête internationale sur les compétences des adultes (PIAAC, OCDE ; 2e cycle réalisé en 2022-2023, résultats publiés en décembre 2024)	Compétences testées en lecture (littératie), en calcul (numératie) et en résolution de problèmes, chez les 16-65 ans	Les scores moyens des adultes en France sont inférieurs à la moyenne de l'OCDE ; 28 % ont une faible maîtrise de l'écrit (Dares, 2024) ; une part importante des adultes ne dépasse pas les niveaux les plus bas, surtout parmi les moins diplômés et les plus âgés
Tests de lecture de la Journée défense et citoyenneté (DEPP, chaque année)	Lecture des jeunes Français de 16 à 25 ans	En 2025, **14 %** des jeunes sont en difficulté de lecture, dont **6 %** en très grande difficulté, assimilable à l'illettrisme (DEPP, note n° 26.43, octobre 2026)
Enquête TIC ménages (Insee)	Usage d'internet et compétences numériques des 16-74 ans	L'illectronisme (7 % en 2025, contre 10 % en 2021) est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées, peu diplômées et aux revenus modestes
Données locales (centres sociaux, associations d'apprentissage du français, France Services)	Demandes d'aide, publics accueillis	Elles décrivent le terrain réel du projet, mais seulement pour les personnes qui viennent déjà

Méthode pas à pas – Utiliser ces chiffres dans un diagnostic, sans erreur

1. Citer la source, l'année et la population exacte (âge, territoire).

2. Ne pas additionner des indicateurs différents (illettrisme, illectronisme, littératie en santé).

3. Ne pas appliquer un pourcentage national à un quartier sans dire que c'est une **estimation**.

4. Compléter par des données locales et par des entretiens avec les acteurs du terrain.

5. Présenter les chiffres comme un **besoin d'adaptation** des actions, jamais comme un défaut des habitants.

Exemple – Une phrase de diagnostic bien construite

« Selon l'Insee (enquête 2025, publiée en 2026), 7 % des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme en France et 34 % ont des difficultés numériques ; cette part est plus élevée chez les personnes âgées. Le club de retraités compte 120 adhérents ; lors de notre recueil, 22 des 80 adhérents présents disent n'avoir jamais utilisé internet. Nous prévoyons donc une inscription par téléphone et sur papier. »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.5

Un étudiant écrit dans son diagnostic : « Dans le quartier, 7 % + 34 % + 44 % = 85 % des habitants ont des problèmes de littératie. » Relevez les trois erreurs et réécrivez la phrase.

Corrigé

Erreurs : il additionne des indicateurs qui mesurent des choses différentes ; il compte plusieurs fois les mêmes personnes ; il applique des chiffres nationaux, portant sur des populations différentes (18-65 ans scolarisés en France, 16-74 ans, adultes), au quartier sans le dire. Réécriture : « En France, environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (HLS19, 2021) et 34 % des 16-74 ans ont des difficultés numériques (Insee, 2025). Ces chiffres nationaux ne décrivent pas directement le quartier ; nous les complétons par les données du centre social. »

5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §6 (p. 18)

Les conséquences d'une littératie limitée

Les revues de la littérature (Berkman et coll., 2011, pour l'agence américaine AHRQ) associent un faible niveau de littératie en santé à :

- un **moindre recours à la prévention** (dépistages, vaccinations) et un recours plus tardif aux soins ;
- davantage d'**hospitalisations** et de passages aux urgences ;
- une moins bonne **compréhension des traitements** et des conseils (posologies, régimes prescrits) ;
- une moins bonne **gestion des maladies chroniques** (diabète, insuffisance cardiaque) ;
- un état de santé perçu plus mauvais et une mortalité plus élevée chez les personnes âgées.

En nutrition, une littératie limitée rend plus difficile la lecture des étiquettes, la compréhension des portions et des fréquences (« 5 fruits et légumes », « au moins 2 fois par semaine »), le tri entre informations fiables et publicités.

Littératie et inégalités sociales de santé

Lien diététique – Retour au chapitre 2

La littératie est à la fois un **déterminant** de la santé et un **médiateur** des inégalités : les personnes défavorisées ont plus souvent une littératie limitée, et les messages de prévention écrits, abstraits ou numériques profitent d'abord aux personnes les plus favorisées. Une campagne non adaptée peut donc **creuser** le gradient social (effet « loi inverse des soins »). L'**universalisme proportionné** (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à tous, avec une intensité et des modalités adaptées : la communication accessible en fait partie.

Exemple – Le Nutri-Score : un outil pensé pour la littératie

Le Nutri-Score a été conçu comme un logo **synthétique**, coloré et gradué (A à E), précisément parce que le tableau nutritionnel (pour 100 g, en kJ et en kcal) est difficile à utiliser pour une grande partie des consommateurs. Les études ont montré qu'il améliore la capacité à classer les produits selon leur qualité nutritionnelle, y compris chez les personnes ayant un faible niveau d'études. Il ne dispense pas d'expliquer : comparer **au sein d'une même famille** de produits, regarder aussi la liste d'ingrédients.

Par quels chemins la littératie agit-elle sur la santé ?

Constater qu'une littératie limitée est associée à une moins bonne santé ne dit pas **pourquoi**. Paasche-Orlow et Wolf (2007) ont proposé un modèle qui décrit trois chemins principaux. Il aide à choisir où agir dans un projet.

Chemin (Paasche-Orlow et Wolf, 2007)	Ce qui se passe	Exemple en nutrition	Où agir
Accès aux soins et à la prévention	La personne trouve mal les services, renonce aux démarches, arrive plus tard	Une famille ne demande pas le tarif social de la cantine ; un patient ne prend pas rendez-vous avec la diététicienne	Simplifier les démarches, accompagner, aller vers les publics
Relation avec les professionnels	L'échange est moins riche : moins de questions, moins de compréhension, moins de décision partagée	Un patient repart avec un plan alimentaire qu'il n'a pas compris et n'ose pas le dire	Former les professionnels, faire dire, donner du temps
Prendre soin de soi au quotidien	La personne applique moins bien les conseils et gère moins bien sa maladie	Une personne vivant avec un diabète ne sait pas adapter son repas quand elle mange à l'extérieur	Éducation pratique, supports simples, entraînement avec des aliments réels

Le modèle rappelle que la littératie ne joue pas seule : l'âge, la langue, les revenus, la culture, mais aussi la complexité du système de santé interviennent. Il montre surtout que les professionnels et les organisations sont sur deux des trois chemins.

À retenir – Trois chemins, trois leviers

Accès (simplifier et accompagner), relation (communiquer clairement et vérifier), autonomie au quotidien (éduquer avec des situations concrètes). Un projet efficace agit sur au moins deux de ces chemins.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.6

Mme L., 58 ans, a appris qu'elle a une hypertension. Elle a reçu un dépliant sur le sel et n'est pas venue à l'atelier du centre de santé, car l'inscription se faisait en ligne. Lors d'une consultation, elle a dit « oui » à toutes les questions. Repérez, pour chacun des trois chemins du modèle, un élément de la situation, puis proposez une action par chemin.

Corrigé

Accès : l'inscription en ligne l'a empêchée de venir à l'atelier ; action : inscription par téléphone ou à l'accueil. Relation : elle a dit « oui » à tout, sans que l'on vérifie sa compréhension ; action : faire dire, questions ouvertes, un seul message par consultation. Autonomie au quotidien : un dépliant ne suffit pas à savoir repérer le sel caché ; action : atelier pratique avec des emballages et une recette de plat peu salé, remise d'une fiche en images.

Le coût d'une littératie limitée

Plusieurs études ont essayé d'estimer ce que coûte au système de santé une littératie limitée, à cause des hospitalisations évitables, des complications des maladies chroniques et des passages aux urgences. Aux États-Unis, Vernon et coll. (2007) l'estimaient entre 106 et 238 milliards de dollars par an. Une revue européenne (Eichler et coll., 2009) concluait à un surcoût de l'ordre de **3 à 5 %** des dépenses totales de santé. Ces chiffres sont des ordres de grandeur, calculés avec des méthodes et dans des systèmes de santé différents.

Calcul détaillé – Ce que représente un ordre de grandeur de 3 à 5 % (exemple fictif)

Un territoire de santé dépense 400 millions d'euros par an pour les soins de ses habitants (donnée fictive).

- Hypothèse basse : 400 × 3 / 100 = **12 millions d'euros**.
- Hypothèse haute : 400 × 5 / 100 = **20 millions d'euros**.
- Un programme de formation de 50 professionnels à la communication claire coûte 25 000 € (donnée

fictive) : il représente 25 000 / 12 000 000 × 100 = **0,21 %** de l'hypothèse basse.

Interprétation : on ne peut pas en déduire que le programme « rapportera » 12 millions. Le calcul montre seulement que l'enjeu financier est important au regard du coût des actions ; l'efficacité réelle d'un programme doit être évaluée.

Attention – Un argument à manier avec respect

L'argument économique peut convaincre un financeur, mais il ne doit pas faire des personnes à littératie limitée un « coût ». Dans un dossier de projet, on le présente avec l'argument de **justice sociale** : rendre l'information accessible est d'abord une question d'égalité d'accès à la santé (chapitre 2).

Littératie et alimentation : ce que montrent les études

Les travaux sur la littératie et l'alimentation montrent des associations cohérentes : une littératie en santé limitée va souvent avec une moins bonne compréhension des étiquettes et des portions, un usage moins fréquent des informations nutritionnelles et, dans certaines études, une alimentation de moins bonne qualité. Ces associations sont en partie expliquées par le niveau d'études et les revenus, qui jouent sur les deux à la fois : on parle de **facteurs de confusion** (chapitre 16). C'est pourquoi les actions efficaces combinent l'éducation et l'amélioration de l'environnement (prix, offre, étiquetage simple comme le Nutri-Score).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.7

Une étude observe que les personnes à littératie limitée consomment moins de fruits et légumes. Un élu conclut : « Il suffit de leur apprendre à lire les étiquettes. » Expliquez pourquoi cette conclusion est trop rapide.

Corrigé

L'étude montre une association, pas une cause. Les personnes à littératie limitée ont souvent aussi des revenus plus faibles et moins accès à des commerces de fruits et légumes : ces facteurs de confusion peuvent expliquer une partie de la différence. Apprendre à lire une étiquette est utile, mais ne règle ni le prix ni l'offre. L'action doit combiner éducation, accès (prix, marché, paniers) et information simple.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.2 et 5.3.3 – Données et enjeux

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle part des adultes a une littératie en santé limitée en France selon HLS19 ? Et quelles sont les deux catégories qui la composent ?
2. Une personne répond facilement à 8 questions sur 12 du HLS19-Q12. Calculez son score et donnez son niveau.
3. Pourquoi ne peut-on pas additionner les taux d'illettrisme et d'illectronisme ?
4. Citez les trois chemins du modèle de Paasche-Orlow et Wolf (2007).
5. Citez trois conséquences d'une littératie limitée sur la santé.
6. Qu'est-ce qu'un facteur de confusion dans l'association entre littératie et alimentation ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.2 et 5.3.3

1. Environ 44 % ; littératie « problématique » (environ 30 %) et « insuffisante » (environ 14 %).
2. 8 / 12 × 100 = 66,7 : niveau problématique (de plus de 50 à 66,7).
3. Ils mesurent des choses différentes, sur des populations différentes, et une même personne peut être

comptée dans les deux.

4. L'accès aux soins et à la prévention ; la relation avec les professionnels ; la capacité à prendre soin de soi au quotidien.
5. Moins de prévention, plus d'hospitalisations et de passages aux urgences, moins bonne compréhension des traitements, moins bonne gestion des maladies chroniques.
6. Un facteur, comme le revenu ou le niveau d'études, lié à la fois à la littératie et à l'alimentation, qui peut expliquer une partie de leur association.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de données et le modèle des trois chemins, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.2 et 5.3.3 et je refais les exercices d'application.

5.3.4 Repérer sans stigmatiser

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Méthode pas à pas – L'approche des « précautions universelles »

Il est impossible de savoir, en regardant quelqu'un, s'il a des difficultés de littératie ; les personnes les **cachent** souvent par honte. Plutôt que de « tester » le public, on applique à **tous** une communication claire : c'est l'approche des **précautions universelles** (*health literacy universal precautions*, AHRQ). Tout le monde y gagne, et personne n'est désigné.

Signaux possibles (à interpréter avec prudence)	Exemples
Évitement de l'écrit	« J'ai oublié mes lunettes », « Je le lirai chez moi », formulaire rempli par un proche
Difficultés avec les chiffres	Confusion entre grammes et kilos, entre 100 g et la portion, difficulté à calculer un prix au kilo
Questions déjà traitées dans le document	Demander ce qui est écrit sur le support distribué
Faible participation à l'écrit	Questionnaires non remplis, fiches recettes non utilisées
Difficultés numériques	Pas d'adresse mail, inscription en ligne impossible, smartphone utilisé seulement pour appeler

Méthode pas à pas – Questions simples pour adapter, sans juger

- « Comment préférez-vous recevoir les informations : par écrit, en vidéo, en parlant ? »
- « Est-ce que quelqu'un vous aide habituellement pour les papiers ? »
- « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? »
- Dans un questionnaire de diagnostic : proposer une passation **orale** (entretien) ou avec pictogrammes, plutôt qu'un questionnaire écrit autoadministré.

Faut-il mesurer la littératie de chaque personne ? Les outils et le débat

Des outils de mesure individuelle existent depuis les années 1990. Ils sont utiles en **recherche** et pour évaluer un programme, mais leur usage pour trier les personnes dans un atelier ou une consultation est discuté.

Outil	Principe	Durée	Usage raisonnable
REALM (Davis et coll., 1993)	La personne lit à voix haute une liste de mots médicaux ; on compte les mots bien prononcés	2 à 3 minutes	Recherche ; il mesure la lecture de mots, pas la compréhension
TOFHLA et sa version courte (Parker et coll., 1995)	Textes à trous et questions sur une ordonnance, un rendez-vous	7 à 22 minutes	Recherche
NVS (Weiss et coll., 2005)	Six questions sur une étiquette de crème glacée (encadré L3, 5.5)	3 minutes	Recherche, évaluation de programmes
Question unique (Chew et coll., 2004)	« Êtes-vous à l'aise pour remplir seul(e) des formulaires médicaux ? »	Moins d'une minute	Repérage rapide en soins, avec tact
Questionnaires de difficulté ressentie (HLS-EU, HLQ)	Autoévaluation de tâches de santé	5 à 20 minutes	Enquêtes de population, diagnostic d'un groupe

Attention – Pourquoi on ne « teste » pas le public d'un atelier

Faire lire une liste de mots ou remplir un test à des adultes venus pour un atelier peut être vécu comme un examen humiliant. La personne peut partir et ne plus revenir. De plus, le résultat ne change presque rien à ce que l'on doit faire : avec les **précautions universelles**, la communication est déjà adaptée à tous. On réserve donc ces outils aux études, avec un consentement éclairé et une présentation respectueuse.

Exemple – Utiliser un outil pour évaluer un programme, pas pour trier les personnes

Un réseau d'éducation thérapeutique veut savoir si son programme améliore la capacité des patients à lire une étiquette. Avec l'accord des participants, il fait passer un court test inspiré du NVS au début et à la fin du programme, de façon anonyme. Il compare les résultats du groupe, sans jamais les utiliser pour exclure ou classer un patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.8

Une stagiaire propose de faire lire une liste de mots médicaux à chaque nouveau participant d'un atelier de cuisine, « pour faire des groupes de niveau ». Donnez deux arguments contre cette idée et une alternative.

Corrigé

Arguments : le test peut humilier et faire fuir les personnes qui en ont le plus besoin ; il mesure la lecture de mots médicaux, pas la capacité à cuisiner ou à comprendre une recette ; les groupes de niveau stigmatisent. Alternative : appliquer à tous les précautions universelles (consignes orales et en images, démonstration, binômes mixtes) et demander simplement à l'inscription comment la personne préfère recevoir les informations.

Comprendre la honte pour mieux accueillir

Les difficultés avec l'écrit sont souvent cachées. Parikh et coll. (1996) ont interrogé des patients d'un hôpital américain dont la littératie était limitée : environ **4 sur 10** disaient ressentir de la honte face à leurs difficultés de lecture ; parmi eux, environ **les deux tiers** n'en avaient jamais parlé à leur conjoint, et près d'**un sur cinq** n'en avait jamais parlé à personne. Les personnes développent alors des **stratégies de contournement** très efficaces, qui rendent les difficultés invisibles pour les professionnels.

Stratégie de contournement	Ce que le professionnel peut faire, pour tous
Venir toujours accompagné d'un proche qui lit	Proposer de lire ensemble les documents importants à tous les participants

Stratégie de contournement	Ce que le professionnel peut faire, pour tous
Mémoriser à l'oral ce qui a été dit	Répéter les messages clés en fin de séance ; laisser un support en images
Repérer les produits par la couleur ou la forme de l'emballage	Utiliser de vrais emballages en atelier ; associer couleurs et pictogrammes
Prendre les papiers « pour les lire à la maison »	Remplir les formulaires ensemble, dans un endroit calme
Ne pas revenir quand un écrit est demandé	Réduire l'écrit à l'inscription et à l'évaluation (oral, smileys, gommettes)

À retenir – Une règle d'accueil

Ce n'est pas à la personne de révéler ses difficultés : c'est à la structure de rendre l'information accessible sans que personne n'ait à se signaler. Une phrase neutre, valable pour tous, aide : « Ici, on remplit les papiers ensemble, c'est plus rapide. »

Calcul détaillé – Appliquer des proportions à un groupe (ordre de grandeur, données fictives)

Un programme d'ateliers accueille 60 adultes, dont on estime, d'après le diagnostic, que 25 environ ont une littératie limitée.

- Si 4 sur 10 ressentent de la honte : 25 × 0,4 = **10 personnes**.
- Si les deux tiers d'entre elles n'en ont pas parlé à leur conjoint : 10 × 2 / 3 ≈ **7 personnes**.

Interprétation : ces chiffres viennent d'une étude ancienne et étrangère ; on ne peut pas les appliquer exactement au groupe. Ils montrent simplement qu'une partie du public peut vivre ses difficultés en silence, ce qui justifie une communication claire pour tous.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.9

À la fin d'un atelier, une participante refuse de remplir le questionnaire de satisfaction : « Je n'ai pas le temps, je le ferai la prochaine fois. » Proposez deux façons de recueillir son avis sans la mettre en difficulté, valables pour tout le groupe.

Corrigé

Une évaluation par gommettes sur des smileys pour tout le groupe, avec les questions lues à voix haute ; un tour de parole rapide « Une chose que vous allez refaire ». On peut aussi proposer à chacun de répondre à l'oral à l'animatrice en rangeant la salle. Ces solutions valent pour tous et ne désignent personne.

Les précautions universelles en pratique : la boîte à outils de l'AHRQ

L'agence américaine pour la recherche et la qualité en santé (AHRQ) a publié en 2010, puis révisé, une **boîte à outils des précautions universelles en littératie** (*Health Literacy Universal Precautions Toolkit*). Elle est conçue pour les cabinets et les centres de soins, mais ses principes s'appliquent très bien à une structure de santé publique, à un centre social ou à un service de restauration. Elle s'organise en quatre domaines.

Domaine de la boîte à outils	Exemples d'outils	Adaptation pour une action en nutrition
Améliorer la communication orale	Faire dire, préparer les messages clés, utiliser des mots simples	Trois messages au plus par atelier, démonstration avant explication
Améliorer la communication écrite	Évaluer et simplifier les documents, utiliser des supports adaptés	Fiches recettes en photos testées auprès du public

Domaine de la boîte à outils	Exemples d'outils	Adaptation pour une action en nutrition
Améliorer l'autonomie et le pouvoir d'agir	Fixer des objectifs avec la personne, l'encourager à poser des questions	Chaque participant choisit une action à essayer chez lui
Améliorer les systèmes de soutien	Orienter vers les aides, faciliter les démarches, s'occuper des besoins non médicaux	Lien avec l'épicerie solidaire, aide à l'inscription à la cantine, contact France Services

Méthode pas à pas – Lancer une démarche de précautions universelles dans une structure

1. **Constituer une petite équipe** : un responsable, un professionnel de terrain, un usager.
2. **Faire un état des lieux** : relire les documents, observer l'accueil, demander l'avis de quelques usagers.
3. **Choisir deux ou trois améliorations** faciles et visibles (signalétique, inscription, fiches).
4. **Tester** chaque amélioration avec des usagers avant de la généraliser.
5. **Former** toute l'équipe, y compris l'accueil et les bénévoles.
6. **Suivre** quelques indicateurs : nombre d'inscriptions par téléphone, réussite des « faire dire », documents testés.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.10

Une épicerie solidaire veut appliquer les précautions universelles. Proposez une action pour chacun des quatre domaines de la boîte à outils.

Corrigé

Communication orale : les bénévoles présentent oralement les nouveaux produits du mois et vérifient avec « montrez-moi ». Communication écrite : affichage des prix avec des chiffres en gros et des pictogrammes de familles d'aliments, testé avec des bénéficiaires. Autonomie : à chaque atelier, chacun choisit une recette à refaire et la raconte la fois suivante. Systèmes de soutien : un point d'aide aux démarches (CAF, cantine) avec un partenaire, et une orientation vers France Services.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.4 – Repérer sans stigmatiser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez l'approche des précautions universelles.
2. Citez trois signaux possibles de difficulté avec l'écrit.
3. Pourquoi un signal n'est-il jamais une preuve ?
4. Citez un outil de mesure individuelle de la littératie et dites dans quel cadre on peut l'utiliser.
5. Citez deux stratégies de contournement utilisées par des personnes qui cachent leurs difficultés.
6. Citez les quatre domaines de la boîte à outils de l'AHRQ.

Corrigé – Point d'étape 5.3.4

1. Appliquer à tout le public une communication claire, au lieu de chercher à repérer ou tester les personnes en difficulté.
2. « J'ai oublié mes lunettes », formulaire rempli par un proche, questions sur ce qui est déjà écrit, difficulté avec les chiffres, pas d'adresse mail.
3. Parce qu'il peut avoir d'autres causes (fatigue, oubli réel, manque de temps) ; on ne pose pas de diagnostic sur une personne.
4. REALM, TOFHLA, NVS ou la question unique de Chew ; en recherche ou pour évaluer un programme, avec

consentement, jamais pour trier les participants.

5. Venir avec un proche qui lit, mémoriser à l'oral, repérer les produits par la couleur, emporter les papiers « pour les lire à la maison ».

6. Communication orale, communication écrite, autonomie et pouvoir d'agir, systèmes de soutien.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.4 et je refais les exercices d'application.

5.3.5 Adapter les messages et les supports

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 122 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

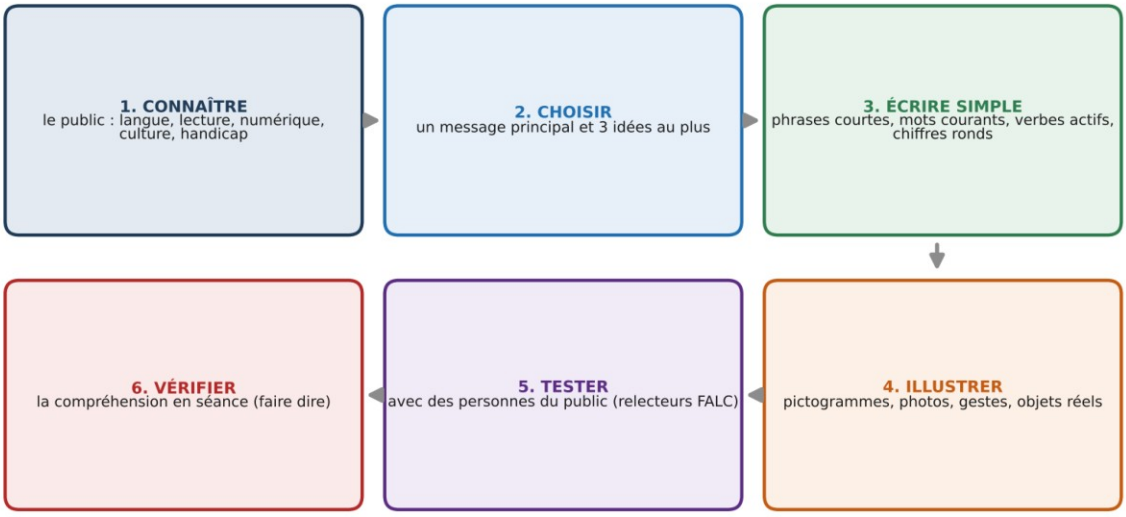


Figure 5.5 – Six étapes pour une communication accessible

Comprendre le schéma – Figure 5.5

1. Connaître le public : langue, maîtrise de l'écrit, accès au numérique, culture, handicap (visuel, auditif, cognitif) ; le diagnostic (chapitre 7) doit recueillir ces informations.

2. Choisir un message principal et au plus trois idées secondaires : trop d'informations noient l'essentiel.

3. Écrire simple : phrases courtes (une idée par phrase), mots courants, verbes actifs, pas de sigles, chiffres ronds et concrets (« une poignée » plutôt que « 30 g »).

4. Illustrer : pictogrammes, photos réalistes, objets réels (emballages, verres, cuillères), gestes ; l'image doit dire la même chose que le texte.

5. Tester le support auprès de personnes du public (relecteurs, groupe test) avant de l'imprimer.

6. Vérifier la compréhension en séance par le « faire dire ».

Les règles d'écriture claire (guide « Communiquer pour tous »)

Règle	À éviter	À préférer
Une idée par phrase, 15 mots au plus	« Afin de favoriser un apport suffisant en fibres, il est recommandé de privilégier les féculents complets lors de chacun des repas. »	« Mangez du pain complet ou des pâtes complètes. Ils contiennent des fibres. »
Mots courants	Légumineuses, apports, privilégier	Lentilles, pois chiches, haricots secs ; manger ; choisir
Forme active et directe	« Il est conseillé de limiter… »	« Mangez moins de… »
Phrases positives	« Ne pas oublier de boire »	« Buvez de l'eau »
Chiffres concrets	« 400 g de fruits et légumes par jour »	« 5 fruits et légumes par jour : une portion = la taille d'un poing »
Pas de sigles	PNNS, AJR, IMC	« Les conseils officiels » ; expliquer si nécessaire
Mise en page aérée	Texte justifié, italique, majuscules, police fantaisie	Police sans empattement, 14 points au moins, aligné à gauche, gras pour l'essentiel, puces
Image utile	Image décorative ou ambiguë	Photo réelle du geste ou de l'aliment

Définition – FALC – Facile à lire et à comprendre

Méthode de rédaction issue des **règles européennes** (Inclusion Europe, 2009), conçue avec et pour les personnes en situation de **handicap intellectuel**, mais utile à beaucoup d'autres publics (personnes âgées, personnes apprenant le français, personnes fatiguées ou stressées). Un document FALC est **relu et validé** par des personnes concernées et peut porter le logo européen « Facile à lire ». Exemple de ressource en santé : *SantéBD*, bandes dessinées en FALC pour expliquer la santé et les consultations.

Mesurer la lisibilité d'un texte

La **lisibilité** d'un texte dépend de la longueur des phrases et des mots. L'indice de **Flesch**, adapté au français par Kandel et Moles (1958), en donne une estimation :

Méthode pas à pas – Indice de lisibilité de Kandel et Moles (adaptation française de Flesch)

L = 207 − 1,015 × (nombre de mots / nombre de phrases) − 73,6 × (nombre de syllabes / nombre de mots)
Interprétation (échelle de Flesch) : 0-30 très difficile ; 30-50 difficile ; 50-60 assez difficile ; 60-70 standard ; 70- 80 assez facile ; 80-90 facile ; 90-100 très facile.

Exemple – Calcul détaillé : un dépliant avant et après réécriture

Version initiale : 120 mots, 5 phrases, 204 syllabes.

- Mots par phrase : 120 / 5 = **24** ; syllabes par mot : 204 / 120 = **1,7**.
- L = 207 − 1,015 × 24 − 73,6 × 1,7 = 207 − 24,36 − 125,12 = **57,52** → « assez difficile ».

Version réécrite : 96 mots, 12 phrases, 144 syllabes.

- Mots par phrase : 96 / 12 = **8** ; syllabes par mot : 144 / 96 = **1,5**.
- L = 207 − 1,015 × 8 − 73,6 × 1,5 = 207 − 8,12 − 110,4 = **88,48** → « facile ».

Gain : 88,48 − 57,52 = **30,96 points**. Limite : l'indice ne mesure ni le sens, ni la mise en page, ni l'adéquation au public ; il complète le test auprès des personnes, il ne le remplace pas.

Adapter l'oral, l'atelier et le numérique

Support	Adaptations
Oral (séance, atelier)	Parler lentement, mots simples, un message à la fois, reformuler, montrer (gestes, objets), répéter les messages clés en fin de séance, s'appuyer sur l'expérience des participants
Atelier culinaire	Recettes en images (photos de chaque étape), quantités en contenants courants (verre, cuillère, poignée), démonstration avant de faire, binômes mixtes
Écrit (affiche, dépliant)	Un message par affiche, titre qui dit l'essentiel, pictogrammes, tests de compréhension
Numérique (site, réseaux, vidéo)	Vidéos courtes sous-titrées, audio, navigation simple, version papier ou accompagnement (médiateur numérique, France Services) ; ne jamais réserver une inscription au seul numérique
Langues	Traduction professionnelle ou interprétariat (médiation en santé), supports multilingues testés ; éviter les traducteurs automatiques non relus pour des messages de santé
Handicap	Contrastes et grande police (déficience visuelle), sous-titres et langue des signes (déficience auditive), FALC (déficience intellectuelle), accessibilité des locaux

Situer un texte sur l'échelle et compter les syllabes

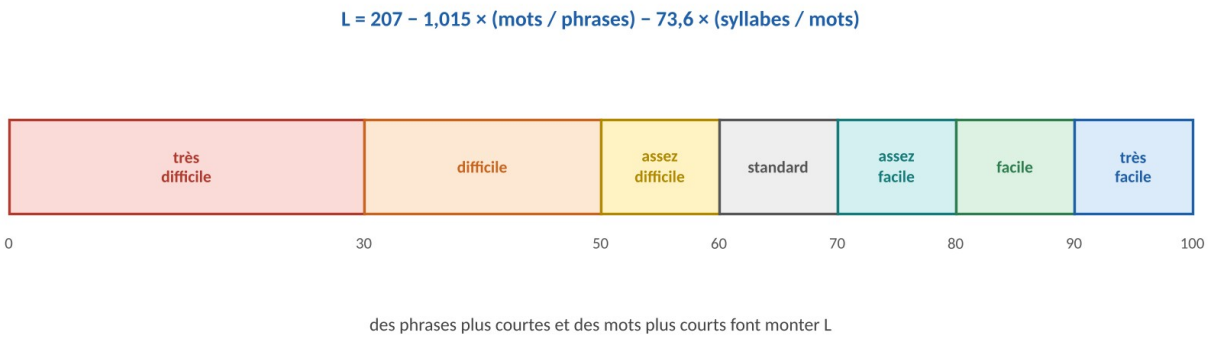


Figure 5.5 bis – L'échelle de lisibilité de Kandel et Moles

Comprendre le schéma – Figure 5.5 bis

1. La barre va de **0** (texte très difficile) à **100** (texte très facile) ; chaque couleur correspond à une catégorie de l'échelle de Flesch reprise par Kandel et Moles (1958).
2. Les zones ne sont pas de même largeur : la zone « très difficile » couvre 0 à 30, alors que les zones « assez difficile » à « très facile » ne couvrent que 10 points chacune. Un gain de 10 points peut donc faire changer de catégorie.
3. La formule rappelle les deux leviers : la **longueur des phrases** (mots par phrase) et la **longueur des mots** (syllabes par mot). Le second pèse beaucoup : passer de 1,7 à 1,5 syllabe par mot fait gagner 73,6 × 0,2 = 14,72 points.
4. Pour un public à littératie limitée, on vise au moins la zone « facile » (80 et plus), puis on teste le support auprès de quelques personnes.

Méthode pas à pas – Compter mots, phrases et syllabes à la main

1. Les mots : chaque groupe de lettres séparé par un espace compte pour un mot ; « l'eau » compte pour deux mots (l' et eau) ; un nombre écrit en chiffres compte pour un mot.

2. Les phrases : on compte les phrases terminées par un point, un point d'exclamation ou d'interrogation ; une liste à puces sans point compte pour une phrase par puce.

3. Les syllabes : on les compte **à l'oreille**, comme on les prononce en parlant normalement ; le « e » muet de fin de mot ne compte pas (« lé-gumes » = 2) ; un sigle ou un nombre se compte comme il se dit (« 14 » = qua-torze = 2).

4. Une seule convention : on garde la même façon de compter pour la version initiale et la version réécrite ; c'est la **comparaison** qui compte, plus que la valeur exacte.

Calcul détaillé – Une phrase comptée pas à pas

« Mangez des légumes à chaque repas. » : man-gez (2) des (1) lé-gumes (2) à (1) chaque (1) re-pas (2) = **9 syllabes** ; **6 mots** ; **1 phrase**.

- Mots par phrase : 6 ; syllabes par mot : 9 / 6 = **1,5**.
- L = 207 − 1,015 × 6 − 73,6 × 1,5 = 207 − 6,09 − 110,4 = **90,51** : très facile.

Remarque : une phrase seule donne un indice peu fiable ; on calcule l'indice sur un passage d'au moins 100 mots, ou sur tout le support s'il est court.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.11

Comptez les mots, les syllabes et calculez l'indice de la consigne suivante : « Lavez vos mains avant de cuisiner. Coupez les carottes en rondelles. » (On compte « ron-delles » = 2 syllabes.)

Corrigé

Mots : 6 + 5 = 11 ; phrases : 2 ; syllabes : la-vez (2) vos (1) mains (1) a-vant (2) de (1) cui-si-ner (3) = 10 ; cou-pez (2) les (1) ca-rottes (2) en (1) ron-delles (2) = 8 ; total 18. Mots par phrase : 11 / 2 = 5,5 ; syllabes par mot : 18 / 11 = 1,636. L = 207 − 1,015 × 5,5 − 73,6 × 1,636 = 207 − 5,58 − 120,44 = 80,98 : facile. Le calcul porte sur un texte très court : il sert ici d'entraînement.

Remplacer les mots du métier par des mots de tous les jours

Le vocabulaire de la nutrition est plein de mots techniques que le professionnel n'entend plus comme difficiles. Une liste de remplacements, établie en équipe et complétée après chaque test de support, fait gagner du temps et rend les documents cohérents.

Mot du métier	Mot ou expression de tous les jours
Légumineuses, légumes secs	Lentilles, pois chiches, haricots secs (donner des exemples)
Féculents	Pain, pâtes, riz, pommes de terre, semoule
Produits laitiers	Lait, yaourt, fromage
Apport, consommation	Ce que l'on mange, ce que l'on boit
Privilégier	Choisir plus souvent
Limiter	Manger moins souvent, en petite quantité
Collation	Petit en-cas, goûter
Hydratation	Boire
Matières grasses ajoutées	Huile, beurre, crème

Mot du métier	Mot ou expression de tous les jours
Aliments ultra-transformés	Produits avec une longue liste d'ingrédients que l'on n'a pas dans sa cuisine
Densité énergétique	Aliment qui apporte beaucoup de calories pour un petit volume
Rassasiement	Se sentir plein à la fin du repas
Glucides complexes	Pain, pâtes, riz (le mot « glucides » est à expliquer s'il est utile)
Portion	Quantité dans l'assiette ; montrer avec la main, un verre, une cuillère
Équilibré	Varié, avec des légumes, un féculent et un peu de viande, de poisson, d'œufs ou de légumes secs

Attention – Simplifier sans infantiliser

Écrire simplement ne veut pas dire écrire comme pour un enfant. On garde un ton adulte, on vouvoie (sauf public d'enfants ou d'adolescents), on évite les diminutifs et les jeux de mots. Si un mot technique est utile, par exemple « allergène » ou « Nutri-Score », on le garde et on l'explique une fois avec des mots simples.

Exemple – Une phrase réécrite en deux temps

Version initiale : « La consommation de féculents complets permet d'augmenter les apports en fibres et de favoriser le rassasiement. » Première réécriture : « Le pain complet et les pâtes complètes contiennent des fibres. » Seconde réécriture, après le test : « Le pain complet et les pâtes complètes calent plus longtemps. » Lors du test, plusieurs personnes ne savaient pas à quoi servent les fibres : l'effet ressenti (« calent plus longtemps ») a été mieux compris que le nom du nutriment.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.12

Réécrivez avec des mots de tous les jours : « Privilégiez les légumineuses et limitez les produits ultra-transformés lors de vos collations. »

Corrigé

« Mangez plus souvent des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs. Pour le goûter, choisissez un fruit, du pain ou un yaourt plutôt que des biscuits ou des barres. » On a remplacé chaque mot technique par des exemples concrets et découpé la phrase en deux idées.

Mettre en page pour être lu

Un texte bien écrit peut rester difficile à lire s'il est mal présenté. La mise en page est la première chose que voit le lecteur : elle décide souvent s'il va lire ou non.

Élément	Ce qui aide	Ce qui gêne
Police	Sans empattement (de type Arial, Verdana), 14 points au moins pour un document à lire seul, 12 au minimum	Police fantaisie ou manuscrite, petits caractères
Mise en valeur	Le gras pour les mots importants	L'italique, le souligné en dehors des liens, les MAJUSCULES sur des phrases entières
Alignement	Texte aligné à gauche, une phrase par ligne si possible	Texte justifié (espaces irréguliers), phrase coupée entre deux pages
Espace	Interligne large, marges, paragraphes courts, beaucoup de blanc	Page pleine, texte serré

Élément	Ce qui aide	Ce qui gêne
Structure	Titre qui dit l'essentiel, intertitres sous forme de question, puces	Titre abstrait, longs paragraphes
Couleurs	Texte foncé sur fond clair, contraste fort	Texte sur une photo, couleurs pâles, information donnée seulement par la couleur
Images	Une image à côté du texte qu'elle illustre	Image décorative, éloignée du texte
Chiffres	En chiffres (« 3 verres »), unités connues	Chiffres en lettres longues, grands nombres, pourcentages non expliqués

Méthode pas à pas – Relire un support en 5 minutes avant de le tester

1. Le titre dit-il ce que le lecteur va trouver ou faire ?

2. Y a-t-il un seul message principal, visible en premier ?

3. Chaque phrase fait-elle moins de 15 mots ?

4. La police, la taille et le contraste respectent-ils le tableau ci-dessus ?

5. Chaque image dit-elle la même chose que le texte voisin ?

6. Le lecteur sait-il quoi faire à la fin (venir, appeler, essayer une recette) ?

À vous de jouer – Exercice d'application 5.13

Une affiche pour un atelier est écrite en majuscules italiques jaunes sur la photo d'un marché. Le titre est « PROGRAMME ALIMENTATION SANTÉ ». Relevez quatre défauts et proposez une nouvelle présentation.

Corrigé

Défauts : majuscules et italique difficiles à lire ; texte jaune sur une photo, contraste faible ; titre abstrait qui ne dit pas ce que l'on va faire ; aucune information pratique visible. Nouvelle présentation : fond blanc, titre en gras noir « Cuisinons ensemble le mardi », photo de personnes qui cuisinent placée à côté du texte, trois informations avec pictogrammes (horloge : mardi 14 h ; lieu : salle du rez-de-chaussée ; pièce barrée : gratuit), contact téléphonique en gros.

Les images qui aident et celles qui trompent

Une revue de la littérature de Houts et coll. (2006) a montré que des images bien choisies, placées à côté d'un texte ou d'une explication orale, améliorent l'**attention**, la **compréhension**, la **mémorisation** et l'**application** des consignes de santé, surtout chez les personnes à littératie limitée. Mais une image peut aussi tromper : elle doit être choisie, puis testée.

Image qui aide	Image qui trompe ou gêne
Photo réelle d'un geste (rincer les lentilles)	Dessin humoristique dont on ne comprend pas le sens
Photo d'une portion à côté d'une main ou d'un verre	Photo d'une assiette sans repère de taille
Pictogramme simple, toujours le même pour la même idée	Pictogramme différent à chaque page pour la même idée
Image qui montre ce qu'il faut faire	Image qui montre seulement ce qu'il ne faut pas faire (le geste « interdit » est souvent retenu)
Personnes diverses, dans des situations réalistes	Corps idéalisés, images qui stigmatisent (personne en surpoids triste)

Attention – Un pictogramme n'est pas universel

Un même pictogramme peut être compris différemment selon la culture, l'âge ou l'habitude. Une croix rouge peut vouloir dire « interdit » ou « soins » ; une main levée peut vouloir dire « stop » ou « bonjour ». Les normes de conception des pictogrammes publics (série ISO 9186) prévoient d'ailleurs de **tester leur compréhension** auprès du public avant de les utiliser.

Calcul détaillé – Tester quatre pictogrammes d'allergènes (données fictives)

On montre quatre pictogrammes, sans texte, à 15 parents d'une crèche, et l'on demande « Qu'est-ce que cela veut dire ? ». Dans ce cours, on retient qu'un pictogramme est **validé** si au moins deux personnes sur trois le comprennent (66,7 %).

- Lait (verre de lait) : 14 / 15 × 100 = **93,3 %** : validé.
- Œuf : 13 / 15 = **86,7 %** : validé.
- Gluten (épi de blé) : 8 / 15 = **53,3 %** : non validé ; plusieurs parents ont répondu « céréales » ou « pain ».
- Fruits à coque (noisette) : 9 / 15 = **60,0 %** : non validé.

Décision : on garde les deux premiers ; pour le gluten et les fruits à coque, on ajoute le mot sous l'image et des exemples d'aliments (« blé : pain, pâtes, gâteaux »), puis on refait le test.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.14

Pour une fiche sur l'hygiène en cuisine, une collègue propose trois images : une main barrée devant un réfrigérateur, la photo d'une personne qui se lave les mains, un dessin de microbe souriant. Dites lesquelles garder et pourquoi.

Corrigé

On garde la photo d'une personne qui se lave les mains : elle montre le geste attendu. La main barrée est ambiguë (on ne sait pas ce qui est interdit) et montre ce qu'il ne faut pas faire. Le microbe souriant donne une image positive de ce qu'on veut éviter et n'apporte aucune information. On peut ajouter une photo du réfrigérateur rangé correctement, avec un mot sous chaque zone.

Écrire en FALC pas à pas

Les règles européennes du FALC ont été publiées en 2009 par Inclusion Europe dans le guide *L'information pour tous*, rédigé avec des personnes en situation de handicap intellectuel. Elles vont plus loin que l'écriture claire : chaque règle est pensée pour une personne qui lit peu ou lentement et qui a besoin de repères stables.

Étape	Règles principales du FALC
Avant d'écrire	Savoir qui va lire et ce qu'il doit savoir ou faire ; associer dès le début des personnes concernées
Les mots	Mots simples et connus ; expliquer un mot difficile la première fois ; toujours le même mot pour la même chose ; pas de mots d'une autre langue, pas d'abréviations ni de sigles ; pas d'images de langage (« avoir un petit creux »)
Les phrases	Phrases courtes, une idée par phrase ; forme active et positive ; s'adresser directement au lecteur (« vous ») ; les idées dans l'ordre où elles se passent
Les nombres	En chiffres (« 3 » et non « trois ») ; éviter les pourcentages et les grands nombres (« beaucoup de personnes ») ; dates écrites en entier (« mardi 12 janvier »)
La mise en page	Police claire et grande, pas d'italique, texte aligné à gauche, une phrase par ligne si possible, ne pas couper une phrase entre deux pages ; images à côté du texte

Étape	Règles principales du FALC
Après l'écriture	Faire relire par des personnes concernées ; corriger ; elles valident le document, qui peut alors porter le logo européen « Facile à lire »

Exemple – Une consigne d'hygiène réécrite en FALC

Version initiale : « Le lavage des mains, réalisé avant toute manipulation de denrées et après chaque passage aux sanitaires, constitue une mesure d'hygiène essentielle. »

Version FALC (avec une photo à gauche de chaque ligne) :

- « Lavez vos mains avec du savon. »
- « Lavez vos mains avant de cuisiner. »
- « Lavez vos mains après être allé aux toilettes. »
- « Lavez vos mains pendant 30 secondes. Chantez une petite chanson dans votre tête. »

Le verbe « lavez » est répété : en FALC, la répétition aide à repérer l'information.

Attention – FALC, écriture claire : ne pas confondre

L'écriture claire s'adresse à tout le monde et le professionnel peut l'appliquer seul. Le FALC est une méthode précise, conçue avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel ; un document n'est FALC que s'il a été **relu et validé** par des personnes concernées. Des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des associations proposent ce travail de relecture, qui doit être reconnu et, si possible, rémunéré.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.15

Réécrivez en FALC l'invitation suivante, pour des adultes d'un foyer d'hébergement : « Un atelier de sensibilisation à l'équilibre alimentaire aura lieu le 12/03/2027 à 14h30 au réfectoire ; la participation de 80 % des résidents est souhaitée. »

Corrigé

« Venez cuisiner avec nous. » « C'est le vendredi 12 mars 2027. » « Nous commençons à 14 heures 30. » « C'est dans la salle à manger. » « Nous allons préparer un repas bon pour la santé. » « Nous voulons que beaucoup de personnes viennent. » (Photos : des personnes qui cuisinent, une horloge, la salle à manger.) Le pourcentage a été remplacé par « beaucoup de personnes », la date est écrite en entier avec le jour de la semaine, le jargon (« sensibilisation », « équilibre alimentaire ») a disparu. Le document est ensuite relu par des résidents.

D'autres formules de lisibilité, et pourquoi on ne les mélange pas

La formule de Kandel et Moles est une adaptation au français de la formule de Rudolf **Flesch** (1948), conçue pour l'anglais : L = 206,835 − 1,015 × (mots / phrases) − 84,6 × (syllabes / mots). Les mots français ont en moyenne plus de syllabes que les mots anglais ; Kandel et Moles (1958) ont donc réduit le poids des syllabes (73,6 au lieu de 84,6) pour que les scores des deux langues restent comparables. D'autres indices existent, par exemple l'indice **Gunning Fog** (1952), qui estime un nombre d'années d'études nécessaires à partir de la longueur des phrases et de la part des mots de trois syllabes ou plus, et des outils en ligne en français, comme **Scolarius**, développé au Québec.

Calcul détaillé – Le même texte, deux formules

Un texte français compte 120 mots, 12 phrases et 180 syllabes : 10 mots par phrase, 1,5 syllabe par mot.

- Formule française (Kandel et Moles) : 207 − 1,015 × 10 − 73,6 × 1,5 = 207 − 10,15 − 110,4 = **86,45** : facile.

- Formule anglaise (Flesch) appliquée par erreur : 206,835 − 10,15 − 84,6 × 1,5 = 206,835 − 10,15 − 126,9 = **69,79** : standard.

Un second texte compte 180 mots, 10 phrases et 324 syllabes : 18 mots par phrase, 1,8 syllabe par mot.

- Kandel et Moles : 207 − 18,27 − 132,48 = **56,25** : assez difficile. Flesch : 206,835 − 18,27 − 152,28 = **36,29** : difficile.

Leçon : la formule anglaise sous-estime la lisibilité d'un texte français d'environ 15 à 20 points. On utilise toujours la formule adaptée à la langue, et on ne compare que des scores calculés avec la même formule.

Méthode pas à pas – Utiliser un outil de lisibilité en ligne avec prudence

1. Vérifier quelle formule l'outil utilise et pour quelle langue.

2. Retirer du texte les titres, les listes de chiffres et les tableaux, qui faussent le calcul.

3. Comparer la version initiale et la version réécrite avec le même outil.

4. Ne jamais coller dans un outil en ligne un texte qui contient des données personnelles (nom, situation de santé) : règles du RGPD (chapitre 6).

5. Compléter toujours par la relecture des mots difficiles et par un test auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.16

Un collègue annonce que la fiche de l'atelier obtient 62 « d'après un site américain » et qu'il faut tout réécrire. La fiche compte 100 mots, 10 phrases et 160 syllabes. Calculez l'indice de Kandel et Moles et donnez votre avis.

Corrigé

Mots par phrase : 100 / 10 = 10 ; syllabes par mot : 160 / 100 = 1,6. L = 207 − 10,15 − 73,6 × 1,6 = 207 − 10,15 − 117,76 = 79,09 : assez facile, à la limite de « facile ». Le site américain applique sans doute la formule anglaise, qui sous-estime les textes français (206,835 − 10,15 − 84,6 × 1,6 = 61,32, soit environ 62). Il n'est pas nécessaire de tout réécrire : on peut raccourcir quelques mots longs pour dépasser 80, puis tester la fiche auprès de quelques personnes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.5 – Adapter les messages et les supports

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les six étapes d'une communication accessible.

2. Donnez la formule de Kandel et Moles et la zone visée pour un public à littératie limitée.

3. Calculez l'indice d'un texte de 80 mots, 8 phrases et 120 syllabes.

4. Citez trois règles de mise en page qui facilitent la lecture.

5. Qui valide un document FALC ?

6. Pourquoi faut-il tester un pictogramme avant de l'utiliser ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.5

1. Connaître le public, choisir un message, écrire simple, illustrer, tester, vérifier par le faire dire.

2. L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; on vise 80 et plus (facile ou très facile).

3. 80 / 8 = 10 mots par phrase ; 120 / 80 = 1,5 syllabe par mot ; L = 207 − 10,15 − 110,4 = 86,45 : facile.

4. Police sans empattement de 14 points, texte aligné à gauche, gras plutôt qu'italique ou majuscules, contraste fort, images à côté du texte, beaucoup d'espace.

5. Des personnes en situation de handicap intellectuel, qui relisent et valident le document.
6. Parce qu'un pictogramme peut être compris différemment selon la culture, l'âge ou l'habitude ; seul le test montre s'il est compris.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de lisibilité et je relis les tableaux de la section.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.5 et je refais les exercices d'application.

5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire »

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 24-25 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

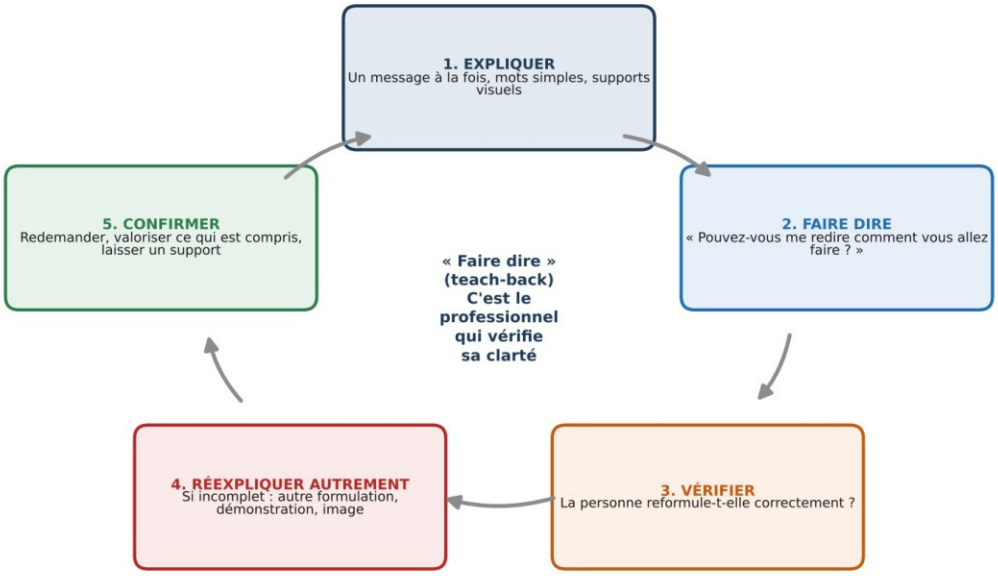


Figure 5.6 – La boucle du « faire dire » (teach-back)

Comprendre le schéma – Figure 5.6

1. Expliquer un message à la fois, avec des mots simples et un support visuel.

2. Faire dire : demander à la personne de reformuler **avec ses mots** ce qu'elle va faire, en présentant la demande comme une vérification de **sa propre clarté** (« Pour être sûr(e) d'avoir bien expliqué… »).

3. Vérifier la reformulation.

4. Si elle est incomplète, **réexpliquer autrement** (autre formulation, démonstration, image), sans répéter mot pour mot.

5. Confirmer par une nouvelle reformulation, valoriser, laisser un support.

6. La HAS a publié en 2015 une fiche-outil « Faire dire » pour les professionnels de santé ; la technique s'utilise aussi en atelier collectif (« Qui peut expliquer à son voisin comment on lit le Nutri-Score ? »).

Attention – Ce qu'il ne faut pas dire

« Vous avez compris ? » appelle presque toujours la réponse « oui », par politesse ou par gêne. On préfère une **question ouverte** qui demande d'agir : « Montrez-moi comment vous choisiriez entre ces deux céréales.

»

À vous de jouer – Exercice d'application 5.17

Réécrivez le message suivant pour des parents ayant une littératie limitée, puis formulez la question de « faire dire » : « Il est recommandé de limiter la consommation de boissons sucrées, y compris les jus de fruits, qui ne doivent pas excéder un verre par jour, et de privilégier l'eau, seule boisson indispensable. »

Corrigé

Réécriture : « L'eau est la meilleure boisson. Les sodas et les jus ont beaucoup de sucre. Les jus de fruits : un petit verre par jour, pas plus. » (avec un pictogramme verre d'eau en vert, soda en rouge). **Faire dire** : « Pour être sûre d'avoir été claire : qu'est-ce que vous allez donner à boire à vos enfants au goûter demain ? »

Découper, vérifier, faire faire : trois façons d'utiliser le « faire dire »

Le principe du « faire dire » et son usage en groupe ont été présentés au chapitre 3. En littératie, on l'utilise sous trois formes complémentaires.

Forme	Ce que l'on fait	Quand l'utiliser
Découper et vérifier (*chunk and check*)	On donne une information à la fois, puis on vérifie avant de passer à la suivante	Explication longue : un plan alimentaire, une recette en plusieurs étapes, une démarche administrative
Faire faire (*show me*)	On demande de **montrer** le geste plutôt que de le dire : verser une portion, lire une étiquette, régler une plaque	Gestes techniques, numératie (quantités, prix), public allophone
Faire dire à distance	Au téléphone ou en visioconférence, on demande à la personne de répéter le rendez-vous, l'adresse, ce qu'elle doit apporter	Rappel d'atelier, suivi après une séance, personnes isolées

Exemple – Découper et vérifier une recette de soupe

L'animatrice explique d'abord les trois premières étapes (laver, éplucher, couper) et demande à un binôme de les montrer. Elle passe ensuite à la cuisson (quantité d'eau, durée) et vérifie avec la question « Combien de verres d'eau allez-vous mettre ? ». Elle termine par le mixage et la conservation. Si elle avait tout expliqué d'un bloc, les participants auraient surtout retenu le début et la fin.

Aider les personnes à poser leurs questions : les trois questions clés

Le « faire dire » vérifie ce que la personne a compris. Il faut aussi l'aider à **demander** ce dont elle a besoin : c'est la littératie interactive. Aux États-Unis, la campagne *Ask Me 3* invite les patients à poser trois questions à chaque rencontre avec un professionnel. On peut l'adapter en atelier ou en consultation diététique :

1. « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ? »
2. « Qu'est-ce que je dois faire ? »
3. « Pourquoi est-ce important pour moi ? »

Méthode pas à pas – Introduire les trois questions dans un atelier

1. Afficher les trois questions en gros, avec un pictogramme pour chacune.
2. Les présenter au début : « Vous avez le droit de nous poser ces questions à tout moment. »
3. En fin de séance, inviter chaque binôme à répondre aux trois questions pour lui-même.

4. Remettre une petite carte avec les trois questions à garder pour les rendez-vous médicaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.18

Vous appelez Mme R., 79 ans, pour lui rappeler l'atelier de jeudi. Rédigez votre message en découpant l'information, puis la question de « faire dire » que vous lui poserez à la fin de l'appel.

Corrigé

« Bonjour Madame R., c'est Julie, du CCAS. Je vous appelle pour l'atelier cuisine. [Pause] C'est jeudi, à 10 heures. [Pause] C'est à la salle des fêtes, à côté de la mairie. [Pause] Apportez une boîte pour emporter la soupe. » Question finale : « Pour être sûre de ne rien avoir oublié, vous pouvez me redire quel jour vous venez, à quelle heure, et ce que vous apportez ? » Si un élément manque, on le redit autrement (« jeudi, le jour du marché ») puis on vérifie à nouveau.

Ce que disent les études sur le « faire dire »

Le « faire dire » est recommandé par la HAS (2015) et par l'AHRQ. Les études qui l'ont évalué donnent des résultats encourageants, avec des limites qu'il faut connaître pour en parler honnêtement.

Étude	Ce qui a été observé	Limite
Schillinger et coll. (2003), patients diabétiques à littératie limitée	Les médecins vérifiaient rarement la compréhension de leurs patients ; quand ils le faisaient, l'équilibre du diabète des patients était meilleur	Étude d'observation : on ne peut pas affirmer que la vérification est la seule cause
Ha Dinh et coll. (2016), revue systématique chez des personnes avec une maladie chronique	Le « faire dire » améliore la compréhension, l'observance et l'autogestion dans de nombreuses études ; effets moins nets sur les hospitalisations	Études très différentes, souvent courtes et de qualité variable

À retenir – Ce que l'on peut dire au public et aux financeurs

Le « faire dire » est une méthode simple, peu coûteuse et sans effet indésirable connu, qui améliore la compréhension. Ses effets sur la santé à long terme sont moins bien démontrés. On le présente donc comme une bonne pratique de communication, et l'on évalue la compréhension dans ses propres actions.

Calcul détaillé – Mesurer l'effet du « faire dire » dans ses ateliers (données fictives)

Une diététicienne compare deux cycles d'ateliers sur les goûters des enfants. Dans le cycle 1, sans « faire dire », 11 parents sur 25 citent correctement deux goûters adaptés trois semaines plus tard. Dans le cycle 2, avec « faire dire » à chaque séance, 19 parents sur 27 les citent correctement.

- Cycle 1 : 11 / 25 × 100 = **44,0 %** ; cycle 2 : 19 / 27 × 100 = **70,4 %**.
- Différence : 70,4 − 44,0 = **26,4 points**.

Interprétation : le résultat est encourageant, mais les deux groupes ne sont pas les mêmes parents, les effectifs sont petits et d'autres changements ont pu jouer (animatrice plus expérimentée, nouvelle fiche). On parlera d'une amélioration observée, pas d'une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.19

Un financeur demande : « Le "faire dire" réduit-il les hospitalisations ? » Rédigez une réponse honnête en trois phrases.

Corrigé

« Les études montrent surtout que le "faire dire" améliore la compréhension et la capacité des personnes à appliquer les conseils. Ses effets sur les hospitalisations sont moins nets, car les études sont courtes et très différentes. Dans notre projet, nous mesurerons la compréhension des participants et l'application des conseils à la maison, ce qui est l'objectif de nos ateliers. »

5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Étape (chapitres 7 à 9)	Prise en compte de la littératie
Diagnostic	Recueillir la langue, la lecture, le numérique ; questionnaire oral ou imagé ; entretiens et groupes de parole
Objectifs	Inclure des objectifs de compétences (« savoir lire le Nutri-Score », « savoir cuisiner les lentilles »)
Conception des supports	Appliquer les règles d'écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant diffusion
Animation	Méthodes actives, démonstrations, faire dire, binômes
Communication	Plusieurs canaux (oral, affiches, bouche-à-oreille, relais) ; ne pas tout miser sur le numérique
Évaluation	Outils d'évaluation accessibles (smileys, gommettes, entretien oral) ; indicateurs de compréhension

Écrire des objectifs de littératie

Un projet qui prend en compte la littératie inclut des **objectifs de compétences**, formulés avec un verbe d'action et vérifiables à la fin d'une séance. La grille de Sørensen aide à les choisir : chaque compétence (accéder, comprendre, évaluer, appliquer) donne une famille de verbes.

Compétence	Verbes utiles	Exemple d'objectif opérationnel
Accéder	Trouver, repérer, demander, contacter	À la fin de la séance, chaque participant sait trouver sur une affiche du marché les fruits et légumes de saison les moins chers
Comprendre	Expliquer, reformuler, montrer, associer	À la fin de l'atelier, 8 participants sur 10 savent expliquer avec leurs mots ce que veut dire la lettre A du Nutri-Score
Évaluer	Comparer, choisir, juger, vérifier	À la fin du cycle, les participants savent comparer deux paquets de céréales et dire lequel contient moins de sucre
Appliquer	Préparer, cuisiner, composer, organiser	Trois semaines après l'atelier, la moitié des participants déclarent avoir cuisiné les lentilles au moins une fois

Attention – Un objectif de littératie n'est pas un objectif de connaissance

« Connaître les repères du PNNS » est difficile à vérifier et ne dit rien de ce que la personne saura faire. On préfère « savoir choisir », « savoir préparer », « savoir demander ». Le verbe « comprendre » seul est trop vague : on le remplace par ce que la personne fera pour montrer qu'elle a compris (« expliquer », « montrer »).

Exemple – De l'objectif général aux objectifs opérationnels

Objectif général : améliorer la littératie alimentaire des familles hébergées au centre. Objectif spécifique : d'ici six mois, les familles savent préparer au moins deux plats complets avec les produits du colis alimentaire. Objectifs opérationnels : organiser six ateliers de cuisine de 2 heures entre janvier et mars ; à chaque atelier, au moins 7 participants sur 10 réussissent le « faire dire » sur la recette du jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.20

Transformez ces trois intentions en objectifs de compétences vérifiables : a) « sensibiliser au sucre caché » ; b) « faire connaître l'épicerie solidaire » ; c) « informer sur les dates de consommation ».

Corrigé

a) À la fin de l'atelier, chaque participant sait poser à côté d'une boisson le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. b) À la fin de la réunion, les participants savent dire où se trouve l'épicerie solidaire, quand elle est ouverte et comment y accéder. c) À la fin de l'atelier, les participants savent trier cinq produits entre « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant » et dire ce qu'ils feront de chacun après la date.

Concevoir avec les personnes concernées

Un support conçu **avec** le public est mieux compris et mieux accepté qu'un support conçu **pour** lui. La participation peut prendre plusieurs formes, de la simple relecture à la co-création, et elle s'organise dès le début du projet (chapitre 7).

Forme de participation	Exemple	Ce qu'elle apporte
Relecture et test	Trois mamans relisent la fiche recette et soulignent les mots difficiles	Repère les mots et les images mal compris
Groupe de travail	Des habitants choisissent les recettes et les photos du livret	Supports proches des pratiques réelles
Co-animation	Une habitante relais montre sa recette en atelier	Confiance, valorisation, modèle proche
Comité d'usagers	Des usagers donnent leur avis sur l'affichage des menus d'une cuisine centrale	Amélioration durable de l'organisation

Calcul détaillé – Combien de personnes pour tester un support ?

Le spécialiste de l'ergonomie Jakob Nielsen (2000) a proposé un modèle simple pour les tests d'utilisabilité : si chaque testeur repère en moyenne 31 % des problèmes d'un support, la part des problèmes repérés par n testeurs vaut $1 - (1 - 0{,}31)^n$.

- 1 testeur : 1 − 0,69 = **31,0 %** des problèmes.
- 3 testeurs : 1 − 0,69 × 0,69 × 0,69 = 1 − 0,329 = **67,1 %**.
- 5 testeurs : $1 - 0{,}69^5 = 1 - 0{,}156$ = **84,4 %**.
- 8 testeurs : $1 - 0{,}69^8 = 1 - 0{,}051$ = **94,9 %**.

Interprétation : quelques testeurs bien choisis repèrent déjà la plupart des problèmes ; il vaut mieux faire deux petits tests successifs (cinq personnes, correction, puis cinq autres) qu'un seul grand test. Le chiffre de 31 % est une moyenne observée dans des tests de sites internet : c'est un ordre de grandeur, pas une loi.

Attention – Respecter les personnes qui participent

La participation demande du temps aux habitants. On les informe de l'usage de leur avis, on les remercie publiquement s'ils le souhaitent, on leur montre ce qui a changé grâce à eux et, quand c'est possible, on reconnaît leur travail (bon d'achat, repas partagé, indemnisation prévue dans le budget du projet). On veille aussi à ne pas toujours solliciter les mêmes personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.21

Vous avez fait tester une affiche par 3 personnes. Selon le modèle de Nielsen, quelle part des problèmes avez-vous probablement repérée ? Combien de testeurs supplémentaires proposez-vous, et pourquoi ?

Corrigé

Avec 3 testeurs : $1 - 0{,}69^3 = 1 - 0{,}329 = 67{,}1\ \%$ des problèmes environ. On peut corriger l'affiche, puis la faire tester par 2 à 5 nouvelles personnes : avec 5 testeurs au total, on repère environ 84 % des problèmes, et la seconde série vérifie aussi que les corrections sont comprises. On choisit des testeurs proches du public visé (langue, âge, lecture).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.6 et 5.3.7 – Vérifier et intégrer au projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq temps de la boucle du « faire dire ».
2. Qu'est-ce que la technique « découper et vérifier » ?
3. Dans quels cas préfère-t-on « faire faire » plutôt que « faire dire » ?
4. Citez les trois questions clés que l'on peut apprendre aux participants à poser.
5. Transformez « sensibiliser aux étiquettes » en objectif de compétence vérifiable.
6. Selon le modèle de Nielsen, quelle part des problèmes d'un support cinq testeurs repèrent-ils environ ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.6 et 5.3.7

1. Expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer autrement si besoin, confirmer.
2. Donner une information à la fois et vérifier qu'elle est comprise avant de passer à la suivante.
3. Pour les gestes techniques, les quantités et les prix (numératie), et avec un public allophone.
4. « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? », « Qu'est-ce que je dois faire ? », « Pourquoi est-ce important pour moi ? »
5. Par exemple : « À la fin de l'atelier, chaque participant sait comparer deux paquets de biscuits avec le Nutri-Score et dire lequel il choisirait. »
6. Environ 84 % ($1 - 0{,}69^5$).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des sections 5.3.6 et 5.3.7, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les deux sections et je refais les exercices d'application.

5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M3 S1 §2 (p. 29)

L'étiquetage des denrées est encadré par le **règlement (UE) n° 1169/2011** (dit « INCO ») : dénomination, liste des ingrédients, allergènes mis en évidence, quantité nette, dates, conditions de conservation, déclaration

nutritionnelle (énergie, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel, pour 100 g ou 100 mL). Le **Nutri-Score**, logo facultatif en France depuis 2017, complète cette information ; son algorithme a été révisé (aliments en 2022, boissons en 2023) et rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, avec deux ans de transition pour les produits déjà sur le marché.



Figure 5.7 – Lire une étiquette en 6 étapes

Comprendre le schéma – Figure 5.7

1. La dénomination dit ce qu'est réellement le produit ; « préparation à base de… », « saveur… » signalent souvent une faible part de l'ingrédient mis en avant sur l'emballage.

2. La liste d'ingrédients est classée par ordre **décroissant** de poids : le premier ingrédient est le plus abondant ; les **14 allergènes** réglementaires apparaissent en gras ou soulignés ; une longue liste avec additifs signale souvent un produit ultra-transformé (chapitre 4).

3. Le Nutri-Score (de A, vert foncé, à E, orange foncé) permet de **comparer** des produits d'une **même famille** (deux céréales, deux pizzas), pas une pizza et une pomme.

4. Le tableau nutritionnel donne les valeurs **pour 100 g** (pour comparer) et parfois **par portion** (pour savoir ce que l'on mange réellement) ; la portion indiquée par le fabricant est souvent plus petite que celle réellement consommée.

5. Les dates : DLC (« à consommer jusqu'au ») et DDM (« à consommer de préférence avant »), chapitre 4.

6. Le prix au kilo, affiché en rayon, permet de comparer des conditionnements différents.

Exemple – Calcul détaillé : du tableau nutritionnel aux morceaux de sucre

Une boisson aux fruits contient **9,8 g de sucres pour 100 mL** ; la bouteille fait **33 cL** ; on retient qu'un morceau de sucre pèse **environ 5 g**.

- Sucres dans la bouteille : 9,8 × 330 / 100 = 9,8 × 3,3 = **32,3 g**.
- En morceaux de sucre : 32,3 / 5 = **6,5 morceaux**.
- Repère : l'OMS recommande de limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique (idéalement moins de 5 %) ; pour un adulte à 2 000 kcal, 10 % = 200 kcal, soit 200 / 4 = **50 g** de sucres par jour. La bouteille en représente 32,3 / 50 × 100 = **64,6 %**.
- Pour un enfant de 8 ans à environ 1 700 kcal : 10 % = 170 kcal, soit 170 / 4 = **42,5 g** ; la bouteille en

représente 32,3 / 42,5 × 100 = **76 %**.

En atelier, on matérialise : 6 à 7 morceaux de sucre posés à côté de la bouteille ; l'image est mieux comprise que les grammes (littératie numérique et calculatoire).

Exemple – Calcul détaillé : comparer deux produits « pour 100 g » et « par portion »

Pour 100 g	Céréales A (Nutri-Score A)	Céréales B (Nutri-Score D)	Portion habituelle
Énergie	360 kcal	420 kcal	40 g
Sucres	4,5 g	26 g	
Fibres	10 g	3 g	
Prix au kilo	3,20 €	4,90 €	

- Sucres par portion : A : 4,5 × 40 / 100 = **1,8 g** ; B : 26 × 40 / 100 = **10,4 g**, soit plus de 2 morceaux de sucre (10,4 / 5 = 2,1).
- Fibres par portion : A : 10 × 0,4 = **4 g** ; B : 3 × 0,4 = **1,2 g**.
- Coût par portion : A : 0,040 × 3,20 = **0,13 €** ; B : 0,040 × 4,90 = **0,20 €**.

Conclusion : le produit le mieux classé au Nutri-Score est aussi le moins cher par portion ; le message « mieux et moins cher » est particulièrement mobilisateur pour des publics à budget contraint.

Les allégations nutritionnelles : ce que les mots veulent dire

Les mentions comme « riche en fibres » ou « allégé » attirent l'œil sur l'emballage. Elles sont encadrées par le **règlement (CE) n° 1924/2006** sur les allégations nutritionnelles et de santé : chaque mention correspond à un **seuil précis**. Les connaître permet d'expliquer au public ce qu'elles promettent vraiment, et ce qu'elles ne disent pas.

Allégation	Condition (annexe du règlement 1924/2006)
Faible teneur en sucres	5 g de sucres au plus pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour une boisson)
Sans sucres	0,5 g de sucres au plus pour 100 g ou 100 mL
Sans sucres ajoutés	Aucun sucre ni aliment sucrant ajouté ; si le produit contient des sucres naturellement présents, l'étiquette doit l'indiquer
Faible teneur en matières grasses	3 g au plus pour 100 g (1,5 g pour 100 mL)
Pauvre en sel	0,12 g de sodium au plus pour 100 g, soit environ 0,3 g de sel
Source de fibres	3 g de fibres au moins pour 100 g, ou 1,5 g pour 100 kcal
Riche en fibres	6 g au moins pour 100 g, ou 3 g pour 100 kcal
Source de protéines	Les protéines apportent au moins 12 % de l'énergie du produit
Riche en protéines	Au moins 20 % de l'énergie
Allégé, réduit en…	Au moins 30 % de moins qu'un produit similaire (25 % pour le sel)

Attention – Une allégation ne fait pas un aliment favorable

« Allégé en matières grasses » ne veut pas dire « peu calorique » ni « peu sucré » : un produit allégé en gras peut être riche en sucres. « Sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres » : une compote ou un jus contiennent les sucres des fruits. « Source de fibres » peut figurer sur des biscuits très sucrés. En atelier, on apprend à vérifier l'allégation avec le tableau nutritionnel et à comparer avec le Nutri-Score.

Calcul détaillé – Vérifier trois allégations (produits fictifs)

- Des biscuits affichent « source de fibres » : 4,5 g de fibres et 450 kcal pour 100 g. Le seuil de 3 g pour 100 g est atteint ; pour 100 kcal, ils apportent 4,5 / 450 × 100 = **1,0 g** de fibres, sous le seuil de 1,5 g ; il suffit qu'une des deux conditions soit remplie : l'allégation est **autorisée**, mais les biscuits contiennent aussi 28 g de sucres pour 100 g.
- Des céréales affichent « source de protéines » : 8 g de protéines et 380 kcal pour 100 g. Part de l'énergie : 8 × 4 / 380 × 100 = **8,4 %**, sous le seuil de 12 % : l'allégation serait **non conforme**.
- Un yaourt « allégé » contient 1,6 g de lipides pour 100 g, contre 3,2 g pour le yaourt de référence : baisse de (3,2 − 1,6) / 3,2 × 100 = **50 %** : conforme. Mais il contient 9,5 g de sucres pour 100 g contre 12,5 g pour un yaourt aromatisé classique : la baisse des sucres, (12,5 − 9,5) / 12,5 × 100 = **24 %**, ne suffirait pas pour écrire « réduit en sucres ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.22

Une boisson affiche « faible teneur en sucres » et contient 4 g de sucres pour 100 mL. Un pain de mie affiche « riche en fibres » et contient 5 g de fibres et 250 kcal pour 100 g. Dites si chaque allégation est conforme.

Corrigé

Boisson : le seuil pour un liquide est de 2,5 g pour 100 mL ; avec 4 g, l'allégation n'est pas conforme. Pain de mie : 5 g pour 100 g est sous le seuil de 6 g, mais pour 100 kcal il apporte 5 / 250 × 100 = 2,0 g, sous le seuil de 3 g : l'allégation « riche en fibres » n'est pas conforme ; « source de fibres » le serait (5 g pour 100 g, au-dessus de 3 g).

Les apports de référence de l'étiquette : un repère à expliquer

Beaucoup d'emballages indiquent, à côté du tableau nutritionnel, un pourcentage des **apports de référence** (AR) par portion. Ces valeurs sont fixées par le règlement INCO (annexe XIII) pour un adulte moyen : ce ne sont pas des besoins personnels, mais des repères communs pour comparer.

Élément	Apport de référence (adulte, règlement INCO)
Énergie	8 400 kJ, soit 2 000 kcal
Matières grasses	70 g
Acides gras saturés	20 g
Glucides	260 g
Sucres	90 g
Protéines	50 g
Sel	6 g

Attention – Deux repères de sucres différents

L'AR des **sucres** de l'étiquette (90 g) porte sur **tous** les sucres, y compris ceux du lait et des fruits. Le repère de l'OMS (moins de 10 % de l'énergie, soit environ 50 g pour 2 000 kcal) ne porte que sur les **sucres libres** (ajoutés, miel, sirops, jus). Un pourcentage d'AR faible pour les sucres peut donc rassurer à tort. En atelier, on préfère traduire les sucres en morceaux.

Calcul détaillé – Une demi-pizza en pourcentage des apports de référence (produit fictif)

Pour 100 g : 245 kcal ; lipides 9,5 g ; acides gras saturés 4,2 g ; glucides 29 g ; sucres 3,6 g ; protéines 10,5 g ;

sel 1,3 g. La portion indiquée est une demi-pizza de 200 g.

- Énergie : 245 × 2 = 490 kcal, soit 490 / 2 000 × 100 = **24,5 %** de l'AR.
- Acides gras saturés : 8,4 g, soit 8,4 / 20 × 100 = **42,0 %**.
- Sel : 2,6 g, soit 2,6 / 6 × 100 = **43,3 %**.
- Sucres : 7,2 g, soit **8,0 %** de l'AR.

Interprétation : la demi-pizza apporte un quart de l'énergie de référence de la journée, mais près de la moitié du sel et des graisses saturées. On conseille de l'accompagner d'une grande salade et d'un fruit, et de limiter les autres aliments salés ce jour-là.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.23

Un paquet de chips indique pour une portion de 30 g : 160 kcal et 0,45 g de sel. Calculez le pourcentage des AR pour l'énergie et pour le sel. Que se passe-t-il si une personne mange le sachet entier de 150 g ?

Corrigé

Portion : énergie 160 / 2 000 × 100 = 8,0 % ; sel 0,45 / 6 × 100 = 7,5 %. Le sachet de 150 g contient 150 / 30 = 5 portions : 5 × 160 = 800 kcal, soit 40,0 % de l'AR, et 5 × 0,45 = 2,25 g de sel, soit 37,5 % de l'AR. La portion indiquée est petite : les pourcentages par portion peuvent sous-estimer ce qui est réellement mangé.

Comment le Nutri-Score est-il calculé ?

Le Nutri-Score a été proposé par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de Serge Hercberg et adopté en France par un arrêté du 31 octobre 2017, comme logo facultatif. Il est aussi utilisé en Belgique, en Espagne, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. Son calcul se fait en trois temps, pour 100 g ou 100 mL de produit.

Méthode pas à pas – Le principe du calcul (sans les tableaux de points)

1. Points défavorables : on attribue des points selon la teneur en énergie, en sucres, en acides gras saturés et en sel ; plus il y en a, plus il y a de points.

2. Points favorables : on attribue des points selon la teneur en fibres, en protéines et la part de fruits, légumes et légumineuses.

3. Score final : points défavorables moins points favorables ; le score est ensuite converti en une lettre de A à E, avec des seuils différents pour les aliments solides, les boissons et les matières grasses.

Ce qui a changé avec l'algorithme révisé (aliments 2022, boissons 2023)	Conséquence pour le consommateur
Les sucres et le sel sont pénalisés plus fortement	Des céréales sucrées et des produits salés perdent une lettre
Les céréales complètes sont mieux distinguées des céréales raffinées	Le pain et les pâtes complets sont mieux classés
Les huiles d'olive, de colza et de noix sont mieux classées	Elles peuvent obtenir la lettre B
La viande rouge est moins bien classée que la volaille et le poisson	Les plats à base de viande rouge baissent
Les boissons : l'eau est la référence, les boissons avec édulcorants sont pénalisées, les boissons lactées sucrées sont classées avec les boissons	Les boissons sucrées ou édulcorées sont moins bien classées qu'avant ; seule l'eau obtient la lettre A

Exemple – Expliquer un « changement de lettre » au public

Une participante s'étonne : « Mes céréales étaient B, maintenant elles sont D. Elles ont changé ? » Réponse simple : « La recette n'a peut-être pas changé. C'est la règle de calcul qui a changé : elle compte plus le sucre. Vos céréales contiennent beaucoup de sucre, c'est pour ça qu'elles ont perdu des lettres. Comparez-les avec un autre paquet de céréales du même rayon. »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.24

Expliquez en deux phrases simples, pour un atelier, pourquoi on ne peut pas comparer le Nutri-Score d'un soda et celui d'un fromage.

Corrigé

« Le Nutri-Score compare des produits qui se ressemblent : deux fromages entre eux, ou deux boissons entre elles. Un fromage et un soda ne servent pas à la même chose et ne sont pas calculés de la même façon. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.8 – Lire une étiquette

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel ordre sont classés les ingrédients d'une liste ? Comment repère-t-on les allergènes ?
2. Quelle différence y a-t-il entre DLC et DDM ?
3. Quel est le seuil de l'allégation « faible teneur en sucres » pour un aliment solide ?
4. Un produit de 400 kcal pour 100 g contient 10 g de protéines. Peut-il afficher « source de protéines » ?
5. Pourquoi l'apport de référence des sucres de l'étiquette (90 g) ne se compare-t-il pas au repère de l'OMS ?
6. Citez les deux familles de composants qui entrent dans le calcul du Nutri-Score.

Corrigé – Point d'étape 5.3.8

1. Par ordre décroissant de poids ; les 14 allergènes réglementaires sont mis en évidence (gras, souligné).
2. DLC (« à consommer jusqu'au ») : ne pas dépasser ; DDM (« de préférence avant ») : le produit reste consommable après la date s'il est bien conservé.
3. 5 g de sucres au plus pour 100 g.
4. 10 × 4 / 400 × 100 = 10 % de l'énergie, sous le seuil de 12 % : non.
5. L'AR porte sur tous les sucres ; le repère de l'OMS porte sur les sucres libres (environ 50 g pour 2 000 kcal).
6. Les composants défavorables (énergie, sucres, acides gras saturés, sel) et favorables (fibres, protéines, fruits, légumes et légumineuses).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs d'allégations et je relis le tableau des apports de référence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.8 et je refais les exercices d'application.

5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

La **numératie** (*numeracy*) est la capacité à comprendre et utiliser des nombres, des pourcentages, des proportions et des probabilités dans la vie courante. Une part importante de la population a des difficultés avec

les pourcentages et les risques ; or les messages de santé sont pleins de chiffres (« 5 par jour », « 30 minutes », « – 30 % de risque », « 25 g de fibres »).

Présenter un risque de façon compréhensible

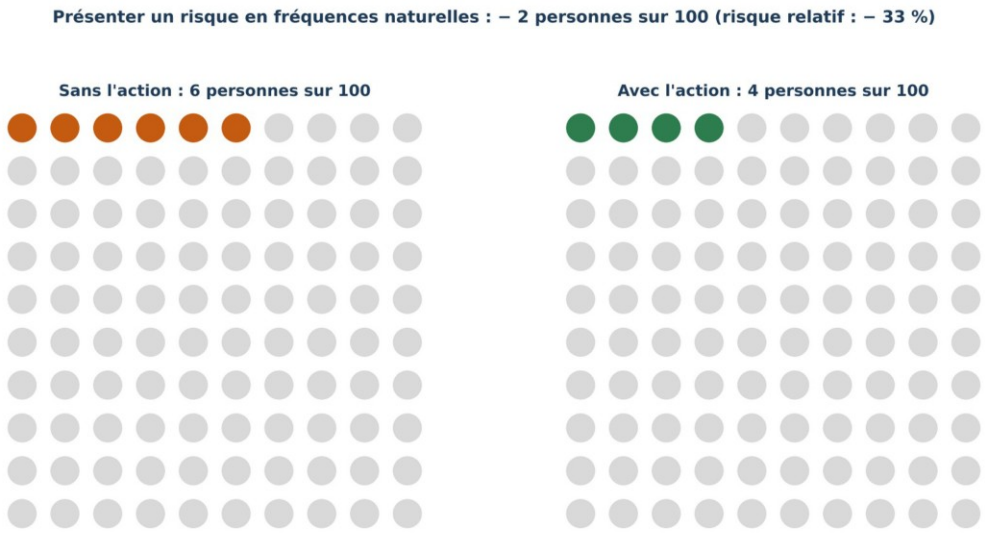


Figure 5.8 – Un risque présenté en fréquences naturelles

Comprendre le schéma – Figure 5.8

1. Les **fréquences naturelles** (« 6 personnes sur 100 ») sont mieux comprises que les pourcentages ou les probabilités (« 0,06 ») (Gigerenzer).
2. Les **tableaux d'icônes** (100 pictogrammes dont certains colorés) rendent visible l'ampleur réelle d'un risque.
3. Passer de 6 à 4 personnes sur 100 correspond à une **réduction absolue** de **2 personnes sur 100** (2 points) mais à une **réduction relative** de (6 − 4) / 6 × 100 = **33 %**.
4. Présenter seulement la réduction relative (« − 33 % ! ») **exagère** l'effet perçu ; la présentation honnête donne les deux, en fréquences naturelles (chapitre 2 : risque relatif et différence de risques).

À éviter	À préférer	Pourquoi
« Réduit le risque de 50 % »	« Le risque passe de 2 sur 100 à 1 sur 100 »	Le relatif seul exagère
« 0,3 % de la population »	« 3 personnes sur 1 000 »	Les petites proportions sont difficiles à se représenter
« 25 g de fibres par jour »	« Du pain complet, des légumes à chaque repas, des légumes secs 2 fois par semaine »	Les grammes de nutriments ne se voient pas dans l'assiette
« 400 g de fruits et légumes »	« 5 portions : une portion = un poing ou deux cuillères à soupe pleines »	Mesure concrète
« 10 % de l'apport énergétique »	« Pas plus d'un verre de jus par jour »	Traduire en aliments

À vous de jouer – Exercice d'application 5.25

Une publicité affirme : « Notre yaourt réduit de 40 % le risque de troubles digestifs ! » L'étude citée montre 5 personnes sur 100 avec troubles dans le groupe témoin et 3 sur 100 dans le groupe yaourt. Calculez les réductions absolue et relative et rédigez une phrase honnête.

Corrigé

Réduction absolue : 5 − 3 = **2 personnes sur 100** (2 points). Réduction relative : 2 / 5 × 100 = **40 %**. Phrase honnête : « Sur 100 personnes, 3 ont eu des troubles digestifs avec ce yaourt au lieu de 5 sans : 2 personnes sur 100 en ont été protégées. » Il faudrait aussi vérifier la qualité de l'étude, sa durée et qui l'a financée (chapitre 6).

Les pièges de calcul les plus fréquents, et comment les éviter

Les messages de nutrition contiennent beaucoup de chiffres. Certaines erreurs reviennent souvent, chez le public mais aussi chez les professionnels. Les connaître permet de les prévenir dans les supports et de les travailler en atelier.

Piège	Exemple	Ce qu'il faut savoir ou dire
Kilojoules et kilocalories	L'étiquette affiche « 1 674 kJ / 400 kcal » ; une personne retient 1 674	1 kcal = 4,184 kJ ; en atelier, on n'utilise que les kcal, ou mieux, des repères en aliments
Centilitres et millilitres	Une canette de 33 cL est lue « 33 mL »	33 cL = 330 mL ; on montre la canette réelle
Pour 100 g et par portion	On compare les sucres pour 100 g d'un produit et par portion d'un autre	On compare toujours sur la même base, de préférence pour 100 g
Pourcentage et points	« Le risque passe de 10 % à 8 % : il baisse de 2 % »	Il baisse de 2 **points** ; la baisse relative est de 20 %
« Deux fois moins »	« Deux fois moins sucré » compris comme « sans sucre »	Deux fois moins = divisé par 2 ; il reste la moitié du sucre
« Jusqu'à 30 % de moins »	La publicité annonce le chiffre maximal	« Jusqu'à » veut dire que certains produits baissent moins, voire pas du tout
Moyenne	« En moyenne, les élèves de la classe mangent 3 fruits par semaine » compris comme « chaque élève »	Une moyenne cache des personnes très au-dessus et très en dessous

Calcul détaillé – Trois conversions utiles en atelier

- Énergie : un plat affiche 2 100 kJ pour une portion ; 2 100 / 4,184 = **502 kcal**, environ un quart des 2 000 kcal de référence.
- Volume : une bouteille de boisson de 1,5 L contient 1 500 mL ; avec 8 g de sucres pour 100 mL, elle contient 8 × 15 = **120 g** de sucres, soit **24 morceaux** de 5 g.
- Points et pourcentage : la part d'enfants qui prennent un petit-déjeuner passe de 70 % à 84 % ; c'est une hausse de **14 points**, soit une hausse relative de 14 / 70 × 100 = **20 %**.

Méthode pas à pas – Présenter un chiffre dans un support grand public

1. Se demander si le chiffre est indispensable ; sinon, le remplacer par un repère concret.

2. Préférer les nombres entiers et arrondis (« environ 6 morceaux de sucre »).

3. Donner une seule unité, connue du public.

4. Comparer à quelque chose de familier (« autant de sucre que dans 3 yaourts aromatisés »).

5. Tester la compréhension du chiffre avec quelques personnes, comme pour le reste du support.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.26

Un article annonce : « La part des adolescents qui boivent des sodas chaque jour est passée de 25 % à 20 %, soit une baisse de 5 %. » Corrigez la phrase et calculez la baisse relative.

Corrigé

La baisse est de 5 points (25 − 20), et non de 5 %. La baisse relative vaut 5 / 25 × 100 = 20 %. Phrase corrigée : « La part des adolescents qui boivent des sodas chaque jour est passée de 25 % à 20 % : c'est 5 points de moins, soit une baisse d'un cinquième. » Pour le grand public : « Avant, 1 adolescent sur 4 buvait des sodas chaque jour ; maintenant, c'est 1 sur 5. »

Mesures ménagères : passer des grammes aux gestes

Un conseil en grammes est difficile à appliquer sans balance. En atelier comme sur les fiches recettes, on traduit les quantités en **mesures ménagères** : cuillère, verre, bol, poignée, main. Les correspondances varient selon l'ustensile, le remplissage et l'aliment ; il faut donc les construire avec les ustensiles réellement utilisés par le public.

Mesure ménagère	Volume approximatif	Repères de poids (approximatifs, à vérifier)
Cuillère à café rase	5 mL	Sucre : environ 5 g ; sel : environ 5 g
Cuillère à soupe rase	15 mL	Huile : environ 10 à 14 g selon le remplissage ; sucre : environ 12 à 15 g
Verre (type verre à eau)	150 à 200 mL	Riz ou lentilles crus : environ 150 à 180 g pour un verre plein
Bol	300 à 350 mL	Soupe : un bol plein
Poing fermé	—	Repère d'une portion de fruits ou de légumes (environ 80 à 100 g)
Paume de la main sans les doigts	—	Repère d'une portion de viande ou de poisson

Méthode pas à pas – Construire sa propre table de correspondance

1. Choisir l'ustensile du public (le verre de la cuisine du centre social, le bol des familles).

2. Remplir l'ustensile trois fois avec l'aliment et peser à chaque fois.

3. Calculer la moyenne et l'arrondir.

4. Écrire la correspondance sur la fiche recette, avec la photo de l'ustensile.

Calcul détaillé – Un verre de riz au centre social (données fictives)

Trois pesées d'un verre de riz cru rempli à ras bord : 162 g, 170 g et 166 g.

- Moyenne : (162 + 170 + 166) / 3 = 498 / 3 = **166 g**.
- Pour une recette qui demande 60 g de riz cru par personne, il faut 60 / 166 = **0,36 verre**, soit **un tiers de verre** environ par personne, ou **un verre pour 3 personnes**.

Sur la fiche : « Riz : 1 verre pour 3 personnes » avec la photo du verre. La consigne est plus facile à suivre que « 180 g de riz pour 3 personnes ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.27

Une recette pour 4 personnes demande 240 g de lentilles corail crues. Au centre social, un verre de lentilles corail pèse en moyenne 180 g. Combien de verres faut-il ? Proposez la formulation pour la fiche.

Corrigé

240 / 180 = 1,33 verre, soit environ un verre et un tiers. Formulation : « Lentilles corail : 1 verre plein et un tiers de verre » avec la photo du verre, ou plus simple : « 1 verre et demi pas tout à fait plein ». On vérifie la formulation en faisant mesurer un participant pendant l'atelier.

Construire un graphique ou un tableau d'icônes que tout le monde comprend

Un graphique peut aider à comprendre, ou au contraire tromper. Quelques règles simples rendent les graphiques plus honnêtes et plus lisibles, que ce soit dans un dossier de projet, un diaporama ou une affiche.

Règle	Pourquoi
Un axe des barres qui commence à zéro	Un axe tronqué grossit les différences
Un seul message par graphique, écrit dans le titre	Le lecteur sait ce qu'il doit voir
Pas d'effet 3D, pas de camembert à plus de 4 parts	Les angles et les volumes sont mal estimés
Les mêmes dénominateurs (« sur 100 », « sur 1 000 ») pour comparer	Comparer 2 sur 100 et 1 sur 50 demande un calcul
Les étiquettes directement sur les barres	Le lecteur ne fait pas d'aller-retour avec une légende
Des couleurs distinctes aussi en noir et blanc	Les personnes daltoniennes et les photocopies

Calcul détaillé – L'effet d'un axe tronqué

Deux quartiers : 42 % et 46 % des enfants prennent un petit-déjeuner chaque jour. La différence réelle est de 4 points, soit (46 − 42) / 42 × 100 = **9,5 %** de plus.

- Axe qui commence à 0 : les barres mesurent 42 et 46 unités ; la seconde est à peine plus haute.
- Axe qui commence à 40 : les barres mesurent 42 − 40 = 2 et 46 − 40 = 6 unités ; la seconde paraît **3 fois** plus haute.

Leçon : on vérifie toujours le début de l'axe avant d'interpréter un graphique, et l'on commence à zéro dans ses propres supports.

Méthode pas à pas – Construire un tableau d'icônes

1. Choisir le dénominateur : 100 icônes pour des risques de quelques pour cent, 1 000 pour des risques plus rares.

2. Ranger les icônes en lignes de 10, et colorer les personnes concernées en bloc, en commençant en haut à gauche.

3. Faire deux tableaux côte à côte (sans action, avec action) avec la même disposition.

4. Écrire sous chaque tableau la phrase en fréquences naturelles (« 6 personnes sur 100 »).

5. Tester la compréhension : « Dans quel groupe y a-t-il le moins de malades ? De combien ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.28

Un diaporama compare la part d'enfants en surpoids dans deux écoles : 18 % et 21 %. L'axe vertical va de 15 à 22 %. Expliquez ce que le lecteur risque de croire et proposez une correction.

Corrigé

Avec un axe qui commence à 15, les barres mesurent 3 et 6 unités : le lecteur croit que le surpoids est deux

fois plus fréquent dans la seconde école, alors que la différence réelle est de 3 points (environ 17 % de plus). Correction : faire commencer l'axe à 0, écrire les valeurs sur les barres, et présenter la différence en fréquences naturelles (« 18 enfants sur 100 contre 21 sur 100 »).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.9 – La numératie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce que la numératie ?
2. Un risque passe de 12 sur 100 à 9 sur 100. Donnez la réduction absolue et la réduction relative.
3. Convertissez 1 255 kJ en kcal.
4. Une part passe de 30 % à 36 %. Est-ce une hausse de 6 % ? Justifiez.
5. Comment construire sa propre correspondance entre un verre et un poids d'aliment ?
6. Pourquoi l'axe d'un graphique en barres doit-il commencer à zéro ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.9

1. La capacité à comprendre et utiliser des nombres, des pourcentages, des proportions et des probabilités dans la vie courante.
2. Absolue : 3 personnes sur 100 ; relative : 3 / 12 × 100 = 25 %.
3. 1 255 / 4,184 = 300 kcal environ.
4. Non : c'est une hausse de 6 points ; la hausse relative est de 6 / 30 × 100 = 20 %.
5. Remplir trois fois l'ustensile du public, peser, faire la moyenne, l'écrire sur la fiche avec la photo de l'ustensile.
6. Parce qu'un axe tronqué grossit visuellement les différences.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs de la section et je relis le tableau des pièges.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.9 et je refais les exercices d'application.

5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 24-25 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Applications et sites : aider à choisir et à utiliser

Les applications de scan des produits, les sites officiels (*mangerbouger.fr*, *Mon espace santé*), les réseaux sociaux et les outils d'intelligence artificielle font désormais partie de l'environnement alimentaire. Le diététicien peut aider le public à les **utiliser** et à les **évaluer**.

Critère d'évaluation d'une application ou d'un site	Questions
Éditeur et financement	Qui édite l'outil ? Est-il financé par la publicité, par des marques, par un organisme public ?
Fondement scientifique	Sur quoi reposent les notes ou les conseils (Nutri-Score officiel, algorithme propre, avis d'experts) ?
Mise à jour	Les données sont-elles récentes ? Les repères suivis sont-ils ceux en vigueur ?
Protection des données	Quelles données sont collectées ? Consentement, revente, localisation (RGPD, chapitre 6) ?

Critère d'évaluation d'une application ou d'un site	Questions
Accessibilité	Lisible, simple, utilisable par des personnes âgées ou malvoyantes, disponible en plusieurs langues ?
Effets indésirables	Culpabilisation, obsession du comptage (calories, notes), restriction ?

Rendre un support numérique accessible

Les sites des organismes publics doivent respecter le **référentiel général d'amélioration de l'accessibilité** (RGAA), fondé sur les normes internationales **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*). Pour un support numérique de projet (page de présentation, vidéo, publication), quelques règles suffisent à améliorer nettement l'accessibilité : contraste suffisant, taille de texte modifiable, **texte alternatif** décrivant les images, vidéos **sous-titrées**, liens explicites (« Télécharger le livret de recettes » plutôt que « cliquez ici »), navigation simple.

Exemple – Calcul détaillé : un mini-audit d'accessibilité d'une page de projet

Une page de présentation d'ateliers est vérifiée avec 12 critères simples (contraste, titres structurés, texte alternatif des 4 images, sous-titres de la vidéo, liens explicites, langue déclarée, taille de police, formulaire accessible, absence d'information uniquement par la couleur, version imprimable, contact téléphonique, FALC).

- Critères respectés : 7 sur 12, soit 7 / 12 × 100 = **58,3 %**.
- Corrections prioritaires (rapides) : textes alternatifs des images, sous-titres de la vidéo, contact téléphonique visible : 3 critères de plus, soit 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.

Leçon : une grande partie de l'accessibilité repose sur des gestes simples, à intégrer dès la conception.

Couleurs et contrastes : un calcul simple pour un support lisible

Le contraste entre le texte et le fond est l'un des critères d'accessibilité les plus importants, pour les personnes malvoyantes mais aussi pour tous ceux qui lisent sur un téléphone en plein soleil ou sur une photocopie. Les règles internationales WCAG, reprises par le RGAA, le mesurent par un **ratio de contraste**.

Méthode pas à pas – Calculer un ratio de contraste

1. Trouver la **luminance relative** de chaque couleur (de 0 pour le noir à 1 pour le blanc) avec un outil de vérification du contraste ou un tableau fourni.

2. Ratio = (luminance la plus claire + 0,05) / (luminance la plus foncée + 0,05). Il va de 1 (aucun contraste) à 21 (noir sur blanc).

3. Comparer aux seuils : **4,5** au moins pour un texte courant et **3** pour un grand texte (niveau AA) ; **7** et **4,5** pour le niveau renforcé (AAA).

Calcul détaillé – Quatre couleurs pour une affiche d'atelier

Luminances relatives (calculées selon les WCAG) : blanc 1,0000 ; vert foncé (#2E7D32) 0,1548 ; jaune vif (#FFD600) 0,6935 ; rouge (#D32F2F) 0,1609 ; noir 0,0000.

- Texte vert foncé sur blanc : 1,05 / (0,1548 + 0,05) = 1,05 / 0,2048 = **5,13** : conforme pour un texte courant.
- Texte jaune sur blanc : 1,05 / (0,6935 + 0,05) = 1,05 / 0,7435 = **1,41** : illisible.
- Texte blanc sur fond rouge : 1,05 / (0,1609 + 0,05) = 1,05 / 0,2109 = **4,98** : conforme, de justesse.
- Texte noir sur fond jaune : (0,6935 + 0,05) / (0 + 0,05) = **14,87** : très bon contraste, utile pour un bandeau d'alerte.

Attention – Ne jamais donner une information par la couleur seule

Environ 8 % des hommes et 0,5 % des femmes d'origine européenne ont une forme de daltonisme, le plus souvent une difficulté à distinguer le rouge et le vert. Un code « vert = conseillé, rouge = à limiter » n'est pas compris par ces personnes. On double toujours la couleur par un mot, une forme ou un pictogramme (pouce levé, sablier), comme le fait le Nutri-Score avec ses lettres.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.29

Un menu de cantine indique les plats végétariens en vert clair sur fond blanc, avec un ratio de contraste de 1,9. Dites ce qui ne va pas et proposez deux corrections.

Corrigé

Le ratio de 1,9 est très inférieur au seuil de 4,5 : le texte est difficile à lire, en particulier pour les personnes malvoyantes. De plus, l'information est donnée seulement par la couleur, ce qui exclut les personnes daltoniennes. Corrections : écrire le texte en noir ou en vert très foncé (par exemple #1B5E20, ratio de 7,87 sur blanc) ; ajouter un pictogramme « feuille » et le mot « végétarien » à côté des plats concernés.

Aider un groupe face aux fausses informations sur l'alimentation

Les réseaux sociaux diffusent chaque jour des conseils alimentaires faux ou exagérés : « détox », régimes miracles, peur des conserves ou du pain. Pendant la pandémie de Covid-19, l'OMS a parlé d'**infodémie** (2020) pour désigner cette surabondance d'informations, vraies et fausses, qui rend difficile de trouver des sources fiables. La littératie critique aide à y faire face. Le professionnel a deux rôles : répondre aux idées fausses sans les renforcer, et entraîner le public à juger lui-même une information (grille des 6 questions, 5.4.1).

Méthode pas à pas – Répondre à une idée fausse : le « sandwich de vérité »

1. Commencer par le fait juste, en une phrase simple : « Les légumes en conserve gardent l'essentiel de leurs fibres et de leurs minéraux. »

2. Nommer l'idée fausse une seule fois, en disant qu'elle est fausse : « On lit parfois que les conserves sont "du poison" : c'est faux. »

3. Expliquer pourquoi elle circule : « Cette idée vient souvent de la peur des produits industriels, ou de vidéos qui vendent autre chose. »

4. Redire le fait juste et donner une action : « Les conserves de légumes et de légumes secs sont pratiques et pas chères. Rincez-les pour enlever une partie du sel. »

À retenir – Ce qui aide, ce qui ne marche pas

Ce qui aide : partir des questions du groupe, rester respectueux, montrer comment on vérifie une source, donner une alternative concrète. Ce qui ne marche pas : se moquer, accumuler les chiffres, répéter l'idée fausse dans le titre d'une affiche (« Les conserves, un poison ? ») : on risque de la rendre plus familière et donc plus crédible.

Exemple – Un atelier « vrai ou faux » avec des collégiens

L'animatrice projette trois publications réelles et anonymisées : une recette « détox » au citron, une vidéo qui dit que le pain fait grossir, et une publication de mangerbouger.fr. Par groupes, les élèves répondent aux questions : qui parle ? que veut-il ? sur quoi s'appuie-t-il ? que disent les sources officielles ? Chaque groupe présente sa conclusion. L'animatrice termine par un « sandwich de vérité » sur le pain.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.30

Une participante dit : « J'ai vu sur internet que les jus détox nettoient le foie. » Rédigez votre réponse en suivant les quatre étapes du sandwich de vérité.

Corrigé

1. « Le foie et les reins éliminent eux-mêmes les déchets du corps, chaque jour. » 2. « On lit souvent que des jus "détox" nettoient le foie : ce n'est pas démontré. » 3. « Ces messages circulent beaucoup parce qu'ils promettent un résultat rapide, et souvent pour vendre des produits. » 4. « Pour aider votre corps, buvez de l'eau et mangez des fruits et des légumes entiers : ils apportent aussi des fibres. »

Accompagner vers le numérique sans exclure

La dématérialisation touche aussi l'alimentation et la santé : inscription aux ateliers, prise de rendez-vous, Mon espace santé (ouvert à tous les assurés en 2022), aides sociales en ligne. Pour les personnes éloignées du numérique, plusieurs dispositifs publics existent. Le diététicien peut s'appuyer sur eux comme **partenaires** d'un projet.

Dispositif	Ce qu'il propose	Intérêt pour un projet en nutrition
Espaces France Services	Accueil de proximité pour les démarches administratives, avec un accompagnement au numérique	Aide à l'inscription en ligne, aux démarches CAF et cantine
Conseillers numériques (dispositif lancé en 2021)	Ateliers d'initiation et accompagnement individuel au numérique, dans les mairies, médiathèques, associations	Ateliers « mon téléphone pour cuisiner » : vidéos de recettes, applications utiles
Aidants Connect	Permet à un professionnel habilité (travailleur social, agent France Services) de faire une démarche en ligne pour le compte d'une personne, de façon sécurisée et avec son accord	Évite que la personne donne ses identifiants à un tiers
Médiathèques, associations d'éducation populaire	Accès libre à des ordinateurs, ateliers	Lieux relais pour diffuser un programme

Méthode pas à pas – Proposer un support numérique dans un projet, sans exclure

1. Toujours prévoir un canal non numérique équivalent (papier, téléphone, accueil).

2. Choisir des formats peu exigeants : message vocal, vidéo courte sous-titrée, photo.

3. Montrer en atelier comment accéder au support (scanner un code, ouvrir une vidéo).

4. Ne jamais demander de créer un compte ou de donner une adresse mail pour participer.

5. Évaluer l'usage réel du support numérique (nombre de vues, avis des participants).

Attention – Les identifiants des personnes

Il arrive qu'un professionnel ou un bénévole remplisse une démarche en ligne avec les identifiants d'une personne. C'est risqué pour la personne et pour le professionnel (accès à des données personnelles, responsabilité). On oriente vers un dispositif prévu pour cela, comme Aidants Connect, ou l'on accompagne la personne pour qu'elle fasse elle-même la démarche.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.31

Un CCAS veut remplacer les inscriptions papier aux ateliers par un formulaire en ligne. Proposez trois conditions pour que ce changement n'exclue personne.

Corrigé

Garder une inscription par téléphone et à l'accueil ; proposer un accompagnement pour remplir le formulaire (agent d'accueil, conseiller numérique, France Services) ; rendre le formulaire court et accessible (peu de champs, pas de compte à créer, texte lisible, contact visible). On suit ensuite la part des inscriptions faites par chaque canal pour vérifier que les publics habituels continuent de s'inscrire.

5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Une personne **allophone** est une personne dont la langue maternelle n'est pas la langue du pays où elle vit. Dans de nombreux quartiers, une part importante des familles maîtrise peu le français, au moins à l'écrit.

Ressource	Usage
Interprétariat professionnel (sur place ou par téléphone)	Échanges importants ou sensibles (santé, allergies) ; neutralité et confidentialité garanties ; référentiel de la HAS (2017)
Médiateurs en santé, habitants relais	Lien de confiance, compréhension des codes culturels ; ne remplacent pas un interprète pour une consultation
Supports multilingues testés	Fiches traduites par des professionnels et relues par des locuteurs ; préférer les ressources validées (Santé publique France, associations spécialisées)
Pictogrammes et photos	Recettes en images, gestes d'hygiène, allergènes ; vérifier qu'ils sont compris (certains symboles sont culturels)
Démonstration	Montrer avant d'expliquer ; faire faire
Cours de français à visée sociale	Partenariat avec les associations d'apprentissage du français : les ateliers culinaires peuvent être support d'apprentissage de la langue

Attention – Les enfants interprètes

Faire traduire des informations de santé par un enfant est à éviter : cela inverse les rôles familiaux, expose l'enfant à des informations qui ne le concernent pas et produit des erreurs de traduction. On recherche un interprète professionnel ou un adulte relais.

Travailler avec un interprète : avant, pendant, après

L'interprétariat professionnel fait l'objet d'un référentiel de la HAS (2017). Il peut se faire sur place ou par téléphone, ce qui le rend accessible même pour un atelier ou un entretien court. Un interprète professionnel traduit fidèlement, reste neutre et respecte le secret. Pour que l'échange se passe bien, le professionnel a lui aussi un rôle à jouer.

Moment	Ce que fait le professionnel
Avant	Réserver l'interprète à l'avance et vérifier la langue (et la variante régionale) ; présenter brièvement l'objectif de l'entretien ou de l'atelier et les mots techniques qui seront utilisés ; prévoir plus de temps (environ le double)

Moment	Ce que fait le professionnel
Au début	Présenter l'interprète et son rôle à la personne ; rappeler que tout sera traduit et que tout restera confidentiel
Pendant	Regarder et s'adresser à la **personne**, pas à l'interprète ; parler à la première personne (« Je vous conseille… ») ; faire des phrases courtes et s'arrêter souvent ; éviter les expressions imagées et l'humour difficile à traduire ; vérifier la compréhension avec le « faire dire »
Après	Faire un court bilan avec l'interprète (difficultés de traduction, malentendus culturels possibles) ; noter les mots qui ont posé problème pour les prochaines fois

Exemple – Une phrase difficile à traduire

La diététicienne dit : « Il faut y aller mollo sur le gras et ne pas avoir la main lourde sur le sel. » L'interprète doit d'abord deviner le sens de deux expressions familières avant de les traduire. Reformulation : « Mettez moins d'huile dans la poêle : une cuillère suffit. Mettez moins de sel : goûtez avant de saler. » Les deux phrases sont courtes, concrètes et se traduisent sans perte.

Attention – Médiateur, interprète, accompagnant : trois rôles différents

L'**interprète** traduit fidèlement et reste neutre. Le **médiateur en santé** crée le lien de confiance, explique les codes et accompagne vers les droits et les soins ; il peut traduire de façon informelle, mais ce n'est pas son rôle principal. Le **proche accompagnant** connaît la personne mais peut filtrer ou déformer l'information, volontairement ou non. Pour une information médicale importante (allergie, traitement, régime prescrit), on fait appel à un interprète professionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.32

Pendant un entretien avec interprète, une diététicienne dit à l'interprète : « Demandez-lui ce qu'elle mange le matin. » Relevez l'erreur, réécrivez la phrase, et citez deux autres règles à respecter pendant l'échange.

Corrigé

Elle parle à l'interprète et de la personne à la troisième personne, ce qui exclut la personne de l'échange. Réécriture, en regardant la personne : « Qu'est-ce que vous mangez le matin ? » Autres règles : faire des phrases courtes et s'arrêter pour laisser traduire ; éviter les expressions imagées ; vérifier la compréhension par le « faire dire » à la fin.

Des ressources multilingues et visuelles à connaître

Il est rarement utile de tout créer soi-même. Des ressources existent, conçues par des institutions ou des associations, souvent testées auprès des publics. Avant de les utiliser, on vérifie la date, la source et l'adaptation au public, comme pour tout outil pédagogique (5.3.13).

Ressource	Ce qu'elle propose	Point de vigilance
Livret de santé bilingue (Comede et Santé publique France)	Informations sur le système de santé et la prévention, en français et dans une autre langue, dans de nombreuses langues	Vérifier la dernière mise à jour et la présence de la langue souhaitée
Supports de Santé publique France et du PNNS	Affiches et dépliants sur les repères alimentaires, parfois en plusieurs langues ou en version adaptée	Repères de 2019 pour les adultes : vérifier la version

Ressource	Ce qu'elle propose	Point de vigilance
SantéBD	Bandes dessinées en FALC pour comprendre la santé, les consultations et certains examens	Conçu pour le handicap intellectuel, utile pour d'autres publics
Banques de pictogrammes libres de droits	Pictogrammes pour les recettes, les allergènes, les consignes	Tester la compréhension auprès du public (5.3.5)
Associations d'apprentissage du français et de médiation	Mots de vocabulaire alimentaire illustrés, ateliers de langue autour de la cuisine	Construire le partenariat en amont

Méthode pas à pas – Faire traduire un support écrit de santé

1. Simplifier d'abord le texte en français : un texte clair se traduit mieux.

2. Confier la traduction à un traducteur professionnel ou à un service spécialisé ; un outil de traduction automatique peut servir de brouillon, jamais de version finale.

3. Faire relire la traduction par une ou deux personnes dont c'est la langue, si possible du public visé.

4. Vérifier les images : certaines photos ou certains aliments peuvent ne rien évoquer ou choquer.

5. Tester le support traduit comme la version française, puis noter la date et la source sur le document.

Calcul détaillé – Choisir les langues à traduire (données fictives)

Dans une maison de quartier, le diagnostic oral auprès de 90 familles donne les langues parlées à la maison : arabe 28, turc 17, tamoul 9, roumain 7, autres langues (moins de 4 familles chacune) 11, français seulement 18.

- Familles qui parlent une autre langue que le français : 90 − 18 = **72**, soit 72 / 90 × 100 = **80,0 %**.
- Les trois premières langues réunissent 28 + 17 + 9 = **54** familles, soit 54 / 72 × 100 = **75,0 %** des familles qui parlent une autre langue.

Décision : traduire les supports clés en arabe, en turc et en tamoul ; pour les autres familles, s'appuyer sur les images, la démonstration et l'interprétariat par téléphone pour les entretiens importants.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.33

Une collègue a traduit la fiche « goûters » en roumain avec un traducteur automatique et veut l'imprimer à 200 exemplaires. Citez deux risques et décrivez ce que vous proposez avant l'impression.

Corrigé

Risques : erreurs de sens (mots de cuisine, quantités, allergènes) qui peuvent être dangereuses ; phrases incompréhensibles qui décrédibilisent la structure. Proposition : simplifier le texte français, faire relire ou traduire par une personne compétente dont c'est la langue, tester la fiche auprès de deux ou trois familles roumanophones, puis imprimer un petit nombre d'exemplaires.

Une adaptation pour chaque situation

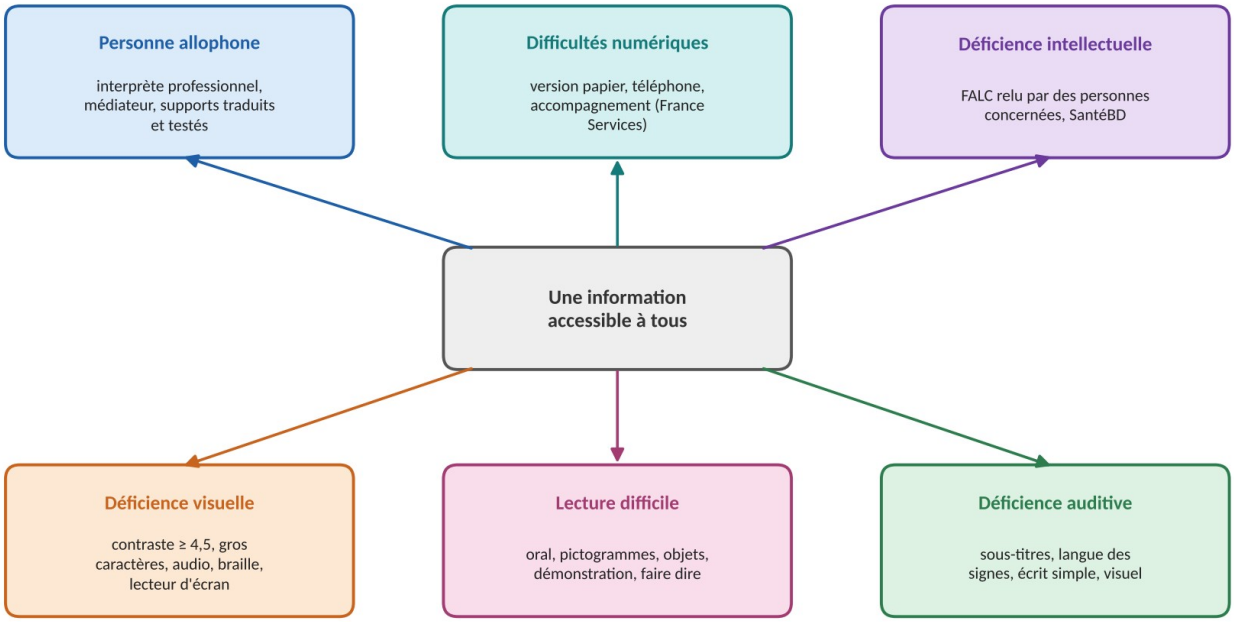


Figure 5.8 bis – Adapter l'information selon la situation de la personne

Comprendre le schéma – Figure 5.8 bis

1. Au centre, l'objectif commun : une information **accessible à tous**. Les six cases montrent des situations fréquentes, qui peuvent se cumuler chez une même personne.
2. **Langue** et **numérique** (en haut) relèvent surtout de l'organisation : interprète, médiateur, version papier, téléphone, accompagnement France Services.
3. **Déficiences** intellectuelle, visuelle et auditive : chacune appelle des adaptations précises (FALC, contraste et audio, sous-titres et langue des signes), qui se préparent avec les associations concernées.
4. **Lecture difficile** : l'oral, les objets, la démonstration et le faire dire, qui profitent à tous les publics.
5. Beaucoup d'adaptations sont utiles à plusieurs situations à la fois : une vidéo sous-titrée avec un commentaire audio aide les personnes sourdes, malvoyantes, allophones et celles qui lisent peu.

Situation	Adaptations à prévoir pour un atelier cuisine
Déficience visuelle	Accueil oral et description des lieux ; recette en gros caractères ou en audio ; ustensiles toujours rangés au même endroit ; repères tactiles (élastique sur un flacon) ; décrire ce que l'on fait pendant la démonstration
Déficience auditive	Interprète en langue des signes française ou codeur en langue française parlée complétée selon les personnes ; animatrice face au groupe, visage éclairé ; bruit réduit ; consignes écrites et visuelles ; boucle magnétique si disponible
Déficience intellectuelle	Supports en FALC, une étape à la fois, routines stables, durée courte, valorisation, aide d'un éducateur connu
Handicap moteur	Plan de travail à hauteur adaptée, ustensiles ergonomiques, circulation libre, toilettes accessibles
Troubles psychiques	Cadre rassurant, petit groupe, possibilité de faire une pause, pas d'obligation de parler

À vous de jouer – Exercice d'application 5.34

Un groupe d'atelier comprend une personne malvoyante et une personne qui parle peu le français. Proposez

trois adaptations qui aident les deux à la fois.

Corrigé

Décrire à voix haute chaque geste pendant la démonstration, avec des mots simples et des phrases courtes ; faire toucher et sentir les aliments et les ustensiles avant de commencer ; proposer une recette en audio (message vocal) avec des étapes numérotées ; travailler en binôme avec un participant qui guide. Ces adaptations s'appuient sur l'oral, le toucher et la démonstration plutôt que sur l'écrit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.10 et 5.3.11 – Numérique et langues

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel ratio de contraste minimal faut-il pour un texte courant (niveau AA) ?
2. Pourquoi ne faut-il jamais donner une information par la couleur seule ?
3. Citez les quatre étapes du « sandwich de vérité ».
4. Citez deux dispositifs publics d'accompagnement au numérique.
5. Citez deux règles à respecter pendant un entretien avec un interprète.
6. Pourquoi ne pas imprimer directement un support traduit automatiquement ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.10 et 5.3.11

1. 4,5 (et 3 pour un grand texte).
2. Parce que les personnes daltoniennes (environ 8 % des hommes) et les photocopies en noir et blanc ne distinguent pas les couleurs.
3. Dire le fait juste, nommer l'idée fausse une fois en disant qu'elle est fausse, expliquer pourquoi elle circule, redire le fait juste avec une action.
4. Espaces France Services, conseillers numériques, Aidants Connect.
5. S'adresser à la personne et non à l'interprète, parler à la première personne, faire des phrases courtes, éviter les expressions imagées.
6. La traduction peut contenir des erreurs de sens dangereuses ; il faut la faire relire par une personne compétente et la tester.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes des deux sections et je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.10 et 5.3.11 et je refais les exercices d'application.

5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Exemple – Avant et après : la fiche « Bien conserver les aliments » d'une épicerie solidaire

Version initiale : texte de 260 mots en 9 phrases, police de 10 points, justifié, trois sigles (DLC, DDM, HACCP), aucune image ; 520 syllabes.

- Indice de lisibilité : mots par phrase 260 / 9 = **28,9** ; syllabes par mot 520 / 260 = **2,0** ; L = 207 − 1,015 × 28,9 − 73,6 × 2,0 = 207 − 29,33 − 147,2 = **30,47** : texte difficile, à la limite du « très difficile ».

Version réécrite : 110 mots en 16 phrases courtes, 160 syllabes ; 6 pictogrammes (réfrigérateur,

thermomètre, calendrier, poubelle barrée…) ; police de 14 points ; un seul message par encadré.

- L = 207 − 1,015 × (110 / 16) − 73,6 × (160 / 110) = 207 − 1,015 × 6,875 − 73,6 × 1,4545 = 207 − 6,98 − 107,05 = **92,97** : très facile.

Test auprès de 8 bénéficiaires : question « Où rangez-vous la viande dans le réfrigérateur ? » (bonne réponse : en haut ou dans la zone la plus froide, selon le modèle) : version initiale 3 bonnes réponses sur 8 (**37,5** %) ; version réécrite 7 sur 8 (**87,5 %**). Question « Peut-on manger un yaourt après la date ? » (réponse attendue : non si DLC) : 2 / 8 (**25 %**) puis 6 / 8 (**75 %**). **Conclusion** : l'indice de lisibilité confirme l'amélioration, mais c'est le **test auprès du public** qui prouve la compréhension.

Tester un support par l'entretien cognitif

Le test d'un support (5.3.12) peut se limiter à une ou deux questions. Pour un support important (livret, affiche d'une campagne, questionnaire de diagnostic), on utilise une méthode plus complète : l'**entretien cognitif**. Issue de la recherche sur les questionnaires (Willis, 2005), elle consiste à demander à quelques personnes du public de lire ou d'utiliser le support **à voix haute**, puis à leur poser des questions précises sur ce qu'elles ont compris.

Méthode pas à pas – Conduire un entretien cognitif de 20 minutes

1. Préparer : choisir 5 à 8 personnes proches du public (langue, âge, lecture), un lieu calme, une grille de questions ; expliquer que l'on teste le document, pas la personne.

2. Penser à voix haute : « Lisez ce document comme chez vous, et dites tout ce qui vous passe par la tête. » On n'aide pas, on note les hésitations.

3. Questions de relance : « Que veut dire ce mot pour vous ? » ; « Avec vos mots, que vous demande-t-on de faire ? » ; « Qu'est-ce qui vous a gêné ? » ; « Que représente cette image ? »

4. Tâche pratique : « Montrez-moi la quantité de riz pour 4 personnes », « Où appelez-vous pour vous inscrire ? »

5. Remercier et noter dans un tableau : problème repéré, nombre de personnes concernées, correction proposée.

Calcul détaillé – Le tableau de synthèse d'un test (livret de recettes, 6 testeuses, données fictives)

Problème repéré	Personnes concernées	Part	Décision
« Émincer » non compris	5 sur 6	83,3 %	Remplacer par « couper en fines lamelles » + photo
Photo de l'étape 3 confondue avec l'étape 4	3 sur 6	50,0 %	Refaire la photo en gros plan
Quantité « 1 verre » : quel verre ?	4 sur 6	66,7 %	Ajouter la photo du verre de référence
Numéro de téléphone trop petit	1 sur 6	16,7 %	Agrandir (correction simple, gardée même si une seule personne l'a signalée)

Règle de décision : on corrige tous les problèmes qui empêchent de comprendre ou d'agir, quel que soit le nombre de personnes ; on discute en équipe des remarques de goût (couleurs, style).

Attention – Ce que l'entretien cognitif ne dit pas

Il montre si le support est compris, pas s'il fera changer les pratiques. Il porte sur quelques personnes, choisies, souvent plus motivées que la moyenne. Il complète l'indice de lisibilité et ne remplace pas l'évaluation de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.35

Rédigez quatre questions de relance pour tester une affiche qui annonce un atelier « goûters » pour des parents d'une école maternelle.

Corrigé

« Avec vos mots, qu'est-ce que l'affiche vous propose ? » ; « Quel jour et à quelle heure est l'atelier ? Où ? » ; « Que veut dire, pour vous, le mot "goûter équilibré" ? » ; « Que représente la photo en bas à droite ? » On peut ajouter une tâche : « Montrez-moi comment vous feriez pour vous inscrire. »

5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Les **outils pédagogiques** (jeux, cartes, photos, maquettes, vidéos) rendent les notions concrètes et favorisent la participation, surtout auprès des publics à littératie limitée. Les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé mettent à disposition des **pédagothèques** (prêt d'outils) et des bases documentaires qui en présentent l'analyse.

Type d'outil	Exemples en nutrition	Intérêt pour la littératie
Objets réels	Emballages vides, aliments, ustensiles, verres doseurs, morceaux de sucre	Concrets, compréhensibles sans lecture
Photos et photolangage	Photos de plats, de portions, de situations de repas	Expression sans écrit, représentations
Maquettes et répliques d'aliments	Répliques de portions (féculents, viande, fromage)	Estimer les quantités (numératie)
Jeux de cartes et de plateau	Classer des aliments, composer un menu à petit prix	Apprentissage actif, coopération
Outils numériques	Vidéos courtes sous-titrées, quiz sur tablette	Attractifs, à accompagner (illectronisme)
Supports à emporter	Fiches recettes en photos, calendrier des légumes secs, aimant « repères »	Rappel à la maison

Méthode pas à pas – Analyser un outil pédagogique avant de l'utiliser : 8 questions

1. **Qui l'a conçu**, quand, avec quelles sources ? (institution, association, marque ?)
2. Le **contenu** est-il exact et à jour (repères de 2019, PNNS 5) ?
3. Les **objectifs** de l'outil correspondent-ils aux miens ?
4. Le **public** visé (âge, langue, littératie) correspond-il au mien ?
5. L'outil favorise-t-il la **participation** ou seulement l'écoute ?
6. Est-il **non stigmatisant** (images de corps, vocabulaire moral) ?
7. Est-il **accessible** (images, peu d'écrit, manipulation simple) ?
8. Quelles **adaptations** sont nécessaires (traduction, simplification, prix locaux) ?

Exemple – Concevoir un jeu « le panier à 10 € » (littératie alimentaire et numératie)

Objectif : composer, en groupe, les repas d'une journée pour 4 personnes avec 10 €. **Matériel** : 30 cartes-aliments avec photo, nom, portion et **prix par portion** (par exemple lentilles 0,16 € ; œufs 0,28 € l'unité ; poulet 0,75 € ; yaourt 0,18 € ; pomme 0,30 € ; pain complet 0,10 € la tranche). **Déroulé** : chaque équipe compose 3 repas et un goûter, additionne les prix, vérifie la présence des familles d'aliments (code couleur),

présente son panier. **Exemple de calcul** d'un déjeuner pour 4 : lentilles 4 × 0,16 = 0,64 € ; riz 4 × 0,14 = 0,56 € ; carottes 4 × 0,19 = 0,76 € ; yaourts 4 × 0,18 = 0,72 € ; pommes 4 × 0,30 = 1,20 € ; total **3,88 €**, soit 0,97 € par personne. **Intérêt** : manipuler des prix réels, comparer, discuter, sans lecture complexe.

Le photolangage : faire parler sans écrire

Le **photolangage** est une méthode d'animation née à Lyon à la fin des années 1960, dans la formation des adultes. On étale sur une table une série de photos variées ; chaque participant choisit une ou deux photos qui répondent à une question, puis explique son choix au groupe. Il se distingue de l'image d'illustration : la photo n'est pas là pour montrer la « bonne réponse », mais pour **aider à parler** de ses représentations et de son expérience. C'est un outil précieux avec les publics qui lisent peu ou qui parlent peu le français.

Méthode pas à pas – Animer un photolangage en 30 minutes

1. Préparer la question : ouverte et liée à l'objectif (« Choisissez une photo qui représente pour vous un bon repas en famille »).

2. Choisir 30 à 50 photos variées : plats de différentes cultures, situations de repas (seul, en famille, devant un écran), lieux d'achat, personnes de tous âges et de toutes corpulences ; éviter les photos publicitaires et les images qui jugent.

3. Temps de choix silencieux (5 minutes) : chacun regarde et choisit, sans parler.

4. Tour de parole (20 minutes) : chacun montre sa photo et dit pourquoi ; l'animateur reformule, ne juge pas, ne corrige pas.

5. Synthèse (5 minutes) : l'animateur relève les points communs et les différences, qui serviront de point de départ à l'atelier.

Exemple – Ce que le photolangage a révélé

Dans un atelier avec des mères de jeunes enfants, la question était : « Choisissez une photo qui montre un goûter pour votre enfant. » Plusieurs mères ont choisi la photo d'une boisson à la fraise et d'un gâteau emballé : « C'est ce qu'il aime, et c'est propre, ça vient du magasin. » D'autres ont choisi la photo d'un pain avec du chocolat : « Chez nous, c'était ça. » L'animatrice a découvert que pour certaines mères, le produit emballé était un signe de **soin** et de **sécurité**. Elle a construit la suite de l'atelier sur cette idée, au lieu de commencer par les « sucres cachés ».

Attention – Respecter les règles du photolangage

Chacun a le droit de ne pas parler ou de passer son tour ; on ne commente pas le choix des autres ; ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Les photos de personnes doivent être libres de droits et ne pas présenter de corps comme des modèles ou des contre-modèles.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.36

Vous préparez un photolangage pour un groupe de retraités sur le thème « manger seul ». Rédigez la question posée et citez six photos à prévoir.

Corrigé

Question : « Choisissez une photo qui ressemble à votre repas du soir, ou à celui que vous aimeriez avoir. » Photos : une personne âgée qui mange seule devant la télévision ; un repas partagé au club ; un plateau-repas livré ; une soupe maison ; un marché ; une table dressée avec une nappe et des fleurs ; un sandwich sur

un coin de table ; une cuisine collective. Les photos montrent des situations variées, sans porter de jugement.

5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Un atelier conçu selon les **précautions universelles** (5.3.4) profite à tous. La séquence suivante, de 2 heures, intègre les principes du chapitre.

Durée	Étape	Adaptations de littératie
10 min	Accueil	Accueil individuel, prénom écrit en grand, consignes de sécurité montrées (pictogrammes, démonstration), interprète ou médiatrice si besoin
10 min	Recueil des pratiques	Photolangage : « Montrez la photo qui ressemble à votre repas d'hier soir » ; aucune lecture nécessaire
15 min	Message principal	Un seul message (« les légumes secs : bons, rassasiants, pas chers »), avec objets réels (sachets, verre doseur, prix) ; chiffres concrets (0,16 € la portion)
15 min	Démonstration	Geste clé montré lentement (rincer, cuire les lentilles corail), puis refait par un participant
40 min	Pratique en binômes	Recette en photos (une action par photo), binômes mixtes (lecteur / non- lecteur, langues), animateur qui circule et reformule
15 min	Dégustation	Vocabulaire sensoriel simple, échelle à smileys
10 min	Faire dire	Chaque binôme montre ou explique une astuce ; l'animateur réexplique autrement si besoin
5 min	Clôture	Fiche recette en photos à emporter, rappel oral de la date suivante (et message vocal la veille)

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la compréhension en fin d'atelier

L'animatrice note, pour 10 participants, la réussite de trois « faire dire » : expliquer la cuisson des lentilles corail (8 réussites), estimer le coût d'une portion à 20 centimes près (6 réussites), citer une recette à refaire (10 réussites).

- Taux de réussite : 8 / 10 = **80 %** ; 6 / 10 = **60 %** ; 10 / 10 = **100 %**.
- Moyenne des trois : (80 + 60 + 100) / 3 = 240 / 3 = **80 %**.
- **Ajustement** : l'estimation du coût est la moins réussie (numératie) : à la séance suivante, l'animatrice prévoit des étiquettes de prix par portion déjà calculées et un exercice de comparaison en binôme.

Adapter la séquence type à quelques publics

La séquence type de 2 heures (5.3.14) se modifie selon le public. Les principes restent les mêmes (précautions universelles, démonstration, faire dire), mais la durée, le rythme et les supports changent.

Public	Adaptations principales
Enfants de 6 à 10 ans	Séance d'une heure ; consignes très courtes ; une tâche par enfant (laver, verser, mélanger) ; vocabulaire des sens (« croquant, doux, acide ») ; dégustation avec une échelle à 3 visages ; aucun jugement sur ce que les familles mangent
Adolescents	Partir de leurs pratiques (restauration rapide, boissons énergisantes) ; méthodes actives et défis ; usage du téléphone (photo, vidéo) ; éviter le ton moralisateur ; donner des choix

Public	Adaptations principales
Personnes âgées	Rythme lent, grande police, bonne lumière, sièges ; tenir compte de l'audition et de la vue ; recettes simples à une seule casserole ; lien social au cœur de la séance
Personnes en situation de handicap intellectuel	Séance courte et régulière, même jour et même lieu ; supports FALC, pictogrammes, une étape à la fois ; routines (lavage des mains en chanson) ; présence d'un éducateur connu
Personnes allophones	Démonstration avant explication ; vocabulaire illustré ; interprète pour les consignes de sécurité ; binômes de même langue si possible ; recettes des pays d'origine valorisées

Exemple – La séance d'un ESAT, en 1 h 15 (données fictives)

L'atelier « Salade de pâtes » accueille 8 travailleurs d'un ESAT, le jeudi à 14 h, chaque semaine pendant 6 semaines. Déroulé : accueil et lavage des mains avec la même chanson chaque semaine (10 minutes) ; présentation des ingrédients réels, chacun nomme ou montre un ingrédient (10 minutes) ; démonstration de l'étape du jour (10 minutes) ; préparation en binômes avec la recette en 5 photos (25 minutes) ; dégustation et vote avec gommettes (10 minutes) ; rangement et « faire faire » : chaque binôme montre l'étape qu'il a réussie (10 minutes). Total : 10 + 10 + 10 + 25 + 10 + 10 = **75 minutes**.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.37

Un club de collégiens veut un atelier « petit-déjeuner » d'une heure, de 12 h 30 à 13 h 30. Proposez un déroulé minuté avec deux adaptations propres à ce public.

Corrigé

Exemple : 5 minutes d'accueil ; 10 minutes de défi « le vrai prix du petit-déjeuner » (les élèves classent par prix des produits réels et des photos de petits-déjeuners) ; 10 minutes de démonstration d'un petit-déjeuner rapide (pain, fromage, fruit, boisson) ; 20 minutes de préparation en équipes, chacune invente sa version ; 10 minutes de dégustation et de photos ; 5 minutes de « faire dire » : chaque équipe dit l'astuce qu'elle va utiliser un matin pressé. Total : 60 minutes. Adaptations : partir des contraintes réelles des élèves (temps, réveil tardif) sans les juger ; utiliser leur téléphone pour photographier leur création et la partager.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.12 à 5.3.15 – Supports, outils et ateliers accessibles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un entretien cognitif ? Combien de personnes faut-il environ ?
2. Pourquoi l'indice de lisibilité ne suffit-il pas pour valider un support ?
3. Citez quatre des huit questions pour analyser un outil pédagogique.
4. Décrivez en trois étapes l'animation d'un photolangage.
5. Citez deux adaptations d'un atelier pour des personnes âgées.
6. Dans le fil rouge des Tilleuls, citez deux adaptations de la communication.

Corrigé – Point d'étape 5.3.12 à 5.3.15

1. Une méthode de test où des personnes du public lisent ou utilisent le support à voix haute, puis répondent à des questions sur ce qu'elles ont compris ; 5 à 8 personnes.
2. Il ne mesure ni le sens des mots, ni les sigles, ni les images, ni la mise en page ; seul un test auprès du public montre la compréhension.

3. Qui l'a conçu ; contenu à jour ; objectifs ; public visé ; participation ; non-stigmatisation ; accessibilité ; adaptations nécessaires.
4. Choix silencieux d'une photo à partir d'une question ouverte ; tour de parole où chacun explique son choix ; synthèse par l'animateur, sans jugement.
5. Rythme lent, grande police et bonne lumière, prise en compte de l'audition, recettes simples, place du lien social.
6. Invitation sur papier, message vocal WhatsApp enregistré par la référente familles, bouche-à-oreille par les mamans relais, pas d'inscription seulement en ligne.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes des sections 5.3.12 à 5.3.14.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.12 à 5.3.15 et je refais les exercices d'application.

5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a observé et adapté

- **Diagnostic** : lors de la passation du questionnaire à la sortie de l'école, 11 parents sur 48 ont demandé à Inès de lire les questions à voix haute ; 6 parents parlaient peu le français. Inès a donc réalisé la passation **en entretien oral**, avec l'aide d'une médiatrice parlant arabe et soninké.
- **Calcul** : 11 / 48 × 100 = **22,9 %** des parents ont eu besoin d'une lecture orale ; 6 / 48 × 100 = **12,5 %** parlaient peu le français. Ces chiffres ne sont pas des taux d'illettrisme : ils indiquent un **besoin d'adaptation**.
- **Supports** : les fiches recettes ont été refaites en **photos** (une photo par étape), avec des quantités en verres et en cuillères ; l'indice de lisibilité de la fiche « lentilles corail » est passé de 54 à 82 après réécriture ; la fiche a été testée par 3 mamans du groupe.
- **Animation** : à chaque atelier, Inès termine par un « tour de faire dire » : chaque binôme explique au groupe une astuce retenue.
- **Communication** : invitation sur papier, message vocal WhatsApp enregistré par la référente familles, bouche-à-oreille par les mamans relais ; pas d'inscription uniquement en ligne.
- **Évaluation** : questionnaire de satisfaction à **smileys** et question orale « Qu'allez-vous refaire à la maison ? ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : l'atelier « lire une étiquette » et le livret des Tilleuls

- **Atelier étiquettes** (intégré à l'atelier 4) : comparaison de deux céréales et de deux boissons, morceaux de sucre posés à côté des bouteilles ; à la question « Combien de morceaux de sucre dans cette bouteille de 33 cL ? », 2 parents sur 11 répondaient juste avant la démonstration (18,2 %), 9 sur 11 après (81,8 %).
- **Numératie** : Inès a remplacé « 400 g de fruits et légumes » par « 5 portions = 5 poings » et « 2 fois par semaine des légumes secs » par un calendrier illustré de la semaine.
- **Livret de recettes** : indice de lisibilité moyen des 12 fiches 84 (minimum 78, maximum 91) ; chaque recette en 6 photos au plus, quantités en verres et cuillères ; testé par 3 mamans (correction de 4 mots jugés difficiles : « émincer », « blanchir », « réserver », « assaisonner »).
- **Allophones** : 6 familles sur 12 parlent une autre langue à la maison ; une médiatrice a traduit oralement les consignes de sécurité ; les allergènes étaient signalés par pictogrammes.
- **Numérique** : 9 familles sur 12 utilisent WhatsApp : rappels vocaux la veille ; aucune inscription n'était

uniquement en ligne.

5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie

Module · Référentiel et guide : voir 5.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Ces six cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre attendu par le jury : décrire la situation avec des chiffres, l'analyser avec les notions du cours, puis proposer des adaptations argumentées qui valent pour tout le public. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – L'affiche du menu végétarien au restaurant universitaire (données fictives)

Un restaurant universitaire propose chaque jour un plat végétarien, peu choisi. L'affiche actuelle, en police de 11 points, gris clair sur fond blanc, dit : « Dans le cadre de notre engagement en faveur d'une alimentation durable, nous vous proposons quotidiennement une alternative végétarienne équilibrée… » Elle compte 96 mots, 4 phrases et 175 syllabes. Une enquête auprès de 120 étudiants montre que 41 savent qu'un plat végétarien est proposé chaque jour ; 180 plats végétariens sont vendus sur 1 450 repas par jour.

Une nouvelle affiche est conçue avec des étudiants : 60 mots, 9 phrases, 87 syllabes, photo du plat du jour, texte noir. Deux semaines plus tard, 78 étudiants sur 130 interrogés connaissent l'offre et 255 plats végétariens sont vendus sur 1 480 repas.

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez l'indice de lisibilité des deux affiches et les pourcentages avant et après (connaissance de l'offre, part des plats végétariens vendus).
2. Relevez trois défauts de l'ancienne affiche.
3. Peut-on attribuer toute la hausse des ventes à la nouvelle affiche ? Justifiez.
4. Proposez deux autres actions, en dehors de l'affiche, pour faire connaître le plat végétarien.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Ancienne affiche : 96 / 4 = 24 mots par phrase ; 175 / 96 = 1,823 syllabe par mot ; L = 207 − 24,36 − 134,17 = **48,47** : difficile. Nouvelle : 60 / 9 = 6,67 ; 87 / 60 = 1,45 ; L = 207 − 6,77 − 106,72 = **93,51** : très facile. Connaissance de l'offre : 41 / 120 = **34,2 %** puis 78 / 130 = **60,0 %**. Part des plats végétariens : 180 / 1 450 = **12,4 %** puis 255 / 1 480 = **17,2 %**.

2. Contraste faible (gris clair sur blanc) ; petite police ; phrases longues et jargon (« dans le cadre de notre engagement », « alternative ») ; aucune image du plat ; le message principal (« un plat végétarien chaque jour ») n'apparaît pas d'abord.

3. Non : il n'y a pas de groupe de comparaison, et d'autres facteurs ont pu jouer en deux semaines (plats du jour plus appréciés, météo, bouche-à-oreille, prix). On parle d'une évolution favorable observée, à confirmer sur une plus longue période.

4. Une dégustation gratuite du plat végétarien à l'entrée du self ; une présentation du plat en première position sur la ligne de self ; une publication sur les réseaux sociaux des associations étudiantes avec la photo du jour ; un pictogramme « végétarien » sur le menu en ligne.

Cas guidé 2 – Le courrier aux parents après le bilan de santé de l'école (données fictives)

Lors du bilan de santé des élèves de 6 ans d'une circonscription, l'infirmière scolaire a mesuré 112 enfants ; 14 ont un indice de masse corporelle au-dessus de la zone habituelle pour leur âge. Les parents de ces 14 enfants ont reçu dans le cartable une lettre : « Votre enfant présente un IMC supérieur au 97e percentile des courbes de référence ; une prise en charge est recommandée. » Seuls 6 parents sont venus à la réunion

proposée. Une mère a dit : « J'ai cru que mon fils était malade. Il a lu la lettre avant moi. »

Questions – Cas guidé 2

1. Calculez la part d'enfants concernés et la part de parents venus à la réunion.

2. Expliquez le « 97e percentile » en fréquences naturelles, avec des mots simples.

3. Relevez les problèmes de littératie et d'éthique de ce courrier.

4. Proposez une autre façon d'informer ces familles.

Corrigé – Cas guidé 2

1. Enfants concernés : 14 / 112 = **12,5 %**. Parents venus : 6 / 14 = **42,9 %**.

2. « Si l'on range 100 enfants du même âge et du même sexe du plus mince au plus fort, votre enfant fait partie des 3 enfants les plus forts. » On ajoute que ce n'est pas une maladie, mais un repère qui invite à faire le point.

3. Littératie : vocabulaire technique (IMC, percentile, courbes de référence, prise en charge) ; aucune explication ni conseil concret ; aucune personne à contacter. Éthique : courrier transmis par le cartable, que l'enfant peut lire ; risque de stigmatisation et d'inquiétude ; le mot « prise en charge » fait penser à une maladie ; la confidentialité n'est pas garantie.

4. Un entretien individuel proposé par téléphone ou à la sortie de l'école, avec l'infirmière, sans l'enfant ; une courbe de corpulence montrée et expliquée oralement ; des conseils centrés sur toute la famille (repas, activité, sommeil), sans parler de régime ; l'orientation vers le médecin traitant ; un courrier envoyé par voie postale, court et en écriture claire, qui propose simplement un rendez-vous. Pour toutes les familles de l'école, une action collective non ciblée (atelier goûters, activité physique) évite de désigner les enfants.

Cas guidé 3 – L'application des menus de la cantine (données fictives)

Une commune de 2 400 élèves remplace l'affichage papier des menus par une application. Une enquête auprès de 300 parents montre : 171 ont installé l'application ; 120 consultent les menus chaque semaine ; 135 souhaitent garder un menu papier ; parmi les 63 parents d'enfants allergiques, 48 trouvent l'information sur les allergènes. Dans l'application, le texte est gris moyen (#8A8A8A, luminance relative 0,2542) sur fond blanc.

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez les pourcentages de l'enquête.

2. Calculez le ratio de contraste du texte et concluez.

3. Analysez les risques de cette dématérialisation pour les familles.

4. Proposez quatre améliorations.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Application installée : 171 / 300 = **57,0 %** ; consultation hebdomadaire : 120 / 300 = **40,0 %** ; menu papier souhaité : 135 / 300 = **45,0 %** ; parents d'enfants allergiques qui trouvent l'information : 48 / 63 = **76,2 %**, donc **23,8 %** ne la trouvent pas.

2. (1 + 0,05) / (0,2542 + 0,05) = 1,05 / 0,3042 = **3,45** : sous le seuil de 4,5 pour un texte courant ; seul un grand texte serait conforme.

3. 43 % des parents n'ont pas l'application et 60 % ne consultent pas les menus chaque semaine : les familles éloignées du numérique perdent l'information. Pour les allergies, près d'un parent concerné sur quatre ne

trouve pas l'information : c'est un risque pour la sécurité des enfants. Le faible contraste gêne la lecture.

4. Garder un affichage papier à l'entrée de l'école et sur le site de la mairie ; ajouter dans l'application des pictogrammes d'allergènes et un texte foncé (par exemple #595959, ratio de 7,0) ; envoyer chaque mois le menu papier aux familles qui le demandent ; organiser une présentation de l'application lors d'une réunion de parents, avec un « faire faire » (trouver les allergènes du jeudi) ; prévoir un contact téléphonique pour les parents d'enfants allergiques.

Cas guidé 4 – Les boissons énergisantes au club de football (données fictives, étiquette courante)

Un club de football amateur accueille 46 joueurs de 13 à 17 ans. L'entraîneur vous alerte : 21 jeunes boivent une boisson énergisante au moins une fois par semaine, dont 14 avant les matchs. L'étiquette d'une canette de 250 mL courante indique pour 100 mL : 11 g de sucres et 32 mg de caféine. Un jeune dit : « Ça donne des ailes, c'est fait pour le sport. »

Questions – Cas guidé 4

1. Calculez la part de jeunes concernés, puis le sucre (en grammes et en morceaux) et la caféine d'une canette.
2. Un jeune de 50 kg boit deux canettes avant un match. Comparez sa dose de caféine à la valeur de 3 mg par kilogramme de poids corporel retenue par l'EFSA (2015) pour les enfants et adolescents.
3. Analysez la phrase du jeune avec la notion de littératie critique.
4. Proposez une séance de 45 minutes avec les jeunes, puis une action avec le club.

Corrigé – Cas guidé 4

1. Au moins une fois par semaine : 21 / 46 = **45,7 %** ; avant les matchs : 14 / 46 = **30,4 %**. Sucres : 11 × 2,5 = **27,5 g**, soit **5,5 morceaux** (55 % du repère de 50 g de sucres libres pour un adulte) ; caféine : 32 × 2,5 = **80 mg**.

2. Valeur de l'EFSA : 3 × 50 = **150 mg**. Deux canettes : 2 × 80 = **160 mg**, au-dessus de cette valeur. L'ANSES (2013) déconseille la consommation de boissons énergisantes par les enfants et les adolescents, et au cours d'un effort physique.

3. Le jeune reprend un slogan publicitaire comme une information de santé. La littératie critique consiste à se demander qui parle (une marque), dans quel but (vendre) et ce que disent les sources indépendantes (pas d'intérêt pour la performance, risques liés à la caféine et au sucre).

4. Séance : 10 minutes de « vrai ou faux » sur les boissons ; 10 minutes pour poser les morceaux de sucre à côté de la canette ; 15 minutes d'analyse d'une publicité en petits groupes (qui, pourquoi, quelles preuves) ; 10 minutes pour fabriquer une boisson de match (eau, un peu de jus) et faire dire « ce que je bois avant et pendant le match ». Action avec le club : remplacer la vente de boissons énergisantes à la buvette par de l'eau et des fruits ; informer les parents par un message court ; impliquer l'entraîneur, que les jeunes écoutent.

Cas guidé 5 – Cuisiner les légumes du chantier d'insertion (données fictives)

Un chantier d'insertion en maraîchage emploie 18 salariés. Lors d'entretiens oraux, 7 disent lire difficilement, 5 parlent peu le français et 12 disent ne pas cuisiner les légumes qu'ils récoltent (« je ne sais pas quoi faire des courgettes »). L'encadrante propose un atelier « tortilla de courgettes » pour 6 personnes : 6 œufs (3,30 € les 12), 600 g nets de pommes de terre (1,20 € le kg, 15 % de pertes), 600 g de courgettes du jardin (sans coût), 100 g nets d'oignon (1,80 € le kg, 10 % de pertes), 30 g d'huile d'olive (6,50 € le kg), sel et poivre (forfait de 0,20 €). Au premier atelier, 14 salariés sont présents ; 11 réussissent à montrer comment couper et cuire les légumes.

Questions – Cas guidé 5

1. Calculez les pourcentages du diagnostic, de la présence et de la réussite du « faire faire ».

2. Calculez le coût de la recette pour 6 et par portion.

3. Situez les difficultés dans les domaines de la littératie alimentaire.

4. Proposez trois adaptations de l'atelier et un support à emporter.

Corrigé – Cas guidé 5

1. Lisent difficilement : 7 / 18 = **38,9 %** ; parlent peu le français : 5 / 18 = **27,8 %** ; ne cuisinent pas les légumes récoltés : 12 / 18 = **66,7 %**. Présence : 14 / 18 = **77,8 %** ; réussite : 11 / 14 = **78,6 %**.

2. Œufs : 6 × 3,30 / 12 = 1,65 € ; pommes de terre : 600 / 0,85 = 705,9 g bruts, soit 0,85 € ; oignon : 100 / 0,90 = 111,1 g bruts, soit 0,20 € ; huile : 0,030 × 6,50 = 0,20 € ; forfait : 0,20 €. Total : 1,65 + 0,85 + 0,20 + 0,20 + 0,20 = **3,09 €** (calcul non arrondi : 3,09 €), soit environ **0,52 €** par portion.

3. Préparer : ne pas savoir cuisiner les légumes récoltés (domaine principal). Planifier et gérer : utiliser ce que l'on a, sans gaspiller. Sélectionner : l'accès aux légumes est déjà assuré par le chantier, c'est un atout. Manger : faire goûter et partager un repas entre collègues.

4. Démonstration de chaque geste avant de le faire faire ; recette en 6 photos, une action par photo, quantités en nombre (« 6 œufs », « 4 pommes de terre moyennes ») ; binômes mélangeant lecteurs et non-lecteurs, et participants de même langue si besoin ; dégustation au repas de midi du chantier. Support : une carte recette en photos, avec un pictogramme de saison pour chaque légume, et un message vocal de l'encadrante qui reprend les étapes.

Cas guidé 6 – Former les aides à domicile au « faire dire » (données fictives)

Un service d'aide à domicile veut prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'il accompagne. Les 24 aides à domicile ont suivi une formation de 3 heures : conseils d'enrichissement des repas, écriture claire, « faire dire ». Avant et après la formation, une responsable a observé 2 visites par aide (48 visites) et noté si l'aide vérifiait la compréhension d'un conseil. Elle a aussi demandé à 24 personnes accompagnées d'expliquer un conseil d'enrichissement reçu. Résultats : vérification de la compréhension dans 5 visites sur 48 avant, 29 sur 48 après ; explication correcte par 9 personnes sur 24 avant, 17 sur 24 après.

Questions – Cas guidé 6

1. Calculez les pourcentages avant et après, et leur évolution en points.

2. Montrez que cette action relève à la fois de la littératie des personnes et de la littératie organisationnelle.

3. Citez deux limites de cette évaluation.

4. Proposez deux actions pour faire durer les effets de la formation.

Corrigé – Cas guidé 6

1. Vérification de la compréhension : 5 / 48 = **10,4 %** avant, 29 / 48 = **60,4 %** après, soit **+ 50,0 points**. Explication correcte par les personnes accompagnées : 9 / 24 = **37,5 %** avant, 17 / 24 = **70,8 %** après, soit **+ 33,3 points**.

2. Littératie des personnes : les personnes âgées comprennent mieux et savent mieux expliquer les conseils d'enrichissement. Littératie organisationnelle : le service forme son personnel et change ses pratiques de communication, ce qui rend l'information plus accessible pour toutes les personnes accompagnées.

3. Observation par une responsable, qui peut modifier le comportement des aides pendant la visite (elles savent qu'on les observe) ; mesure juste après la formation, sans recul sur la durée ; pas de groupe témoin ; petit effectif.

4. Un temps d'échange de 15 minutes lors des réunions d'équipe mensuelles pour partager des situations ; une fiche aide-mémoire « 3 conseils, 1 question de faire dire » dans le classeur de chaque domicile ; une nouvelle observation six mois plus tard ; la formation des nouvelles aides à leur arrivée.

5.4 Approfondissements

5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé)

La **littératie numérique en santé** (*eHealth literacy*, Norman et Skinner, 2006) est la capacité à rechercher, trouver, comprendre et évaluer l'information de santé en ligne et à l'utiliser. Elle combine six littératies : traditionnelle, en santé, informationnelle, scientifique, médiatique et informatique. Avec la dématérialisation des démarches (Mon espace santé, prise de rendez-vous, inscriptions aux ateliers), les personnes en situation d'**illectronisme** risquent d'être exclues : les **Conseillers numériques** et les **espaces France Services** peuvent être des partenaires d'une action de santé publique.

Méthode pas à pas – Juger la fiabilité d'une information de santé en ligne : 6 questions

1. Qui est l'auteur ? Est-il identifié, compétent (professionnel de santé, institution) ?

2. Quel est l'objectif : informer ou vendre ?

3. D'où viennent les informations : sources citées, études, recommandations officielles ?

4. Quand le contenu a-t-il été publié ou mis à jour ?

5. Le contenu est-il **cohérent** avec les repères officiels (Santé publique France, ANSES, HAS) ?

6. Promet-il des **résultats miraculeux**, rapides, sans effort ? (signal d'alerte).

Mesurer la littératie numérique en santé : l'échelle eHEALS

Norman et Skinner (2006) ont proposé une échelle courte, l'**eHEALS** (*eHealth Literacy Scale*), traduite et validée en français. Elle comporte **8 affirmations** sur la capacité à trouver, utiliser et juger l'information de santé sur internet. La personne répond pour chacune sur une échelle de 1 (« pas du tout d'accord ») à 5 (« tout à fait d'accord »). Le **score total** va donc de **8 à 40** : plus il est élevé, plus la personne se sent capable d'utiliser l'information de santé en ligne.

N°	Idée de l'affirmation (formulation simplifiée)	Compétence
1	Je sais quelles ressources de santé existent sur internet.	Accéder
2	Je sais où trouver sur internet des ressources utiles.	Accéder
3	Je sais comment trouver ces ressources.	Accéder
4	Je sais utiliser internet pour répondre à mes questions de santé.	Comprendre
5	Je sais utiliser l'information trouvée pour m'aider.	Appliquer
6	J'ai les compétences pour évaluer les ressources trouvées.	Évaluer
7	Je sais distinguer les ressources de bonne et de mauvaise qualité.	Évaluer
8	Je me sens en confiance pour utiliser l'information d'internet pour décider.	Appliquer

Attention – Une mesure déclarative, pas un test

L'eHEALS mesure ce que la personne **pense** savoir faire, pas ce qu'elle sait réellement faire. Une personne très confiante peut se tromper sur la fiabilité d'un site. Il n'existe pas de seuil officiel en France : dans un projet, on utilise surtout l'échelle pour **comparer** un groupe avant et après une action, en toute

confidentialité et avec l'accord des participants.

Exemple – Le score de M. B. et l'évaluation d'un atelier

M. B., 62 ans, répond 4, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Son score est 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 = **22 sur 40**, soit une moyenne de 22 / 8 = **2,75** par affirmation. Ses réponses sont les plus basses pour l'utilisation et l'évaluation (affirmations 4 à 8) : il sait que des ressources existent, mais il ne sait pas juger leur qualité.

Huit participants d'un atelier « Bien s'informer sur l'alimentation » à l'espace France Services remplissent l'échelle avant et un mois après l'atelier (données fictives).

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8
Avant	18	22	25	30	16	27	21	24
Après	24	26	29	32	22	30	25	28
Progression	+ 6	+ 4	+ 4	+ 2	+ 6	+ 3	+ 4	+ 4

Moyenne avant : 183 / 8 = **22,875**, soit environ 22,9. Moyenne après : 216 / 8 = **27**. Progression moyenne : **+ 4,1 points**. Six participants sur huit gagnent au moins 4 points. Ce résultat est encourageant, mais l'effectif est très petit et il n'y a pas de groupe de comparaison : on parle d'une **évolution observée**, pas d'une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.38

Trois personnes ont rempli l'eHEALS au début d'un atelier.

- Awa : 5, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4.
- Gérard : 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1.
- Inès : 4, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 3.

1. Calculez le score de chacune.

2. Pour Inès, repérez les affirmations les plus basses et la compétence correspondante.

3. Proposez une adaptation de l'atelier pour Gérard, sans le mettre à l'écart du groupe.

Corrigé – Exercice d'application 5.39

1. Awa : 31 sur 40 ; Gérard : 12 sur 40 ; Inès : 29 sur 40.

2. Inès répond 2, 2 et 3 aux affirmations 6, 7 et 8 : elle trouve facilement l'information, mais se sent peu capable de l'**évaluer** et de l'utiliser pour décider. L'atelier doit insister sur les six questions de fiabilité.

3. Gérard se sent peu à l'aise dès l'accès à internet. On peut former des binômes (Gérard avec Awa par exemple), partir de son propre téléphone, montrer un seul site fiable (manger-bouger.fr) enregistré en favori et lui proposer un rendez-vous avec le conseiller numérique, sans souligner son score devant les autres.

5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat

La **médiation en santé** est reconnue par la loi de modernisation de notre système de santé (2016, article L. 1110-13 du Code de la santé publique) et encadrée par un référentiel de la HAS (2017) : un médiateur fait le **lien** entre des publics éloignés et les professionnels, facilite l'accès aux droits et aux soins et aide les professionnels à adapter leurs pratiques. L'**interprétariat linguistique** professionnel dans le domaine de la santé fait l'objet d'un autre référentiel de la HAS (2017). Dans un projet en quartier prioritaire, s'appuyer sur un médiateur ou des **habitants relais** est souvent plus efficace que la traduction d'une affiche.

Médiateur, interprète, habitant relais : qui fait quoi ?

Ces trois intervenants sont souvent confondus (la conduite d'un entretien avec un interprète est détaillée en 5.3.11). Ils sont pourtant complémentaires, et le diététicien doit savoir lequel solliciter selon le besoin.

	Médiateur en santé	Interprète professionnel	Habitant relais (ou pair)
Rôle principal	Faire le lien entre le public et les services ; faciliter l'accès aux droits et aux soins	Traduire fidèlement les propos, dans les deux sens	Informer, mobiliser et accompagner ses voisins ou sa communauté
Formation	Formation spécifique (référentiel HAS 2017)	Formation à l'interprétariat et à la déontologie (neutralité, secret)	Formation courte, souvent par la structure
Statut	Salarié d'une association, d'une collectivité, d'un hôpital	Professionnel, sur place, par téléphone ou par vidéo	Bénévole ou indemnisé
Exemple dans un projet alimentaire	Accompagner des familles vers le centre social et l'épicerie solidaire	Permettre un entretien individuel avec une mère qui parle tamoul	Inviter les voisines à l'atelier et traduire les idées clés de façon informelle
Limite	Ne remplace pas les professionnels de santé	Ne donne pas son avis, ne conseille pas	Ne doit pas traduire des informations médicales individuelles ou confidentielles

En France, le **Programme national de médiation sanitaire**, lancé en 2011 pour les personnes vivant en habitat précaire (bidonvilles, squats), a montré que la présence régulière de médiateurs améliore l'ouverture des droits, la vaccination et le suivi des grossesses. La médiation en santé se développe aussi dans les quartiers prioritaires (adultes-relais, ateliers santé ville).

Méthode pas à pas – Travailler avec un médiateur dans un projet

1. L'associer dès le diagnostic : il connaît les habitudes, les freins et les lieux fréquentés par le public.

2. Définir ensemble les rôles : qui invite, qui anime, qui traduit, qui fait le lien avec les familles après l'atelier.

3. Partager les messages clés : le diététicien vérifie l'exactitude, le médiateur vérifie que les mots et les exemples conviennent au public.

4. Préparer la séance ensemble : supports, exemples d'aliments, moments de reformulation.

5. Faire le bilan à deux : ce qui a été compris, ce qui a surpris, ce qu'il faut changer.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.40

Pour chaque besoin, indiquez l'intervenant le plus adapté (médiateur, interprète professionnel, habitant relais) et justifiez.

a) Mme R., qui ne parle que le bengali, vient pour un entretien sur l'alimentation de son enfant diabétique.

b) Le centre social veut faire connaître un nouvel atelier cuisine aux familles d'un immeuble.

c) Des familles vivant dans un campement ne connaissent pas leurs droits à la complémentaire santé solidaire ni l'épicerie solidaire.

d) Un atelier collectif réunit des femmes qui parlent arabe et qui comprennent un peu le français ; une participante bilingue propose son aide.

Corrigé – Exercice d'application 5.41

a) **Interprète professionnel** : il s'agit d'informations de santé individuelles et confidentielles, qui demandent une traduction fidèle et neutre ; on évite de faire traduire par un enfant ou un proche.

b) **Habitant relais** : il connaît les familles, inspire confiance et mobilise par le bouche-à-oreille.

c) **Médiateur en santé** : il fait le lien avec les services, accompagne l'ouverture des droits et oriente vers

l'épicerie solidaire.

d) **Habitant relais** (la participante bilingue) pour les consignes et les idées générales d'un atelier collectif, à condition de lui demander son accord, de ne pas lui confier de questions personnelles et de vérifier la compréhension de toutes avec des images et le « faire dire ».

5.4.3 Les organisations « amies de la littératie »

Agir sur la littératie, ce n'est pas seulement former les personnes : c'est aussi **simplifier l'environnement**. Une structure « littératie-amicale » (*health literate organization*, Brach et coll., 2012) : forme son personnel, associe les usagers à la conception des documents, rend les lieux faciles à trouver (signalétique, pictogrammes), simplifie les formulaires et propose de l'aide, communique clairement les coûts, vérifie la compréhension. Le diététicien peut proposer à un centre social, à une cuisine centrale ou à une épicerie solidaire un **audit** simple de ses supports (fiche-outil O5.3).

Les dix caractéristiques d'une organisation « amie de la littératie »

Brach et ses collègues (2012, *Institute of Medicine*, États-Unis) décrivent **dix caractéristiques** d'une organisation de santé qui facilite la vie des personnes ayant une littératie limitée. Elles s'adaptent facilement à un centre social, une épicerie solidaire, un service de restauration ou une association.

N°	Caractéristique (formulation adaptée)	Exemple dans une épicerie solidaire
1	La direction fait de la littératie une priorité.	Le projet associatif mentionne l'accessibilité des informations.
2	La littératie est intégrée à la planification et à l'évaluation.	Un indicateur « compréhension » figure dans le bilan annuel.
3	Le personnel est formé.	Les bénévoles ont suivi une formation « communiquer pour tous ».
4	Le public participe à la conception des supports.	Les affiches sont testées auprès de bénéficiaires.
5	L'organisation répond à des niveaux de compétences variés, sans stigmatiser.	Les informations existent à l'écrit, en images et à l'oral.
6	La communication orale est claire et la compréhension est vérifiée.	Les bénévoles pratiquent le « faire dire » à l'accueil.
7	L'accès à l'information et l'orientation sont faciles.	Signalétique avec pictogrammes, plan affiché, horaires clairs.
8	Les documents écrits, audiovisuels et numériques sont faciles à comprendre et à utiliser.	Fiches recettes en écriture claire, avec photos.
9	La littératie est prise en compte dans les situations à risque.	Information claire sur les allergènes et les dates de consommation.
10	Les coûts et les droits sont expliqués clairement.	Le prix restant à payer par la famille est affiché simplement.

Méthode pas à pas – Réaliser un audit rapide avec une grille à 3 niveaux

1. Noter chaque caractéristique : 0 = absent ; 1 = partiel ; 2 = en place. Le total est sur 20.

2. Croiser les regards : remplir la grille avec l'équipe et avec deux ou trois usagers, puis comparer.

3. Exprimer le résultat en pourcentage du maximum, pour suivre l'évolution d'une année sur l'autre.

4. Choisir deux ou trois priorités : les caractéristiques notées 0, en commençant par celles qui sont faciles à améliorer et utiles au public.

5. Fixer une date pour refaire l'audit (par exemple dans un an).

Exemple – L'audit de l'épicerie solidaire « Le Panier partagé » (données fictives)

Notes obtenues pour les caractéristiques 1 à 10 : 2, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2. Total : **11 sur 20**, soit 11 / 20 × 100 = **55 %**.

Les deux caractéristiques notées 0 sont la formation des bénévoles (3) et la qualité des documents (8). L'équipe retient deux priorités : une formation de deux heures pour les bénévoles et la réécriture des cinq fiches recettes en écriture claire, testées auprès de six bénéficiaires.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.42

La cuisine centrale d'une ville obtient les notes suivantes pour les caractéristiques 1 à 10 : 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0 (données fictives).

1. Calculez le total et le pourcentage.
2. Identifiez les caractéristiques absentes.
3. Choisissez deux priorités et proposez pour chacune une action concrète liée aux menus ou à l'information des familles.

Corrigé – Exercice d'application 5.43

1. Total : 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 0 = **8 sur 20**, soit **40 %**.
2. Caractéristiques notées 0 : la littératie dans la planification et l'évaluation (2), la formation du personnel (3), la participation du public (4), la clarté des coûts (10).
3. Exemples : **participation du public (4)** : tester le nouvel affichage des menus et des allergènes auprès de 10 parents et d'une classe d'élèves avant de le diffuser ; **coûts (10)** : présenter le tarif de la cantine selon le quotient familial dans un tableau simple, avec un exemple chiffré et le contact d'une personne qui aide à faire la démarche. D'autres choix sont possibles s'ils sont justifiés.

5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations

La littératie n'est pas seulement l'affaire du public : les **professionnels** doivent être formés à communiquer clairement, et les **organisations** à réduire la complexité de leurs démarches (5.4.3). En France, la stratégie nationale de santé et plusieurs plans régionaux intègrent désormais la littératie en santé ; des formations courtes (« communiquer pour tous », faire dire, FALC) sont proposées par les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé. Pour un diététicien, c'est une compétence transversale, utile en consultation (BC1), en restauration (BC2 : menus, affichage des allergènes) et en santé publique.

Former une équipe à communiquer clairement : un exemple

Former les professionnels est l'une des actions les plus rentables : une seule formation améliore ensuite des centaines d'échanges avec le public. Le diététicien peut concevoir et animer une courte formation pour une équipe d'animateurs, d'agents de restauration ou de bénévoles.

Exemple – Deux demi-journées pour l'équipe d'un centre social (données fictives)

Public : 14 animateurs et bénévoles du centre social. **Durée** : deux séances de 3 heures.

Objectifs : à la fin de la formation, les participants seront capables de réécrire une consigne en écriture claire, de pratiquer le « faire dire » et de repérer trois signaux possibles de difficulté de lecture, sans stigmatiser.

Séance	Contenu	Méthode
1	Qu'est-ce que la littératie ? Les chiffres de HLS19 ; les précautions universelles	Photolangage, quiz à main levée

Séance	Contenu	Méthode
1	Les règles d'écriture claire	Réécriture en binômes de trois documents du centre
2	Le « faire dire » et l'accueil	Jeux de rôle filmés avec l'accord des participants
2	Plan d'action de l'équipe	Chaque binôme choisit un support à améliorer dans le mois

Évaluation : un quiz de 10 questions est proposé avant et après la formation.

Agent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Avant	4	6	5	3	7	5	6	4	5	6	3	5	7	6
Après	8	8	7	7	9	8	8	7	8	9	6	8	9	8

Moyenne avant : 72 / 14 = **5,1 sur 10** ; moyenne après : 110 / 14 = **7,9 sur 10** ; progression moyenne : **+ 2,7 points**. Après la formation, 10 agents sur 14, soit **71,4 %**, obtiennent au moins 8 sur 10.

Coût : intervention du diététicien 2 × 3 h × 45 € = 270 € ; pause et documents 14 × 2 × 3,50 € = 98 € ; total **368 €**, soit **26,29 €** par participant.

Attention – Évaluer la pratique, pas seulement les connaissances

Un bon score au quiz ne prouve pas que les pratiques changent. Pour aller plus loin, on observe quelques accueils (avec l'accord des agents), on compte les supports réécrits trois mois plus tard ou on interroge les usagers sur la clarté des informations reçues. On retrouve les niveaux d'évaluation des connaissances, des pratiques et des résultats pour le public (chapitre 9).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.44

Le service de restauration d'un EHPAD vous demande une formation d'une séance de 2 heures pour 9 agents qui servent les repas et présentent les menus aux résidents.

1. Formulez deux objectifs pédagogiques.
2. Proposez le déroulé de la séance en trois temps, avec une méthode active pour chacun.
3. Calculez le coût si votre intervention est facturée 45 € de l'heure et si les documents coûtent 2 € par agent.
4. Proposez un indicateur de pratique à mesurer un mois plus tard.

Corrigé – Exercice d'application 5.45

1. Exemples : « présenter oralement le menu du jour en phrases courtes, en montrant le plat » ; « vérifier par le "faire dire" qu'un résident a compris le choix proposé ».
2. Exemple : 20 minutes de mise en situation (un agent présente un menu écrit en jargon, les autres jouent les résidents) puis échange ; 50 minutes d'atelier de réécriture des menus en mots simples avec photos ; 50 minutes de jeux de rôle sur la présentation du menu et le « faire dire », en tenant compte des troubles de l'audition et de la vue.
3. 2 × 45 = 90 € ; 9 × 2 = 18 € ; total **108 €**, soit **12 €** par agent.
4. Exemple : part des repas observés où le menu est présenté oralement avec le plat montré (observation de 20 services) ; ou nombre de menus réécrits et affichés en gros caractères.

5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes

Les outils d'intelligence artificielle générative peuvent aider à **simplifier** un texte, proposer des versions dans d'autres langues ou générer des idées d'images ; ils peuvent aussi introduire des **erreurs** (« hallucinations »), des simplifications abusives ou des traductions inexactes. Leur usage professionnel suppose : de ne pas y saisir de données personnelles ou de santé (RGPD, chapitre 6) ; de **vérifier** chaque information auprès des sources officielles ; de faire **relire** par une personne compétente (et par le public pour le FALC) ; d'assumer la responsabilité du contenu diffusé. La compétence C3.3 du référentiel mentionne explicitement la connaissance des enjeux de l'IA.

Utiliser une IA pour simplifier un texte : une méthode prudente

Les règles juridiques et la sécurité des données sont traitées au chapitre 20. Ici, on s'intéresse à la question de la littératie : comment une intelligence artificielle peut **aider** à rendre un texte plus clair sans **dégrader** l'information.

Méthode pas à pas – Simplifier un texte avec une IA en cinq étapes

1. Préparer un texte source exact, déjà validé, sans aucune donnée personnelle (pas de nom, pas de situation de santé individuelle).

2. Donner une consigne précise : le public visé, le niveau de langue, la longueur, les règles d'écriture claire, les mots à conserver (« légumes secs », « Nutri-Score »).

3. Comparer phrase par phrase le texte produit avec le texte source : chaque chiffre, chaque repère et chaque conseil doit être identique ou équivalent.

4. Vérifier les repères auprès des sources officielles datées (Santé publique France, ANSES, HAS) et noter la date de vérification.

5. Tester le texte final auprès de quelques personnes du public (entretien cognitif, 5.3.12) ; pour un texte FALC, la relecture par des personnes en situation de handicap intellectuel reste obligatoire.

Attention – Les erreurs typiques d'une simplification automatique

- **Chiffre modifié** : une quantité, une fréquence ou une unité change (« par semaine » devient « par jour »).
- **Nuance supprimée** : « limiter » devient « supprimer », « au moins » disparaît.
- **Conseil inventé** : une recommandation qui n'existait pas dans le texte source apparaît.
- **Source inventée** : une étude ou un organisme cité n'existe pas.
- **Ton infantilisant** : simplifier ne veut pas dire parler à un adulte comme à un enfant.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.46

Une collègue a demandé à une IA de simplifier un texte sur les repères alimentaires de Santé publique France (2019). Voici le résultat. Repérez les erreurs et corrigez-les.

« Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Les jus de fruits comptent : vous pouvez boire 5 verres de jus pour remplacer les fruits. Mangez des légumes secs (lentilles, pois chiches) une fois par mois. Ne mangez plus jamais de charcuterie. Une étude de l'université de Lyon de 2023 montre que le pain complet fait maigrir. »

Corrigé – Exercice d'application 5.47

- « Au moins 5 fruits et légumes par jour » : **correct**.
- Les jus : **erreur**. Le repère conseille de ne pas boire plus d'un petit verre de jus de fruits par jour ; les jus ne remplacent pas les fruits entiers.
- Légumes secs : **erreur de fréquence**. Le repère est **au moins deux fois par semaine**.
- Charcuterie : **nuance supprimée**. Le repère est de **limiter** la charcuterie à **150 g par semaine**, pas de

l'interdire.

- L'étude citée : **source invérifiable**, probablement inventée ; le texte source ne la contenait pas. On la supprime.

Conclusion : le texte simplifié contient quatre erreurs sur cinq phrases. Il ne doit pas être diffusé sans une vérification complète, phrase par phrase.

5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école

L'école est un lieu privilégié pour développer la littératie alimentaire dès l'enfance, car elle touche tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Le **parcours éducatif de santé** (circulaire du 28 janvier 2016) organise, de la maternelle au lycée, trois axes : l'éducation à la santé, la prévention et la protection de la santé. L'éducation à l'alimentation et au goût y a toute sa place. L'éducation sensorielle (classes du goût) est présentée aux chapitres 1 et 11 ; on s'intéresse ici aux compétences de **lecture**, de **calcul** et d'**esprit critique** liées à l'alimentation.

Âge	Compétences de littératie alimentaire à développer	Exemple d'activité
Maternelle	Nommer les aliments, les classer, reconnaître des familles	Jeu de tri avec de vrais aliments et des photos
Élémentaire (CP-CM2)	Lire une liste d'ingrédients simple, repérer le sucre, comparer deux produits	Poser les morceaux de sucre à côté de l'emballage
Collège	Lire le tableau nutritionnel, calculer pour une portion, analyser une publicité	Comparer deux céréales, décoder une publicité en ligne
Lycée	Juger une information en ligne, débattre d'un sujet (influenceurs, régimes)	Enquête sur la fiabilité de trois vidéos

Exemple – Une séance « Le sucre caché » en CM1 (données fictives)

Une classe de CM1 compte 26 élèves. Avant la séance, 9 élèves savent montrer où se trouve le sucre sur un emballage, soit 9 / 26 = **34,6 %**. La diététicienne apporte un yaourt aromatisé de 125 g qui contient 13 g de sucres pour 100 g : 13 × 1,25 = **16,25 g** de sucres, soit environ **3 morceaux** de 5 g (3,25 exactement). Les élèves posent les morceaux à côté du pot, puis cherchent l'information sur trois autres emballages en binômes. Une semaine plus tard, l'enseignante refait le test : 21 élèves sur 26 réussissent, soit **80,8 %**.

La séance respecte les règles de la littératie : objets réels, consignes courtes, travail à deux, vérification par le « faire dire », aucun aliment présenté comme « interdit ». Un mot simple est remis aux parents avec l'activité à refaire à la maison.

Attention – Ne pas culpabiliser les enfants ni leurs familles

Un enfant n'est pas responsable des achats de sa famille. Les messages doivent rester positifs (« on peut choisir », « on peut goûter »), éviter les aliments « bons » ou « mauvais » et ne jamais commenter le contenu d'un goûter apporté de la maison devant la classe. Associer les parents (réunion, atelier parents-enfants) renforce l'action et évite le conflit de loyauté.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.48

Un collège vous demande une séance de 55 minutes pour une classe de 5e sur les boissons.

1. Formulez un objectif de littératie fonctionnelle et un objectif de littératie critique.
2. Une boisson aux fruits de 33 cL contient 9 g de sucres pour 100 mL. Calculez la quantité de sucres et le nombre de morceaux de 5 g.

3. Proposez le déroulé de la séance en trois temps.
4. Proposez une action pour associer les familles.

Corrigé – Exercice d'application 5.49

1. Fonctionnel : « trouver sur l'étiquette la quantité de sucres pour 100 mL et la calculer pour la bouteille ». Critique : « repérer dans une publicité les techniques utilisées pour donner envie d'acheter une boisson ».
2. 9 × 3,3 = **29,7 g** de sucres, soit environ **6 morceaux** de 5 g (5,94).
3. Exemple : 15 minutes de lecture d'étiquettes en binômes (quatre boissons, calcul pour la bouteille, morceaux de sucre posés à côté) ; 25 minutes d'analyse de deux publicités en petits groupes (qui parle, pour quoi faire, quelles images, quelles preuves) ; 15 minutes de mise en commun et de « faire dire » : chaque groupe énonce une chose qu'il retient.
4. Exemple : les élèves conçoivent eux-mêmes une affiche ou une courte vidéo pour les parents, présentée à la réunion parents-professeurs ; un message court et traduit si besoin est envoyé par l'application de l'établissement.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien d'affirmations compte l'échelle eHEALS, et entre quelles valeurs varie son score ?
2. Quelle est la différence principale entre un médiateur en santé et un interprète professionnel ?
3. Citez quatre des dix caractéristiques d'une organisation « amie de la littératie ».
4. Une grille d'audit donne 13 sur 20. Exprimez ce résultat en pourcentage.
5. Citez trois erreurs typiques d'un texte simplifié par une IA.
6. Pourquoi faut-il éviter de commenter le goûter d'un enfant devant la classe ?

Corrigé – Point d'étape 5.4

1. 8 affirmations notées de 1 à 5 ; score de 8 à 40.
2. Le médiateur fait le lien entre le public et les services et facilite l'accès aux droits ; l'interprète traduit fidèlement et de façon neutre, sans conseiller.
3. Direction engagée ; littératie dans la planification et l'évaluation ; personnel formé ; participation du public ; réponse à des niveaux variés sans stigmatiser ; communication orale claire et vérifiée ; orientation facile ; documents faciles à comprendre ; situations à risque ; coûts expliqués clairement.
4. 13 / 20 × 100 = 65 %.
5. Chiffre modifié ; nuance supprimée ; conseil inventé ; source inventée ; ton infantilisant.
6. L'enfant n'est pas responsable des achats de sa famille ; le commentaire le stigmatise et crée un conflit de loyauté entre l'école et la famille.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie « Pour aller plus loin ».
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes et les exemples de la partie 5.4.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 5.4 et je refais les exercices d'application.

5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer la littératie en santé

Plusieurs instruments existent : **HLS-EU-Q47** et ses versions courtes (Q16, Q12 du HLS19), fondés sur l'autoévaluation des difficultés ; tests de performance comme le **NVS** (*Newest Vital Sign*, Weiss et coll., 2005), qui demande de lire une étiquette de crème glacée et de répondre à 6 questions (calculs de portions, d'énergie, d'allergènes) ; le **HLQ** (*Health Literacy Questionnaire*, Osborne et coll., 2013), à 9 dimensions, conçu pour orienter les interventions (démarche **Ophelia**). Les mesures autodéclarées et les tests de performance ne mesurent pas la même chose ; en pratique de terrain, on ne « teste » pas le public, on applique les précautions universelles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie critique et capacité d'agir collective

Nutbeam (2008) oppose deux conceptions : la littératie comme **facteur de risque** (à repérer et à compenser dans les soins) et la littératie comme **atout** (*asset*) à développer par l'éducation, qui renforce le pouvoir d'agir des personnes et des communautés. Cette seconde conception rejoint la Charte d'Ottawa et la pédagogie de Paulo Freire (*Pédagogie des opprimés*, 1968) : apprendre à « lire le monde » pour le transformer. Dans un projet alimentaire, elle peut conduire un groupe d'habitants à interpeller la mairie sur l'offre de fruits et légumes de leur quartier.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie et intelligence artificielle générative

Les outils d'intelligence artificielle générative (agents conversationnels) sont désormais utilisés par une partie du public pour s'informer sur l'alimentation et la santé. Ils peuvent simplifier un texte, mais produisent parfois des informations inexactes présentées avec assurance. La littératie **critique** inclut désormais la capacité à vérifier une réponse générée par une IA auprès de sources officielles ; le professionnel reste responsable des contenus qu'il diffuse.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La numératie et la perception des risques

Les recherches de Gerd Gigerenzer (Institut Max Planck, Berlin) montrent que de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé, interprètent mal les probabilités conditionnelles et les risques relatifs, alors qu'elles comprennent bien les **fréquences naturelles**. Exemple : « Sur 1 000 personnes, 10 ont la maladie ; le test est positif chez 9 d'entre elles et chez 99 des 990 non-malades » permet de calculer facilement que, parmi les 9 + 99 = 108 tests positifs, seuls 9 / 108 = **8,3 %** correspondent à une maladie réelle, alors que la même information exprimée en pourcentages (prévalence 1 %, sensibilité 90 %, taux de faux positifs 10 %) induit souvent des réponses de l'ordre de 90 %. Ces travaux fondent l'usage des fréquences naturelles et des tableaux d'icônes dans la communication en santé.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La littératie en santé, priorité internationale

La **Déclaration de Shanghai** (OMS, 2016), présentée au chapitre 1 avec les autres grandes conférences de promotion de la santé, fait de la littératie en santé l'un de ses **trois piliers**, avec la bonne gouvernance et les villes-santé. Le rapport du bureau régional de l'OMS pour l'Europe *Health literacy: the solid facts* (Kickbusch, Pelikan, Apfel et Tsouros, 2013) synthétise les données européennes et recommande d'agir à la fois sur les **compétences** des personnes et sur la **complexité** des systèmes. En France, la littératie en santé est inscrite dans la stratégie nationale de santé et dans plusieurs projets régionaux de santé ; l'action du diététicien s'inscrit donc dans des orientations publiques identifiables, qu'il peut citer pour justifier un projet.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La « réactivité » des organisations à la littératie

Le concept de *health literacy responsiveness* (Trezona, Dodson et Osborne, 2017) déplace la question : il ne s'agit plus seulement de savoir si une personne a une littératie suffisante, mais si une **organisation** est capable de s'adapter aux besoins de littératie de tous ses usagers. Le cadre décrit plusieurs domaines (engagement de la direction, systèmes et procédures, communication, compétences du personnel, environnement physique, partenariats). Il complète les dix caractéristiques de Brach (2012) et permet de construire des indicateurs d'évaluation au niveau de la structure, et pas uniquement au niveau des participants.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie, numératie et choix alimentaires : ce que montre la recherche

Plusieurs études observent que les personnes ayant une numératie limitée utilisent moins le tableau nutritionnel, se trompent davantage dans le calcul d'une portion et s'appuient plus sur les allégations de façade. Les logos simples et colorés, comme le Nutri-Score, ont été conçus en partie pour réduire cet écart : les essais menés en France (équipe EREN, Hercberg et Julia) ont montré qu'ils sont mieux compris que des repères chiffrés, y compris par les personnes les moins diplômées. La recherche conclut cependant qu'un logo ne suffit pas : l'environnement (prix, offre, publicité) pèse plus lourd que la compréhension seule sur les achats.

5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et compréhension

Un patient diabétique de type 2 repart d'une consultation avec un plan alimentaire de 4 pages. Le diététicien réduit à 3 messages prioritaires, utilise l'assiette modèle et des photos de portions, pratique le « faire dire » et remet un support d'une page.

Situation bc2 – Les menus affichés

En restauration collective, le diététicien conçoit un affichage des menus avec pictogrammes (plat végétarien, allergènes, fait maison), lisible par les enfants et par les familles qui maîtrisent peu le français.

Situation bc3 – Atelier « lire une étiquette » à l'épicerie solidaire

Le diététicien anime un atelier avec de vrais emballages : comparaison de deux céréales par le Nutri-Score, repérage du sucre dans la liste d'ingrédients, jeu de tri ; les consignes sont orales et imagées, et l'atelier se termine par un « faire dire ».

Situation bc3 – Une campagne municipale accessible

Une ville prépare une campagne sur les boissons sucrées. Le diététicien propose de tester les affiches auprès de collégiens et de parents, de produire une version FALC et une vidéo sous-titrée, et de relayer par les associations de quartier.

Situation bc2 – Affichage des allergènes

Le diététicien d'une cuisine centrale conçoit un affichage des 14 allergènes par pictogrammes et couleurs, compréhensible par les enfants, les familles allophones et les agents, et le teste auprès de 10 parents.

Situation bc3 – Une campagne « sucres cachés »

Pour une campagne dans des collèges, le diététicien remplace les grammes par des morceaux de sucre réels, présente les risques en fréquences naturelles et fait concevoir les affiches par des élèves.

Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet

À l'oral, le jury demande souvent : « Comment avez-vous adapté votre action à votre public ? » Une réponse vague (« j'ai fait simple ») ne montre pas la compétence. Une réponse structurée en quatre temps, appuyée sur des faits, est beaucoup plus convaincante.

Méthode pas à pas – Répondre en 2 minutes avec la structure « constat, choix, vérification, limite »

1. Le constat (20 secondes) : ce que vous saviez du public, avec une source datée (données HLS19, diagnostic, entretien avec la structure). Exemple : « la référente familles m'a indiqué que la moitié des participantes lisent difficilement le français ».

2. Les choix (50 secondes) : deux ou trois adaptations précises, chacune reliée au constat (supports imagés, consignes orales, vrais aliments, horaires, mode d'inscription).

3. La vérification (30 secondes) : comment vous avez vérifié la compréhension (test du support, « faire dire », indice de lisibilité avant et après, retour des participants).

4. La limite et l'amélioration (20 secondes) : ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous changeriez. Le jury apprécie un regard critique honnête.

Exemple – Une réponse structurée (projet fictif)

« **Constat** : l'atelier s'adressait à des résidents d'un foyer de travailleurs migrants ; le directeur m'a indiqué que beaucoup parlent un peu le français mais le lisent peu, et l'enquête HLS19 montre que la littératie limitée est plus fréquente chez les personnes peu diplômées.

Choix : j'ai remplacé la fiche recette écrite par une fiche en six photos numérotées ; j'ai fait les consignes à l'oral en montrant les gestes ; j'ai utilisé des boîtes de conserve réelles pour la lecture des étiquettes, en me limitant au sel.

Vérification : j'ai testé la fiche auprès de trois résidents la semaine précédente, ce qui m'a fait changer deux photos ; en fin d'atelier, chaque participant a montré la boîte la moins salée et expliqué pourquoi.

Limite : deux résidents ne parlaient que le soninké ; la prochaine fois, je prévoirai un résident relais pour la traduction des consignes. »

Attention – Les phrases à éviter devant le jury

- « Mon public avait un faible niveau » : formulation stigmatisante. Préférez « certains participants lisaient difficilement le français ».
- « J'ai testé leur niveau de lecture » : contraire aux précautions universelles, sauf démarche de recherche encadrée et consentie.
- « Le support était adapté » sans preuve : citez un test, un indice ou un retour du public.
- « J'ai traduit avec Google Traduction » sans vérification : un outil automatique ne remplace pas la relecture par une personne qui maîtrise la langue.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.50

Vous avez animé un atelier « petit-déjeuner » dans une école maternelle avec des parents dont plusieurs maîtrisent peu le français écrit. Rédigez votre réponse orale à la question « Comment avez-vous adapté votre action ? » en suivant les quatre temps (environ 10 lignes).

Corrigé – Exercice d'application 5.51

Exemple de réponse : « **Constat** : la directrice m'a signalé que plusieurs parents parlent arabe, turc ou tamoul et lisent peu le français ; les invitations écrites précédentes avaient eu peu de retours. **Choix** : l'invitation a été remise en main propre par les enseignantes, avec un dessin et l'heure en gros chiffres ; pendant l'atelier, j'ai montré de vrais aliments et une assiette modèle, et j'ai limité le message à trois idées ; une maman bilingue a accepté de reformuler les consignes. **Vérification** : à la fin, chaque parent a composé un petit-déjeuner avec les aliments posés sur la table et l'a expliqué à son voisin ; 11 parents sur 13 ont composé un petit-déjeuner conforme aux trois idées. **Limite** : l'atelier avait lieu à 8 h 30, et les parents qui travaillent n'ont pas pu venir ; je proposerais une deuxième séance en fin de journée. »

Le corrigé n'est qu'un exemple : l'essentiel est que chaque adaptation réponde à un constat et que la compréhension soit vérifiée.

Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve

Les sujets E5 présentent souvent un document (affiche, dépliant, page web, menu) et demandent : « Analysez ce support au regard de la littératie en santé et proposez des améliorations. » La méthode ci-dessous évite d'oublier des critères et donne une réponse organisée.

Méthode pas à pas – Analyser un support en cinq critères

1. Le public et l'objectif : à qui s'adresse le support, et que doit faire la personne après l'avoir lu ?

2. Le texte : longueur des phrases, mots difficiles, sigles, chiffres, formulations négatives ; si possible, un indice de lisibilité calculé sur un extrait.

3. La mise en page : taille des caractères, contraste, hiérarchie (titre, message principal), place des images, espaces.

4. Les images et les chiffres : images utiles ou décoratives, pictogrammes compréhensibles, chiffres présentés en fréquences ou en mesures ménagères.

5. L'accès et l'action : où le support est-il diffusé, existe-t-il en version orale, traduite ou numérique accessible ; l'action demandée est-elle possible (coût, lieu, horaires) ?

Pour chaque critère, on écrit **un point fort ou une faiblesse observée dans le document**, puis **une amélioration précise**. On termine par la manière de tester la nouvelle version auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.52

Une mairie distribue ce texte imprimé en police 9, en gris clair sur fond blanc, sans image : « Dans le cadre du PNNS et du PAT, la Ville organise, sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits, des ateliers nutritionnels non obligatoires visant l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des ménages. Inscriptions exclusivement sur le portail citoyen avant le 15/03. »

Analysez ce support avec les cinq critères et proposez une nouvelle version.

Corrigé – Exercice d'application 5.53

1. Public et objectif : le public n'est pas nommé et l'action attendue (s'inscrire) arrive à la fin. Amélioration : commencer par l'invitation.

2. Texte : deux phrases longues, deux sigles (PNNS, PAT), une négation (« non obligatoires »), des mots abstraits (« qualité nutritionnelle de l'alimentation des ménages »). Amélioration : phrases courtes, mots courants, sigles supprimés.

3. Mise en page : police 9 et gris clair, contraste insuffisant. Amélioration : police d'au moins 12 à 14 points, texte noir ou très foncé, titre en gras.

4. Images : aucune. Amélioration : une photo d'un atelier ou d'un plat, un pictogramme pour la date et le lieu.

5. Accès et action : inscription uniquement en ligne, ce qui exclut une partie du public. Amélioration : inscription aussi par téléphone et à l'accueil de la mairie ou du centre social.

Nouvelle version : « Venez cuisiner avec nous ! Ateliers cuisine gratuits pour toute la famille. Où : centre social, 12 rue des Écoles. Quand : les mercredis de 14 h à 16 h. Pour vous inscrire : à l'accueil de la mairie, par téléphone au (numéro) ou sur le site de la ville. Avant le 15 mars. » La version est ensuite testée auprès de cinq habitants.

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « La littératie en santé, c'est savoir lire. »
2. « Une personne diplômée a forcément une bonne littératie en santé. »
3. « Les précautions universelles consistent à communiquer clairement avec tout le monde. »
4. « Il faut demander aux participants leur niveau de lecture au début d'un atelier. »
5. « Un indice de Flesch élevé signifie que le texte est difficile. »
6. « Un bon indice de lisibilité suffit pour valider un support. »
7. « Le FALC peut être rédigé seul par un professionnel, sans relecture. »
8. « Demander "Avez-vous compris ?" permet de vérifier la compréhension. »
9. « Le "faire dire" teste la mémoire du patient. »
10. « Un risque qui passe de 2 sur 1 000 à 1 sur 1 000 diminue de 50 %. »
11. « Faire traduire un entretien de santé par l'enfant de la famille est une bonne solution. »
12. « Le Nutri-Score permet de comparer des produits d'une même catégorie. »
13. « Mettre tout le texte en majuscules le rend plus lisible. »
14. « La littératie critique permet d'agir collectivement sur son environnement. »
15. « Agir sur la littératie, c'est seulement former les personnes. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. **Faux.** Elle comprend l'accès, la compréhension, l'évaluation et l'application de l'information de santé (Sørensen, 2012), à l'écrit comme à l'oral et en ligne.
2. **Faux.** La littératie dépend aussi de la situation : une personne diplômée peut être en difficulté face à un diagnostic grave, au stress ou à un vocabulaire médical inhabituel.
3. **Vrai.** On ne peut pas savoir qui a des difficultés ; on adapte donc la communication pour tous, sans repérage stigmatisant.
4. **Faux.** C'est stigmatisant et contraire aux précautions universelles ; la honte peut éloigner les personnes de l'atelier.
5. **Faux.** C'est l'inverse : plus l'indice de Flesch (ou de Kandel et Moles) est élevé, plus le texte est facile à lire.

6. **Faux.** L'indice ne mesure ni le sens des mots, ni les images, ni la mise en page ; seul un test auprès du public montre la compréhension.
7. **Faux.** Les règles européennes du FALC prévoient la participation de personnes en situation de handicap intellectuel à la rédaction ou à la relecture.
8. **Faux.** La plupart des personnes répondent « oui » par politesse ou par gêne ; il faut demander de reformuler ou de montrer.
9. **Faux.** Il teste la **clarté des explications du professionnel** : si la personne ne sait pas reformuler, c'est l'explication qu'il faut reprendre.
10. **Vrai**, en risque relatif ; mais la diminution absolue n'est que de 1 sur 1 000. Il faut présenter les deux, de préférence en fréquences naturelles.
11. **Faux.** L'enfant n'a ni la neutralité ni le vocabulaire d'un interprète, et le rôle inverse sa place dans la famille ; on fait appel à un interprète professionnel.
12. **Vrai.** Il est surtout utile pour comparer des produits comparables (des céréales entre elles, par exemple) ; il ne dit pas s'il faut manger un aliment ni en quelle quantité.
13. **Faux.** Les majuscules ralentissent la lecture, car les mots perdent leur forme ; on les réserve à quelques mots courts.
14. **Vrai.** Selon Nutbeam, la littératie critique permet d'analyser l'information et d'agir, seul ou en groupe, sur les déterminants de la santé.
15. **Faux.** Il faut aussi simplifier l'environnement : documents, démarches, signalétique, formation des professionnels (organisations « amies de la littératie »).

Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours

La littératie n'est pas une notion isolée : à l'épreuve, elle se combine presque toujours avec d'autres parties du programme. Le tableau ci-dessous aide à faire ces liens sans répéter les contenus.

Notion du chapitre 5	Lien avec	Ce que l'on mobilise
Gradient social de la littératie	Chapitre 2 (inégalités sociales de santé)	Universalisme proportionné, lentille inégalités
Précautions universelles, honte	Chapitre 3 (psychologie sociale)	Estime de soi, stigmatisation, influence des pairs
Littératie alimentaire	Chapitre 4 (pratiques alimentaires)	Stratégies des ménages modestes, cultures culinaires
Respect de la personne, interprétariat	Chapitre 6 (éthique)	Autonomie, consentement, secret
Littératie à chaque étape du projet	Chapitres 7 à 9 (démarche de projet)	Diagnostic participatif, objectifs, évaluation
Atelier accessible	Chapitre 10 (atelier culinaire)	Fiches recettes imagées, consignes orales
Supports écrits et numériques	Chapitres 14 et 15 (communication)	Choix du canal, conception graphique, accessibilité
Numératie, risques	Chapitre 16 (épidémiologie)	Risques relatifs et absolus, fréquences
Fiabilité de l'information	Chapitre 19 (veille et lecture critique)	Sources, niveau de preuve
IA, données, accessibilité numérique	Chapitre 20 (numérique en santé)	RGPD, responsabilité, outils

À vous de jouer – Exercice d'application 5.54

Un sujet E5 présente un projet de « défi cuisine » dans un quartier prioritaire, avec inscription en ligne et livret de recettes de 20 pages. Citez trois chapitres du cours que vous mobiliseriez en plus du chapitre 5 et

indiquez pour chacun l'idée principale.

Corrigé – Exercice d'application 5.55

Exemples : **chapitre 2**, l'inscription en ligne et le livret long risquent de creuser les inégalités, d'où des modalités adaptées aux habitants les plus éloignés ; **chapitre 7**, associer les habitants au diagnostic et à la conception du défi ; **chapitre 15**, transformer le livret en fiches recettes courtes et imagées, testées auprès du public ; **chapitre 10**, prévoir des recettes réalisables avec un petit équipement et un petit budget. Trois liens justifiés suffisent.

5.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Définitions et données

- **Littératie en santé** (Sørensen, 2012) : connaissances, motivation et compétences pour **accéder, comprendre, évaluer, appliquer** l'information, dans les domaines des **soins**, de la **prévention** et de la **promotion de la santé** (12 dimensions).
- **Niveaux** (Nutbeam, 2000) : **fonctionnel** (lire, comprendre), **interactif** (échanger), **critique** (juger, agir).
- **Littératie alimentaire** : planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger (Vidgen et Gallegos, 2014).
- **France (HLS19, 2021)** : environ **44 %** des adultes ont une littératie limitée ; difficultés encore plus fréquentes en **numérique** ; **gradient social**.
- **Illettrisme** 7 % des 18-65 ans (ANLCI, 2011) ; **illectronisme** 7 % des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; faible maîtrise de l'écrit 28 % des 16-65 ans (PIAAC 2023).
- Conséquences : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne gestion des maladies chroniques ; **creusement des inégalités** si la communication n'est pas adaptée.

À retenir – Pratique professionnelle

- **Précautions universelles** : communiquer clairement avec tous, sans tester ni stigmatiser.
- **Écrire simple** : une idée par phrase, mots courants, forme active et positive, chiffres concrets, pictogrammes, mise en page aérée ; **FALC** ; tester les supports.
- **Lisibilité** : L = 207 − 1,015 × (mots/phrase) − 73,6 × (syllabes/mot).
- **Faire dire** (HAS, 2015) : expliquer → faire reformuler → vérifier → réexpliquer autrement → confirmer.
- **Plusieurs canaux** : oral, imagé, numérique accompagné, médiation, relais.

À retenir – Compléments : étiquettes, numératie, numérique, allophonie

- **Étiquette** (règlement INCO 1169/2011) : dénomination, ingrédients (ordre décroissant, 14 allergènes), Nutri-Score (comparer dans une même famille ; algorithme révisé), tableau pour 100 g et par portion, dates, prix au kilo.
- **Sucres** : g pour 100 mL × volume / 100 ; un morceau ≈ 5 g ; OMS : sucres libres < 10 % de l'énergie (≈ 50 g pour 2 000 kcal).
- **Numératie** : fréquences naturelles (« 6 sur 100 ») ; tableaux d'icônes ; donner la réduction **absolue** et **relative**.
- **Numérique** : évaluer une application (éditeur, fondement, mise à jour, données, accessibilité, effets indésirables) ; RGAA / WCAG ; texte alternatif, sous-titres.
- **Allophones** : interprétariat professionnel, médiateurs, supports testés, pictogrammes ; pas d'enfants

interprètes.

- **Tester** : l'indice de lisibilité ne remplace pas le test de compréhension auprès du public.

5.8 Entraînement

5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Selon Sørensen (2012), les quatre compétences de la littératie en santé sont :

a) accéder **b)** mémoriser **c)** évaluer **d)** appliquer

QCM 2 – Les trois domaines du modèle de Sørensen sont :

a) les soins **b)** la prévention **c)** la promotion de la santé **d)** la recherche

QCM 3 – La littératie critique (Nutbeam) correspond à :

a) savoir lire une étiquette **b)** juger la fiabilité d'une information et agir sur ses déterminants **c)** échanger avec un professionnel **d)** le niveau le plus élevé d'autonomie

QCM 4 – D'après HLS19, la part des adultes en France ayant une littératie en santé limitée est d'environ :

a) 7 % **b)** 15 % **c)** 44 % **d)** 90 %

QCM 5 – L'illettrisme concerne des personnes :

a) jamais scolarisées **b)** scolarisées en France sans maîtrise suffisante de l'écrit **c)** apprenant le français comme langue étrangère **d)** environ 7 % des 18-65 ans en 2011

QCM 6 – L'approche des précautions universelles consiste à :

a) tester le niveau de lecture de chaque participant **b)** communiquer clairement avec tout le monde **c)** éviter de désigner les personnes en difficulté **d)** réserver les supports simplifiés aux personnes illettrées

QCM 7 – La technique du « faire dire » :

a) consiste à demander « Vous avez compris ? » **b)** fait reformuler la personne avec ses mots **c)** vérifie la clarté du professionnel **d)** a fait l'objet d'une fiche-outil de la HAS

QCM 8 – Parmi ces règles d'écriture claire, lesquelles sont correctes ?

a) une idée par phrase **b)** utiliser des sigles pour gagner de la place **c)** préférer la forme active **d)** écrire en majuscules pour être lisible

QCM 9 – Le FALC :

a) signifie « facile à lire et à comprendre » **b)** repose sur des règles européennes **c)** implique une relecture par des personnes concernées **d)** est réservé aux enfants

QCM 10 – Dans l'indice de Kandel et Moles, la lisibilité augmente quand :

a) les phrases sont plus courtes **b)** les mots ont moins de syllabes **c)** le texte est plus long **d)** le texte contient plus de sigles

QCM 11 – La littératie alimentaire comprend :

a) planifier et gérer **b)** sélectionner **c)** préparer **d)** manger

QCM 12 – Une littératie en santé limitée est associée à :

a) un moindre recours à la prévention **b)** davantage d'hospitalisations **c)** une meilleure observance **d)** un creusement des inégalités sociales de santé

QCM 13 – L'illectronisme :

a) concerne environ 7 % des 16-74 ans (Insee, 2025) **b)** est sans effet sur l'accès à la prévention **c)** justifie de ne pas réserver une inscription au numérique **d)** désigne une maladie de la vue

QCM 14 – La médiation en santé :

a) est inscrite dans le Code de la santé publique **b)** a fait l'objet d'un référentiel de la HAS en 2017 **c)** remplace le diététicien **d)** facilite le lien entre publics éloignés et professionnels

QCM 15 – Le Nutri-Score :

a) a été conçu pour être compris par le plus grand nombre **b)** remplace la liste d'ingrédients **c)** permet de comparer des produits d'une même famille **d)** n'a aucun lien avec la littératie

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d (+ comprendre). 2. **a, b, c**. 3. **b, d**. 4. **c**. 5. **b, d** (a = analphabétisme ; c = FLE). 6. **b, c**. 7. **b, c, d** (a est justement à éviter). 8. **a, c**. 9. **a, b, c**. 10. **a, b**. 11. **a, b, c, d**. 12. **a, b, d**. 13. **a, c**. 14. **a, b, d**. 15. **a, c**.

QCM 16 – Dans la liste des ingrédients :

a) les ingrédients sont classés par ordre décroissant de poids **b)** les allergènes sont mis en évidence **c)** le premier ingrédient est le moins abondant **d)** le classement est libre

QCM 17 – Une boisson à 10 g de sucres pour 100 mL, en bouteille de 50 cL, contient environ :

a) 10 g de sucres **b)** 50 g de sucres **c)** 10 morceaux de sucre **d)** 2 morceaux de sucre

QCM 18 – Un risque qui passe de 4 sur 100 à 2 sur 100 correspond à :

a) une réduction absolue de 2 points **b)** une réduction relative de 50 % **c)** une réduction relative de 2 % **d)** une réduction absolue de 50 %

QCM 19 – Pour rendre une vidéo de prévention accessible, on ajoute :

a) des sous-titres **b)** une musique forte **c)** une version audio-décrite ou un texte explicatif **d)** un texte alternatif aux images de la page

QCM 20 – Le Nutri-Score permet de :

a) comparer des produits d'une même famille **b)** comparer une pizza et une pomme **c)** remplacer la liste des ingrédients **d)** mesurer le degré de transformation

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b. 17. **b, c** (10 × 500 / 100 = 50 g ; 50 / 5 = 10 morceaux). 18. **a, b**. 19. **a, c, d**. 20. **a**.

5.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le modèle de Sørensen

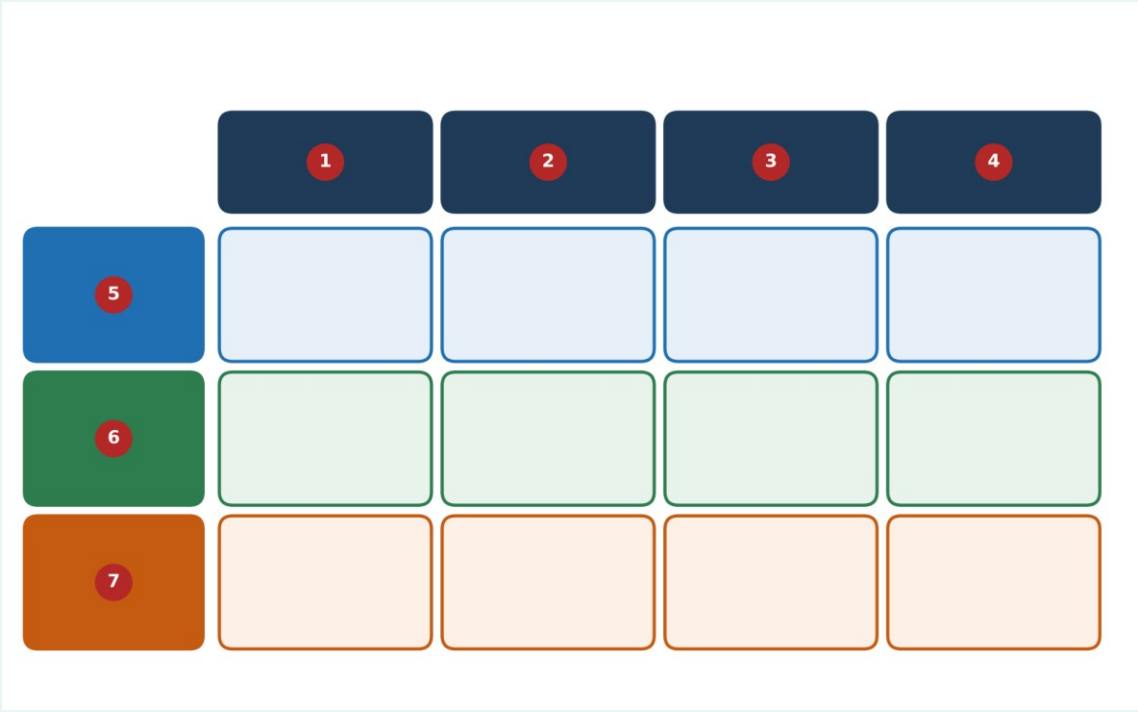


Figure 5.9 – Schéma à légender

Légendez les colonnes 1 à 4 et les lignes 5 à 7, puis complétez trois cases avec un exemple alimentaire.

Corrigé

1. Accéder. 2. Comprendre. 3. Évaluer. 4. Appliquer. 5. Soins. 6. Prévention. 7. Promotion de la santé. Exemples : *prévention × comprendre* : comprendre le Nutri-Score ; *prévention × évaluer* : juger un conseil minceur sur un réseau social ; *promotion × accéder* : connaître l'épicerie solidaire du quartier.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les niveaux de Nutbeam

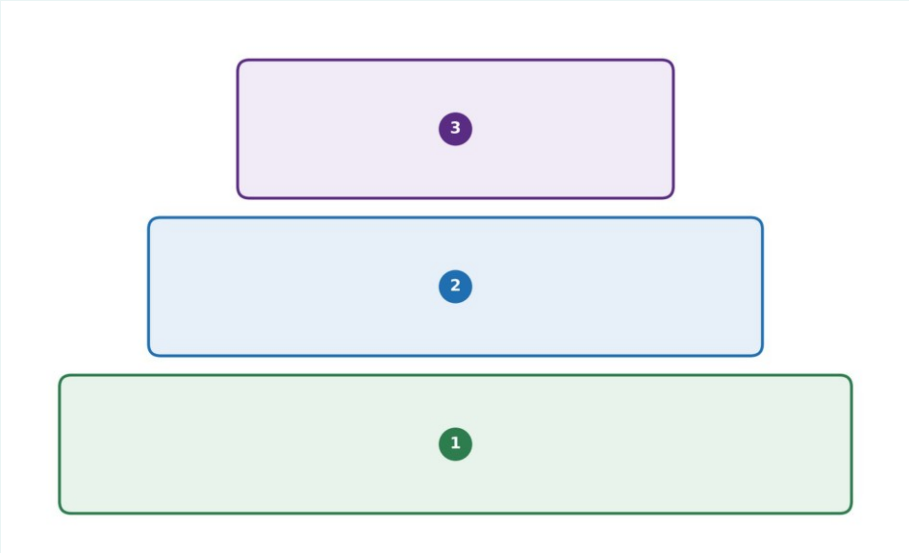


Figure 5.10 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 3 et associez chacune des situations suivantes à un niveau : a) Mme K. lit la date limite sur un yaourt ; b) M. T. demande au diététicien si les conseils s'appliquent à son travail de nuit ; c) un collectif de parents obtient de l'eau en carafe à la cantine.

Corrigé

1. Fonctionnelle – a. 2. **Interactive** – b. 3. **Critique** – c (action collective sur un déterminant).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le faire dire

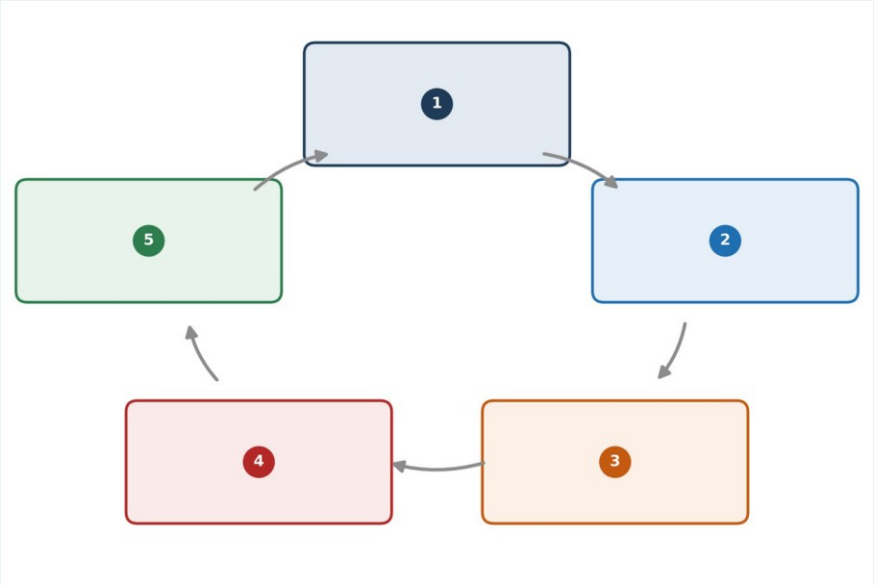


Figure 5.11 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 5 et rédigez la phrase que vous utiliseriez à l'étape 2 après un atelier sur la lecture des étiquettes.

Corrigé

1. Expliquer. 2. Faire dire. 3. Vérifier. 4. Réexpliquer autrement. 5. Confirmer. Phrase : « Pour vérifier que j'ai bien expliqué : montrez-moi, avec ces deux paquets de biscuits, lequel vous choisiriez et pourquoi. »

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer un indice de lisibilité

Un texte de prévention compte 150 mots, 6 phrases et 255 syllabes. a) Calculez l'indice de Kandel et Moles et interprétez. b) Après réécriture : 140 mots, 14 phrases, 210 syllabes. Recalculez et concluez.

Corrigé

a) Mots/phrase = 150 / 6 = **25** ; syllabes/mot = 255 / 150 = **1,7**. L = 207 − 1,015 × 25 − 73,6 × 1,7 = 207 − 25,375 − 125,12 = **56,505 ≈ 56,5** → assez difficile. **b)** Mots/phrase = 140 / 14 = **10** ; syllabes/mot = 210 / 140 = **1,5**. L = 207 − 1,015 × 10 − 73,6 × 1,5 = 207 − 10,15 − 110,4 = **86,45** → facile. Gain : 86,45 − 56,505 = **29,9 points**. L'indice confirme l'amélioration, mais le texte doit encore être **testé** auprès du public.

À vous de jouer – Exercice 5 – Réécrire un message

Réécrivez en langage clair : « La consommation de légumineuses, sources de protéines végétales et de fibres, doit être augmentée à au moins deux fois par semaine conformément aux recommandations nutritionnelles en vigueur. »

Corrigé

« Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins 2 fois par semaine. Ils nourrissent bien et coûtent peu cher. » + photos des trois aliments + un exemple de plat (dahl, chili, salade de lentilles). Les mots « légumineuses », « protéines végétales » et « recommandations en vigueur » ont été remplacés par des exemples concrets.

À vous de jouer – Exercice 6 – Analyser un support existant

Une affiche d'atelier comporte : un titre « Programme d'éducation nutritionnelle PNNS – Session 2 », un texte justifié de 12 lignes en police 10, une photo décorative de salade, une inscription par QR code uniquement. Relevez les problèmes et proposez des corrections.

Corrigé

Problèmes : sigle (PNNS), titre abstrait qui ne dit pas ce qu'on va faire ; texte long, justifié, police trop petite ; image décorative sans information ; inscription uniquement numérique (exclusion des personnes en illectronisme). Corrections : titre concret « Cuisinons ensemble des repas pas chers » ; 3 informations (quand, où, gratuit) en gros caractères avec pictogrammes (horloge, lieu, euro barré) ; photo de participants en train de cuisiner ; inscription à l'accueil, par téléphone **ou** par QR code.

À vous de jouer – Exercice 7 – Interpréter des données

Dans un questionnaire de diagnostic rempli par 60 personnes d'une épicerie solidaire, 27 déclarent qu'il leur est « difficile » ou « très difficile » de comprendre les informations sur les emballages, et 42 n'ont jamais utilisé le site *mangerbouger.fr*. Calculez les pourcentages et proposez deux conséquences pour l'action.

Corrigé

27 / 60 × 100 = **45 %** ont des difficultés avec les emballages (proche de l'ordre de grandeur national de HLS19, 44 %) ; 42 / 60 × 100 = **70 %** n'utilisent pas le site. Conséquences : atelier pratique avec de vrais emballages (compétence « comprendre » et « évaluer ») ; supports papier et oraux plutôt qu'un renvoi au site, ou accompagnement à son utilisation sur smartphone.

À vous de jouer – Exercice 8 – Recette en images

Transformez la recette suivante en fiche accessible : « Faire revenir 1 oignon émincé dans 1 c. à s. d'huile, ajouter 200 g de lentilles corail rincées, 400 g de tomates concassées et 600 mL d'eau, cuire 15 min, assaisonner de cumin. »

Corrigé

Titre : **Soupe de lentilles corail** (4 personnes, 20 minutes, environ 2 €). Étape 1 (photo) : Coupez 1 oignon en petits morceaux. Étape 2 : Faites cuire l'oignon avec 1 cuillère à soupe d'huile, 3 minutes. Étape 3 : Lavez 1 grand verre de lentilles corail (200 g) dans une passoire. Étape 4 : Mettez les lentilles, 1 boîte de tomates et 3 verres d'eau (600 mL avec un verre de 200 mL). Étape 5 : Faites cuire 15 minutes. Étape 6 : Ajoutez 1 pincée de cumin et de sel. Chaque étape a une photo, une seule action, un verbe d'action au début.

À vous de jouer – Exercice 9 – Juger une information en ligne

Une vidéo d'un influenceur affirme : « Le jus de citron à jeun fait fondre les graisses : -5 kg en 2 semaines ! » Appliquez la grille des 6 questions.

Corrigé

Auteur : influenceur sans qualification en santé identifiée ; objectif : souvent commercial (lien vers une cure) ; sources : aucune étude citée ; date : non pertinente ici ; cohérence : contraire aux connaissances (aucun aliment ne « fait fondre » les graisses) ; promesse miraculeuse et rapide : **signal d'alerte**. Conclusion : information non fiable ; c'est un bon support pour un atelier de littératie critique.

À vous de jouer – Exercice 10 – Questionnaire accessible

Transformez la question suivante pour des enfants de 8 ans : « Évaluez votre niveau de satisfaction concernant l'atelier sur une échelle de 1 à 10. »

Corrigé

« As-tu aimé l'atelier ? » avec trois ou cinq visages (très content, content, moyen, pas content, pas du tout content) à entourer ou une gommette à coller ; question complémentaire orale : « Qu'est-ce que tu as préféré ? ».

5.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi dit-on que la littératie en santé est aussi une responsabilité des professionnels et des organisations ?

Corrigé

Parce que la difficulté naît de la **rencontre** entre les compétences d'une personne et la complexité de l'information et des services. Simplifier les documents, former les professionnels, proposer plusieurs canaux réduit les difficultés pour tous, sans faire porter l'effort sur les seules personnes (littératie organisationnelle). C'est aussi une question d'équité.

À vous de jouer – Question 2

Une campagne de prévention diffusée uniquement sur les réseaux sociaux peut-elle accroître les inégalités ?

Corrigé

Oui : les personnes les plus favorisées ont plus d'accès et de compétences numériques et critiques ; elles s'approprient mieux les messages. Les personnes en illectronisme ou à littératie limitée sont moins touchées. D'où l'universalisme proportionné : diffusion large **et** actions de proximité adaptées (ateliers, relais, médiation).

À vous de jouer – Question 3

Simplifier un message, est-ce le rendre moins exact ?

Corrigé

Non, si on choisit l'**essentiel** et qu'on le formule concrètement : « 5 fruits et légumes par jour » est simple et exact. Le risque est de simplifier jusqu'à l'erreur (« le gras, c'est mauvais ») ; on garde donc la validation scientifique du fond (repères officiels) et on adapte la forme. La simplification est un travail exigeant, pas un appauvrissement.

5.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le foyer de travailleurs migrants

Un foyer de travailleurs migrants (180 résidents, âge moyen 58 ans) souhaite une action sur le diabète et l'alimentation. Une partie des résidents lit peu le français ; beaucoup cuisinent collectivement dans les cuisines d'étage ; le gestionnaire propose de « distribuer la brochure de l'Assurance maladie ».

1. Analysez les enjeux de littératie (domaines et niveaux).
2. Pourquoi la brochure seule est-elle insuffisante ?
3. Proposez une action adaptée (supports, méthodes, partenaires).
4. Comment vérifier la compréhension ?
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation accessibles.

Corrigé

1. Domaines : **prévention** (dépistage du diabète), **soins** (comprendre un traitement) ; niveaux fonctionnel (lecture) et interactif (échanger avec un soignant) ; facteurs : langue, âge, culture culinaire, cuisine collective.
2. Elle repose sur l'écrit en français, est générale, ne tient pas compte des plats cuisinés au foyer ni des pratiques (Ramadan, plats communautaires).
3. Groupe de parole et atelier culinaire dans la cuisine d'étage, avec un **médiateur en santé** ou un résident relais parlant les langues du groupe ; supports imagés (assiette, portions de riz et de semoule en photos) ; travail sur les plats habituels (mafé, riz au poisson) pour ajuster les portions de féculents et ajouter des légumes ; partenariat avec la CPAM ou un centre d'examens de santé pour un dépistage, la PASS ou le centre de santé pour l'orientation.
4. Faire dire en petit groupe (« Montrez-moi la quantité de riz pour une assiette »), démonstrations, questions ouvertes, avec traduction.
5. Nombre de résidents ayant participé et ayant réalisé un dépistage ; proportion de participants capables de montrer la portion conseillée en fin de séance (observation).

5.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Donnez une définition de la littératie en santé. »

Corrigé

Ce sont les connaissances, la motivation et les compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé (Sørensen, 2012).

Mise en situation – MSE 2

Une participante dit : « J'ai oublié mes lunettes, je remplirai le questionnaire chez moi. »

Corrigé

Je ne mets pas la personne en difficulté : je propose de lui poser les questions oralement (« Je peux vous les lire, ça ira plus vite ») et je note les réponses ; à l'avenir, je proposerai l'oral à tout le groupe.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pourquoi ne pas demander "Vous avez compris ?" »

Corrigé

Parce que la réponse est presque toujours « oui », par politesse ou par gêne ; je préfère le faire dire : faire reformuler ou montrer, ce qui vérifie vraiment ma clarté.

Mise en situation – MSE 4

Votre tutrice vous demande une affiche pour un atelier ; vous avez 30 minutes.

Corrigé

Un titre concret, trois informations (quoi, quand, où) en gros caractères, des pictogrammes, une photo réelle, une inscription possible à l'accueil ; je la fais relire par deux personnes du public avant impression.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Quel chiffre retenez-vous sur la littératie en France ? »

Corrigé

Environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (HLS19, résultats 2021), avec des difficultés plus fréquentes pour les informations numériques et un gradient social marqué.

Mise en situation – MSE 6

Un parent ne parle pas français et vient à l'atelier avec son enfant de 10 ans qui traduit.

Corrigé

J'accueille le parent, je privilégie la démonstration et les images ; je ne fais pas porter à l'enfant des informations de santé complexes ou intimes ; je recherche un interprète ou un adulte relais (médiatrice) pour les séances suivantes.

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Qu'est-ce que le FALC ? »

Corrigé

Le « facile à lire et à comprendre » : une méthode de rédaction fondée sur des règles européennes (Inclusion Europe, 2009), conçue avec des personnes en situation de handicap intellectuel, et validée par des relecteurs

concernés.

Mise en situation – MSE 8

Un participant affirme : « J'ai vu sur internet que le gluten est un poison. »

Corrigé

Je l'écoute, puis on applique ensemble la grille de fiabilité (qui ? quel objectif ? quelles sources ?) ; j'explique que l'éviction du gluten ne se justifie qu'en cas de maladie cœliaque ou d'allergie diagnostiquée ; j'en fais un exemple de littératie critique pour le groupe.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Comment avez-vous pris en compte la littératie dans votre projet ? »

Corrigé

À chaque étape : diagnostic oral, objectifs de compétences, supports testés et imagés, méthodes actives et faire dire, communication multicanale, évaluation par smileys et questions orales ; j'illustre par un exemple précis et un chiffre (par exemple, l'indice de lisibilité avant et après).

Mise en situation – MSE 10

La mairie veut lancer une application de recettes pour les familles du quartier.

Corrigé

Je salue l'idée mais je rappelle l'illectronisme (7 % des 16-74 ans en 2025, et 34 % en difficulté numérique) : je propose de l'associer à des ateliers d'accompagnement, à une version papier des recettes et à des relais humains, et de tester l'application avec des habitants.

Mise en situation – MSE 11

Le jury : « Faut-il faire passer un test de lecture aux participants ? »

Corrigé

Non : cela stigmatise et n'est pas nécessaire ; j'applique les précautions universelles en communiquant clairement avec tout le monde, et j'observe les besoins pour ajuster.

Mise en situation – MSE 12

Une collègue propose de traduire l'affiche avec un traducteur automatique.

Corrigé

Je propose plutôt une traduction relue par une personne qui parle la langue (médiatrice, habitant relais), car une erreur dans un message de santé peut être grave ; et je privilégie les pictogrammes et la transmission orale.

5.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Sucres en morceaux

Calculez en grammes et en morceaux de sucre (5 g) : a) un soda à 10,6 g/100 mL, canette de 33 cL ; b) un yaourt aromatisé de 125 g à 12 g/100 g ; c) une compote « sans sucres ajoutés » à 12,5 g/100 g, gourde de 90 g. Commentez c.

Corrigé

a) 10,6 × 3,3 = **35,0 g**, soit **7 morceaux**. b) 12 × 1,25 = **15 g**, soit **3 morceaux**. c) 12,5 × 0,9 = **11,25 g**, soit **2,25 morceaux** : « sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres » : ce sont les sucres naturellement présents dans les fruits (moins préoccupants que les sucres libres d'un soda, mais à connaître).

À vous de jouer – Exercice 12 – Fréquences naturelles

Reformulez en fréquences naturelles et donnez les réductions absolue et relative : « Manger des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de ce problème de 0,8 % à 0,6 %. »

Corrigé

« Sur 1 000 personnes, 8 auraient ce problème sans fruits et légumes quotidiens, et 6 avec. » Réduction absolue : 8 − 6 = **2 personnes sur 1 000** (0,2 point) ; relative : 2 / 8 × 100 = **25 %**.

À vous de jouer – Exercice 13 – Évaluer une application

Une famille utilise une application qui note les produits de 0 à 100 et colore en rouge tous les produits contenant un additif. Appliquez la grille d'évaluation et donnez un conseil.

Corrigé

Éditeur et financement : à vérifier (société privée, modèle économique) ; fondement : algorithme propre, différent du Nutri-Score officiel, qui pénalise fortement les additifs ; mise à jour : variable ; données personnelles : vérifier les autorisations ; effets indésirables possibles : peur de tous les additifs, exclusion de produits utiles (conserves de légumes), culpabilisation. Conseil : l'utiliser comme une information parmi d'autres, se référer au Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle et privilégier les produits peu transformés, sans s'inquiéter de chaque additif.

À vous de jouer – Exercice 14 – Lisibilité et test

Une fiche passe de 180 mots en 8 phrases (300 syllabes) à 120 mots en 15 phrases (180 syllabes). Calculez les deux indices. Au test, 4 personnes sur 10 comprennent la version 1 et 8 sur 10 la version 2. Concluez.

Corrigé

V1 : 180 / 8 = 22,5 mots par phrase ; 300 / 180 = 1,667 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 22,5 − 73,6 × 1,667 = 207 − 22,84 − 122,69 = **61,47** (standard). V2 : 120 / 15 = 8 ; 180 / 120 = 1,5 ; L = 207 − 8,12 − 110,4 = **88,48** (facile). Compréhension : **40 %** → **80 %**. Les deux mesures convergent ; c'est le test qui démontre la compréhension.

À vous de jouer – Exercice 15 – Adapter pour un public allophone

Un atelier réunit 10 participantes dont 4 parlent peu le français (2 en arabe, 2 en tamoul). Proposez 5 adaptations.

Corrigé

Interprète professionnel ou médiatrice pour l'accueil et les consignes de sécurité ; démonstration avant chaque étape ; recette en photos, quantités en contenants ; pictogrammes des allergènes ; binômes associant une participante francophone et une non francophone ; vocabulaire culinaire illustré à emporter ; vérification par « montrez-moi » plutôt que par questions verbales.

5.9 Glossaire

Terme	Définition
Analphabétisme	Situation de personnes jamais scolarisées, n'ayant pas appris à lire et à écrire
FALC	Facile à lire et à comprendre : méthode de rédaction fondée sur des règles européennes (2009), avec relecture par des personnes concernées
Faire dire (teach-back)	Technique qui fait reformuler la personne pour vérifier la clarté du professionnel
HLS19	Enquête européenne sur la littératie en santé (réseau M-POHL, OMS Europe), 2019-2021
Illectronisme	Difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques et internet
Illettrisme	Maîtrise insuffisante de l'écrit et du calcul chez des personnes scolarisées en France
Indice de lisibilité	Estimation de la difficulté d'un texte à partir de la longueur des phrases et des mots
Littératie alimentaire	Compétences pour planifier, sélectionner, préparer et manger des aliments
Littératie critique	Capacité à juger l'information et à agir sur les déterminants de sa santé
Littératie en santé	Connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé
Littératie fonctionnelle	Compétences de base en lecture, écriture et calcul
Littératie interactive	Capacité à échanger et à extraire l'information d'une communication
Littératie numérique en santé	Capacité à trouver, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en ligne
Littératie organisationnelle	Capacité d'une structure à rendre information et services faciles à trouver, comprendre et utiliser
Médiation en santé	Fonction d'interface entre publics éloignés et professionnels (art. L. 1110-13 CSP ; HAS, 2017)
Précautions universelles	Communication claire appliquée à tous, sans repérage stigmatisant
Pictogramme	Dessin simple qui représente une action, un objet ou une information
Allophone	Personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où elle vit

Terme	Définition
Fréquences naturelles	Présentation d'un risque en nombre de personnes (« 6 sur 100 »)
Numératie	Capacité à comprendre et utiliser nombres, pourcentages et risques
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité des services numériques publics
Règlement INCO	Règlement (UE) n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Réduction absolue / relative	Différence de risques en points / rapportée au risque initial
Tableau d'icônes	Représentation d'un risque par 100 (ou 1 000) pictogrammes dont certains colorés
Texte alternatif	Description textuelle d'une image, lue par les logiciels de synthèse vocale

5.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, modèles	[1] Sørensen ; [2] Nutbeam 2000 ; [3] Nutbeam 2008 ; [4] Vidgen et Gallegos
Données	[5] HLS19 ; [6] ANLCI ; [7] Insee illectronisme ; [8] OCDE PIAAC
Conséquences	[9] Berkman et coll.
Adapter, FALC	[10] Santé publique France, Communiquer pour tous ; [11] Inclusion Europe ; [12] Kandel et Moles
Faire dire, médiation	[13] HAS Faire dire ; [14] HAS médiation et interprétariat
Organisations, mesure	[15] Brach et coll. ; [16] Norman et Skinner ; [17] Weiss (NVS)

5.12 Bibliographie numérotée

1. Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J. et coll. « Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models ». *BMC Public Health*, 2012, 12, 80.
2. Nutbeam D. « Health literacy as a public health goal ». *Health Promotion International*, 2000, 15 (3), p. 259-267.
3. Nutbeam D. « The evolving concept of health literacy ». *Social Science & Medicine*, 2008, 67 (12), p. 2072-2078.
4. Vidgen H. A., Gallegos D. « Defining food literacy and its components ». *Appetite*, 2014, 76, p. 50-59.
5. The HLS19 Consortium of the WHO Action Network M-POHL. *International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19)*. 2021 (rapport international et résultats France).
6. Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). *L'évolution de l'illettrisme en France* (enquête IVQ 2011, Insee). 2013.
7. Insee. Enquête TIC ménages 2025 (usages et compétences numériques), publiée le 19 février 2026 ; pour l'évolution : *Insee Première* sur l'illectronisme en 2021, 2023.
8. OCDE. *Survey of Adult Skills 2023 (PIAAC, 2e cycle)*. Décembre 2024 ; Dares. « Compétences des adultes en 2023 ». *Dares Analyses* n° 73, décembre 2024.
9. Berkman N. D. et coll. « Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review ». *Annals of Internal Medicine*, 2011, 155 (2), p. 97-107.

10. Ruel J., Allaire C. (dir.). *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Santé publique France, mai 2018, mise à jour février 2025.

11. Inclusion Europe. *L'information pour tous : règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre*. 2009.

12. Kandel L., Moles A. « Application de l'indice de Flesch à la langue française ». *Cahiers d'études de radio-télévision*, 1958, 19, p. 253-274.

13. HAS. *Faire dire*. Fiche outil, 2015.

14. HAS. *La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins* ; *Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé*. Référentiels de compétences, 2017.

15. Brach C. et coll. *Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations*. Institute of Medicine, 2012.

16. Norman C. D., Skinner H. A. « eHealth literacy: essential skills for consumer health in a networked world ». *Journal of Medical Internet Research*, 2006, 8 (2), e9.

17. Weiss B. D. et coll. « Quick assessment of literacy in primary care: the Newest Vital Sign ». *Annals of Family Medicine*, 2005, 3 (6), p. 514-522.

18. Marmot M. *Fair Society, Healthy Lives* (The Marmot Review). 2010.

19. Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO).

20. Santé publique France. *Nutri-Score* : documents de référence et mise à jour de l'algorithme (2022-2024), *santepubliquefrance.fr*.

21. OMS. *Guideline: Sugars intake for adults and children*. Genève, 2015.

22. Gigerenzer G. *Calculated Risks: How to Know When Numbers Deceive You*. New York, Simon & Schuster, 2002.

23. DINUM. *Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)*, version 4, *accessibilite.numerique.gouv.fr*.

24. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023.

25. Conférence nationale de santé. *La littératie en santé – usagers et professionnels : tous concernés*. Avis adopté le 6 juillet 2017.

26. Van den Broucke S. « La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique ». *La Santé en action*, n° 440, juin 2017.

27. Le Brun M., Godard D., Camps L. et coll. « La littératie en santé : définition, outils d'évaluation, état des lieux en Europe ». *La Revue de médecine interne*, 2025, 46, p. 32-39.

28. DEPP. « Journée défense et citoyenneté 2025 : 14 % des jeunes rencontrent des difficultés de lecture ». *Note d'information* n° 26.43, octobre 2026.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 5.2.2)

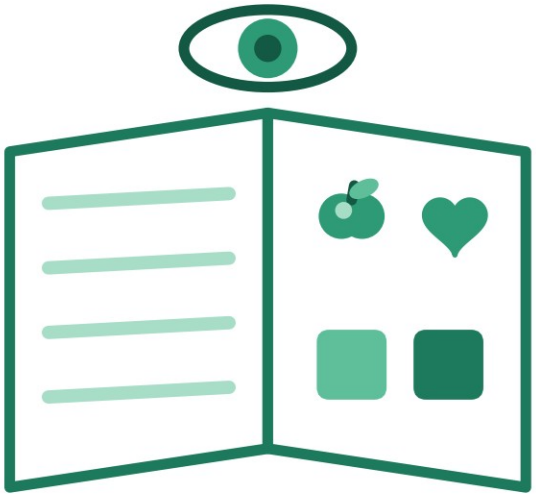
29. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

30. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

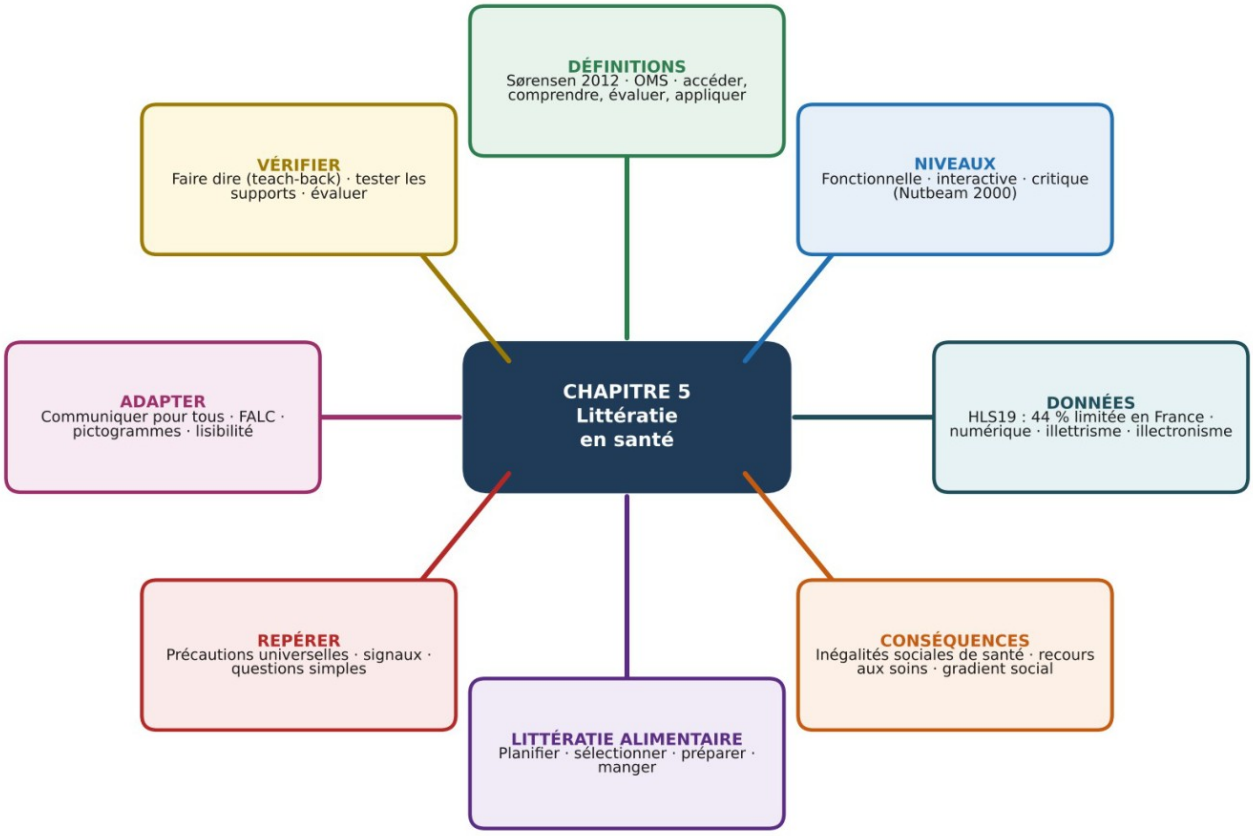
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 5 100
1. Les définitions à savoir 100
2. Chiffres-clés 101
3. La formule à connaître 101
4. Les règles d'écriture claire 101
5. Faire dire 101
6. Les pièges 101
7. Auto-test 101
8. Flashcards 101
Compléments du chapitre enrichi 102

Fiches-outils du chapitre 5 102
O5.1 – Grille de vérification d'un support écrit 102
O5.2 – Calcul de l'indice de lisibilité 103
O5.3 – Audit « littératie » d'une structure 103
O5.4 – Guide du faire dire 103
O5.5 – Test d'un support auprès du public 104

Fiche de révision du chapitre 5

Littératie en santé



Carte mentale du chapitre 5

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Littératie en santé	Connaissances, motivation, compétences pour accéder, comprendre, évaluer, appliquer l'information ; soins, prévention, promotion (Sørensen, 2012)
Niveaux (Nutbeam, 2000)	Fonctionnel (lire) · interactif (échanger) · critique (juger, agir)
Littératie alimentaire	Planifier et gérer · sélectionner · préparer · manger (Vidgen et Gallegos, 2014)
Littératie organisationnelle	Une structure rend l'information facile à trouver, comprendre, utiliser
Illettrisme / analphabétisme	Scolarisé en France sans maîtrise suffisante / jamais scolarisé
Illectronisme	Difficulté ou incapacité à utiliser le numérique
Précautions universelles	Communiquer clairement avec tous, sans tester
FALC	Facile à lire et à comprendre (Inclusion Europe, 2009), relu par des personnes concernées

2. Chiffres-clés

- **44 %** des adultes en France : littératie en santé limitée (HLS19, 2021), ≈ 30 % problématique + 14 % insuffisante ; difficultés plus fréquentes en numérique (≈ 72 %).
- Illettrisme : **7 %** des 18-65 ans, 2,5 millions (ANLCI, 2011).
- Illectronisme : **7 %** des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; 34 % en difficulté numérique.

3. La formule à connaître

Méthode pas à pas – Lisibilité (Kandel et Moles, 1958)

L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; 60-70 standard ; 80-90 facile. Exemple : 120 mots, 5 phrases, 204 syllabes → 207 − 24,36 − 125,12 = **57,52**.

4. Les règles d'écriture claire

Une idée par phrase (≤ 15 mots) · mots courants · forme active et positive · pas de sigles · chiffres concrets · pictogrammes et photos réelles · police ≥ 14, aligné à gauche · tester auprès du public.

5. Faire dire

Expliquer → faire reformuler → vérifier → réexpliquer autrement → confirmer (HAS, 2015). Jamais « Vous avez compris ? ».

6. Les pièges

Attention

- Confondre littératie et intelligence ou niveau d'études.
- Additionner illettrisme, illectronisme et littératie limitée.
- « Tester » le public au lieu d'appliquer les précautions universelles.
- Tout miser sur le numérique.
- Faire traduire un enfant ou un traducteur automatique non relu.

7. Auto-test

1. Les 4 compétences de Sørensen ? 2. Les 3 domaines ? 3. Les 3 niveaux de Nutbeam ? 4. Chiffre HLS19 ? 5. Différence illettrisme / analphabétisme ? 6. Que signifie FALC ? 7. Que mesure l'indice de Kandel et Moles ? 8. Les étapes du faire dire ? 9. Les 4 domaines de la littératie alimentaire ? 10. Article du CSP sur la médiation en santé ? *Réponses : 1. Accéder, comprendre, évaluer, appliquer – 2. Soins, prévention, promotion – 3. Fonctionnel, interactif, critique – 4. 44 % limitée – 5. Scolarisé en France ou jamais scolarisé – 6. Facile à lire et à comprendre – 7. La lisibilité (longueur des phrases et des mots) – 8. Expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer, confirmer – 9. Planifier, sélectionner, préparer, manger – 10. L. 1110-13.*

8. Flashcards

Recto : Littératie critique ?	Verso : Juger la fiabilité et agir sur les déterminants, seul ou collectivement
Recto : Pourquoi la littératie creuse-t-elle les ISS ?	Verso : Les messages non adaptés profitent d'abord aux plus favorisés

Recto : Littératie critique ?	Verso : Juger la fiabilité et agir sur les déterminants, seul ou collectivement
Recto : Universalisme proportionné ?	Verso : Action pour tous, intensité adaptée aux besoins (Marmot, 2010)
Recto : 6 questions de fiabilité ?	Verso : Qui ? Objectif ? Sources ? Date ? Cohérence ? Promesse miraculeuse ?
Recto : Outil de mesure par l'étiquette ?	Verso : Newest Vital Sign (Weiss, 2005)
Recto : Évaluer avec des enfants ?	Verso : Smileys, gommettes, question orale

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Étiquette	INCO 1169/2011 ; dénomination, ingrédients (ordre décroissant, 14 allergènes), Nutri- Score (même famille), tableau pour 100 g et par portion, dates, prix au kilo
Sucres	g/100 mL × volume / 100 ; 1 morceau ≈ 5 g ; OMS : < 10 % de l'énergie (≈ 50 g pour 2 000 kcal)
Numératie	Fréquences naturelles, tableaux d'icônes ; donner réductions absolue ET relative
Numérique	Grille d'évaluation des applications ; RGAA/WCAG ; texte alternatif, sous-titres
Allophones	Interprétariat professionnel, médiateurs, pictogrammes testés ; pas d'enfant interprète
Tester	Lisibilité + test de compréhension auprès du public

Fiches-outils du chapitre 5

Outil	Intitulé	Utilité
O5.1	Grille de vérification d'un support écrit	Avant impression d'une affiche, d'un dépliant, d'une fiche recette
O5.2	Calcul de l'indice de lisibilité	Mesurer et comparer deux versions d'un texte
O5.3	Audit « littératie » d'une structure	Proposer des améliorations à un partenaire
O5.4	Guide du faire dire	Vérifier la compréhension en entretien et en atelier
O5.5	Test d'un support auprès du public	Recueillir l'avis de 5 à 8 personnes

O5.1 – Grille de vérification d'un support écrit

Critère	Oui	Non	À revoir
Le titre dit ce que la personne va faire ou gagner	☐	☐	☐
Un message principal, 3 idées au plus	☐	☐	☐
Phrases de 15 mots au plus, une idée par phrase	☐	☐	☐
Mots courants, aucun sigle non expliqué	☐	☐	☐
Forme active et positive (« Buvez de l'eau »)	☐	☐	☐
Chiffres concrets (verre, poignée, cuillère)	☐	☐	☐
Images utiles et réalistes, qui disent la même chose que le texte	☐	☐	☐
Police sans empattement ≥ 14, aligné à gauche, pas de majuscules continues	☐	☐	☐
Contraste suffisant, mise en page aérée	☐	☐	☐

Critère	Oui	Non	À revoir
Informations pratiques claires (quand, où, coût, contact)	☐	☐	☐
Accès non exclusivement numérique	☐	☐	☐
Source et date indiquées	☐	☐	☐
Testé auprès de personnes du public	☐	☐	☐

O5.2 – Calcul de l'indice de lisibilité

Étape	Version 1	Version 2
Nombre de mots (M)		
Nombre de phrases (P)		
Nombre de syllabes (S)		
M / P		
S / M		
1,015 × (M / P)		
73,6 × (S / M)		
L = 207 − 1,015 × (M/P) − 73,6 × (S/M)		
Interprétation		

0-30 très difficile · 30-50 difficile · 50-60 assez difficile · 60-70 standard · 70-80 assez facile · 80-90 facile · 90-100 très facile.

O5.3 – Audit « littératie » d'une structure

Point observé	Constat (satisfaisant ou à améliorer)	Proposition
Le lieu est facile à trouver (signalétique, plan, pictogrammes)		
L'accueil propose de l'aide pour les papiers		
Les documents sont clairs (grille O5.1)		
Plusieurs langues ou un accès à l'interprétariat		
Inscriptions possibles sans numérique		
Les professionnels vérifient la compréhension (faire dire)		
Les usagers participent à la conception des supports		
Les coûts sont annoncés clairement		

O5.4 – Guide du faire dire

Étape	Formulations possibles
Annoncer	« Je vais vous expliquer… ensuite je vous demanderai de me le redire, pour vérifier que j'ai été clair(e). »
Expliquer	Un message à la fois ; un objet, une image, un geste
Faire dire	« Comment allez-vous l'expliquer à votre famille ? » ; « Montrez-moi comment vous feriez. »

Étape	Formulations possibles
Si incomplet	« Je me suis peut-être mal exprimé(e), je reprends autrement… »
Confirmer	« C'est exactement ça. » ; laisser un support d'une page
En groupe	« Chaque binôme explique au groupe une astuce retenue. »

O5.5 – Test d'un support auprès du public

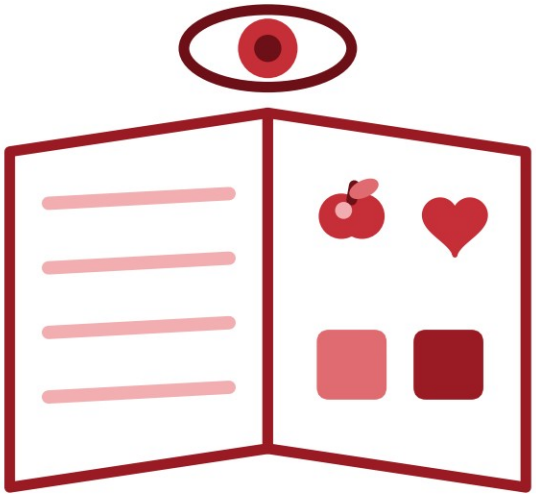
Question posée	Personne 1	Personne 2	Personne 3
« Que vous dit ce document ? »			
« Qu'allez-vous faire après l'avoir lu ? »			
Mots ou images non compris			
Ce qui plaît / ne plaît pas			
Proposition de la personne			

Conclusion : modifications à apporter avant impression.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 5 108
Mode d'emploi du cahier 108
Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire 110
Exercice 5.1 – Légender les 12 dimensions de la littératie en santé (10 points) 111
Exercice 5.2 – Les trois niveaux de Nutbeam (10 points) 113
Exercice 5.3 – La littératie alimentaire d'étudiants (10 points) 115
Exercice 5.4 – Le parcours d'inscription à la cantine : une question d'organisation (12 points) 117
Exercice 5.5 – Personne, situation, complexité de l'information (10 points) 119
Exercice 5.6 – Diagnostiquer avec la grille de Sørensen (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique 126
Exercice 5.7 – Légender les mesures françaises et distinguer les notions (10 points) 127
Exercice 5.8 – Transposer l'enquête HLS19 à une commune (10 points) 129
Exercice 5.9 – Le gradient social de la littératie (12 points) 131
Exercice 5.10 – Comprendre son plan alimentaire quand on a un diabète (12 points) 133
Exercice 5.11 – Une campagne qui creuse les écarts (12 points) 134
Exercice 5.12 – Le Nutri-Score, un outil pensé pour la littératie (14 points) 135
Corrigés de la partie 2 137
Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic 140
Exercice 5.13 – Vrai ou faux : les précautions universelles (8 points) 141
Exercice 5.14 – Les signaux à l'accueil d'une épicerie solidaire (10 points) 142
Exercice 5.15 – Réécrire un questionnaire de diagnostic (12 points) 143
Exercice 5.16 – Questionnaire écrit ou passation orale ? (12 points) 145
Exercice 5.17 – Poser les bonnes questions sans juger (10 points) 147
Exercice 5.18 – Diagnostic dans une résidence sociale (16 points) 148
Corrigés de la partie 3 150
Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité 153
Exercice 5.19 – Les six étapes d'une communication accessible (10 points) 154
Exercice 5.20 – Calculer et situer trois indices de lisibilité (10 points) 156
Exercice 5.21 – Appliquer les règles d'écriture claire (12 points) 158
Exercice 5.22 – La lettre aux familles sur le goûter (14 points) 160
Exercice 5.23 – Un menu en FALC pour un ESAT (12 points) 162
Exercice 5.24 – Les limites de l'indice de lisibilité (12 points) 164
Corrigés de la partie 4 166
Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible 168
Exercice 5.25 – Légender la boucle du « faire dire » (10 points) 169
Exercice 5.26 – Des questions qui font agir (8 points) 171
Exercice 5.27 – Analyser un « faire dire » en entretien (12 points) 172
Exercice 5.28 – Construire une séquence d'atelier accessible (14 points) 174
Exercice 5.29 – Exploiter une grille de « faire dire » (12 points) 176
Exercice 5.30 – Un message vocal pour rappeler l'atelier (10 points) 178
Corrigés de la partie 5 179
Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie 181
Exercice 5.31 – Légender une étiquette (10 points) 182
Exercice 5.32 – Lire trois listes d'ingrédients (10 points) 184
Exercice 5.33 – Les boissons en morceaux de sucre (12 points) 186
Exercice 5.34 – Pour 100 g ou par portion ? Deux goûters comparés (12 points) 188
Exercice 5.35 – Présenter honnêtement un risque (12 points) 190

Exercice 5.36 – Traduire les repères chiffrés en assiettes (14 points) 192
Corrigés de la partie 6 194

Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible 196
Exercice 5.37 – Une adaptation pour chaque situation (10 points) 197
Exercice 5.38 – Évaluer une application de scan (10 points) 199
Exercice 5.39 – Rendre accessible la page d'inscription (14 points) 201
Exercice 5.40 – Communiquer avec des parents allophones (10 points) 203
Exercice 5.41 – Un atelier cuisine avec des personnes sourdes et malentendantes (12 points) 205
Exercice 5.42 – Le club des seniors et le numérique (14 points) 207
Corrigés de la partie 7 209

Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet 212
Exercice 5.43 – La littératie à chaque étape du projet (10 points) 213
Exercice 5.44 – Analyser un kit pédagogique offert par une marque (10 points) 214
Exercice 5.45 – Créer des cartes-prix pour un jeu de numératie (12 points) 216
Exercice 5.46 – Évaluer avec des smileys (12 points) 218
Exercice 5.47 – Un budget de communication accessible (12 points) 219
Exercice 5.48 – Cas complet : cuisiner le colis au centre d'hébergement (40 points) 221
Corrigés de la partie 8 224

Bilan : grille d'auto-évaluation 227

Cahier d'exercices – Chapitre 5

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 5 : définitions et modèles de la littératie en santé (Sørensen, Nutbeam), littératie alimentaire, littératie organisationnelle, données françaises (HLS19, illettrisme, illectronisme), conséquences et inégalités sociales de santé, repérage sans stigmatisation, écriture claire et FALC, lisibilité, « faire dire », lecture d'étiquette, numératie, inclusion numérique, publics allophones et en situation de handicap, outils pédagogiques et intégration à chaque étape du projet (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les 12 dimensions de Sørensen, les trois niveaux de Nutbeam, les domaines de la littératie alimentaire, les mesures françaises, les six étapes d'une communication accessible, l'échelle de lisibilité, la boucle du « faire dire », l'étiquette, les fréquences naturelles, les adaptations selon les publics, la littératie dans le projet.
- Calculer et interpréter : pourcentages d'un diagnostic, indice de lisibilité de Kandel et Moles, taux de compréhension avant et après, risque relatif, réductions absolue et relative, sucres en morceaux, valeurs « pour 100 g » et « par portion », ratio de contraste, coût par portion (Ciqual 2025).
- Proposer des messages, des supports et des séances que tout le public peut comprendre, sans désigner personne.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) ; pour les boissons, on assimile 100 g à 100 mL. Les auteurs, les textes officiels, les enquêtes nationales et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Traiter une question de littératie à l'examen

Pour chaque situation, suivez trois temps. D'abord, repérez où se situe la difficulté : trouver, comprendre, juger ou utiliser l'information, et dans quel domaine (soins, prévention, promotion de la santé). Ensuite, citez un élément précis du document qui le montre. Enfin, proposez une adaptation qui vaut pour tout le public (précautions universelles) et dites comment vous vérifierez qu'elle marche : test du support auprès de

personnes du public, « faire dire » en séance, indicateur de compréhension. Une copie qui « teste » ou désigne les personnes en difficulté perd des points.

Partie 1 – Définir la littératie en santé et la littératie alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la littératie en santé selon Sørensen (2012) et citer ses quatre compétences et ses trois domaines.
- Situer une situation dans les trois niveaux de Nutbeam (2000).
- Définir la littératie alimentaire et ses quatre domaines (Vidgen et Gallegos, 2014).
- Distinguer la littératie d'une personne et la littératie d'une organisation.
- Utiliser la grille des 12 dimensions pour analyser les besoins d'un public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012) : connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé.
- Quatre compétences × trois domaines = 12 dimensions ; l'enquête européenne HLS-EU les mesure par 47 questions.
- Trois niveaux (Nutbeam, 2000) : fonctionnel (lire, écrire, compter), interactif (échanger, adapter l'information à sa situation), critique (juger, analyser, agir sur les déterminants avec d'autres).
- Littératie alimentaire (Vidgen et Gallegos, 2014) : planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger ; 4 domaines et 11 composantes.
- Littératie organisationnelle : capacité d'une structure à rendre l'information et les services faciles à trouver, à comprendre et à utiliser.
- La littératie n'est ni l'intelligence ni le niveau d'études : elle dépend de la personne, de la situation et de la complexité de l'information.

Exercice 5.1 – Légender les 12 dimensions de la littératie en santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez la littératie en santé à l'équipe d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui veut mieux accompagner ses patients. Vous projetez le schéma de Sørensen et vous demandez aux professionnels de le compléter avec des exemples alimentaires.

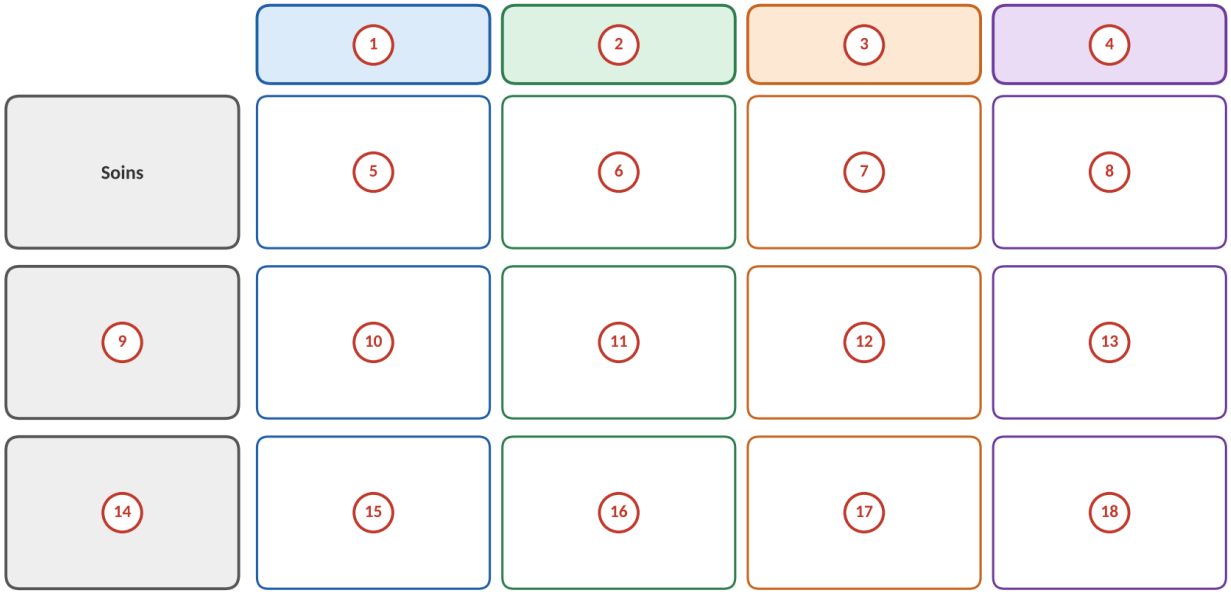


Figure 5.1 – Document 1 – Les 12 dimensions de la littératie en santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 18 du document 1 : les quatre compétences, les deux domaines manquants et un exemple alimentaire pour chaque case. (6 pts)
2. Donnez la définition de la littératie en santé de Sørensen et coll. (2012) en citant les quatre compétences et les trois domaines. (2 pts)
3. Expliquez en deux phrases pourquoi ce schéma sert de grille de diagnostic pour un projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Les trois niveaux de Nutbeam (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention sur l'alimentation pour un groupe de salariés en reconversion. Vous voulez leur montrer qu'il existe plusieurs niveaux de littératie et que chacun peut progresser.

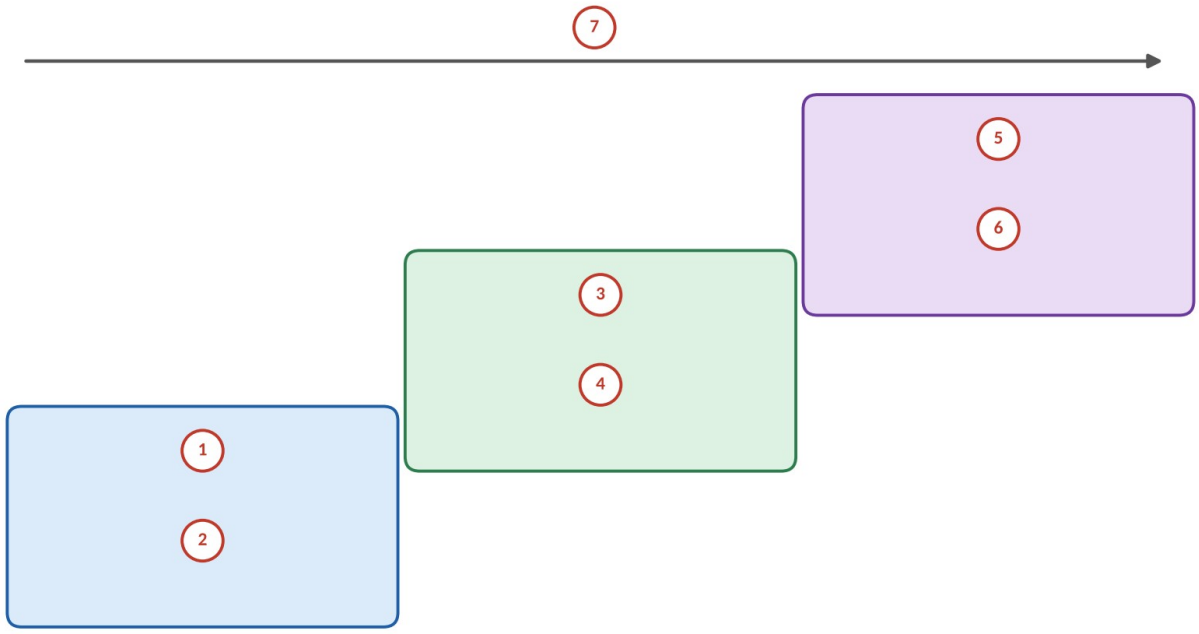


Figure 5.2 – Document 1 – Les trois niveaux de littératie en santé (schéma à légender)

Document 2 – Huit situations observées pendant l'intervention

a) Karim lit sur le sachet de lentilles le temps de cuisson indiqué.

b) Sophie demande à l'intervenante si le conseil « 5 fruits et légumes » vaut aussi pour son fils de 3 ans.

c) Thierry remarque que la publicité pour une boisson « riche en vitamines » ne parle pas du sucre.

d) Leïla calcule le prix au kilo de deux paquets de riz.

e) Un collectif d'habitants obtient du bailleur social des parcelles de jardin partagé au pied des immeubles.

f) Marc, chauffeur routier, explique ses horaires à la diététicienne et lui demande comment organiser ses repas sur la route.

g) Nadia vérifie qui a publié une vidéo « détox » avant de la partager.

h) Paul suit la notice pour préparer un biberon de lait infantile.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. **2.** Classez chaque situation du document 2 dans un des trois niveaux. (4 pts)
3. **3.** Expliquez pourquoi la situation e) relève de la promotion de la santé et du pouvoir d'agir. (1,5 pt)
4. **4.** Citez une action d'atelier qui fait passer le groupe du niveau fonctionnel au niveau interactif. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.3 – La littératie alimentaire d'étudiants (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale étudiante (fictive) vous demande d'animer quatre séances pour des étudiants de première année qui vivent seuls pour la première fois. La responsable vous transmet ce qu'elle entend à la caisse.

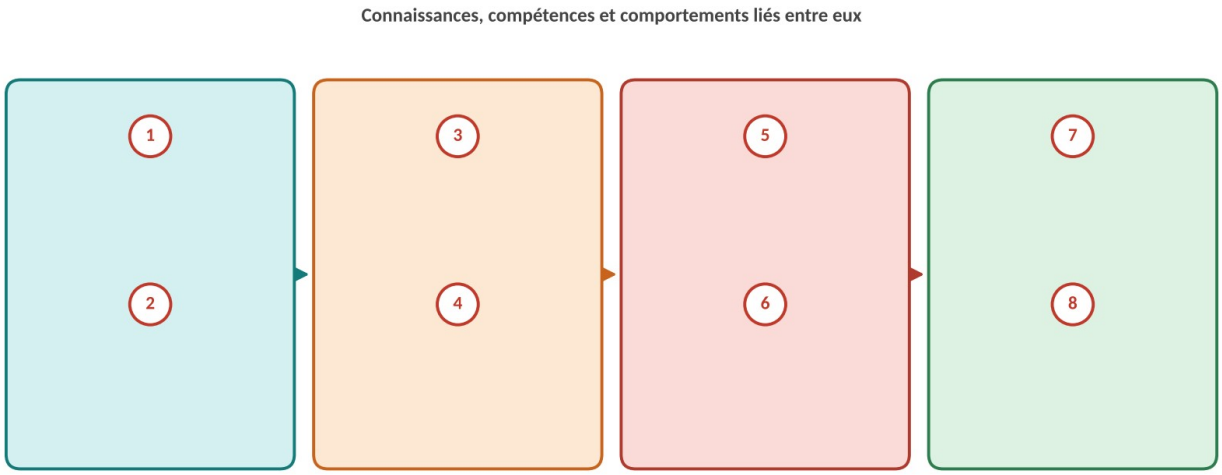


Figure 5.3 – Document 1 – Les quatre domaines de la littératie alimentaire (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les étudiants

a) « Je fais les courses quand le frigo est vide, sans liste, et j'achète trop de choses que je jette. »

b) « Je ne sais pas cuire des lentilles, alors j'achète des plats préparés. »

c) « Je ne comprends pas pourquoi deux paquets de céréales qui se ressemblent n'ont pas le même Nutri-Score. »

d) « Je mange devant mon ordinateur, souvent à 22 h, et je ne sens plus si j'ai faim. »

e) « À la fin du mois, il me reste 15 € pour dix jours. »

f) « Je ne sais pas combien de temps on peut garder un reste de riz au frigo. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Rattachez chaque phrase du document 2 à un domaine de la littératie alimentaire. (3 pts)
3. Proposez un titre et un objectif pour chacune des quatre séances, un par domaine. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.4 – Le parcours d'inscription à la cantine : une question d'organisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration scolaire d'une commune de 18 000 habitants (fictive) constate que beaucoup de familles des quartiers prioritaires ne demandent pas le tarif social de la cantine. Il vous demande d'analyser le parcours d'inscription.

Document 1 – Le parcours actuel, décrit par une médiatrice sociale

- L'inscription se fait uniquement sur le « portail famille » en ligne, avec un identifiant reçu par courriel.
- Le formulaire compte 9 pages ; il utilise les mots « quotient familial », « justificatif de domicile de moins de 3 mois » et « PAI ».
- Le tarif social demande de télécharger l'avis d'imposition au format PDF.
- Le règlement intérieur de 14 pages est en police de 9 points, sans image.
- L'accueil de la mairie est ouvert de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi.
- Le menu est affiché à l'entrée de l'école en texte seul, sans pictogrammes pour les allergènes.
- Aucune information n'existe dans une autre langue que le français.
- Une famille témoigne : « On m'a dit de tout faire sur internet. Je n'ai qu'un téléphone et ma fille m'aide le soir. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la littératie en santé organisationnelle et dites en quoi elle déplace la responsabilité. (2 pts)
2. Relevez dans le document 1 six obstacles qui viennent de l'organisation et non des familles. (3 pts)
3. Pour chaque obstacle relevé, proposez une amélioration réaliste pour la commune. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi ce parcours peut creuser les inégalités sociales de santé, alors que le tarif social veut les réduire. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour savoir si les améliorations fonctionnent. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.5 – Personne, situation, complexité de l'information (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe dans un centre communal d'action sociale (CCAS), un collègue affirme : « La littératie, c'est un problème de personnes qui ne savent pas lire. Chez nous, les gens diplômés n'en ont pas besoin. » Vous lui présentez des situations recueillies pendant votre stage.

Document 1 – Cinq situations

a) Hélène, ingénieure, vient d'apprendre que son mari a un cancer. Pendant l'entretien, elle ne retient rien des conseils pour la dénutrition.

b) Moussa, maçon, lit difficilement mais explique très bien à l'animatrice comment il adapte le ramadan à son diabète, avec les conseils de son médecin.

c) Claire, professeure de lettres, ne comprend pas le tableau nutritionnel « pour 100 g » et « par portion » d'un plat préparé.

d) Ana, arrivée du Brésil il y a six mois, est infirmière diplômée ; elle parle peu le français.

e) Jean, 82 ans, ancien comptable, a du mal à lire les petits caractères des étiquettes et n'utilise pas internet.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, dites si la difficulté vient surtout de la personne, de la situation ou de la complexité de l'information. Justifiez en une phrase. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi on parle de « situations de littératie limitée » plutôt que de « personnes illettrées en santé ». (2 pts)
3. Rédigez la réponse que vous faites à votre collègue en trois phrases, sans le mettre en défaut. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.6 – Diagnostiquer avec la grille de Sørensen (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'un entrepôt de logistique (fictif) prépare une action « bien manger quand on travaille en horaires décalés ». Avec l'infirmière, vous avez fait passer en entretien un questionnaire court inspiré de l'enquête HLS-EU à 60 salariés volontaires. Chaque question demande s'il est facile ou difficile de réaliser une tâche.

Document 1 – Nombre de salariés qui répondent « difficile » ou « très difficile » (n = 60, données fictives)

Domaine	Accéder	Comprendre	Évaluer	Appliquer
Soins (« … un régime prescrit par le médecin »)	14	18	33	12
Prévention (« … les repères pour bien manger »)	11	21	38	16
Promotion de la santé (« … l'offre de repas de l'entreprise »)	19	17	35	24

Document 2 – Extraits des entretiens

- « Sur internet, chacun dit le contraire. Le jeûne, le sans gluten… je ne sais plus qui croire. »
- « Le distributeur ne propose que des sandwichs et des barres. On n'a pas notre mot à dire. »
- « La nuit, je ne sais pas si je dois manger à 2 h ou attendre le matin. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque case du document 1, le pourcentage de salariés en difficulté (au dixième). (4 pts)
2. Calculez le pourcentage moyen de difficulté pour chaque compétence (sur les trois domaines) et pour chaque domaine (sur les quatre compétences). (3 pts)
3. Identifiez la compétence et la case les plus en difficulté, et reliez-les à un extrait du document 2. (2 pts)
4. Formulez deux objectifs spécifiques de l'action, l'un sur la compétence la plus faible, l'autre sur la promotion de la santé. (3 pts)
5. Proposez deux activités, l'une pour développer l'esprit critique, l'autre pour donner du pouvoir d'agir sur l'offre de l'entreprise. (2 pts)
6. Citez deux limites de ces données. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 5.1

1. Légendes : 1 Accéder ; 2 Comprendre ; 3 Évaluer ; 4 Appliquer ; 5 trouver le numéro de la diététicienne ; 6 comprendre un régime prescrit ; 7 juger un second avis ; 8 suivre le plan alimentaire ; 9 Prévention ; 10 trouver les repères du PNNS ; 11 comprendre le Nutri-Score ; 12 juger un conseil vu sur un réseau social ; 13 choisir un produit au magasin ; 14 Promotion de la santé ; 15 connaître l'offre du quartier ; 16 comprendre un menu affiché ; 17 juger la qualité de la cantine ; 18 agir en association de parents. Tout autre exemple alimentaire juste est accepté.
2. Selon Sørensen et coll. (2012), la littératie en santé englobe les connaissances, la motivation et les compétences qui permettent d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer l'information en santé. Elle sert à prendre des décisions dans la vie quotidienne dans trois domaines : les soins, la prévention des maladies et la promotion de la santé.
3. La grille permet de situer précisément la difficulté d'un public : ce n'est pas la même chose de ne pas trouver une information et de ne pas savoir la juger. On en déduit des objectifs pédagogiques précis et des activités adaptées à chaque case.

Corrigé – Exercice 5.2

1. Légendes : 1 Fonctionnelle ; 2 lire, écrire, compter pour comprendre une information simple (étiquette, date, dépliant) ; 3 Interactive ; 4 échanger, poser des questions, adapter l'information à sa situation ; 5 Critique ; 6 juger la fiabilité, analyser la publicité, agir sur les déterminants avec d'autres ; 7 plus d'autonomie et de pouvoir d'agir.
2. Fonctionnelle : a) lire une information simple sur un emballage, d) calculer un prix au kilo, h) suivre une notice. Interactive : b) poser une question pour adapter le conseil à son enfant, f) expliquer sa situation à la diététicienne pour obtenir un conseil adapté. Critique : c) analyser une publicité, e) agir collectivement sur l'offre alimentaire du quartier, g) vérifier la source d'une vidéo.
3. Les habitants ne changent pas seulement leur propre comportement : ils agissent ensemble sur un déterminant de la santé de tout le quartier (l'accès à des fruits et légumes cultivés sur place, une activité physique et du lien social). C'est le niveau critique de Nutbeam et l'axe « créer des milieux favorables » de la Charte d'Ottawa (1986).
4. Exemple : après la lecture d'une étiquette, chaque participant pose une question sur sa propre situation (« et pour mon enfant ? ») et l'animatrice l'aide à adapter le conseil ; ou un jeu de rôle « je pose ma question au diététicien ».

Corrigé – Exercice 5.3

1. Légendes : 1 Planifier et gérer ; 2 prévoir les repas, faire une liste, gérer un budget et des réserves ; 3 Sélectionner ; 4 savoir où acheter, lire une étiquette, juger la fraîcheur ; 5 Préparer ; 6 cuisiner avec ce que l'on a, hygiène, techniques de base ; 7 Manger ; 8 écouter ses sensations, partager, connaître les repères.
2. a) planifier et gérer (liste, gaspillage) ; b) préparer (technique de base) ; c) sélectionner (lire une étiquette) ; d) manger (sensations, conditions du repas) ; e) planifier et gérer (budget) ; f) préparer (hygiène, conservation des restes).
3. Exemples : « Ma semaine en 10 minutes » : savoir établir un menu de 5 jours et une liste de courses ; « Le rayon mode d'emploi » : savoir comparer deux produits d'une même famille avec le Nutri-Score et le prix au kilo ; « Cuisiner 3 recettes avec un paquet de lentilles » : savoir cuire des lentilles et conserver un reste en sécurité ; « Mon repas, ma pause » : savoir repérer sa faim et organiser un repas sans écran. Un objectif commence par un verbe d'action et se vérifie à la fin de la séance.

Corrigé – Exercice 5.4

1. C'est la capacité d'une organisation à rendre l'information et les services faciles à trouver, à comprendre et à utiliser pour tous. La responsabilité ne repose plus seulement sur la personne (« elle devrait savoir faire ») : c'est à la structure d'adapter ses documents, son accueil et ses démarches.

2. Obstacles : inscription uniquement en ligne ; formulaire de 9 pages ; mots techniques (« quotient familial », « PAI ») ; téléversement d'un PDF ; règlement long en petits caractères, sans image ; horaires d'accueil limités au matin en semaine ; menu sans pictogrammes pour les allergènes ; aucune autre langue que le français.

3. Améliorations : garder le portail mais proposer aussi une inscription papier et un rendez-vous à l'accueil ou par téléphone ; réduire le formulaire à l'essentiel et expliquer chaque mot (« quotient familial : un chiffre calculé par la CAF selon vos revenus ») ; accepter la photo du document prise avec le téléphone ou l'avis remis au guichet ; écrire une version courte du règlement en écriture claire avec pictogrammes ; ouvrir l'accueil un soir par semaine ou le samedi matin ; ajouter les pictogrammes des allergènes au menu ; faire traduire une fiche d'information dans les langues les plus parlées et former une médiatrice ou un adulte relais.

4. Les familles qui réussissent l'inscription en ligne sont surtout celles qui ont un ordinateur, une bonne maîtrise du français écrit et du temps. Les familles les plus modestes, à qui le tarif social est destiné, renoncent plus souvent : c'est le non-recours. L'aide profite alors moins à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui creuse le gradient social.

5. Exemple : part des familles des quartiers prioritaires qui bénéficient du tarif social, avant et un an après les changements ; ou nombre d'inscriptions faites à l'accueil et par téléphone.

Corrigé – Exercice 5.5

1. a) Situation : le choc de l'annonce empêche de retenir l'information, quel que soit le niveau d'études. b) Personne, mais avec une bonne littératie interactive : il lit peu, mais il échange et adapte très bien l'information. c) Complexité de l'information : le double affichage « pour 100 g » et « par portion » est difficile même pour une lectrice experte. d) Personne et situation : elle a une bonne littératie en santé dans sa langue ; la difficulté vient de la langue du pays. e) Personne (vue, âge) et complexité des supports (petits caractères, information en ligne).

2. La littératie n'est pas une caractéristique fixe : elle change selon le moment, le stress, la langue, le domaine et la qualité des documents. Parler de situations évite de coller une étiquette aux personnes et rappelle que les professionnels peuvent agir sur la situation et sur les supports.

3. Exemple : « Tu as raison, les difficultés de lecture comptent beaucoup. Mais même une personne diplômée peut ne rien retenir après une mauvaise nouvelle ou ne pas comprendre un tableau nutritionnel. C'est pour ça qu'on écrit simplement et qu'on vérifie la compréhension avec tout le monde : tout le monde y gagne. »

Corrigé – Exercice 5.6

1. Soins : accéder 14 / 60 × 100 = 23,3 % ; comprendre 18 / 60 = 30,0 % ; évaluer 33 / 60 = 55,0 % ; appliquer 12 / 60 = 20,0 %. Prévention : 11 / 60 = 18,3 % ; 21 / 60 = 35,0 % ; 38 / 60 = 63,3 % ; 16 / 60 = 26,7 %. Promotion de la santé : 19 / 60 = 31,7 % ; 17 / 60 = 28,3 % ; 35 / 60 = 58,3 % ; 24 / 60 = 40,0 %.

2. Par compétence (sur 180 réponses) : accéder (14 + 11 + 19) / 180 = 44 / 180 = 24,4 % ; comprendre 56 / 180 = 31,1 % ; évaluer 106 / 180 = 58,9 % ; appliquer 52 / 180 = 28,9 %. Par domaine (sur 240 réponses) : soins 77 / 240 = 32,1 % ; prévention 86 / 240 = 35,8 % ; promotion de la santé 95 / 240 = 39,6 %.

3. La compétence la plus en difficulté est « évaluer » (58,9 %), et la case la plus touchée est « évaluer, en prévention » (63,3 %). L'extrait « Sur internet, chacun dit le contraire… je ne sais plus qui croire » le montre. Comme dans l'enquête HLS19, c'est le jugement de l'information qui pose le plus de problèmes.

4. Exemples : « À la fin de l'action, au moins 70 % des salariés participants sauront citer deux critères pour juger la fiabilité d'une information sur l'alimentation (auteur, source, intérêt commercial) » ; « D'ici un an,

un groupe de salariés aura proposé à la direction au moins deux changements de l'offre alimentaire du site (distributeur, salle de pause), et au moins un sera mis en place. »

5. Esprit critique : atelier « vrai ou faux ? » avec des publications réelles sur le jeûne ou le sans gluten ; les salariés cherchent l'auteur, la date, la source et l'intérêt commercial, puis comparent avec mangerbouger.fr. Pouvoir d'agir : un groupe de travail de salariés de nuit fait un relevé de l'offre du distributeur et prépare des propositions avec le comité social et économique (CSE).

6. Limites : les salariés étaient volontaires, donc l'échantillon n'est pas représentatif (les plus en difficulté ont pu refuser) ; les réponses sont déclaratives (difficulté ressentie, pas mesurée) ; le questionnaire est un court extrait de HLS-EU et ne permet pas de comparer avec les résultats nationaux ; l'effectif de 60 donne des pourcentages peu précis.

Partie 2 – Les données françaises et les enjeux pour la santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et interpréter les principales mesures françaises : HLS19, illettrisme, illectronisme.
- Distinguer illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère et illectronisme.
- Décrire les conséquences d'une littératie limitée sur la santé et la nutrition.
- Montrer qu'une communication non adaptée peut creuser les inégalités sociales de santé.
- Calculer et interpréter des pourcentages, un écart et un risque relatif.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- HLS19 (réseau M-POHL de l'OMS Europe, résultats français publiés en 2021) : environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (environ 30 % « problématique » et 14 % « insuffisante ») ; environ 72 % déclarent des difficultés avec l'information numérique.
- Illettrisme : 7 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France (ANLCI, enquête IVQ 2011). Illectronisme : 7 % des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; 34 % en difficulté numérique.
- Ces chiffres mesurent des choses différentes : on ne les additionne pas.
- Conséquences d'une littératie limitée (Berkman et coll., 2011) : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne compréhension des traitements et gestion des maladies chroniques, mortalité plus élevée chez les personnes âgées.
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : agir pour tous, avec une intensité et des modalités adaptées aux besoins.

Exercice 5.7 – Légender les mesures françaises et distinguer les notions (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un diaporama pour une réunion d'élus d'une communauté de communes. Vous voulez présenter trois chiffres sans les mélanger.

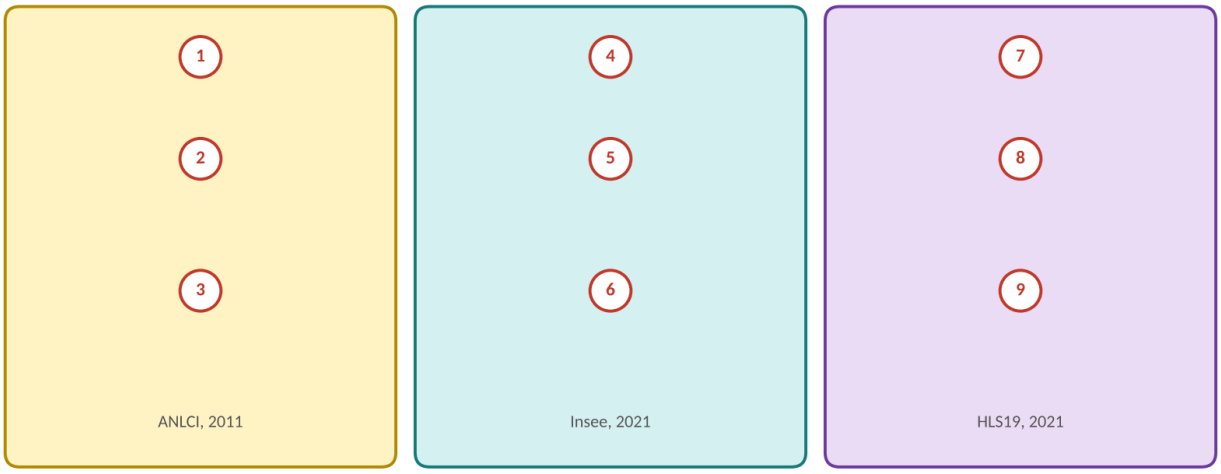


Figure 5.4 – Document 1 – Trois mesures à ne pas confondre (schéma à légender)

Document 2 – Six portraits

a) Mme D., 45 ans, a été à l'école en France jusqu'à 16 ans ; elle déchiffre mal les mots et évite de remplir les formulaires.

b) M. T., 60 ans, n'est jamais allé à l'école ; il ne sait ni lire ni écrire.

c) Mme R., 32 ans, a fait des études de commerce en Syrie ; elle apprend le français depuis un an.

d) M. L., 71 ans, lit très bien mais n'a jamais utilisé internet et n'a pas d'ordinateur.

e) Mme G., 28 ans, lit bien mais trouve très difficile de savoir si un conseil nutritionnel lu en ligne est fiable.

f) M. K., 50 ans, a un smartphone mais ne sait pas remplir un formulaire en ligne ni envoyer un document.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Associez chaque portrait du document 2 à la notion qui le décrit : illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère, illectronisme, littératie en santé limitée. (3 pts)
3. Un élu propose d'additionner les trois chiffres du document 1. Expliquez-lui en deux phrases pourquoi c'est impossible. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.8 – Transposer l'enquête HLS19 à une commune (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune de 12 000 adultes (fictive) veut savoir combien d'habitants pourraient avoir du mal avec les informations de santé. Le directeur du CCAS vous demande une estimation à partir des données nationales.

Document 1 – Résultats français de l'enquête HLS19 (publiés en 2021)

- Littératie en santé générale limitée : environ 44 % des adultes.
- Dont littératie « problématique » : environ 30 % ; « insuffisante » : environ 14 %.
- Difficultés avec l'information de santé numérique : environ 72 % des adultes.
- Le niveau est plus bas chez les personnes en difficulté financière, peu diplômées, âgées ou en mauvaise santé.
- Tâches les plus difficiles : juger la fiabilité d'une information dans les médias.

À vous de jouer – Questions

1. Estimez le nombre d'adultes de la commune qui auraient une littératie limitée, puis problématique, puis insuffisante. (3 pts)

2. Estimez le nombre d'adultes qui auraient des difficultés avec l'information numérique. Que pensez-vous du projet de la commune de ne publier le programme de prévention que sur son site ? (2 pts)

3. Donnez deux raisons pour lesquelles cette estimation peut être fausse pour cette commune. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi ces données sont « déclaratives » et ce que cela change pour leur interprétation. (2 pts)

5. Dites pourquoi on peut comparer les pays de l'enquête entre eux. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.9 – Le gradient social de la littératie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier santé ville (fictif) a fait passer un questionnaire court de littératie en santé à 400 adultes de trois quartiers. Il vous confie le tableau des résultats pour préparer le diagnostic.

Document 1 – Littératie en santé limitée selon les difficultés financières déclarées (données fictives)

Difficultés financières	Effectif	Littératie limitée
Très grandes	60	41
Assez grandes	110	58
Faibles	130	49
Aucune	100	22
Total	400	170

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de littératie limitée dans chaque groupe et dans l'ensemble. (3 pts)
2. Calculez combien de fois la littératie limitée est plus fréquente chez les personnes aux très grandes difficultés que chez celles qui n'en ont aucune. (1 pt)
3. Décrivez le résultat en utilisant la notion de gradient social. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi la littératie est à la fois un déterminant de la santé et un médiateur des inégalités. (2 pts)
5. Définissez l'universalisme proportionné et appliquez-le au futur programme de prévention de ces quartiers. (3 pts)
6. Comparez le pourcentage global à la donnée nationale de HLS19 et dites pourquoi la comparaison doit rester prudente. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.10 – Comprendre son plan alimentaire quand on a un diabète (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau d'éducation thérapeutique (fictif) accueille des adultes vivant avec un diabète de type 2. Avant les séances, une infirmière a évalué la littératie des patients avec un questionnaire court, puis leur a demandé d'expliquer leur plan alimentaire avec leurs mots.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Littératie en santé	Patients	Expliquent correctement leur plan	Ne l'expliquent pas correctement
Limitée	40	14	26
Suffisante	60	45	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque groupe, le pourcentage de patients qui expliquent correctement leur plan, et la différence en points. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif de ne pas comprendre son plan quand la littératie est limitée. Le calcul de son intervalle de confiance à 95 % donne [1,59 ; 4,26] : interprétez. (3 pts)
3. Citez trois conséquences d'une littératie limitée décrites par Berkman et coll. (2011). (2 pts)
4. Proposez trois adaptations des séances d'éducation qui profitent à tous les patients. (3 pts)
5. Pourquoi ne faut-il pas annoncer aux patients leur « score de littératie » ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.11 – Une campagne qui creuse les écarts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) a mené pendant un an une campagne « 5 fruits et légumes par jour » : une brochure de 12 pages envoyée par courrier et une rubrique sur le site de la ville. L'évaluation donne les résultats ci-dessous.

Document 1 – Part des adultes qui déclarent manger au moins 5 portions par jour (données fictives)

Catégorie	Avant la campagne	Un an après
Cadres et professions intellectuelles	32 %	41 %
Employés	21 %	24 %
Ouvriers et personnes sans emploi	14 %	15 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque catégorie, la progression en points et la progression relative en %. (3 pts)
2. Calculez l'écart en points et le rapport entre cadres et ouvriers avant et après. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez ce résultat avec la notion de littératie. (2 pts)
4. Proposez trois changements pour la campagne de l'année suivante, en suivant l'universalisme proportionné. (3 pts)
5. Citez une limite de ces données. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.12 – Le Nutri-Score, un outil pensé pour la littératie (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un stand dans un hypermarché pendant une semaine de prévention. Vous organisez un petit test (fictif) : 90 clients volontaires doivent classer trois pizzas surgelées de la plus favorable à la moins favorable pour la santé. La moitié voit seulement le tableau nutritionnel ; l'autre moitié voit aussi le Nutri-Score.

Document 1 – Nombre de bons classements (données fictives)

Niveau d'études	Effectif par condition	Tableau seul	Tableau et Nutri-Score
Bac ou moins	45	12	33
Plus que le bac	45	24	39

Document 2 – Ce qu'il faut savoir sur le Nutri-Score

Logo facultatif adopté en France en 2017 ; cinq lettres de A (vert foncé) à E (orange foncé) ; algorithme révisé (aliments en 2022, boissons en 2023), appliqué progressivement en France depuis 2024.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de bons classements dans chaque case du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'écart entre les deux niveaux d'études avec le tableau seul, puis avec le Nutri-Score. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un logo synthétique et coloré aide plus les personnes à littératie limitée qu'un tableau. (2 pts)
4. Citez deux limites d'usage du Nutri-Score que vous expliquerez aux clients. (2 pts)
5. Rédigez trois phrases courtes pour une affiche du stand, en écriture claire. (2 pts)
6. Citez deux limites de ce test. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 5.7

1. Légendes : 1 Illettrisme ; 2 7 % des 18-65 ans scolarisés en France ; 3 lire, écrire, compter malgré une scolarité en France ; 4 Illectronisme ; 5 7 % des 16-74 ans (2025) ; 6 pas d'usage d'internet ou aucune compétence numérique ; 7 Littératie en santé limitée ; 8 environ 44 % des adultes ; 9 difficulté à trouver, comprendre, juger, utiliser l'information de santé.
2. a) illettrisme (scolarisée en France, maîtrise insuffisante) ; b) analphabétisme (jamais scolarisé) ; c) français langue étrangère (scolarisée dans une autre langue, bonne littératie dans sa langue) ; d) illectronisme (pas d'usage d'internet) ; e) littératie en santé limitée (difficulté à juger l'information, alors qu'elle lit bien) ; f) illectronisme (pas de compétences numériques de base malgré l'équipement).
3. Les trois chiffres ne mesurent pas la même chose et ne portent pas sur la même population (18-65 ans scolarisés en France, 16-74 ans, adultes). Une même personne peut être comptée dans deux ou trois mesures ; additionner les pourcentages compterait plusieurs fois les mêmes personnes.

Corrigé – Exercice 5.8

1. Littératie limitée : 12 000 × 44 / 100 = 5 280 adultes. Problématique : 12 000 × 0,30 = 3 600. Insuffisante : 12 000 × 0,14 = 1 680. On vérifie : 3 600 + 1 680 = 5 280.
2. 12 000 × 0,72 = 8 640 adultes. Publier le programme uniquement en ligne exclurait une grande partie des habitants ; il faut plusieurs canaux : affiches, courrier simple, relais (pharmacies, écoles, associations), oral.
3. La commune n'a pas forcément la même structure que la France : plus de personnes âgées, plus de difficultés financières ou au contraire une population plus diplômée. Les données nationales datent de 2019-2021 et la situation a pu évoluer.
4. Les personnes disent si une tâche leur paraît facile ou difficile : on mesure une difficulté ressentie, pas une compétence testée. Certaines personnes peuvent surestimer ou sous-estimer leurs capacités ; on interprète donc ces chiffres comme des ordres de grandeur.
5. Les 17 pays ont utilisé le même questionnaire et la même méthode, sous la coordination du réseau M-POHL.

Corrigé – Exercice 5.9

1. Très grandes : 41 / 60 × 100 = 68,3 % ; assez grandes : 58 / 110 = 52,7 % ; faibles : 49 / 130 = 37,7 % ; aucune : 22 / 100 = 22,0 % ; ensemble : 170 / 400 = 42,5 %.
2. 68,3 / 22,0 = 3,1 : la littératie limitée est environ trois fois plus fréquente.
3. La littératie limitée diminue de façon régulière à chaque niveau de difficulté financière, de 68,3 % à 22,0 %. Ce n'est pas seulement le groupe le plus pauvre qui est touché : c'est toute l'échelle sociale qui suit une pente, c'est un gradient social.
4. Déterminant : une littératie limitée rend plus difficile l'accès à la prévention et la gestion des maladies. Médiateur : les personnes défavorisées ont plus souvent une littératie limitée, et une partie de leur moins bonne santé passe par cette difficulté à utiliser l'information.
5. L'universalisme proportionné (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité et des modalités adaptées au niveau de besoin. Ici : un programme ouvert à tous, avec des supports en écriture claire pour tous ; dans les quartiers où les difficultés sont les plus fortes, des ateliers en plus, des relais habitants, une médiatrice, des séances orales et des rappels par message vocal.
6. 42,5 % est proche des 44 % nationaux ; mais le questionnaire local n'est pas celui de HLS19 et l'échantillon n'est pas forcément représentatif : la comparaison reste indicative.

Corrigé – Exercice 5.10

1. Littératie limitée : 14 / 40 × 100 = 35,0 % ; suffisante : 45 / 60 × 100 = 75,0 % ; différence : 75,0 − 35,0 = 40 points.
2. Risque de ne pas comprendre : limitée 26 / 40 = 65,0 % ; suffisante 15 / 60 = 25,0 % ; RR = 65,0 / 25,0 = 2,6. Les patients à littératie limitée ont 2,6 fois plus de risque de ne pas comprendre leur plan. L'intervalle [1,59 ; 4,26] ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative au seuil de 5 %.
3. Moindre compréhension des traitements et des conseils ; moins bonne gestion des maladies chroniques comme le diabète ; davantage d'hospitalisations et de passages aux urgences ; moindre recours à la prévention.
4. Un seul message par séance, en mots simples ; des objets réels (assiette, aliments, emballages, cuillères) et des photos ; la vérification de la compréhension par le « faire dire » ; un support à emporter en images ; la possibilité de venir avec un proche.
5. Annoncer un score étiquette la personne, provoque la honte et peut la faire partir du programme. Le score sert à l'équipe pour adapter les séances, pas à juger le patient.

Corrigé – Exercice 5.11

1. Cadres : + 9 points, soit 9 / 32 × 100 = + 28,1 % ; employés : + 3 points, soit + 14,3 % ; ouvriers et sans emploi : + 1 point, soit + 7,1 %.
2. Avant : écart 32 − 14 = 18 points, rapport 32 / 14 = 2,29. Après : écart 41 − 15 = 26 points, rapport 41 / 15 = 2,73. La campagne a amélioré la situation de tous, mais elle a surtout profité aux plus favorisés : les inégalités se sont creusées.
3. Une brochure de 12 pages et un site internet demandent une bonne littératie fonctionnelle et numérique. Les personnes qui lisent facilement et utilisent internet ont reçu et compris le message ; les autres l'ont moins reçu et moins compris.
4. Exemples : remplacer la brochure par une affiche à un seul message (« une portion = un poing ») et des cartes recettes en photos ; ajouter des actions de proximité dans les quartiers les plus touchés (dégustations au marché, ateliers en centre social, paniers à petit prix) ; passer par des relais (écoles, médiateurs, associations) et des messages oraux ; agir sur le prix et l'offre (bons d'achat, marché à prix solidaires).
5. Les données sont déclaratives : les personnes peuvent surestimer leur consommation, surtout après une campagne qui parle de ce sujet.

Corrigé – Exercice 5.12

1. Bac ou moins : tableau seul 12 / 45 × 100 = 26,7 % ; avec Nutri-Score 33 / 45 = 73,3 %. Plus que le bac : 24 / 45 = 53,3 % ; 39 / 45 = 86,7 %.
2. Avec le tableau seul, l'écart est de 53,3 − 26,7 = 26,6 points. Avec le Nutri-Score, il n'est plus que de 86,7 − 73,3 = 13,4 points. Le logo aide tout le monde, mais il aide davantage les personnes moins diplômées : il réduit l'écart.
3. Le tableau demande de lire des chiffres pour 100 g, de connaître les nutriments et de comparer plusieurs lignes. Le logo résume l'information en une lettre et une couleur, compréhensibles sans calcul et en quelques secondes.
4. On compare des produits d'une même famille (deux pizzas, pas une pizza et une pomme) ; on regarde aussi la liste d'ingrédients et la taille de la portion ; le logo est facultatif et n'est pas présent sur tous les produits.
5. Exemple : « Comparez deux pizzas. Choisissez la lettre la plus proche du A. Regardez aussi la liste des ingrédients. »
6. Les clients sont volontaires et peu nombreux ; le test porte sur une seule famille de produits ; on mesure un classement en situation de test, pas un achat réel au magasin.

Partie 3 – Repérer sans stigmatiser et adapter le diagnostic

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer l'approche des précautions universelles.
- Reconnaître des signaux possibles de difficulté, sans les interpréter comme une preuve.
- Poser des questions simples pour adapter la communication, sans juger.
- Adapter un outil de diagnostic (questionnaire oral, pictogrammes, médiation).
- Comparer deux modes de passation avec des taux de retour et de réponses exploitables.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- On ne peut pas savoir en regardant quelqu'un s'il a des difficultés de littératie ; les personnes les cachent souvent par honte.
- Précautions universelles (AHRQ) : appliquer à tous une communication claire, au lieu de tester le public. Tout le monde y gagne, personne n'est désigné.
- Signaux possibles : évitement de l'écrit (« j'ai oublié mes lunettes »), difficultés avec les chiffres, questions sur ce qui est déjà écrit, questionnaires non remplis, absence d'adresse mail.
- Questions qui aident sans juger : « Comment préférez-vous recevoir les informations ? », « Quelqu'un vous aide-t-il pour les papiers ? », « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? »
- Au diagnostic : préférer la passation orale ou imagée au questionnaire écrit autoadministré quand le public lit difficilement.

Exercice 5.13 – Vrai ou faux : les précautions universelles (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un quiz pour des bénévoles d'une association d'aide alimentaire qui vont accueillir les bénéficiaires d'un atelier cuisine.

Document 1 – Huit affirmations

a) Pour bien adapter un atelier, il faut d'abord faire passer un test de lecture à chaque participant.

b) Une personne qui dit « j'ai oublié mes lunettes » a forcément des difficultés de lecture.

c) Une écriture claire gêne les personnes qui lisent bien.

d) Les précautions universelles consistent à communiquer clairement avec tout le monde.

e) Les personnes en difficulté avec l'écrit le disent spontanément.

f) Proposer de lire le document à voix haute à tout le groupe évite de désigner quelqu'un.

g) Un questionnaire oral peut remplacer un questionnaire écrit autoadministré.

h) Demander « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? » est une question stigmatisante.

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifiez en une phrase. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.14 – Les signaux à l'accueil d'une épicerie solidaire (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une épicerie solidaire (fictive). Pendant l'accueil, vous observez les échanges entre une bénévole et des bénéficiaires.

Document 1 – Notes d'observation

a) Mme B. tend le formulaire d'inscription à sa fille de 12 ans pour qu'elle le remplisse.

b) M. C. demande : « Le prix au kilo, c'est pour combien de paquets ? »

c) Mme F. prend la fiche recette et dit : « Je la lirai chez moi. »

d) M. H. n'a pas d'adresse mail et dit qu'il utilise son téléphone « seulement pour appeler ».

e) La bénévole dit à voix haute devant la file d'attente : « Ah, vous ne savez pas lire ? Je vais vous aider. »

f) Mme K. demande quand a lieu l'atelier, alors que la date est écrite en gros sur l'affiche à côté d'elle.

À vous de jouer – Questions

1. Pour les situations a), b), c), d) et f), nommez le signal possible observé. (2,5 pts)
2. Expliquez pourquoi ces signaux ne sont pas des preuves. Donnez une autre explication possible pour deux d'entre eux. (2,5 pts)
3. Analysez la phrase de la bénévole en e) et ses conséquences possibles. (2 pts)
4. Proposez trois changements simples de l'accueil qui suivent les précautions universelles. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.15 – Réécrire un questionnaire de diagnostic (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (fictive) veut connaître les habitudes de petit-déjeuner des familles avant de lancer un projet. L'an dernier, elle a distribué un questionnaire écrit dans les cartables. Vous devez le refaire.

Document 1 – Extrait du questionnaire de l'an dernier

Q1. Quelle est la fréquence hebdomadaire de prise du petit-déjeuner de votre enfant ?

Q2. Votre enfant consomme-t-il des produits céréaliers complets et/ou des produits laitiers non sucrés au cours de cette prise alimentaire ?

Q3. Estimez-vous que le petit-déjeuner contribue à la couverture des besoins nutritionnels de votre enfant ? (pas du tout / peu / moyennement / assez / tout à fait)

Q4. Quels sont les freins à la prise d'un petit-déjeuner équilibré au domicile ?

Q5. Seriez-vous intéressé(e) par une action collective de type atelier de sensibilisation ?

Q6. Merci de retourner ce questionnaire complété à l'enseignant sous 8 jours.

Document 2 – Bilan de l'an dernier

140 questionnaires distribués ; 23 retournés, dont 9 incomplets.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de retour, la part de questionnaires incomplets parmi les retours et la part de questionnaires exploitables sur l'ensemble des questionnaires distribués. (2 pts)
2. Relevez quatre défauts de rédaction du document 1. (2 pts)
3. Réécrivez les questions Q1, Q2, Q4 et Q5 pour une passation orale, avec des mots courants et des réponses simples. (4 pts)
4. Proposez une version imagée de la question Q2 (décrivez les images et la consigne). (2 pts)
5. Proposez deux autres moyens de recueillir l'information auprès des familles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.16 – Questionnaire écrit ou passation orale ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Suite de l'exercice 5.15. Cette année, la maison de quartier a testé une passation orale à la sortie de l'école, menée par une médiatrice qui parle français, arabe et turc. Vous devez comparer les deux méthodes pour la direction.

Document 1 – Comparaison (données fictives)

	Questionnaire écrit (an dernier)	Passation orale (cette année)
Familles sollicitées	140	75
Réponses obtenues	23	60
Réponses complètes	14	57
Durée par réponse	—	12 minutes
Coût	impression 0,12 € par questionnaire	médiatrice 22 € de l'heure

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour la passation orale, le taux d'acceptation, la part de réponses complètes parmi les réponses et la part de réponses exploitables parmi les familles sollicitées. Comparez avec l'écrit (exercice 5.15). (3 pts)
2. Calculez le temps total de passation orale en heures et son coût, puis le coût par réponse exploitable pour chaque méthode. (3 pts)
3. Argumentez en faveur de la passation orale, en tenant compte du coût. (3 pts)
4. Citez deux biais possibles de la passation orale et la façon de les limiter. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi un taux de retour faible à l'écrit fausse le diagnostic. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.17 – Poser les bonnes questions sans juger (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et production · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez les animateurs d'un centre social à l'accueil des participants d'un nouvel atelier cuisine. Vous avez relevé les questions qu'ils posent en ce moment lors de l'inscription.

Document 1 – Questions posées par les animateurs

a) « Vous savez lire ? »

b) « Vous avez internet, comme tout le monde ? »

c) « Vous comprenez le français ? »

d) « Je vous donne le règlement, vous signez en bas après l'avoir lu. »

e) « Vous avez bien compris ? »

f) « Comment préférez-vous qu'on vous prévienne pour les ateliers ? »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque question : adaptée ou à éviter. Justifiez. (3 pts)
2. Réécrivez les questions à éviter pour qu'elles aident à adapter l'accueil sans juger. (5 pts)
3. Expliquez ce que l'animateur doit faire de la réponse à la question f). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.18 – Diagnostic dans une résidence sociale (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence sociale (fictive), ancien foyer de travailleurs migrants, accueille 52 hommes âgés de 55 à 84 ans. Chaque étage a une cuisine collective. L'infirmière qui passe chaque semaine s'inquiète de repas répétitifs et de cas de diabète. Le gestionnaire vous demande de préparer un projet. Vous avez fait un premier recueil avec le responsable de la résidence.

Document 1 – Premier recueil (n = 52, données fictives)

Caractéristique	Effectif
Langue la plus utilisée : arabe	31
Langue la plus utilisée : soninké ou bambara	9
Langue la plus utilisée : français	12
Lit peu ou pas le français	27
A un téléphone mobile	44
Utilise WhatsApp	18
Cuisine dans la cuisine collective	46
Signale des problèmes de vue non corrigés	15

Document 2 – Paroles recueillies

- « Les papiers, c'est mon voisin qui me les lit. »
- « On cuisine ensemble au troisième, chacun met 3 € et on fait un grand plat. »
- « Le médecin m'a donné une feuille pour le diabète. Je l'ai gardée, mais je ne l'ai pas lue. »
- « Le mardi, après la prière, tout le monde est dans la salle commune. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque caractéristique du document 1. (4 pts)
2. À partir des documents, dites quels éléments de littératie le diagnostic doit encore recueillir et comment les recueillir sans questionnaire écrit. (3 pts)
3. Identifiez trois ressources du milieu sur lesquelles le projet peut s'appuyer. (3 pts)
4. Proposez deux canaux pour inviter les résidents à la première rencontre. Justifiez avec les chiffres. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi la feuille sur le diabète n'a pas été utile, et ce que le projet peut faire avec l'infirmière et le médecin. (2 pts)
6. Citez deux précautions éthiques pour ce diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 5.13

a) Faux : tester les personnes est vécu comme humiliant et inutile ; on adapte la communication pour tous. b) Faux : c'est un signal possible, mais la personne a peut-être vraiment oublié ses lunettes. c) Faux : une écriture claire est plus rapide et plus agréable à lire pour tout le monde. d) Vrai : c'est la définition des précautions universelles (AHRQ). e) Faux : les difficultés sont souvent cachées par honte ; on ne peut pas attendre qu'elles soient dites. f) Vrai : la lecture collective aide tout le monde sans désigner personne. g) Vrai : la passation orale ou en entretien convient mieux aux publics qui lisent peu et donne des réponses plus complètes. h) Faux : c'est une question neutre et respectueuse qui aide à choisir la bonne langue ou un interprète.

Corrigé – Exercice 5.14

1. a) évitement de l'écrit (formulaire rempli par un proche) ; b) difficulté avec les chiffres (prix au kilo) ; c) évitement de l'écrit (« je la lirai chez moi ») ; d) difficultés numériques (pas de mail, téléphone pour appeler) ; f) question sur une information déjà écrite.
2. Un signal peut avoir d'autres causes ; seul, il ne prouve rien et on ne pose pas de diagnostic sur une personne. Exemples : en a), Mme B. a peut-être mal aux yeux ou veut apprendre à sa fille à remplir un document ; en c), Mme F. est peut-être pressée ; en f), elle veut peut-être simplement engager la conversation.
3. La bénévole révèle devant tout le monde une difficulté supposée : c'est humiliant et stigmatisant. La personne risque de ne pas revenir, et d'autres personnes en difficulté n'oseront plus demander d'aide. La phrase est aussi peut-être fausse.
4. Exemples : lire à voix haute les informations importantes à tous les nouveaux inscrits ; proposer à tous de remplir le formulaire ensemble, dans un coin calme ; afficher les dates avec un calendrier en images et les rappeler à l'oral ; remettre des fiches recettes en photos ; former les bénévoles à des phrases neutres (« Je remplis avec vous, c'est plus rapide »).

Corrigé – Exercice 5.15

1. Taux de retour : 23 / 140 × 100 = 16,4 %. Incomplets parmi les retours : 9 / 23 × 100 = 39,1 %. Exploitables sur l'ensemble : (23 − 9) / 140 = 14 / 140 × 100 = 10,0 %.
2. Défauts : vocabulaire technique (« fréquence hebdomadaire », « produits céréaliers complets », « couverture des besoins nutritionnels », « freins ») ; questions longues et doubles (Q2 mélange deux sujets avec « et/ou ») ; échelle à cinq niveaux difficile à utiliser ; Q5 utilise un jargon (« action collective », « sensibilisation ») ; retour par écrit via l'enseignant, sans aide.
3. Exemples : Q1 « Combien de matins par semaine votre enfant mange-t-il avant l'école ? (jamais, 1 à 3 matins, 4 à 6 matins, tous les matins) » ; Q2 « Le matin, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il boit ? » (l'enquêtrice coche dans une liste) ; Q4 « Qu'est-ce qui rend le petit-déjeuner difficile chez vous ? Par exemple le temps, l'envie de l'enfant, le prix » ; Q5 « Aimeriez-vous venir à un moment entre parents pour préparer des petits-déjeuners ensemble ? (oui, non, peut-être) ».
4. Exemple : une planche de 12 photos réelles (pain, céréales, biscuits, fruit, lait, yaourt, jus, soda, chocolat en poudre, rien…) ; consigne orale : « Montrez-moi les photos de ce que votre enfant a mangé et bu ce matin. » L'enquêtrice note les numéros.
5. Exemples : des entretiens courts avec des parents à la sortie de l'école ; un groupe de parole autour d'un petit-déjeuner partagé ; l'observation d'un petit-déjeuner pris à l'accueil du matin ; un photolangage.

Corrigé – Exercice 5.16

1. Taux d'acceptation : 60 / 75 × 100 = 80,0 %. Réponses complètes parmi les réponses : 57 / 60 = 95,0 %.

Exploitables parmi les familles sollicitées : 57 / 75 = 76,0 %. À l'écrit : 16,4 % de retour, 60,9 % de réponses complètes (14 / 23) et 10,0 % d'exploitables. L'oral donne 7,6 fois plus de réponses exploitables en proportion (76,0 / 10,0).

2. Temps : 60 × 12 = 720 minutes, soit 12 heures. Coût : 12 × 22 = 264 €. Écrit : 140 × 0,12 = 16,80 €, soit 16,80 / 14 = 1,20 € par réponse exploitable. Oral : 264 / 57 = 4,63 € par réponse exploitable.

3. L'oral coûte plus cher, mais il donne 57 réponses complètes au lieu de 14 et il touche les familles qui ne répondent jamais à l'écrit, souvent celles qui ont le plus besoin du projet. Un diagnostic fondé sur 14 réponses ne représente pas le quartier. La médiatrice crée aussi un premier lien de confiance et fait connaître le projet. Le coût reste raisonnable (moins de 5 € par réponse).

4. Biais de désirabilité sociale (on répond ce que l'on pense être attendu) : questions neutres, sans jugement, enquêtrice formée. Biais de l'enquêteur (formulation variable, traduction différente) : grille commune, mêmes mots, traduction préparée à l'avance. On peut aussi citer le biais de sélection (seules les familles présentes à la sortie de l'école sont interrogées) : varier les horaires et les lieux.

5. Les familles qui répondent à l'écrit sont surtout celles qui lisent facilement et qui ont du temps : le diagnostic décrit alors une partie seulement du public, souvent la plus favorisée. C'est un biais de sélection.

Corrigé – Exercice 5.17

1. a) À éviter : humiliante, elle désigne la personne et appelle souvent un « oui » de gêne. b) À éviter : « comme tout le monde » juge et met mal à l'aise. c) À éviter : question fermée qui peut vexer ; mieux vaut demander la langue préférée. d) À éviter : suppose que la personne lit le règlement et la fait signer sans comprendre. e) À éviter : appelle presque toujours « oui » ; ne vérifie rien. f) Adaptée : ouverte, neutre, elle laisse la personne choisir.

2. a) « Pour les papiers, vous préférez qu'on les remplisse ensemble ou que vous les preniez avec vous ? » b) « Comment voulez-vous qu'on vous prévienne : par téléphone, par message, par papier ? » c) « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? Nous pouvons demander à une médiatrice de venir. » d) « Je vous explique les quatre règles importantes, avec les images. Ensuite, vous me dites si vous avez des questions, et on signe ensemble. » e) « Pour être sûr d'avoir bien expliqué, pouvez-vous me dire ce que vous apportez à l'atelier de mardi ? »

3. Il note la réponse dans la fiche d'inscription et la respecte : appel la veille, message vocal, carte papier. Il ne choisit pas à la place de la personne, et il ne réserve pas l'information au numérique.

Corrigé – Exercice 5.18

1. Arabe 31 / 52 × 100 = 59,6 % ; soninké ou bambara 9 / 52 = 17,3 % ; français 12 / 52 = 23,1 % ; lit peu ou pas le français 27 / 52 = 51,9 % ; téléphone mobile 44 / 52 = 84,6 % ; WhatsApp 18 / 52 = 34,6 % ; cuisine collective 46 / 52 = 88,5 % ; problèmes de vue non corrigés 15 / 52 = 28,8 %.

2. À recueillir : la lecture dans la langue d'origine (certains lisent l'arabe), la compréhension orale du français, les habitudes de repas et de courses, les connaissances sur le diabète et ce qui a été compris des consignes du médecin, la vue (lunettes). Méthodes : entretiens individuels avec un interprète ou un résident relais ; un groupe de parole dans la salle commune le mardi ; l'observation d'une préparation de repas dans une cuisine d'étage, avec l'accord des résidents.

3. Ressources : la cuisine collective et l'organisation déjà en place (« chacun met 3 € ») ; l'entraide entre voisins (le voisin qui lit les papiers peut devenir relais) ; le rendez-vous du mardi dans la salle commune ; l'infirmière qui connaît les résidents ; le responsable de la résidence.

4. Une annonce orale le mardi dans la salle commune, faite par un résident relais en arabe, en soninké et en français, car 51,9 % lisent peu le français et le rendez-vous rassemble « tout le monde ». Un appel ou un message vocal sur le téléphone, car 84,6 % ont un mobile ; WhatsApp seul ne suffit pas (34,6 %). Une affiche avec un pictogramme et une photo peut compléter, avec de gros caractères (28,8 % ont des problèmes de vue).

5. La feuille est écrite en français, sans doute avec des mots techniques, et remise sans vérification de la compréhension ; le résident ne la lit pas. Le projet peut proposer avec l'infirmière des séances orales sur le diabète avec des aliments réels, traduire les messages clés avec un interprète professionnel, demander au médecin des consignes courtes et en images, et vérifier la compréhension par le « faire dire ».

6. Recueillir le consentement libre de chaque résident et expliquer à quoi servent les informations ; garantir la confidentialité (ne pas parler du diabète d'un résident devant les autres) ; ne pas utiliser un voisin comme interprète pour des informations médicales personnelles ; ne pas présenter les résultats d'une façon qui stigmatise les résidents.

Partie 4 – Écrire clair, FALC et mesure de la lisibilité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer dans l'ordre les six étapes d'une communication accessible.
- Appliquer les règles d'écriture claire du guide « Communiquer pour tous » (Santé publique France, 2018).
- Définir le FALC et dire qui valide un document FALC.
- Calculer et interpréter l'indice de lisibilité de Kandel et Moles (1958).
- Citer les limites de l'indice et montrer que le test auprès du public reste indispensable.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six étapes : connaître le public, choisir un message, écrire simple, illustrer, tester, vérifier par le « faire dire ».
- Écriture claire : une idée par phrase, 15 mots au plus ; mots courants ; forme active ; phrases positives ; chiffres concrets ; pas de sigles ; police sans empattement de 14 points au moins, alignée à gauche ; images utiles.
- FALC (Facile à lire et à comprendre) : règles européennes (Inclusion Europe, 2009), conçu avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel ; document relu et validé par des personnes concernées.
- L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots). Échelle : 0-30 très difficile ; 30-50 difficile ; 50-60 assez difficile ; 60-70 standard ; 70-80 assez facile ; 80-90 facile ; 90-100 très facile.
- L'indice ne mesure ni le sens, ni la mise en page, ni l'adéquation au public.

Exercice 5.19 – Les six étapes d'une communication accessible (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue doit concevoir une affiche sur l'hydratation pour un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle vous demande de lui rappeler la méthode.

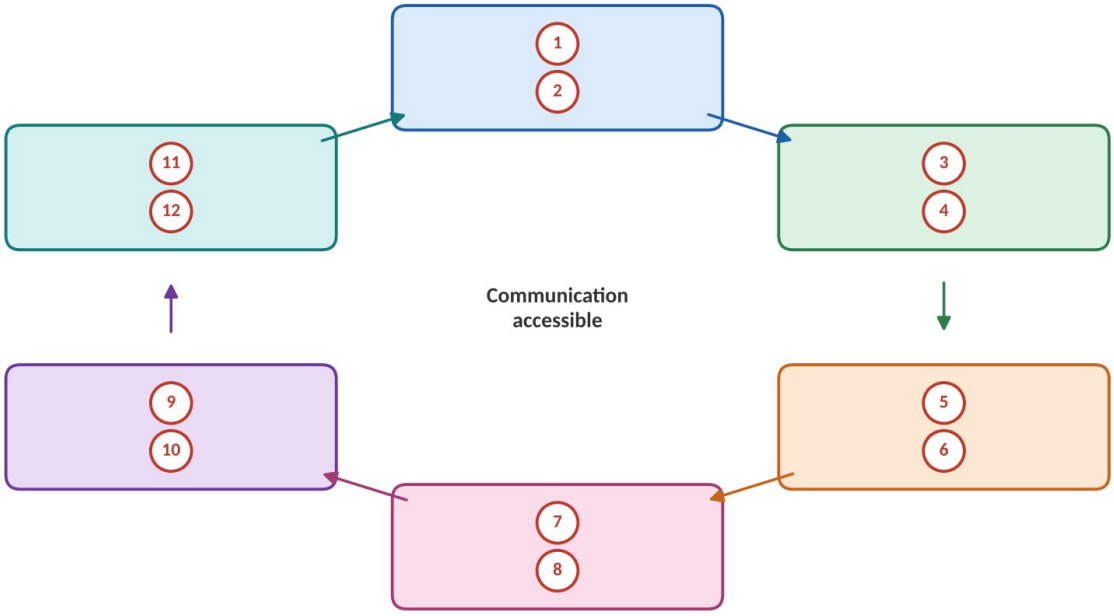


Figure 5.5 – Document 1 – Six étapes pour une communication accessible (schéma à légender)

Document 2 – Ce que la collègue a prévu, dans le désordre

a) Montrer l'affiche à cinq résidents et à deux aides-soignantes avant de l'imprimer.

b) Ajouter la photo d'un verre d'eau et d'une carafe posés sur une table de chambre.

c) Garder un seul message : « Buvez un verre d'eau à chaque repas et entre les repas. »

d) Demander aux résidents, après la présentation, de dire avec leurs mots quand ils vont boire.

e) Se renseigner sur la vue, l'audition et les troubles de la mémoire des résidents.

f) Remplacer « hydratation » par « boire » et « 1,5 L » par « 6 à 8 verres ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Remettez les actions du document 2 dans l'ordre des six étapes. (3 pts)
3. Dites pourquoi l'étape « tester » se place avant l'impression. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.20 – Calculer et situer trois indices de lisibilité (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez choisir, pour un atelier en centre social, le texte le plus facile parmi trois présentations d'une recette de soupe. Vous avez compté les mots, les phrases et les syllabes.

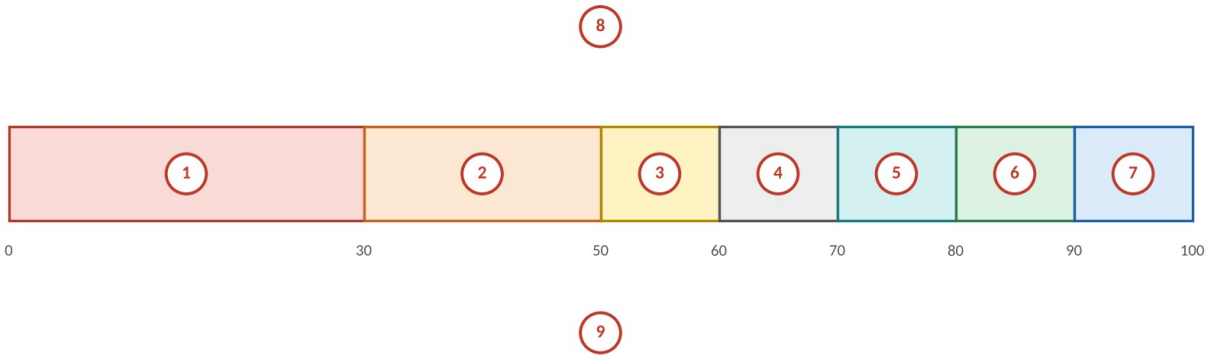


Figure 5.6 – Document 1 – L'échelle de lisibilité (schéma à légender)

Document 2 – Comptages des trois textes

Texte	Mots	Phrases	Syllabes
A	84	4	150
B	60	8	84
C	45	2	90

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque texte, le nombre de mots par phrase, le nombre de syllabes par mot (au millième) et l'indice L (au centième). (4,5 pts)
3. Situez chaque texte sur l'échelle et choisissez le texte pour l'atelier. (1,5 pt)
4. Le texte C est le plus court. Expliquez pourquoi il est pourtant le plus difficile. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.21 – Appliquer les règles d'écriture claire (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) prépare un dépliant « Bien manger avec un petit budget ». Elle vous demande de relire huit phrases.

Document 1 – Les huit phrases du dépliant

a) Il est recommandé de privilégier la consommation de légumineuses au moins deux fois par semaine.

b) Ne pas oublier de consulter les DLC et les DDM avant d'acheter.

c) Les AGS doivent être limités au profit des AGPI oméga-3.

d) Une consommation de 400 g de fruits et légumes par jour est conseillée par l'OMS.

e) Il convient d'éviter de jeter les restes, dans la mesure où ils peuvent être réutilisés dans des préparations ultérieures, par exemple des soupes ou des gratins, ce qui permet de réaliser des économies.

f) LES PRODUITS DE SAISON SONT MOINS CHERS.

g) Les produits ultra-transformés ne sont pas à privilégier.

h) Le pain complet présente une teneur en fibres supérieure.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase, nommez la ou les règles d'écriture claire qui ne sont pas respectées. (4 pts)
2. Réécrivez chaque phrase en écriture claire. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.22 – La lettre aux familles sur le goûter (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire (fictive) veut que les familles apportent des goûters variés pour la récréation de l'après-midi à l'accueil périscolaire. La première lettre n'a rien changé. Vous l'avez réécrite avec deux mamans du conseil d'école, puis vous avez testé les deux versions.

Document 1 – Extrait de la première version

« Dans le cadre de la démarche de promotion de la santé engagée par l'établissement en partenariat avec la commune, nous sollicitons votre collaboration afin de favoriser la diversification des collations apportées par les élèves lors du temps périscolaire, en privilégiant les fruits frais, les produits céréaliers peu sucrés et les produits laitiers non aromatisés, au détriment des produits de biscuiterie industrielle et des boissons sucrées. »

Document 2 – Comptages et test de compréhension

- Première version (lettre entière) : 186 mots, 6 phrases, 320 syllabes.
- Version réécrite : 98 mots, 11 phrases, 147 syllabes, 4 photos de goûters.
- Test auprès de 12 parents : « Citez deux goûters conseillés par l'école. » Première version : 5 bonnes réponses ; version réécrite : 11 bonnes réponses.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice de lisibilité de chaque version (mots par phrase, syllabes par mot, L) et le gain. Situez chaque version sur l'échelle. (5 pts)
2. Calculez le taux de bonnes réponses au test pour chaque version. (2 pts)
3. Relevez dans le document 1 quatre éléments qui rendent la lettre difficile. (2 pts)
4. Rédigez le début de la version réécrite : un titre et quatre phrases. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi le test auprès des parents est plus important que l'indice. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.23 – Un menu en FALC pour un ESAT (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT, fictif) emploie 60 travailleurs en situation de handicap intellectuel. Le restaurant de l'ESAT affiche chaque jour son menu. Le directeur souhaite que les travailleurs puissent le lire seuls et choisir leur plat.

Document 1 – Le menu actuel

« Menu du jeudi : Velouté Du Barry ; Émincé de volaille sauce suprême ou Dos de colin, beurre blanc ; Accompagnements : riz pilaf / poêlée de légumes ; Fromage AOP ou Laitage ; Dessert : Crumble pomme-rhubarbe. Allergènes : se renseigner auprès du personnel. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le FALC et dites d'où viennent ses règles. (2 pts)
2. Relevez cinq difficultés du menu actuel pour les travailleurs de l'ESAT. (2,5 pts)
3. Réécrivez le menu en FALC : mots, présentation, images à prévoir. (4 pts)
4. Expliquez qui doit relire et valider ce menu, et pourquoi. (2 pts)
5. Citez une ressource FALC existante en santé et deux autres publics à qui ce menu sera utile. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.24 – Les limites de l'indice de lisibilité (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a calculé l'indice de lisibilité de trois fiches pour un atelier « diabète et alimentation » d'une association de patients. Elle conclut : « Les fiches 1 et 2 ont le même indice, elles sont aussi faciles l'une que l'autre. »

Document 1 – Extraits et comptages

- Fiche 1 (60 mots, 6 phrases, 90 syllabes) : « Le pain complet cale plus longtemps. Mangez-en le matin. Les légumes vont à chaque repas… »
- Fiche 2 (60 mots, 6 phrases, 90 syllabes) : « Visez un IG bas. Le pain T150 est OK. Évitez les AGS et les GL hauts… »
- Fiche 3 (72 mots, 3 phrases, 115 syllabes), mise en page aérée avec 5 photos.
- Test auprès de 10 membres de l'association : « Que mangez-vous au petit-déjeuner pour être rassasié jusqu'à midi ? » Fiche 1 : 9 bonnes réponses ; fiche 2 : 3 ; fiche 3 : 8.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice L des trois fiches. (3 pts)

2. Calculez le taux de bonnes réponses au test pour chaque fiche. (1,5 pt)

3. Expliquez pourquoi les fiches 1 et 2 ont le même indice mais pas la même compréhension. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi la fiche 3, moins lisible selon l'indice, est bien comprise. (2 pts)

5. Rédigez un paragraphe de conseil à la stagiaire sur le bon usage de l'indice. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 5.19

1. Légendes : 1 Connaître le public ; 2 langue, écrit, numérique, handicap ; 3 Choisir un message ; 4 un message principal, trois idées au plus ; 5 Écrire simple ; 6 phrases courtes, mots courants, chiffres concrets ; 7 Illustrer ; 8 pictogrammes, photos, objets réels ; 9 Tester ; 10 auprès de personnes du public, avant de diffuser ; 11 Vérifier ; 12 faire dire en séance.
2. Ordre : e) connaître le public ; c) choisir un message ; f) écrire simple ; b) illustrer ; a) tester ; d) vérifier.
3. Tester avant l'impression permet de corriger les mots ou les images mal compris sans réimprimer, donc sans perdre d'argent ni diffuser un message mal compris.

Corrigé – Exercice 5.20

1. Légendes : 1 très difficile ; 2 difficile ; 3 assez difficile ; 4 standard ; 5 assez facile ; 6 facile ; 7 très facile ; 8 L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; 9 des phrases plus courtes et des mots plus courts font monter L.
2. Texte A : 84 / 4 = 21 mots par phrase ; 150 / 84 = 1,786 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 21 − 73,6 × 1,786 = 207 − 21,32 − 131,43 = 54,26 (calcul fait avec 150 / 84 non arrondi). Texte B : 60 / 8 = 7,5 ; 84 / 60 = 1,400 ; L = 207 − 7,61 − 103,04 = 96,35. Texte C : 45 / 2 = 22,5 ; 90 / 45 = 2,000 ; L = 207 − 22,84 − 147,2 = 36,96.
3. A : assez difficile (50-60) ; B : très facile (90-100) ; C : difficile (30-50). On choisit le texte B.
4. L'indice ne dépend pas de la longueur totale du texte mais de la longueur des phrases et des mots. Le texte C a de longues phrases (22,5 mots) et des mots longs (2 syllabes en moyenne).

Corrigé – Exercice 5.21

1. a) mots difficiles (« privilégier », « légumineuses »), forme impersonnelle ; b) phrase négative, sigles ; c) sigles, mots techniques ; d) chiffre abstrait (400 g), sigle ; e) phrase très longue avec plusieurs idées, forme impersonnelle ; f) majuscules, difficiles à lire ; g) tournure négative, mot technique ; h) mots difficiles, comparaison sans repère.
2. Exemples : a) « Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs deux fois par semaine. » b) « Avant d'acheter, regardez la date sur l'emballage. » c) « Utilisez de l'huile de colza. Elle est bonne pour le cœur. » d) « Mangez 5 fruits et légumes par jour. Une portion, c'est la taille d'un poing. » e) « Ne jetez pas les restes. Faites une soupe ou un gratin. Vous ferez des économies. » f) « Les fruits et légumes de saison sont moins chers. » g) « Cuisinez des produits simples : légumes, œufs, pâtes, riz. » h) « Le pain complet contient plus de fibres. Il cale plus longtemps. » (Pour b), on peut ajouter une explication courte : « "À consommer jusqu'au" : ne pas dépasser. »)

Corrigé – Exercice 5.22

1. Première version : 186 / 6 = 31,0 mots par phrase ; 320 / 186 = 1,7204 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 31 − 73,6 × 1,7204 = 207 − 31,47 − 126,62 = 48,91, texte difficile. Version réécrite : 98 / 11 = 8,909 mots par phrase ; 147 / 98 = 1,5 ; L = 207 − 9,04 − 110,4 = 87,56, texte facile. Gain : 87,56 − 48,91 = 38,65 points.
2. Première version : 5 / 12 × 100 = 41,7 % ; version réécrite : 11 / 12 × 100 = 91,7 %.
3. Une seule phrase très longue ; vocabulaire administratif (« dans le cadre de », « nous sollicitons votre collaboration ») ; mots techniques (« diversification des collations », « produits céréaliers », « biscuiterie industrielle ») ; aucun exemple concret de goûter ; formulation négative (« au détriment de »).
4. Exemple : titre « Le goûter de l'après-midi ». « Votre enfant a faim à 16 h. » « Donnez-lui un fruit ou du pain. » « Ajoutez un yaourt ou un morceau de fromage. » « Pour boire, de l'eau suffit. »

5. L'indice montre seulement que les phrases et les mots sont plus courts. Le test montre que les parents ont réellement compris le message : 91,7 % au lieu de 41,7 %. C'est le test qui prouve la compréhension.

Corrigé – Exercice 5.23

1. Le FALC (Facile à lire et à comprendre) est une méthode d'écriture qui vient des règles européennes d'Inclusion Europe (2009). Elle a été conçue avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

2. Mots inconnus ou recherchés (« velouté Du Barry », « émincé », « sauce suprême », « beurre blanc », « pilaf ») ; sigle (AOP) ; tout est sur une ligne, sans séparation ni image ; majuscules au milieu des phrases ; choix multiples difficiles à repérer (« ou », « / ») ; allergènes non indiqués.

3. Exemple : titre « Jeudi » avec la photo du jour ; une ligne par plat, avec une photo de chaque plat : « Soupe de chou-fleur » ; « Plat : poulet en sauce blanche OU poisson en sauce » (deux photos côte à côte, le mot « OU » en gras) ; « Avec : riz ou légumes » ; « Fromage ou yaourt » ; « Dessert : gâteau aux pommes ». Pictogrammes des allergènes à côté de chaque plat (lait, poisson, gluten). Police sans empattement, grande taille, texte aligné à gauche, mêmes mots chaque jour pour les mêmes choses.

4. Des travailleurs de l'ESAT relisent le menu et disent ce qu'ils ne comprennent pas ; on corrige avec eux. C'est une règle du FALC : un document n'est « facile à lire » que si des personnes concernées l'ont validé. On peut alors utiliser le logo européen « Facile à lire ».

5. Ressource : SantéBD, bandes dessinées en FALC sur la santé. Autres publics : personnes qui apprennent le français, personnes âgées, personnes fatiguées ou qui lisent peu.

Corrigé – Exercice 5.24

1. Fiche 1 : L = 207 − 1,015 × (60 / 6) − 73,6 × (90 / 60) = 207 − 10,15 − 110,4 = 86,45. Fiche 2 : mêmes comptages, donc L = 86,45. Fiche 3 : 207 − 1,015 × 24 − 73,6 × 1,597 = 207 − 24,36 − 117,56 = 65,08.

2. Fiche 1 : 9 / 10 = 90 % ; fiche 2 : 3 / 10 = 30 % ; fiche 3 : 8 / 10 = 80 %.

3. L'indice ne compte que les mots, les phrases et les syllabes. La fiche 2 utilise des sigles courts mais incompréhensibles (IG, AGS, GL, T150) et des mots familiers sans sens précis (« OK ») : ils ne font pas baisser l'indice mais empêchent de comprendre. L'indice ne mesure pas le sens.

4. Ses phrases sont plus longues, mais la mise en page est aérée et les cinq photos montrent ce qu'il faut manger. L'indice ne tient compte ni de la mise en page ni des images.

5. Exemple : « L'indice est un bon outil pour repérer les phrases trop longues et les mots trop compliqués, et pour comparer deux versions d'un même texte. Mais il ne dit pas si le texte a du sens pour le public, s'il contient des sigles ou si la mise en page aide. Il faut donc toujours vérifier l'absence de sigles et de jargon, puis tester la fiche auprès de quelques personnes du public avant de la diffuser. »

Partie 5 – Vérifier la compréhension et animer un atelier accessible

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire la boucle du « faire dire » (teach-back) et ses cinq temps.
- Transformer une question fermée en question de « faire dire ».
- Construire une séquence d'atelier de 2 heures selon les précautions universelles.
- Calculer des taux de réussite à partir d'une grille d'observation et en tirer un ajustement.
- Adapter un message oral (message vocal, annonce).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Boucle du « faire dire » : expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer autrement si besoin, confirmer.
- On présente la demande comme une vérification de sa propre clarté : « Pour être sûre d'avoir bien expliqué… »
- « Vous avez compris ? » appelle presque toujours « oui » : on préfère une question ouverte qui demande d'agir (« Montrez-moi comment vous choisiriez… »).
- La HAS a publié en 2015 une fiche-outil « Faire dire » ; la technique s'utilise aussi en groupe.
- Atelier accessible : accueil individuel, recueil des pratiques sans écrit (photolangage), un seul message, démonstration, pratique en binômes, dégustation, faire dire, support à emporter en photos.

Exercice 5.25 – Légender la boucle du « faire dire » (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez les animateurs d'un réseau de centres sociaux à la vérification de la compréhension. Vous partez du schéma de la boucle du « faire dire ».

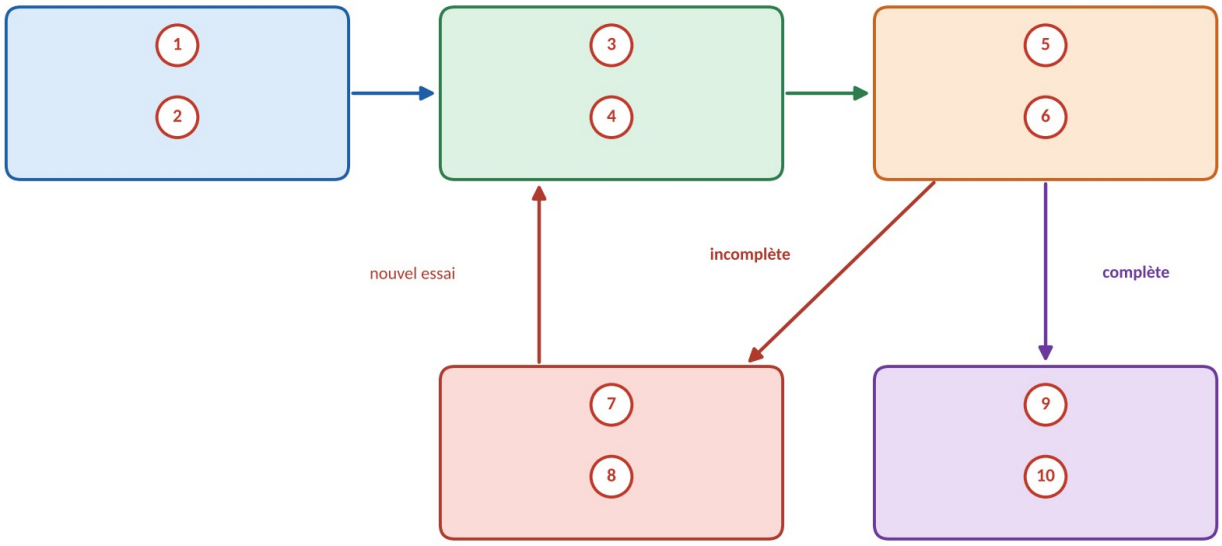


Figure 5.7 – Document 1 – La boucle du « faire dire » (schéma à légender)

Document 2 – Un échange observé en fin d'atelier

Animatrice : « Bon, les lentilles, c'est 20 minutes. Vous avez compris ? »

Participant : « Oui, oui. »

Animatrice : « Parfait, on range. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Relevez deux erreurs de l'animatrice dans le document 2. (2 pts)
3. Réécrivez l'échange en suivant la boucle du « faire dire », avec une réponse incomplète du participant puis une nouvelle explication. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.26 – Des questions qui font agir (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez avec une collègue le déroulé d'un atelier « petit-déjeuner » pour des parents dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI). Chaque séquence se termine par une question fermée.

Document 1 – Les questions prévues

a) « Vous avez compris la différence entre les deux céréales ? »

b) « C'est clair pour la quantité de lait ? »

c) « Vous savez lire le Nutri-Score maintenant ? »

d) « Vous voyez combien de sucre il y a dans ce jus ? »

e) « Vous retiendrez de donner de l'eau ? »

f) « Des questions ? »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi ces questions ne vérifient pas la compréhension. (2 pts)

2. Réécrivez chaque question en question de « faire dire » ou en consigne d'action. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.27 – Analyser un « faire dire » en entretien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'une action de prévention de la déshydratation l'été, le CCAS d'une ville (fictive) organise des visites à domicile. Vous accompagnez une conseillère auprès de Mme P., 84 ans, qui vit seule. Voici l'échange.

Document 1 – L'échange

Conseillère : « Quand il fait chaud, le corps perd de l'eau. Il faut boire même sans soif. Ce verre-là, c'est votre verre : il en faut 6 à 8 par jour. »

Conseillère : « Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez faire demain ? »

Mme P. : « Je bois quand j'ai soif, comme d'habitude. »

Conseillère : « Je vais le dire autrement. On va poser une bouteille ici, sur la table. Chaque fois que vous mangez ou que vous prenez vos médicaments, vous buvez un verre. Le soir, la bouteille doit être presque vide. »

Conseillère : « Vous pouvez me redire ce que vous allez faire avec cette bouteille ? »

Mme P. : « Un verre aux repas et avec les cachets. Et le soir je regarde la bouteille. »

Conseillère : « C'est exactement ça. Je vous laisse cette feuille avec le dessin de la bouteille et des verres. »

À vous de jouer – Questions

1. Repérez dans l'échange chacune des étapes de la boucle du « faire dire ». (5 pts)
2. Expliquez pourquoi la conseillère n'a pas répété sa première phrase, et ce qu'elle a changé. (3 pts)
3. Relevez deux autres adaptations utiles pour une personne âgée. (2 pts)
4. Proposez un moyen de vérifier, lors de la visite suivante, que le conseil est appliqué. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.28 – Construire une séquence d'atelier accessible (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – production · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mission locale (fictive) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans le contrat d'engagement jeune (dispositif national créé en 2022). Elle vous demande un atelier de 2 heures « Manger bien avec 5 € par jour » pour 10 jeunes. La conseillère vous prévient : plusieurs jeunes ont quitté l'école tôt, trois parlent peu le français, presque tous ont un smartphone, et beaucoup « détestent les cours ».

Document 1 – Ressources disponibles

Une cuisine pédagogique avec deux plaques de cuisson ; un budget de courses de 25 € ; un vidéoprojecteur ; une médiatrice qui parle arabe et tigrigna, disponible 1 heure.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez le message principal de l'atelier et un objectif de compétence. (2 pts)
2. Construisez la séquence de 120 minutes sous forme de tableau : durée, étape, ce que font les jeunes, adaptation de littératie. Vérifiez que le total fait 120 minutes. (6 pts)
3. Expliquez comment vous utilisez la médiatrice pendant l'heure où elle est présente. (2 pts)
4. Proposez un support à emporter adapté à ce public. (2 pts)
5. Dites comment vous organisez les binômes et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.29 – Exploiter une grille de « faire dire » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

À la fin d'un atelier « cuisiner les légumes secs » dans une association de quartier (fictive), l'animatrice a noté pour chacun des 12 participants s'il a réussi quatre « faire dire ». Vous l'aidez à analyser la grille.

Document 1 – Grille d'observation (1 = réussi, 0 = non réussi, données fictives)

Participant	Item 1 : rincer et cuire les lentilles	Item 2 : dire une recette à refaire	Item 3 : estimer le prix d'une portion	Item 4 : citer deux légumes secs
A	1	1	0	1
B	1	1	1	1
C	1	0	0	1
D	1	1	1	0
E	1	1	0	1
F	0	1	0	0
G	1	1	1	1
H	1	0	1	1
I	1	1	0	0
J	1	1	0	1
K	1	1	1	1
L	1	0	0	0

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre et le taux de réussite de chaque item. (3 pts)
2. Calculez le taux de réussite global sur l'ensemble des 48 « faire dire ». (1 pt)
3. Calculez le nombre d'items réussis par chaque participant et repérez ceux qui en réussissent deux ou moins. (2 pts)
4. Identifiez l'item le moins réussi, nommez la compétence en jeu et proposez deux ajustements pour la séance suivante. (3 pts)
5. Expliquez ce que l'animatrice peut faire pour les participants F et L, sans les mettre en difficulté devant le groupe. (2 pts)
6. Pourquoi cette grille ne doit-elle pas être montrée aux participants comme une note ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.30 – Un message vocal pour rappeler l'atelier (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – production · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social où vous êtes en stage envoie la veille de chaque atelier un message vocal sur WhatsApp aux participants. La référente familles vous demande d'écrire le texte du prochain message. Pour être bien compris, il ne doit pas durer plus de 45 secondes ; on retient dans cet exercice un débit lent de 120 mots par minute.

Document 1 – Informations à transmettre

Atelier « soupes d'hiver », mardi 12 janvier, de 14 h à 16 h, salle du rez-de-chaussée ; apporter un tablier et une boîte pour repartir avec de la soupe ; les enfants de moins de 3 ans peuvent venir ; c'est gratuit ; prévenir Samia au 06 00 00 00 00 (numéro fictif) en cas d'absence.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre maximal de mots du message. (1 pt)
2. Rédigez le message vocal en respectant cette limite. Indiquez le nombre de mots. (5 pts)
3. Citez trois règles de l'oral que vous avez appliquées. (2 pts)
4. Proposez une solution pour les participants qui n'ont pas WhatsApp. (1 pt)
5. Pourquoi est-il utile que le message soit enregistré par une personne connue des participants ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 5.25

1. Légendes : 1 Expliquer ; 2 un message à la fois, mots simples, support visuel ; 3 Faire dire ; 4 « Pour être sûre d'avoir été claire, que ferez-vous demain ? » ; 5 Vérifier ; 6 la reformulation est-elle complète et juste ? ; 7 Réexpliquer autrement ; 8 autre formulation, démonstration, image ; 9 Confirmer ; 10 valoriser, laisser un support.
2. Elle pose une question fermée (« Vous avez compris ? ») qui appelle un « oui » de politesse ; elle ne demande pas au participant de reformuler ou de montrer ; elle conclut sans rien vérifier ; son message est flou (« 20 minutes » de quoi ? pour quelles lentilles ?).
3. Exemple : Animatrice : « Les lentilles corail, on les rince, puis on les cuit 20 minutes dans deux fois leur volume d'eau. Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez les préparer chez vous ? » Participant : « Je les mets dans l'eau 20 minutes. » Animatrice : « Je vous montre encore une fois : d'abord, on les rince sous l'eau froide, comme ça. Ensuite, un verre de lentilles et deux verres d'eau. Vous me montrez ? » Participant : « Je rince, puis un verre de lentilles, deux verres d'eau, et 20 minutes. » Animatrice : « Exactement. Voilà la fiche en photos pour la maison. »

Corrigé – Exercice 5.26

1. Ce sont des questions fermées : la personne répond « oui » par politesse, par gêne ou pour ne pas paraître en difficulté. Elles ne demandent ni de reformuler ni d'agir, donc elles ne montrent pas ce qui a été compris.
2. Exemples : a) « Voici deux paquets de céréales. Montrez-moi celui que vous choisiriez pour le matin, et dites pourquoi. » b) « Avec ce verre doseur, montrez-moi la quantité de lait pour le bol de votre enfant. » c) « Votre voisine hésite entre ces deux biscuits : expliquez-lui comment le Nutri-Score l'aide à choisir. » d) « Posez à côté du jus le nombre de morceaux de sucre qu'il contient. » e) « Demain, au goûter, qu'est-ce que vous allez donner à boire ? » f) « Qu'est-ce que vous allez essayer cette semaine à la maison ? »

Corrigé – Exercice 5.27

1. Expliquer : « Quand il fait chaud, le corps perd de l'eau… 6 à 8 par jour. » Faire dire : « Pour être sûre d'avoir été claire, vous pouvez me dire comment vous allez faire demain ? » Vérifier : la réponse « Je bois quand j'ai soif » montre que le message n'est pas passé. Réexpliquer autrement : « Je vais le dire autrement. On va poser une bouteille ici… » Confirmer : nouvelle reformulation de Mme P., puis « C'est exactement ça » et remise de la feuille.
2. Répéter la même phrase n'aurait rien changé : c'est la manière d'expliquer qui ne convenait pas. La conseillère est passée d'un chiffre abstrait (6 à 8 verres) à un repère concret et visible (une bouteille sur la table), relié à des habitudes existantes (les repas, les médicaments) et à une vérification simple (la bouteille presque vide le soir).
3. Elle explique pourquoi il faut boire sans soif (la soif diminue avec l'âge) ; elle montre l'objet réel (le verre) ; elle laisse un support en dessin, sans texte long ; elle valorise la réponse.
4. Exemples : regarder avec Mme P. la bouteille du jour ; lui demander de raconter sa journée d'hier et quand elle a bu ; demander à l'aide à domicile si la bouteille est vide le soir.

Corrigé – Exercice 5.28

1. Message principal : « Avec 5 € par jour, on peut manger bien et à sa faim en cuisinant des produits simples. » Objectif : à la fin de l'atelier, chaque jeune sait préparer un plat complet pour moins de 1,50 € la portion.
2. Exemple de séquence : 10 min, accueil : prénoms, café, consignes de sécurité montrées en pictogrammes ; 10 min, recueil des pratiques : chacun montre sur son téléphone la photo d'un repas de la semaine ou

choisit une photo sur la table, sans rien écrire ; 15 min, message principal : comparaison de prix avec des objets réels (paquet de pâtes, boîte de pois chiches, plat préparé, sandwich acheté), prix par portion écrits en gros ; 10 min, démonstration d'une recette (pâtes aux pois chiches et à la tomate) montrée lentement ; 40 min, cuisine en binômes avec la recette en photos, une action par photo ; 15 min, repas partagé et dégustation avec une échelle à smileys ; 15 min, faire dire : chaque binôme montre une astuce et dit le prix de son assiette ; 5 min, clôture : remise du support, date suivante. Total : 10 + 10 + 15 + 10 + 40 + 15 + 15 + 5 = 120 minutes.

3. On la fait venir pendant la première heure : elle traduit l'accueil, les consignes de sécurité et le message principal ; elle reste avec le binôme qui en a le plus besoin pendant la démonstration et le début de la pratique. Les consignes importantes sont aussi données par gestes et en images.

4. Exemple : une courte vidéo sous-titrée de la recette, envoyée sur le téléphone, plus une carte recette en photos avec le prix de chaque ingrédient ; ces jeunes utilisent beaucoup leur smartphone, et la vidéo ne demande pas de lire.

5. On forme des binômes mixtes : un jeune qui lit facilement avec un jeune qui lit moins, ou un jeune qui parle peu le français avec un jeune de la même langue s'il y en a. L'entraide permet à chacun de réussir sans être désigné, et favorise les échanges.

Corrigé – Exercice 5.29

1. Item 1 : 11 / 12 = 91,7 % ; item 2 : 9 / 12 = 75,0 % ; item 3 : 5 / 12 = 41,7 % ; item 4 : 8 / 12 = 66,7 %.

2. (11 + 9 + 5 + 8) / 48 = 33 / 48 × 100 = 68,8 %.

3. Items réussis : A 3 ; B 4 ; C 2 ; D 3 ; E 3 ; F 1 ; G 4 ; H 3 ; I 2 ; J 3 ; K 4 ; L 1. Deux ou moins : C, F, I et L.

4. L'item 3, estimer le prix d'une portion (41,7 %), est le moins réussi : c'est une compétence de numératie. Ajustements : afficher le prix de chaque ingrédient par portion, déjà calculé, sur des étiquettes ; faire un exercice en binôme de comparaison de deux assiettes avec des pièces de monnaie réelles ; utiliser des chiffres ronds (« 20 centimes »).

5. Elle peut se placer à côté d'eux pendant la prochaine pratique, leur confier un rôle qu'ils maîtrisent, refaire la démonstration pour tout le groupe ou leur proposer de former un binôme avec un participant à l'aise. Elle ne cite jamais leurs résultats devant le groupe.

6. La grille sert à évaluer l'atelier et à ajuster l'animation, pas à juger les personnes. Une note mettrait certains participants en échec et pourrait les faire partir.

Corrigé – Exercice 5.30

1. 120 × 45 / 60 = 90 mots au plus.

2. Exemple (81 mots, en comptant chaque groupe de deux chiffres du numéro comme un mot) : « Bonjour, c'est Samia, du centre social. Demain, mardi 12 janvier, on fait des soupes d'hiver ensemble. C'est de 14 heures à 16 heures. C'est dans la salle du rez-de-chaussée. Apportez un tablier. Apportez aussi une boîte : vous repartirez avec de la soupe. Vos enfants de moins de 3 ans peuvent venir. C'est gratuit. Si vous ne pouvez pas venir, appelez-moi, Samia, au 06 00 00 00 00. Je répète : demain mardi, 14 heures, avec un tablier et une boîte. À demain ! »

3. Phrases courtes, une information par phrase ; mots courants ; répétition des informations clés à la fin (jour, heure, matériel) ; débit lent ; prénom de la personne qui parle.

4. Un appel téléphonique la veille ou un SMS court, et une carte papier remise à l'atelier précédent avec la date et un dessin.

5. Une voix connue inspire confiance, le message est écouté et l'on sait qui appeler. Cela renforce le lien entre le centre et les familles.

Partie 6 – Lire une étiquette et comprendre les chiffres : littératie alimentaire et numératie

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les six informations clés d'une étiquette (règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO »).
- Lire une liste d'ingrédients : ordre, allergènes, part de l'ingrédient mis en avant.
- Convertir des sucres en morceaux et les situer par rapport au repère de l'OMS.
- Passer des valeurs « pour 100 g » aux valeurs « par portion » et calculer un coût par portion.
- Présenter un risque en fréquences naturelles, avec la réduction absolue et la réduction relative.
- Traduire un repère chiffré en aliments et en mesures concrètes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Règlement INCO (2011) : dénomination, liste des ingrédients par ordre décroissant de poids, 14 allergènes mis en évidence, quantité nette, dates, conservation, déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 mL.
- DLC « à consommer jusqu'au » : ne pas dépasser. DDM « à consommer de préférence avant » : le produit reste consommable après, s'il est bien conservé.
- Nutri-Score : comparer des produits d'une même famille.
- Un morceau de sucre pèse environ 5 g. OMS : sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique ; 50 g pour 2 000 kcal ; 42,5 g pour 1 700 kcal (enfant de 8 ans environ).
- Fréquences naturelles (« 6 personnes sur 100 ») ; réduction absolue = différence des risques ; réduction relative = différence / risque de départ. Présenter toujours les deux.
- Fibres : 30 g par jour chez l'adulte (ANSES, 2016).

Exercice 5.31 – Légender une étiquette (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « lire une étiquette » pour des adhérents d'une association de locataires. Vous commencez par un schéma d'emballage à compléter ensemble.

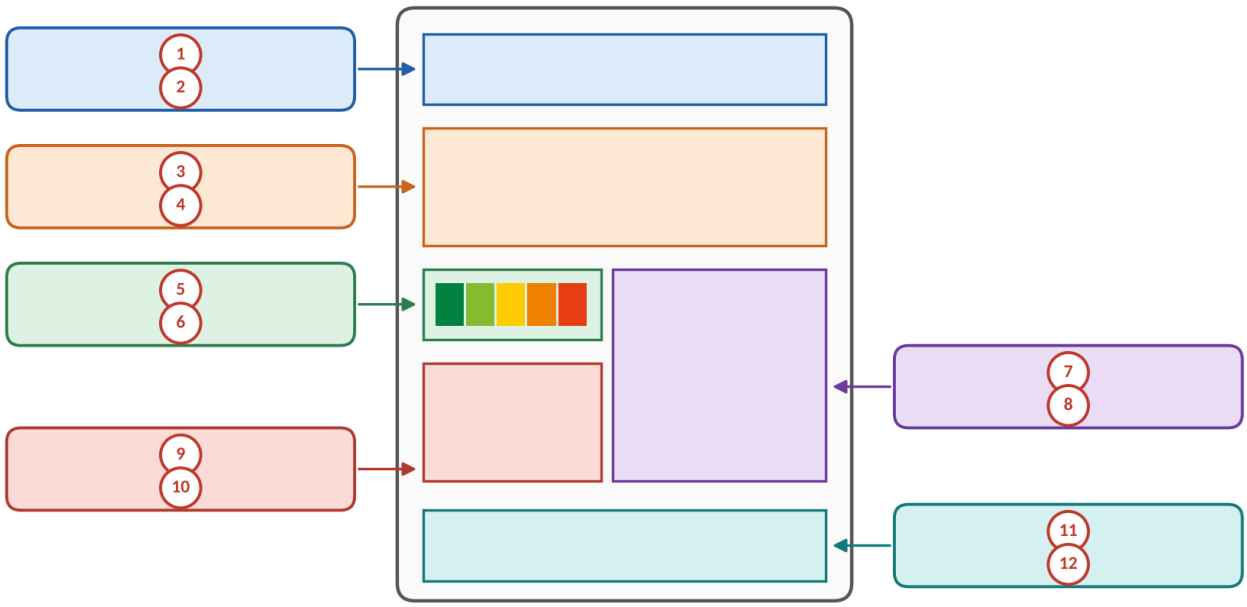


Figure 5.8 – Document 1 – Lire une étiquette (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Citez le texte européen qui rend la plupart de ces informations obligatoires et l'année de son adoption. (1 pt)
3. Lequel de ces éléments est facultatif sur l'emballage ? Lequel n'est pas sur l'emballage mais sur l'étiquette du rayon ? (1 pt)
4. Expliquez la différence entre DLC et DDM avec un exemple d'aliment pour chacune. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.32 – Lire trois listes d'ingrédients (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant l'atelier, une adhérente vous montre trois produits de son placard. Elle pensait que le premier contenait des fraises.

Document 1 – Les étiquettes (produits fictifs)

- Produit 1, « Yaourt aromatisé saveur fraise » : lait écrémé, sucre, crème, amidon modifié de maïs, arôme, colorant : carmins, ferments lactiques.
- Produit 2, « Yaourt aux fruits, fraise » : lait entier, préparation de fraise 15 % (fraise 10 %, sucre, eau, épaississant : pectines), sucre, ferments lactiques.
- Produit 3, « Céréales croustillantes au chocolat » : farine de blé, sucre, farine de riz, cacao maigre en poudre 6 %, huile de tournesol, sirop de glucose, sel, émulsifiant : lécithines de soja, arôme.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez, à partir de la dénomination et de la liste, pourquoi le produit 1 ne contient pas de fraise. (2 pts)

2. Calculez la quantité de fraise dans un pot de 125 g du produit 2. (1 pt)

3. Pour chaque produit, citez le premier ingrédient et ce qu'il indique. (1,5 pt)

4. Relevez les allergènes réglementaires des trois produits. Comment doivent-ils apparaître sur l'emballage ? (2 pts)

5. Dans le produit 3, relevez les ingrédients qui apportent des sucres et dites ce que vous concluez de leur place. (2 pts)

6. Rédigez en écriture claire le conseil que vous donnez à l'adhérente. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.33 – Les boissons en morceaux de sucre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier avec des parents d'élèves d'un collège, vous voulez poser à côté de chaque boisson le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. Vous utilisez les valeurs de la table Ciqual 2025.

Document 1 – Teneur en sucres (Ciqual 2025, pour 100 g, assimilés à 100 mL)

Boisson (code Ciqual)	Sucres (g pour 100 g)	Énergie (kcal pour 100 g)	Contenant présenté
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée (18026)	8,28	34,5	canette de 33 cL
Jus d'orange, pur jus (2070)	9,61	45,4	verre de 20 cL
Boisson au thé, aromatisée, sucrée (18075)	5,65	23,2	bouteille de 50 cL
Nectar multifruit, base pomme, standard (2009)	10	41,1	brique de 20 cL

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque contenant, la quantité de sucres (au dixième de gramme) et le nombre de morceaux de sucre de 5 g (au dixième). (4 pts)
2. Calculez, pour chaque contenant, la part du repère de l'OMS pour un adulte à 2 000 kcal (50 g) et pour un enfant à 1 700 kcal (42,5 g). (3 pts)
3. Un parent dit : « Le thé glacé, c'est léger, il y a moins de sucre que dans le soda. » Répondez-lui avec les chiffres. (2 pts)
4. Le pur jus d'orange ne contient pas de sucre ajouté. Expliquez pourquoi on le compte quand même. (1 pt)
5. Expliquez pourquoi on montre des morceaux de sucre plutôt que des grammes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.34 – Pour 100 g ou par portion ? Deux goûters comparés (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et interprétation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice d'accueil de loisirs hésite entre deux biscuits pour les goûters des 8-10 ans. Elle vous montre les étiquettes et les prix relevés au magasin.

Document 1 – Extraits des étiquettes (produits fictifs)

Pour 100 g	Biscuit A, galette à l'avoine	Biscuit B, biscuit fourré chocolat
Énergie	450 kcal	480 kcal
Sucres	18 g	35 g
Fibres	7 g	3 g
Sel	0,6 g	0,5 g
Portion indiquée	2 galettes = 25 g	1 sachet = 38 g
Prix au kilo	3,40 €	6,20 €
Nutri-Score	B	E

À vous de jouer – Questions

1. Calculez pour une portion de chaque biscuit : l'énergie, les sucres (et en morceaux), les fibres et le sel. (4 pts)
2. Calculez le coût d'une portion de chaque biscuit (au centime). (2 pts)
3. Le biscuit A a presque autant de calories pour 100 g que le biscuit B. Expliquez pourquoi la comparaison par portion change la conclusion, et la limite de cette comparaison. (2 pts)
4. Proposez à l'animatrice un goûter complet à partir du biscuit A. (2 pts)
5. Rédigez le message clé de l'atelier en une phrase « mieux et moins cher ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.35 – Présenter honnêtement un risque (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et argumentation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « démêler le vrai du faux » avec des étudiants en formation d'aide-soignant. Vous partez d'un tableau d'icônes, puis de trois slogans relevés dans des publicités et des articles.

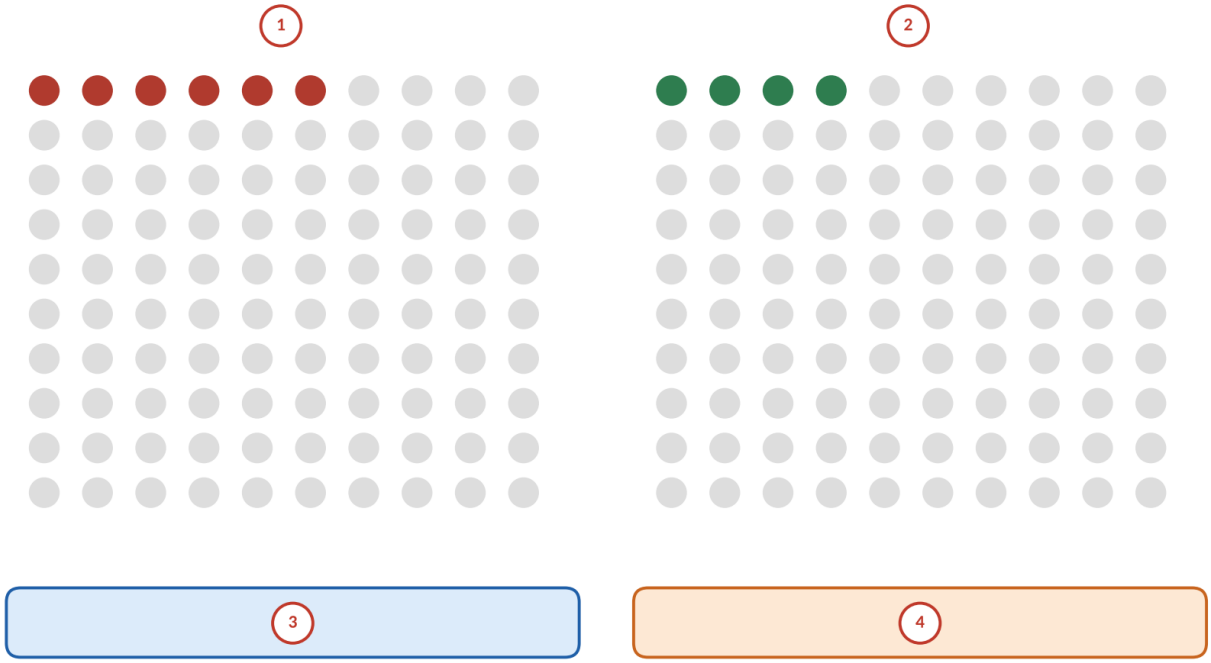


Figure 5.9 – Document 1 – Un risque présenté en fréquences naturelles (schéma à légender)

Document 2 – Trois slogans et les résultats des études citées (données fictives)

a) « Cette margarine réduit de 20 % le risque cardiaque ! » Étude : 10 personnes sur 1 000 ont un accident cardiaque sans la margarine, 8 sur 1 000 avec.

b) « Ce programme de marche réduit de 20 % le risque de chute ! » Étude : 15 personnes sur 100 chutent sans le programme, 12 sur 100 avec.

c) « Les ateliers cuisine réduisent d'un tiers le grignotage ! » Étude : 30 personnes sur 100 grignotent chaque jour sans atelier, 20 sur 100 avec.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Pour chaque slogan, calculez la réduction absolue et la réduction relative. (3 pts)
3. Les slogans a) et b) annoncent la même réduction relative. Expliquez pourquoi leur intérêt réel est très différent. (2 pts)
4. Réécrivez le slogan a) en fréquences naturelles, de façon honnête. (2 pts)
5. Décrivez le tableau d'icônes que vous dessineriez pour le slogan b). (1 pt)
6. Citez deux questions à poser sur l'étude avant de croire un slogan. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.36 – Traduire les repères chiffrés en assiettes (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un club de prévention santé (fictif) pour des adultes en surpoids, plusieurs participants disent : « 30 g de fibres par jour, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Vous voulez leur montrer une journée simple qui atteint ce repère, puis traduire les chiffres en mesures concrètes.

Document 1 – Une journée proposée (Ciqual 2025, fibres en g pour 100 g)

Aliment (code Ciqual)	Quantité	Fibres pour 100 g
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	60 g	7,3
Riz complet, cuit (9103)	150 g	2,1
Lentille verte, cuite à l'eau (20587)	150 g	8,45
Carotte, crue (20009)	100 g	2,9
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	1,4
Haricot vert, cuit à l'eau (20320)	150 g	3,2
Orange, crue (13034)	150 g	2,7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport en fibres de chaque aliment (au centième) et le total de la journée. (4 pts)
2. Calculez la part du repère de 30 g couverte par cette journée et l'aliment qui apporte le plus de fibres. (2 pts)
3. Traduisez chaque quantité du document 1 en une mesure concrète utilisable sans balance. (3 pts)
4. Réécrivez le repère « 30 g de fibres par jour » en trois conseils concrets, sans chiffre en grammes. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut augmenter les fibres progressivement et boire en même temps. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 5.31

1. Légendes : 1 Dénomination ; 2 ce qu'est vraiment le produit ; 3 Liste d'ingrédients ; 4 ordre décroissant ; 14 allergènes en gras ; 5 Nutri-Score ; 6 comparer dans une même famille ; 7 Tableau nutritionnel ; 8 pour 100 g et par portion ; 9 Dates ; 10 DLC « jusqu'au » ; DDM « de préférence avant » ; 11 Prix au kilo ; 12 en rayon, pour comparer.
2. Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO », adopté en 2011.
3. Le Nutri-Score est facultatif. Le prix au kilo est affiché sur l'étiquette du rayon.
4. DLC (« à consommer jusqu'au ») : produit très périssable, on ne le consomme pas après la date (viande hachée, yaourt, jambon). DDM (« à consommer de préférence avant ») : après la date, le produit peut perdre un peu de goût ou de qualité mais reste consommable s'il est bien conservé (pâtes, riz, biscuits, conserves).

Corrigé – Exercice 5.32

1. La dénomination dit « saveur fraise » : le goût vient de l'arôme et la couleur du colorant (carmins). Le mot « fraise » n'apparaît pas dans la liste des ingrédients.
2. 125 × 10 / 100 = 12,5 g de fraise par pot.
3. Produit 1 et produit 2 : le lait est le premier ingrédient, c'est bien un yaourt. Produit 3 : la farine de blé est le premier ingrédient ; le sucre arrive en deuxième position, ce qui montre qu'il y en a beaucoup.
4. Lait (produits 1 et 2 : lait, crème, ferments), céréales contenant du gluten (blé, produit 3) et soja (lécithines de soja, produit 3). Ils doivent être mis en évidence dans la liste, par exemple en gras ou soulignés.
5. Sucre (2e), sirop de glucose (6e) ; le cacao et la farine en apportent un peu. Le sucre est cité en deuxième position et il existe une deuxième source de sucres ajoutés : ce sont des céréales sucrées, à réserver à une consommation occasionnelle.
6. Exemple : « Lisez le nom du produit. "Saveur fraise" veut dire : pas de fraise. Prenez un yaourt nature et ajoutez des fraises ou une cuillère de confiture. »

Corrigé – Exercice 5.33

1. Soda : 8,28 × 330 / 100 = 27,3 g, soit 27,3 / 5 = 5,5 morceaux. Pur jus d'orange : 9,61 × 2 = 19,2 g, soit 3,8 morceaux. Thé glacé : 5,65 × 5 = 28,2 g, soit 5,7 morceaux. Nectar : 10 × 2 = 20,0 g, soit 4,0 morceaux.
2. Soda : 27,3 / 50 × 100 = 54,6 % (adulte), 27,3 / 42,5 × 100 = 64,3 % (enfant). Pur jus : 38,4 % et 45,2 %. Thé glacé : 56,5 % et 66,5 %. Nectar : 40,0 % et 47,1 %.
3. Pour 100 mL, le thé glacé contient en effet moins de sucres que le soda (5,65 g contre 8,28 g). Mais la bouteille de 50 cL en apporte 28,2 g, soit 5,7 morceaux, un peu plus que la canette de soda (5,5 morceaux). Ce qui compte, c'est ce que l'on boit réellement.
4. L'OMS compte parmi les sucres libres les sucres naturellement présents dans les jus de fruits. Le jus n'a pas les fibres du fruit et se boit vite ; on garde le repère d'un petit verre par jour au plus et l'on préfère le fruit entier.
5. Les grammes sont abstraits et difficiles à se représenter. Les morceaux de sucre sont des objets connus, visibles, que l'on peut poser à côté de la boisson : l'information est comprise sans calcul et marque les esprits. C'est une adaptation à la numératie du public.

Corrigé – Exercice 5.34

1. Biscuit A (25 g, soit 0,25 × les valeurs pour 100 g) : énergie 450 × 0,25 = 112,5 kcal ; sucres 18 × 0,25 = 4,5 g, soit 0,9 morceau ; fibres 1,75 g ; sel 0,15 g. Biscuit B (38 g, soit 0,38 ×) : énergie 480 × 0,38 = 182,4

kcal ; sucres 35 × 0,38 = 13,3 g, soit 2,7 morceaux ; fibres 1,14 g ; sel 0,19 g.

2. A : 25 / 1 000 × 3,40 = 0,085 €, soit 0,09 € (environ 9 centimes). B : 38 / 1 000 × 6,20 = 0,236 €, soit 0,24 €.

3. Pour 100 g, les deux biscuits sont proches en énergie. Mais la portion de B est plus grosse (38 g contre 25 g) : il apporte 70 kcal de plus et trois fois plus de sucres par portion. La limite : la portion indiquée par le fabricant n'est pas toujours celle que mangent les enfants ; il faut aussi regarder ce qui est réellement consommé.

4. Exemple : deux galettes à l'avoine, une pomme ou une clémentine, un verre de lait ou un yaourt nature, de l'eau à volonté.

5. Exemple : « La galette à l'avoine : moins de sucre, plus de fibres, et presque trois fois moins chère par goûter. »

Corrigé – Exercice 5.35

1. Légendes : 1 Sans action : 6 personnes sur 100 ; 2 Avec action : 4 personnes sur 100 ; 3 réduction absolue : 2 personnes sur 100 ; 4 réduction relative : (6 − 4) / 6 = 33 %.

2. a) Absolue : 10 − 8 = 2 personnes sur 1 000 ; relative : 2 / 10 × 100 = 20 %. b) Absolue : 15 − 12 = 3 personnes sur 100 ; relative : 3 / 15 × 100 = 20 %. c) Absolue : 30 − 20 = 10 personnes sur 100 ; relative : 10 / 30 = 33,3 %, soit un tiers.

3. Pour a), 2 personnes sur 1 000 sont protégées ; pour b), 3 personnes sur 100, soit 30 sur 1 000, quinze fois plus. La réduction relative est la même parce qu'elle ne tient pas compte du risque de départ, très faible en a). Annoncer seulement le relatif exagère l'effet perçu.

4. « Sur 1 000 personnes, 10 ont un accident cardiaque sans cette margarine et 8 avec : 2 personnes sur 1 000 évitent un accident. »

5. Deux grilles de 100 personnes : 15 icônes colorées dans la première, 12 dans la seconde ; les 3 icônes de différence sont entourées.

6. Qui a financé l'étude ? Combien de personnes ont été suivies et pendant combien de temps ? Les groupes étaient-ils comparables (tirage au sort) ? L'étude a-t-elle été publiée dans une revue scientifique ?

Corrigé – Exercice 5.36

1. Pain complet : 7,3 × 0,6 = 4,38 g ; riz complet : 2,1 × 1,5 = 3,15 g ; lentilles : 8,45 × 1,5 = 12,68 g ; carotte : 2,90 g ; pomme : 1,4 × 1,5 = 2,10 g ; haricots verts : 3,2 × 1,5 = 4,80 g ; orange : 2,7 × 1,5 = 4,05 g. Total : 34,05 g (calcul fait sur les valeurs non arrondies).

2. 34,05 / 30 × 100 = 113,5 % : le repère est dépassé. Les lentilles apportent le plus de fibres (12,68 g, plus d'un tiers du total).

3. Exemples : pain complet 60 g = deux tranches ou un quart de baguette ; riz complet cuit 150 g = environ un bol à moitié plein, ou 4 cuillères à soupe pleines ; lentilles cuites 150 g = environ trois quarts de bol ; carotte 100 g = une grosse carotte ; pomme 150 g = une pomme moyenne ; haricots verts 150 g = une grosse poignée cuite, le volume de deux poings ; orange 150 g = une orange moyenne. On vérifie ces repères en pesant une fois en atelier.

4. Exemples : « Prenez du pain complet ou des céréales complètes au petit-déjeuner. » « Mettez des légumes à chaque repas et des fruits au dessert. » « Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins deux fois par semaine. »

5. Une augmentation brutale des fibres peut donner des ballonnements et des douleurs du ventre, qui découragent. L'eau aide les fibres à jouer leur rôle sur le transit. On augmente donc peu à peu, sur deux ou trois semaines, en buvant régulièrement.

Partie 7 – Numérique, langues et handicaps : rendre l'information accessible

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir une adaptation selon la situation : langue, numérique, déficience visuelle, auditive ou intellectuelle, lecture difficile.
- Évaluer une application ou un site d'information alimentaire avec une grille de critères.
- Réaliser un mini-audit d'accessibilité et calculer un ratio de contraste.
- Choisir la bonne ressource pour communiquer avec une personne allophone.
- Construire un plan de communication qui n'exclut pas les personnes éloignées du numérique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Allophone : personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où elle vit.
- Interprétariat professionnel pour les échanges importants ou sensibles (référentiel de la HAS, 2017) ; médiateurs en santé pour le lien de confiance ; éviter les enfants interprètes et les traducteurs automatiques non relus.
- Accessibilité numérique : RGAA, fondé sur les normes internationales WCAG ; contraste suffisant, texte alternatif des images, vidéos sous-titrées, liens explicites, navigation simple.
- Ratio de contraste = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), L1 étant la luminance relative de la couleur la plus claire ; seuil de 4,5 pour un texte courant et de 3 pour un grand texte (WCAG, niveau AA).
- Ne jamais réserver une inscription ou une information au seul numérique (illectronisme : 7 % des 16-74 ans en 2025, Insee).

Exercice 5.37 – Une adaptation pour chaque situation (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 12 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des solidarités (fictive) accueille un public très varié. L'équipe vous demande une affiche interne qui résume les adaptations possibles.

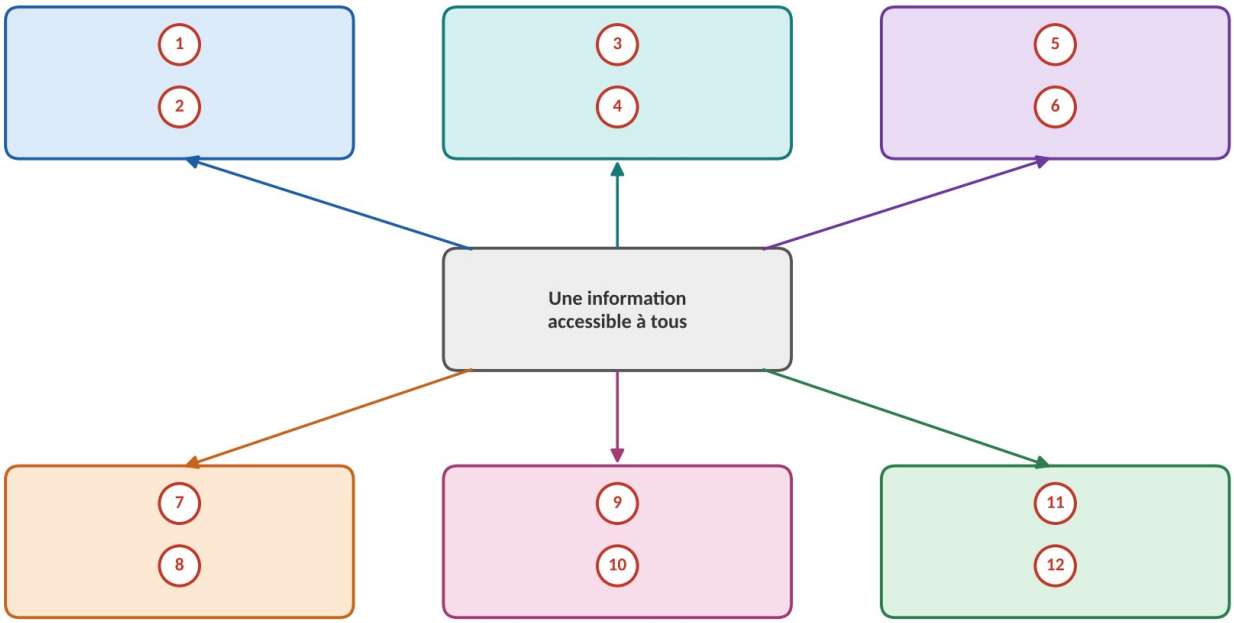


Figure 5.10 – Document 1 – Adapter selon la situation (schéma à légender)

Document 2 – Six personnes accueillies cette semaine

a) M. V., aveugle depuis l'enfance, utilise un lecteur d'écran.

b) Mme O., 38 ans, arrivée d'Ukraine, parle russe et ukrainien.

c) M. S., 24 ans, travailleur d'ESAT, vit en foyer.

d) Mme J., 67 ans, malentendante, lit très bien.

e) M. N., 52 ans, n'a pas d'ordinateur et ne sait pas envoyer un document par courriel.

f) Mme E., 45 ans, a quitté l'école à 14 ans et lit difficilement.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Pour chaque personne du document 2, proposez l'adaptation la plus utile pour l'inviter à un atelier cuisine. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi une affiche avec un gros titre, des pictogrammes et une version audio profite à presque tout le monde. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.38 – Évaluer une application de scan (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Des participants d'un atelier vous demandent s'ils peuvent faire confiance à une application de scan des produits très populaire dans leur entourage. Vous l'analysez avec la grille du cours.

Document 1 – Ce que vous avez relevé sur l'application « ScanFood+ » (application fictive)

- Éditeur : une jeune entreprise ; l'application est gratuite, financée par des publicités pour des compléments alimentaires.
- Notes : une note sur 100 calculée par « notre algorithme exclusif », sans explication publique ; le Nutri-Score officiel n'est pas affiché.
- Mise à jour : la base de produits a été mise à jour il y a trois ans.
- Données : demande l'accès à la localisation et aux contacts ; la politique de confidentialité indique un partage avec des « partenaires commerciaux ».
- Accessibilité : textes en petits caractères gris clair, disponible seulement en français.
- Usage : affiche un message rouge « À ÉVITER ! » sur le pain, les bananes et le fromage ; propose de « compter chaque calorie ».

À vous de jouer – Questions

1. Notez l'application sur chacun des six critères de la grille du cours (éditeur et financement, fondement scientifique, mise à jour, protection des données, accessibilité, effets indésirables) avec 0 (insuffisant), 1 (moyen) ou 2 (satisfaisant), en justifiant. Calculez la note sur 12. (6 pts)

2. Rédigez trois conseils simples pour les participants qui utilisent une application de scan. (3 pts)

3. Citez un site public fiable sur l'alimentation à leur présenter. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.39 – Rendre accessible la page d'inscription (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (fictif) a créé une page internet pour présenter ses ateliers « cuisine et santé » et s'inscrire. Vous faites un mini-audit avec 15 critères simples, puis vous vérifiez les couleurs.

Document 1 – Résultat du mini-audit

Critères respectés (6) : langue de la page déclarée ; titres structurés ; police agrandissable ; adresse postale affichée ; pas de limite de temps pour remplir le formulaire ; version imprimable du programme.

Critères non respectés (9) : contraste du texte ; texte alternatif des 5 photos ; sous-titres de la vidéo de présentation ; liens explicites (« cliquez ici ») ; numéro de téléphone visible ; information donnée seulement par la couleur (« les ateliers en vert sont complets ») ; formulaire avec 14 champs obligatoires ; version en FALC ; possibilité de s'inscrire autrement qu'en ligne.

Document 2 – Couleurs de la page et luminances relatives (calculées selon les WCAG)

Élément	Texte	Fond	Luminance du texte	Luminance du fond
Texte courant	gris clair (#999999)	blanc (#FFFFFF)	0,3185	1,0000
Bouton « S'inscrire »	blanc (#FFFFFF)	orange (#F28C28)	1,0000	0,3779
Titre	bleu foncé (#1F3A93)	blanc (#FFFFFF)	0,0542	1,0000
Proposition pour le bouton	gris très foncé (#333333)	orange (#F28C28)	0,0331	0,3779

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de critères respectés. (1 pt)
2. Choisissez six corrections rapides et peu coûteuses, puis calculez le nouveau pourcentage. (3 pts)
3. Calculez le ratio de contraste de chaque ligne du document 2 (au centième) et dites s'il respecte le seuil de 4,5. (4 pts)
4. Proposez une correction pour le texte courant et justifiez le choix de la proposition pour le bouton. (2 pts)
5. Réécrivez le lien « cliquez ici » et l'information « les ateliers en vert sont complets ». (2 pts)
6. Expliquez pourquoi le critère « s'inscrire autrement qu'en ligne » est le plus important pour ce public. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.40 – Communiquer avec des parents allophones (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une crèche collective (fictive) d'un quartier prioritaire accueille 40 enfants ; 14 familles parlent peu le français. La directrice veut organiser une réunion sur la diversification alimentaire et sur les allergies. Elle propose plusieurs solutions.

Document 1 – Les solutions envisagées par la directrice

a) Demander aux grands frères et sœurs de traduire pour leurs parents.

b) Traduire le document de la crèche avec un traducteur automatique en ligne et l'imprimer tel quel.

c) Faire appel à un service d'interprétariat professionnel par téléphone pour les entretiens individuels sur les allergies.

d) Inviter une médiatrice en santé du quartier qui connaît bien les familles.

e) Montrer les aliments réels et les textures (purée lisse, écrasée, morceaux) pendant la réunion.

f) Proposer un atelier avec l'association d'apprentissage du français du quartier, autour de la préparation de purées.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque solution, dites si vous la retenez ou non et justifiez. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi l'entretien sur les allergies demande un interprète professionnel et pas une médiatrice. (2 pts)
3. Proposez un moyen de vérifier, à la fin de la réunion, que les parents ont compris l'âge de début de la diversification. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.41 – Un atelier cuisine avec des personnes sourdes et malentendantes (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (fictive) de personnes sourdes et malentendantes vous demande quatre ateliers de 2 h 30 sur les repas rapides et équilibrés. Le groupe compte 12 personnes : 7 personnes sourdes qui communiquent en langue des signes française (LSF), 5 personnes malentendantes appareillées qui lisent sur les lèvres.

Document 1 – Informations pratiques

- La pratique courante est de faire appel à deux interprètes en LSF qui se relaient pour une intervention de plus d'une heure.
- Tarif retenu pour l'exercice (tarif fictif) : 65 € de l'heure par interprète.
- Budget de l'association pour les quatre ateliers : 1 500 €, dont 200 € de courses.
- La cuisine est bruyante (hotte, robot) et éclairée par une seule fenêtre derrière le plan de travail de l'animatrice.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de l'interprétariat pour un atelier, puis pour les quatre. Le budget est-il suffisant ? (3 pts)
2. Proposez quatre adaptations de l'animation pour les personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres. (4 pts)
3. Proposez deux adaptations des supports de l'atelier. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut construire l'atelier avec l'association plutôt que seul. (2 pts)
5. Proposez un outil d'évaluation accessible pour la fin de l'atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.42 – Le club des seniors et le numérique (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de retraités (fictif) de 120 adhérents veut lancer un programme « Bien manger après 70 ans ». La mairie propose de tout faire par une application municipale : programme, inscriptions, recettes en vidéo. Avant de décider, le club a interrogé 80 adhérents présents au repas mensuel.

Document 1 – Résultats (n = 80, données fictives)

Usage	Effectif
A un smartphone	46
Utilise internet au moins une fois par semaine	39
A une adresse mail qu'il consulte	31
Utilise WhatsApp	28
N'a jamais utilisé internet	22
Souhaite recevoir le programme sur papier	61

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque ligne du document 1. (3 pts)
2. Comparez la part d'adhérents qui n'ont jamais utilisé internet à la donnée nationale sur l'illectronisme. Expliquez l'écart et la prudence nécessaire. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'échantillon de 80 adhérents présents au repas peut sous-estimer les difficultés du club. (2 pts)
4. Proposez un plan de communication et d'inscription en quatre canaux pour le programme. (4 pts)
5. Proposez une action pour développer la littératie numérique des adhérents qui le souhaitent, avec un partenaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 5.37

1. Légendes : 1 Personne allophone ; 2 interprète professionnel, médiateur, supports traduits et testés ; 3 Difficultés numériques ; 4 version papier, téléphone, accompagnement (France Services) ; 5 Déficience intellectuelle ; 6 FALC relu par des personnes concernées, SantéBD ; 7 Déficience visuelle ; 8 contraste ≥ 4,5, gros caractères, audio, braille, lecteur d'écran ; 9 Lecture difficile ; 10 oral, pictogrammes, objets, démonstration, faire dire ; 11 Déficience auditive ; 12 sous-titres, langue des signes, écrit simple, visuel.
2. a) Invitation numérique lisible par un lecteur d'écran (texte réel, images décrites) ou appel téléphonique ; pendant l'atelier, description orale des gestes et repères tactiles. b) Interprète ou médiatrice parlant russe ou ukrainien, invitation traduite par un professionnel. c) Invitation en FALC avec photos, remise et expliquée par l'éducateur du foyer. d) Invitation écrite, sous-titres si une vidéo est utilisée, boucle magnétique si la salle en a une. e) Invitation papier et appel téléphonique, inscription au guichet. f) Invitation orale et carte avec pictogrammes, rappel par message vocal.
3. Ces adaptations aident les personnes qui en ont besoin, mais aussi les personnes pressées, fatiguées, âgées ou qui lisent dans une autre langue : c'est le principe des précautions universelles.

Corrigé – Exercice 5.38

1. Éditeur et financement : 0, financement par la publicité pour des compléments alimentaires, risque de conflit d'intérêts. Fondement scientifique : 0, algorithme non public, Nutri-Score officiel absent. Mise à jour : 0, base vieille de trois ans, beaucoup de recettes et de Nutri-Score ont changé depuis. Protection des données : 0, accès aux contacts sans raison et partage commercial. Accessibilité : 0, texte peu lisible et une seule langue (on peut accepter 1 si l'interface est simple). Effets indésirables : 0, messages alarmistes sur des aliments courants et incitation au comptage des calories, risque de culpabilisation et de restriction. Note : 0 sur 12 (au plus 1 sur 12 si l'on accorde 1 point à l'accessibilité).
2. Exemples : « Regardez qui a fait l'application et qui la paie. » « Une note sur un produit ne dit pas si votre repas est bon : un fromage ou du pain ne sont pas "à éviter". » « Refusez l'accès à vos contacts et à votre localisation. »
3. mangerbouger.fr, le site du Programme national nutrition santé géré par Santé publique France.

Corrigé – Exercice 5.39

1. 6 / 15 × 100 = 40,0 %.
2. Exemples de corrections rapides : augmenter le contraste du texte ; ajouter un texte alternatif aux 5 photos ; sous-titrer la vidéo ; rendre les liens explicites ; afficher le numéro de téléphone ; ajouter un mot ou un symbole en plus de la couleur pour les ateliers complets. Nouveau score : (6 + 6) / 15 × 100 = 80,0 %.
3. Texte courant : (1,0000 + 0,05) / (0,3185 + 0,05) = 1,05 / 0,3685 = 2,85 : non conforme. Bouton actuel : 1,05 / (0,3779 + 0,05) = 1,05 / 0,4279 = 2,45 : non conforme. Titre : 1,05 / (0,0542 + 0,05) = 1,05 / 0,1042 = 10,08 : conforme. Proposition pour le bouton : (0,3779 + 0,05) / (0,0331 + 0,05) = 0,4279 / 0,0831 = 5,15 : conforme.
4. Écrire le texte courant en gris très foncé ou en noir sur fond blanc (par exemple #333333, dont le ratio avec le blanc dépasse 12). Pour le bouton, le texte gris très foncé sur orange atteint 5,15 et respecte le seuil, tout en gardant la couleur repère des boutons de la page.
5. « Télécharger le programme des ateliers (PDF, 2 pages) » ; « Atelier complet » écrit à côté de chaque atelier concerné, avec un pictogramme, et pas seulement en vert.
6. Le public des ateliers du CCAS compte beaucoup de personnes âgées ou en difficulté, plus souvent concernées par l'illectronisme. Si l'inscription est seulement en ligne, ces personnes renoncent : les plus éloignées de la prévention restent exclues. Il faut garder une inscription par téléphone et à l'accueil.

Corrigé – Exercice 5.40

1. a) Non : faire traduire des enfants inverse les rôles familiaux, les expose à des informations qui ne les concernent pas et produit des erreurs. b) Non sans relecture : un traducteur automatique non relu peut produire des erreurs graves sur la santé ; le texte doit être traduit par un professionnel ou relu par un locuteur, puis testé. c) Oui : l'interprète professionnel garantit l'exactitude, la neutralité et la confidentialité. d) Oui : la médiatrice crée la confiance, fait venir les familles et explique les codes de la crèche ; elle complète l'interprète. e) Oui : les objets et les textures se comprennent sans langue commune. f) Oui : l'atelier aide à apprendre le français à partir d'un sujet concret qui intéresse les parents.
2. Une allergie peut mettre la vie de l'enfant en danger : il faut une traduction exacte, complète et neutre. L'interprète professionnel est formé à cela et tenu au secret ; la médiatrice n'est pas interprète et connaît peut-être la famille, ce qui peut gêner la confidentialité.
3. Exemple : montrer une frise avec des photos d'enfants de différents âges et demander à chaque parent, avec l'aide de l'interprète, de poser le premier petit pot à l'âge où il commencera. On réexplique si besoin. Rappel : la diversification commence entre 4 et 6 mois selon les repères de Santé publique France (2021).

Corrigé – Exercice 5.41

1. Un atelier : 2 interprètes × 2,5 h × 65 € = 325 €. Quatre ateliers : 4 × 325 = 1 300 €. Il reste 1 500 − 1 300 = 200 €, exactement le budget des courses : le budget est suffisant mais sans marge.
2. L'animatrice se place face au groupe, le visage éclairé (pas devant la fenêtre) ; elle parle sans exagérer l'articulation et sans se cacher la bouche ; elle arrête la hotte et le robot pendant les explications ; une personne parle à la fois ; elle montre le geste avant de l'expliquer ; elle écrit les mots clés au tableau.
3. Fiche recette en photos, avec très peu de texte ; vidéo de la recette sous-titrée ; mots clés écrits en gros ; minuteur visuel pour les temps de cuisson.
4. Les personnes concernées connaissent leurs besoins et leurs façons de communiquer ; l'association connaît les interprètes et les codes du groupe. Construire avec elles évite les erreurs, renforce la participation et le pouvoir d'agir, et permet de valider les supports.
5. Exemple : une échelle à smileys ou un vote avec des gommettes de couleur sur des photos des plats, avec une question posée en LSF par l'interprète.

Corrigé – Exercice 5.42

1. Smartphone : 46 / 80 = 57,5 % ; internet chaque semaine : 39 / 80 = 48,8 % ; adresse mail consultée : 31 / 80 = 38,8 % ; WhatsApp : 28 / 80 = 35,0 % ; jamais internet : 22 / 80 = 27,5 % ; programme papier souhaité : 61 / 80 = 76,3 %.
2. 27,5 % des adhérents n'ont jamais utilisé internet, contre 7 % des 16-74 ans en situation d'illectronisme en 2025 (Insee, 2026). L'écart s'explique par l'âge : l'illectronisme est beaucoup plus fréquent chez les plus âgés, et l'enquête nationale s'arrête à 74 ans. La comparaison doit rester prudente : les deux indicateurs ne sont pas définis de la même façon (« jamais utilisé » contre « pas d'usage d'internet ou aucune compétence numérique ») et le club n'est pas représentatif.
3. Les adhérents qui viennent au repas mensuel sont les plus mobiles et les plus en forme. Les 40 adhérents absents sont peut-être plus âgés, plus isolés ou malades, et sans doute encore plus éloignés du numérique.
4. Exemple : programme papier distribué au repas mensuel et envoyé par courrier aux absents ; inscription par téléphone auprès d'une bénévole et sur papier au club ; rappel par appel téléphonique ou message vocal la veille ; application municipale gardée en complément pour ceux qui l'utilisent, avec les vidéos de recettes sous-titrées.
5. Exemple : des ateliers « mon téléphone pas à pas » avec un conseiller numérique de France Services ou de

> la médiathèque, en petits groupes, pour apprendre à regarder une vidéo de recette et à s'inscrire en ligne. L'inscription papier reste possible pour ceux qui ne le souhaitent pas.

Partie 8 – Outils pédagogiques, littératie dans le projet et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Intégrer la littératie à chaque étape du projet : diagnostic, objectifs, supports, animation, communication, évaluation.
- Analyser un outil pédagogique avec les huit questions du cours.
- Concevoir un outil de numératie (cartes-prix) et calculer des coûts par portion.
- Exploiter une évaluation sans écrit (smileys) et un budget de communication.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diagnostic : recueillir la langue, la lecture et le numérique ; questionnaire oral ou imagé.
- Objectifs : inclure des objectifs de compétences (« savoir lire le Nutri-Score », « savoir cuisiner les lentilles »).
- Supports : écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant diffusion.
- Animation : méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire.
- Communication : plusieurs canaux ; ne pas tout miser sur le numérique.
- Évaluation : outils sans écrit (smileys, gommettes, entretien) et indicateurs de compréhension.
- Huit questions avant d'utiliser un outil pédagogique : qui l'a conçu, contenu à jour, objectifs, public, participation, non-stigmatisation, accessibilité, adaptations.

Exercice 5.43 – La littératie à chaque étape du projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez avec une collègue un projet « Cuisiner de saison avec un petit budget » pour les habitants d'une résidence de logements sociaux (fictive). Vous voulez vérifier que la littératie est prise en compte à chaque étape.

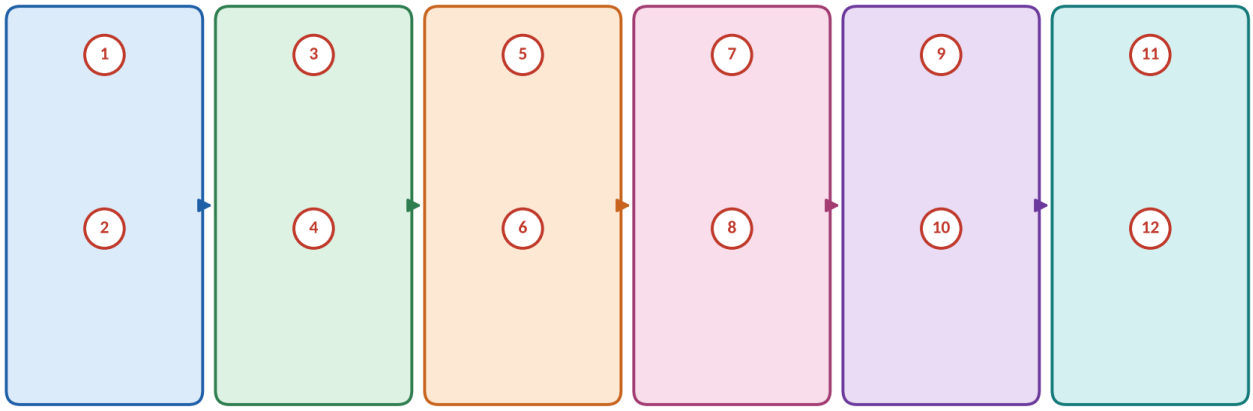


Figure 5.11 – Document 1 – La littératie à chaque étape du projet (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Pour ce projet, proposez une action concrète pour chacune des six étapes. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi il ne suffit pas de « simplifier les supports » à la fin du projet. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.44 – Analyser un kit pédagogique offert par une marque (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire a reçu gratuitement un kit pédagogique « Le goûter malin » (outil fictif), édité par une marque de biscuits. L'enseignante vous demande s'il peut servir pour un projet sur le goûter avec des familles dont beaucoup lisent peu le français.

Document 1 – Description du kit

- Un livret de 24 pages pour l'enseignant, très illustré, publié en 2016, qui cite les repères du PNNS de 2001.
- 30 cartes « aliments » avec photo ; 8 cartes montrent des biscuits de la marque, avec leur logo.
- Un jeu « le bon goûter » où les enfants reçoivent des points s'ils choisissent « le goûter équilibré », toujours composé d'un biscuit de la marque, d'un produit laitier et d'un fruit.
- Une affiche « Les aliments interdits » avec des bonbons, des chips et des sodas barrés en rouge, et le dessin d'un enfant en surpoids triste.
- Un dépliant pour les parents de 4 pages, en français seulement, en petits caractères.

À vous de jouer – Questions

1. Analysez le kit en répondant aux huit questions du cours. (6 pts)

2. Donnez votre conclusion : utiliser, adapter ou refuser le kit. Justifiez. (2 pts)

3. Citez une ressource pour trouver un outil pédagogique validé et indépendant. (1 pt)

4. Proposez une adaptation pour les familles qui lisent peu le français. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.45 – Créer des cartes-prix pour un jeu de numératie (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et production · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous concevez un jeu « Le dîner à 5 € pour 4 personnes » pour un atelier en centre social. Chaque carte montre la photo de l'aliment, la portion pour une personne et son prix. Vous avez relevé des prix dans un supermarché du quartier (relevé fictif).

Document 1 – Prix relevés et portions retenues

Aliment	Prix	Portion par personne
Lentilles vertes sèches	2,60 € le kg	60 g secs
Riz	1,80 € le kg	60 g crus
Carottes	1,40 € le kg	120 g
Pommes	2,20 € le kg	150 g
Pain complet	4,20 € le kg	50 g
Cuisses de poulet	6,50 € le kg	150 g
Fromage blanc	2,40 € le kg	100 g
Huile de colza	3,20 € le litre	10 mL
Œufs	3,30 € les 12	1 œuf
Yaourts nature	1,90 € les 8	1 yaourt

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix d'une portion de chaque aliment (au millième d'euro), puis arrondissez au centime pour l'écrire sur la carte. (4 pts)
2. Calculez le coût pour 4 personnes de ces trois dîners : A) lentilles, riz, carottes à l'huile, yaourt, pomme ; B) omelette de 2 œufs par personne, pain complet, carottes à l'huile, fromage blanc, pomme ; C) poulet, riz, carottes à l'huile, yaourt, pomme. Lesquels respectent les 5 € ? (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on écrit sur les cartes le prix par portion et non le prix au kilo. (2 pts)
4. Proposez une règle du jeu qui fait discuter les participants sans les mettre en échec. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.46 – Évaluer avec des smileys (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), trois ateliers cuisine ont réuni au total 38 participations. À la fin de chaque atelier, les participants ont collé une gommette sur un smiley pour trois affirmations lues à voix haute et illustrées par une image.

Document 1 – Résultats cumulés des trois ateliers (38 participations, données fictives)

Affirmation	Smiley content	Smiley moyen	Smiley pas content
« J'ai aimé l'atelier »	31	6	1
« J'ai compris la recette »	24	11	3
« Je vais refaire la recette à la maison »	19	13	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque case du document 1. (3 pts)
2. Décrivez l'évolution des résultats d'une affirmation à l'autre et proposez une explication. (2 pts)
3. Proposez deux ajustements des ateliers à partir de ces résultats. (2 pts)
4. Citez deux limites de cet outil. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs complémentaires, dont un indicateur de compréhension, et l'outil pour les recueillir sans écrit. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.47 – Un budget de communication accessible (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la communication d'un cycle d'ateliers « familles et cuisine » dans un quartier où vivent environ 1 200 familles, dont beaucoup parlent une autre langue que le français. Le budget de communication est de 300 €. Vous avez obtenu des devis (données fictives).

Document 1 – Actions prévues et coûts

Action	Quantité	Coût unitaire
Affiches A3 avec photos et pictogrammes	20	0,90 €
Cartes d'invitation illustrées à remettre en main propre	300	0,08 €
Kakémono pour le marché et l'école	1	65,00 €
Collation pour 3 réunions avec des habitants relais	3	18,00 €
Traduction orale d'une vidéo courte en deux langues par une professionnelle	1	120,00 €

Document 2 – Résultats attendus

Environ 180 personnes devraient recevoir l'information directement (relais, cartes, marché) ; on vise 42 participants sur le cycle.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque action et le coût total. Le budget est-il respecté ? (3 pts)
2. Calculez le coût par personne informée et par participant visé. (2 pts)
3. Justifiez chaque action du point de vue de la littératie. (3 pts)
4. Proposez deux canaux gratuits supplémentaires. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour savoir quels canaux ont fait venir les participants, et la façon de le recueillir sans écrit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.48 – Cas complet : cuisiner le colis au centre d'hébergement (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans une association qui gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), « Le Relais des Lilas » (données fictives). Il héberge 24 familles, soit 24 adultes référents et 41 enfants de 0 à 10 ans, dans des appartements avec une cuisine partagée par étage. Chaque semaine, les familles reçoivent un colis d'une banque alimentaire. Les travailleurs sociaux constatent que les boîtes de haricots rouges du colis sont souvent données ou jetées. L'association vous confie un projet d'ateliers « Cuisiner le colis ».

Document 1 – Diagnostic mené en entretien oral auprès des 24 adultes référents (données fictives)

Réponse	Nombre d'adultes
Lit difficilement le français	14
Parle une autre langue à la maison	17
Utilise WhatsApp	19
N'a pas de smartphone	5
Cuisine un repas « fait maison » 3 fois par semaine ou moins	15
Dispose de moins de 4 € par jour et par personne pour l'alimentation	16

Document 2 – Paroles recueillies

- « Les boîtes de haricots rouges, je ne sais pas quoi en faire. Je les donne à la voisine. »
- « Le papier de l'atelier de l'an dernier, je ne l'ai pas lu. Trop de mots. »
- « C'est mon fils qui lit les papiers pour moi. »
- « Chez moi, on fait du riz avec une sauce tomate. Mes enfants adorent. »
- « Sur internet, ils disent que les conserves, c'est du poison. »

Document 3 – L'invitation de l'an dernier

« Dans le cadre du programme d'accompagnement à l'autonomie alimentaire, l'association propose aux personnes hébergées un cycle d'ateliers culinaires visant à favoriser l'utilisation optimale des denrées distribuées par la banque alimentaire… » Comptage du texte entier : 142 mots, 5 phrases, 255 syllabes. Nouvelle version préparée avec deux mères hébergées : 70 mots, 10 phrases, 102 syllabes.

Document 4 – Recette « chili sans viande » pour 8 portions : quantités par portion et données (Ciqual 2025 pour 100 g ; prix relevés, fictifs)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine C (mg)	Prix
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	120 g	108	8,31	7	0,68	0,2	colis (valeur : 3,56 € le kg)
Riz blanc, cru (9100)	60 g	350	7,02	1,53	0,0079	0	colis (valeur : 1,80 € le kg)
Tomate, purée, appertisée (20170)	80 g	47,6	1,5	1,6	0,42	9	colis (valeur : 1,60 € le kg)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Vitamine C (mg)	Prix
Oignon, cru (20034)	30 g	39	1,1	1,7	0,098	3,9	1,80 € le kg, 10 % de pertes
Poivron rouge, cru (20087)	50 g	33,6	1,06	3,2	< 0,013	121	4,50 € le kg, 20 % de pertes
Huile de colza (17130)	5 g	900	0	0	< 0,0028	0	3,20 € le kg
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	54	0,25	1,4	0,0037	4,6	2,20 € le kg
Cumin, ail, épices							forfait 0,30 € pour 8

Les valeurs « < » sont comptées 0. Les quantités du tableau sont des quantités nettes.

Document 5 – Premier atelier : présence et « faire dire » (données fictives)

24 adultes invités, 9 présents. À la fin, l'animatrice note les réussites : expliquer comment rincer et utiliser les haricots rouges, 7 sur 9 ; dire le prix d'une portion à 20 centimes près, 4 sur 9 ; citer un plat à refaire avec les haricots, 8 sur 9.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque réponse du document 1 et le taux de présence au premier atelier (document 5). (4 pts)
2. Analysez les besoins de littératie de ces familles avec trois notions du chapitre : les dimensions de Sørensen, les niveaux de Nutbeam et les domaines de la littératie alimentaire. Appuyez-vous sur des éléments précis des documents. (6 pts)
3. Calculez l'indice de lisibilité des deux versions de l'invitation (document 3) et rédigez la nouvelle invitation en écriture claire, avec les images prévues. (5 pts)
4. À partir du document 4, calculez pour une portion l'énergie, les protéines, les fibres, le sel et la vitamine C, puis la part de l'énergie apportée par les protéines. Calculez le coût de la recette pour 8 portions et par portion, en valeur totale puis pour la seule partie achetée par les familles. Commentez. (7 pts)
5. Construisez le déroulé d'un atelier de 2 heures sur cette recette, avec pour chaque étape l'adaptation de littératie et le moment du « faire dire ». (6 pts)
6. Exploitez les résultats du « faire dire » du document 5 et proposez deux ajustements. (4 pts)
7. Proposez un plan de communication en trois canaux pour augmenter la présence au deuxième atelier. Justifiez avec les chiffres. (3 pts)
8. Proposez deux indicateurs d'évaluation accessibles et deux règles éthiques à respecter dans ce projet. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 5.43

1. Légendes : 1 Diagnostic ; 2 recueillir langue, lecture, numérique ; questionnaire oral ou imagé ; 3 Objectifs ; 4 inclure des compétences : lire le Nutri-Score, cuisiner les lentilles ; 5 Supports ; 6 écriture claire, FALC, pictogrammes, test avant diffusion ; 7 Animation ; 8 méthodes actives, démonstration, binômes, faire dire ; 9 Communication ; 10 plusieurs canaux : oral, affiches, relais, numérique accompagné ; 11 Évaluation ; 12 outils sans écrit : smileys, gommettes, entretien, indicateurs de compréhension.
2. Exemples : diagnostic : entretiens en porte-à-porte avec la gardienne, questions sur la langue et la façon de recevoir les informations ; objectifs : « savoir choisir trois légumes de saison au marché et préparer une soupe pour moins de 1 € la portion » ; supports : calendrier des légumes de saison en photos, testé par trois habitants ; animation : démonstration puis cuisine en binômes, faire dire en fin de séance ; communication : affiche dans le hall, invitation remise par la gardienne, message vocal ; évaluation : smileys et question orale « Qu'allez-vous refaire ? ».
3. La littératie se prend en compte dès le diagnostic : si l'on ne sait pas quelles langues et quels supports conviennent, on choisit de mauvais objectifs, de mauvais canaux et de mauvaises méthodes. Simplifier un support à la fin ne rattrape pas ces choix.

Corrigé – Exercice 5.44

1. Qui l'a conçu : une marque de biscuits, qui a un intérêt commercial. Contenu : publié en 2016 avec les repères de 2001, il n'est pas à jour (repères du PNNS révisés en 2019). Objectifs : il cherche à faire choisir un biscuit de la marque, pas à développer l'autonomie des enfants. Public : les enfants, mais le dépliant parents n'est pas adapté à des familles qui lisent peu le français. Participation : le jeu fait participer, mais avec une seule bonne réponse imposée. Non-stigmatisation : l'affiche « aliments interdits » culpabilise et le dessin d'un enfant en surpoids triste stigmatise. Accessibilité : beaucoup d'images, mais dépliant en petits caractères et en français seulement. Adaptations : il faudrait retirer les logos, refaire le jeu, supprimer l'affiche, refaire le dépliant.
2. Refuser le kit : son objectif est publicitaire, son contenu n'est pas à jour et certains éléments sont stigmatisants. Les adaptations seraient si nombreuses qu'il vaut mieux choisir un autre outil. Les cartes photos d'aliments sans logo peuvent éventuellement être réutilisées.
3. La pédagothèque de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) de la région, qui prête des outils analysés.
4. Exemple : une invitation et une fiche goûter en photos, présentées à l'oral à la sortie de l'école avec une médiatrice, et un goûter partagé où les parents goûtent les propositions.

Corrigé – Exercice 5.45

1. Lentilles : 2,60 × 60 / 1 000 = 0,156 €, soit 0,16 € ; riz : 0,108 €, soit 0,11 € ; carottes : 0,168 €, soit 0,17 € ; pommes : 0,330 €, soit 0,33 € ; pain complet : 0,210 €, soit 0,21 € ; poulet : 0,975 €, soit 0,98 € ; fromage blanc : 0,240 €, soit 0,24 € ; huile : 3,20 × 10 / 1 000 = 0,032 €, soit 0,03 € ; œuf : 3,30 / 12 = 0,275 €, soit 0,28 € ; yaourt : 1,90 / 8 = 0,2375 €, soit 0,24 €.
2. A : 4 × (0,156 + 0,108 + 0,168 + 0,032) + 4 × 0,2375 + 4 × 0,330 = 1,856 + 0,950 + 1,320 = 4,13 €. B : 4 × 2 × 0,275 + 4 × 0,210 + 4 × 0,168 + 4 × 0,032 + 4 × 0,240 + 4 × 0,330 = 2,200 + 0,840 + 0,672 + 0,128 + 0,960 + 1,320 = 6,12 €. C : 4 × 0,975 + 4 × 0,108 + 4 × 0,168 + 4 × 0,032 + 0,950 + 1,320 = 3,900 + 0,432 + 0,672 + 0,128 + 0,950 + 1,320 = 7,40 €. Seul le dîner A respecte les 5 € (1,03 € par personne).
3. Le prix au kilo demande un calcul que beaucoup de participants trouvent difficile, et il ne dit pas ce que coûte réellement l'assiette. Le prix par portion se lit directement et s'additionne facilement : c'est une adaptation à la numératie.
4. Exemple : les équipes composent un dîner, additionnent les cartes et présentent leur choix ; il n'y a pas de

« mauvaise réponse », chaque équipe explique ses choix et le groupe cherche ensemble comment rester sous 5 € en gardant un plat qui plaît. On peut garder les prix arrondis et utiliser de vraies pièces de monnaie.

Corrigé – Exercice 5.46

1. « J'ai aimé » : 31 / 38 = 81,6 % ; 6 / 38 = 15,8 % ; 1 / 38 = 2,6 %. « J'ai compris » : 63,2 % ; 28,9 % ; 7,9 %. « Je vais refaire » : 50,0 % ; 34,2 % ; 15,8 %.
2. Les smileys contents diminuent de l'affirmation 1 à l'affirmation 3 (81,6 %, puis 63,2 %, puis 50,0 %). Les participants aiment l'atelier, mais une partie n'est pas sûre d'avoir compris la recette, et encore moins de pouvoir la refaire à la maison : manque d'ingrédients, de matériel, de temps ou de confiance.
3. Exemples : ajouter un « faire dire » sur chaque étape de la recette et remettre une fiche en photos ; choisir des recettes avec des ingrédients du quotidien et peu chers ; terminer par la question « Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de la refaire ? » pour lever les freins.
4. Les participants peuvent coller la gommette sur le smiley content par politesse ou en imitant le voisin ; l'outil mesure une impression et une intention, pas un changement réel ; il ne dit pas pourquoi.
5. Indicateur de compréhension : part des participants qui réussissent le « faire dire » sur la recette (grille d'observation de l'animatrice). Indicateur de résultat : part des participants qui ont refait la recette dans le mois, recueillie à l'oral au début de l'atelier suivant ou par une photo du plat envoyée par message.

Corrigé – Exercice 5.47

1. Affiches : 20 × 0,90 = 18,00 € ; cartes : 300 × 0,08 = 24,00 € ; kakémono : 65,00 € ; collations : 3 × 18,00 = 54,00 € ; vidéo traduite : 120,00 €. Total : 281,00 €, inférieur aux 300 € : le budget est respecté (il reste 19,00 €).
2. Par personne informée : 281 / 180 = 1,56 €. Par participant visé : 281 / 42 = 6,69 €.
3. Affiches avec photos et pictogrammes : compréhensibles sans bien lire. Cartes remises en main propre : l'invitation s'accompagne d'une explication orale. Kakémono au marché et à l'école : visible là où les familles passent. Réunions avec des habitants relais : le bouche-à-oreille par des personnes de confiance est très efficace auprès des familles qui lisent peu ou qui parlent une autre langue. Vidéo traduite oralement : touche les personnes qui ne lisent pas le français, et se partage facilement sur les téléphones.
4. Annonce orale à la sortie de l'école et au marché par l'animatrice ; message vocal partagé dans les groupes WhatsApp des parents par les relais ; annonce par les travailleurs sociaux et la PMI du quartier.
5. Indicateur : répartition des participants selon le canal qui les a fait venir. Recueil : au premier atelier, chaque participant pose une gommette sur l'image du canal (affiche, carte, voisin, vidéo, école).

Corrigé – Exercice 5.48

1. Document 1 : lit difficilement 14 / 24 = 58,3 % ; autre langue 17 / 24 = 70,8 % ; WhatsApp 19 / 24 = 79,2 % ; sans smartphone 5 / 24 = 20,8 % ; fait maison 3 fois par semaine ou moins 15 / 24 = 62,5 % ; moins de 4 € par jour et par personne 16 / 24 = 66,7 %. Présence au premier atelier : 9 / 24 = 37,5 %.
2. Sørensen : les familles accèdent à l'aliment (le colis) mais pas à l'information pour l'utiliser ; elles ont du mal à comprendre l'écrit (« trop de mots ») ; l'évaluation est difficile (« les conserves, c'est du poison ») ; l'application est bloquée (« je ne sais pas quoi en faire »). Domaine : prévention et promotion de la santé. Nutbeam : la littératie fonctionnelle en français est limitée (58,3 % lisent difficilement, le fils lit les papiers) ; la littératie interactive existe (les familles échangent entre voisines, savent dire ce que leurs enfants aiment) ; la littératie critique est à développer (rumeur sur les conserves). Littératie alimentaire : le domaine « préparer » est le plus en difficulté (haricots non cuisinés, fait maison 3 fois ou moins pour 62,5 %) ; « planifier et gérer » est contraint par le budget (66,7 % sous 4 €) ; « sélectionner » est limité car le colis est imposé ; « manger » s'appuie sur des habitudes culturelles fortes (riz et sauce tomate) qui

sont une ressource.

3. Ancienne version : 142 / 5 = 28,4 mots par phrase ; 255 / 142 = 1,796 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 28,4 − 73,6 × 1,796 = 207 − 28,83 − 132,17 = 46,00 : difficile. Nouvelle version : 70 / 10 = 7 ; 102 / 70 = 1,457 ; L = 207 − 7,11 − 107,25 = 92,65 : très facile. Gain : 46,64 points. Exemple d'invitation : « Atelier cuisine. Mardi 14 h. Cuisine du 1er étage. On cuisine les haricots rouges du colis. On fait un plat avec du riz et de la tomate. Vos enfants peuvent goûter. C'est gratuit. Venez avec une boîte : vous repartez avec un plat. Questions ? Demandez à Fatou. » Images : une photo de la boîte de haricots rouges, une photo du plat, un pictogramme horloge, une photo de la cuisine, une photo de l'animatrice.

4. Énergie : 129,60 + 210,00 + 38,08 + 11,70 + 16,80 + 45,00 + 81,00 = 532,18 kcal, soit 532 kcal. Protéines : 9,97 + 4,21 + 1,20 + 0,33 + 0,53 + 0 + 0,38 = 16,62 g. Fibres : 8,40 + 0,92 + 1,28 + 0,51 + 1,60 + 0 + 2,10 = 14,81 g. Sel : 0,82 + 0,00 + 0,34 + 0,03 + 0 + 0 + 0,01 = 1,19 g. Vitamine C : 0,24 + 0 + 7,20 + 1,17 + 60,50 + 0 + 6,90 = 76,01 mg. Protéines : 16,62 × 4 / 532,18 × 100 = 12,5 % de l'énergie. Coût (quantités pour 8 portions) : haricots 960 g × 3,56 € / kg = 3,42 € ; riz 480 g = 0,86 € ; purée 640 g = 1,02 € ; oignon 240 / 0,90 = 266,7 g bruts = 0,48 € ; poivron 400 / 0,80 = 500 g bruts = 2,25 € ; huile 40 g = 0,13 € ; pommes 1 200 g = 2,64 € ; épices 0,30 €. Valeur totale : 11,10 €, soit 1,39 € par portion. Partie achetée par les familles (oignon, poivron, huile, pommes, épices) : 0,48 + 2,25 + 0,13 + 2,64 + 0,30 = 5,80 €, soit 0,72 € par portion. Commentaire : le plat est complet et rassasiant, riche en fibres (14,81 g, environ la moitié des 30 g par jour) et en vitamine C grâce au poivron (76 mg, environ 69 % des 110 mg recommandés par l'ANSES pour un adulte), peu salé (1,19 g, soit 23,8 % du repère de l'OMS de 5 g par jour). Les protéines sont modérées (12,5 %) : on peut ajouter un yaourt ou un morceau de fromage. Rincer les haricots en conserve réduit encore le sel. Le plat reprend « riz et sauce tomate », déjà aimé des enfants, et coûte moins de 1 € par portion pour les familles.

5. Exemple de déroulé de 120 minutes : 10 min, accueil individuel, consignes d'hygiène montrées en pictogrammes, médiatrice présente ; 10 min, photolangage « Montrez la photo du plat que vous faites le plus souvent » ; 10 min, message principal avec objets réels : boîte de haricots, riz, tomate, « un plat complet pour moins de 1 € » ; 10 min, démonstration : ouvrir, rincer et égoutter les haricots, couper l'oignon, faire revenir ; 40 min, cuisine en binômes (une personne qui lit le français avec une personne qui le lit peu), recette en 6 photos, quantités en verres et cuillères ; 20 min, dégustation avec les enfants, échelle à smileys ; 15 min, faire dire : chaque binôme montre comment il rince les haricots et dit le prix d'une portion, l'animatrice réexplique autrement si besoin ; 5 min, clôture : fiche en photos, boîte de plat à emporter, date suivante dite à l'oral. Total : 10 + 10 + 10 + 10 + 40 + 20 + 15 + 5 = 120 minutes.

6. Rincer et utiliser les haricots : 7 / 9 = 77,8 % ; prix d'une portion : 4 / 9 = 44,4 % ; plat à refaire : 8 / 9 = 88,9 % ; moyenne 19 / 27 = 70,4 %. Le geste et l'envie de refaire sont acquis ; le prix d'une portion, une compétence de numératie, l'est beaucoup moins. Ajustements : afficher le prix par portion de chaque ingrédient sur des étiquettes et faire l'addition avec des pièces ; refaire la démonstration du rinçage pour les deux personnes qui ne l'ont pas réussie, en binôme avec une personne qui l'a réussie.

7. Seulement 37,5 % des familles sont venues. Canaux : un message vocal WhatsApp en français et dans les deux langues les plus parlées, enregistré par une mère qui est venue (79,2 % utilisent WhatsApp) ; une invitation orale par les travailleurs sociaux lors des rendez-vous, avec la carte en images (pour les 20,8 % sans smartphone et les 58,3 % qui lisent difficilement) ; une dégustation du plat dans le hall le jour de la distribution du colis, pour donner envie.

8. Indicateurs : part des familles qui déclarent à l'oral avoir cuisiné les haricots rouges dans les deux semaines (objectif : la moitié des participants) ; nombre de boîtes de haricots rouges laissées ou données après la distribution, relevé par les bénévoles avant et après le cycle ; réussite des « faire dire ». Règles éthiques : respect des habitudes culturelles et des choix des familles, sans jugement sur leur budget ou leur cuisine ; confidentialité des informations recueillies au diagnostic (lecture, langue) ; participation libre, sans lien avec l'hébergement ; pas d'enfant utilisé comme interprète pendant les ateliers.

Bilan : grille d'auto-évaluation

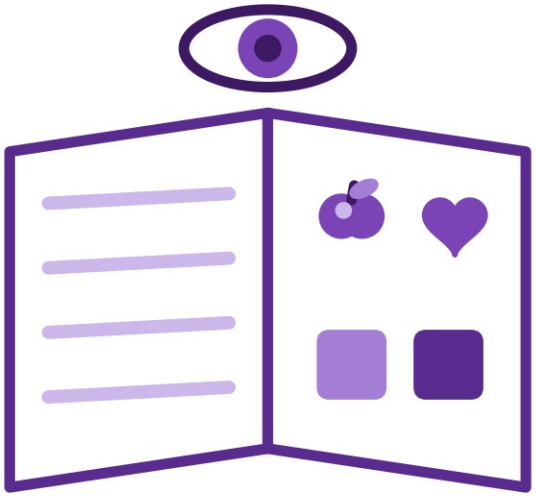
Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la littératie en santé (Sørensen) et la littératie alimentaire ; situer les trois niveaux de Nutbeam ; distinguer littératie individuelle et organisationnelle ; analyser un diagnostic avec la grille des 12 dimensions	5.1 à 5.6			
2	Citer et interpréter HLS19, l'illettrisme et l'illectronisme sans les additionner ; décrire les conséquences d'une littératie limitée ; repérer un gradient social ; calculer un risque relatif ; appliquer l'universalisme proportionné	5.7 à 5.12			
3	Appliquer les précautions universelles ; reconnaître des signaux sans les surinterpréter ; poser des questions qui n'humilient pas ; adapter un questionnaire de diagnostic et comparer deux modes de passation	5.13 à 5.18			
4	Suivre les six étapes d'une communication accessible ; écrire clair ; rédiger en FALC ; calculer et interpréter l'indice de Kandel et Moles et ses limites	5.19 à 5.24			
5	Conduire la boucle du « faire dire » ; transformer une question fermée ; construire un atelier accessible de 2 heures ; exploiter une grille de réussite ; rédiger un message oral	5.25 à 5.30			
6	Lire une étiquette et une liste d'ingrédients ; convertir les sucres en morceaux ; comparer pour 100 g et par portion ; présenter un risque en fréquences naturelles ; traduire un repère chiffré en aliments	5.31 à 5.36			
7	Choisir une adaptation selon la langue, le numérique ou le handicap ; évaluer une application ; calculer un ratio de contraste ; travailler avec un interprète ; construire une communication qui n'exclut personne	5.37 à 5.42			
8	Intégrer la littératie à chaque étape du projet ; analyser un outil pédagogique ; créer des cartes-prix ; évaluer sans écrit ; traiter un cas complet	5.43 à 5.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



05

CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 5 230
Mode d'emploi du cahier d'annales 230
Ce que le jury attend sur ce chapitre 230
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 231
S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 231
S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 235
S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 238
Partie II – Les corrigés détaillés 242
Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage 242
Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques 248
Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles 253
Grille d'auto-évaluation 260

Cahier d'annales E5 – chapitre 5

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 5 porte sur la littératie en santé : définitions (Sørensen, Nutbeam, littératie alimentaire), données françaises (HLS19, illettrisme, illectronisme), lien avec les inégalités sociales de santé, repérage sans stigmatisation (précautions universelles), adaptation des messages et des supports (écriture claire, FALC, pictogrammes, lisibilité, accessibilité numérique), vérification de la compréhension (faire dire), numératie et littératie numérique. Le jury vérifie que le candidat sait **mesurer** les difficultés d'un public sans le juger (questionnaire oral, test de compréhension, indice de lisibilité), **adapter** un support et une animation, puis **vérifier** que le message a été compris, en considérant que la clarté est d'abord la responsabilité du professionnel et de l'organisation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses ressources (langues parlées, entraide, oral, smartphone), ses obstacles (écrit, chiffres, démarches en ligne, handicap) et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque donnée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme une notion du chapitre (dimension de Sørensen, niveau de Nutbeam, numératie, illectronisme, précautions universelles, lisibilité) et l'adaptation qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'association « Chemins de santé » (structure fictive), qui emploie deux médiatrices en santé auprès des familles des deux aires d'accueil des gens du voyage de l'agglomération du Val de Sorne (territoire fictif). La responsable vous confie une demande issue d'une réunion avec le service de protection maternelle et infantile (PMI) et le cabinet dentaire mobile du département : « Beaucoup d'enfants ont des caries, ils boivent des sodas et des jus toute la journée. Les mères nous disent qu'elles ne comprennent pas nos dépliants, et plusieurs adultes diabétiques ne savent pas lire leurs ordonnances. Nos documents ne servent à rien. » Vous devez analyser la situation sous l'angle de la littératie en santé, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – Le territoire, le public et les moyens

- Deux aires d'accueil (64 emplacements au total), gérées par l'agglomération ; en hiver, environ 52 familles sont présentes, soit environ 220 personnes, dont 140 adultes de 18 ans ou plus. Les familles voyagent surtout d'avril à octobre.
- Chaque emplacement dispose d'un bloc sanitaire et d'un branchement électrique payant ; les familles cuisinent dans leur caravane ou à l'extérieur. Les courses se font au supermarché de la zone commerciale, à 3 km.
- La scolarisation des enfants est irrégulière, en particulier au collège ; une partie des adultes n'a pas ou peu été scolarisée.
- Ressources : deux médiatrices, dont l'une est elle-même issue de la communauté ; un local associatif sur l'aire principale (une salle de 30 m², un évier, deux plaques électriques, un réfrigérateur) ; partenaires : PMI, cabinet dentaire mobile, maison de santé, centre social, Éducation nationale.
- Budget de l'action : 1 800 € pour l'année (hors salaires).

Document 2 – Questionnaire administré oralement par les médiatrices (données fictives)

Les médiatrices ont interrogé 74 adultes volontaires, en entretien oral, avec six questions inspirées de l'enquête HLS19 (« Est-ce facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile pour vous de… ») et trois questions sur l'écrit et le numérique.

Question	Réponses « plutôt difficile » ou « très difficile » (n = 74)
Comprendre la notice d'un médicament	41
Remplir un formulaire administratif (CAF, Assurance maladie)	52

Question	Réponses « plutôt difficile » ou « très difficile » (n = 74)
Trouver une information de santé sur internet	49
Juger si une information de santé vue à la télévision ou sur les réseaux sociaux est fiable	44
Comprendre ce que dit le médecin pendant la consultation	18
Comprendre les informations sur les emballages des aliments	46

Écrit et numérique	Réponses « oui » (n = 74)
Possède un smartphone	68
Sait utiliser une application de santé (Mon espace santé, prise de rendez-vous)	15
Déclare lire le français couramment	30

À partir de leurs réponses, les médiatrices ont classé les 74 adultes selon le niveau de littératie en santé générale (méthode de score simplifiée inspirée du HLS19) : insuffisant 26 ; problématique 28 ; suffisant 20.

Document 3 – Le dépliant de la PMI « Les boissons sucrées » et un test de compréhension (données fictives)

- Version actuelle : 180 mots, 7 phrases, 324 syllabes ; texte justifié en police de 9 points ; trois sigles (PNNS, OMS, AJR) ; une photo de bouteilles sans légende.
- Version réécrite par les médiatrices et vous : 90 mots, 13 phrases, 130 syllabes ; police de 14 points ; quatre pictogrammes (verre d'eau, bouteille de soda, morceaux de sucre, dent).
- Test auprès de 20 mères (10 par version, puis croisement des versions) : à la question « Combien de verres de jus de fruits par jour au maximum pour un enfant ? », 6 bonnes réponses sur 20 avec la version actuelle ; 16 sur 20 avec la version réécrite.
- Indice de lisibilité de Kandel et Moles : L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots).

Document 4 – Caries et boissons sucrées chez les enfants vus par le cabinet dentaire mobile (données fictives)

Le cabinet dentaire mobile a examiné 60 enfants de 3 à 11 ans des deux aires. Les parents ont indiqué si l'enfant boit des sodas ou des boissons sucrées tous les jours.

- Enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours : 34, dont 21 ont au moins une carie non soignée.
- Enfants qui n'en boivent pas tous les jours : 26, dont 6 ont au moins une carie non soignée.

Document 5 – Paroles recueillies pendant le stage

« Les papiers, c'est ma fille qui les lit. Elle a douze ans, elle sait mieux que moi. » (Mme R., 41 ans)

« Le docteur parle vite. Je dis oui, oui, et après je demande à la pharmacienne. » (M. L., 58 ans, diabétique)

« Le jus, c'est bon pour les enfants, c'est des fruits. C'est marqué dessus. » (Mme D., 29 ans)

« Les vidéos sur le téléphone, ça on regarde, oui. Pas les papiers. » (Mme S., 34 ans)

« On n'aime pas trop les bureaux. Si c'est Sandra qui vient ici, on écoute. » (Mme P., 52 ans, à propos de la médiatrice)

« Mon garçon, il a eu mal aux dents tout l'hiver. On attendait de repartir pour voir un dentiste ailleurs. »

(Mme V., 36 ans)

Document 6 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Un agent de la mairie vous demande la liste des familles « dont les enfants ont des caries » pour « signaler les familles négligentes ». Une start-up propose de prêter gratuitement des tablettes équipées de son application de « coaching nutritionnel », en échange des données d'utilisation des familles. Une étudiante en journalisme souhaite photographier les enfants pendant votre atelier pour un reportage sur « les voyageurs et la malbouffe ».

Document 7 – Cadre et repères (données réelles)

- La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage organise les aires d'accueil ; la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a supprimé les titres de circulation qui leur étaient imposés.
- La médiation en santé est reconnue par l'article L. 1110-13 du Code de la santé publique (loi du 26 janvier 2016) ; la HAS a publié en 2017 un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques.
- Enquête HLS19 (résultats français publiés en 2021) : environ 44 % des adultes ont une littératie en santé générale limitée (problématique ou insuffisante).
- Insee (enquête 2025, publiée le 19 février 2026) : 7 % des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme et 34 % ont des difficultés numériques.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et idéalement à moins de 5 %, notamment pour prévenir la carie dentaire.
- Santé publique France a publié en 2018, et mis à jour en février 2025, le guide « Communiquer pour tous » pour une information en santé accessible.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation des adultes ; calculez la part de littératie limitée et comparez-la avec la donnée nationale. Classez les six questions selon les quatre compétences du modèle de Sørensen et posez le diagnostic. (2 pts)
2. Calculez l'indice de lisibilité des deux versions du dépliant et les taux de bonnes réponses au test de compréhension (document 3). Interprétez les résultats et dites ce que chaque mesure apporte et ne dit pas. (2 pts)
3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : niveaux de Nutbeam, littératie alimentaire, numératie, illectronisme, littératie organisationnelle, inégalités sociales de santé et ressources du public. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)
5. Présentez le plan d'action sur un an, construit avec les familles et les médiatrices, en tenant compte des périodes de voyage, et un budget qui respecte les 1 800 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez la prévalence des caries, le risque relatif de carie selon la consommation quotidienne de boissons sucrées et son intervalle de confiance à 95 %, avec la formule : IC = exp(ln RR ± 1,96 × √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))). Interprétez. Pourquoi ne peut-on pas conclure à une relation de cause à effet ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion d'adultes ayant une littératie limitée et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points, avec correction pour une population de 140 adultes. Présentez trois limites d'un questionnaire administré oralement par les médiatrices. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la littératie en santé, la santé des gens du voyage et la communication accessible : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 6 (secret professionnel, stigmatisation, données personnelles, droit à l'image des mineurs) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez des supports et des canaux adaptés à ce public (oral, vidéo, pictogrammes, médiation) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le centre social « La Passerelle » de Montclar (structure fictive) organise des ateliers sociolinguistiques (ASL) : des adultes arrivés en France depuis quelques mois ou quelques années y apprennent le français à partir de situations de la vie quotidienne (faire ses courses, aller chez le médecin, inscrire un enfant à l'école). La formatrice bénévole constate que le thème « alimentation » motive beaucoup le groupe : « Ils savent tous cuisiner, souvent très bien, mais ils sont perdus devant les étiquettes et les conseils qu'on leur donne à la PMI. » Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui serve à la fois à **apprendre des mots et des gestes en français** et à **découvrir des repères nutritionnels** utiles à toute la famille, à partir d'un menu simple et économique.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 apprenants de 24 à 63 ans (6 femmes, 2 hommes) ; niveau de français oral A1 à A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; langues parlées : arabe (3), tamoul (2), dari (1), soninké (1), portugais (1).
- Trois apprenants ne lisent pas l'alphabet latin : une femme lit l'arabe, un homme lit le tamoul, une femme n'a jamais été scolarisée.
- Madame A. est enceinte de cinq mois ; Madame N. a un diabète de type 2 traité par comprimés ; Monsieur H. est végétarien ; cinq apprenants ne mangent pas de porc ; personne ne signale d'allergie.
- Cuisine du centre social : 4 plaques à induction, 1 four, 1 four à micro-ondes, 4 postes de travail pour 2 personnes, 1 réfrigérateur ; la formatrice est présente pendant tout l'atelier.
- Budget denrées : au plus 2,00 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 apprenants, la formatrice et vous).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 15, de 9 h 15 à 11 h 30, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : pois chiches mijotés aux épinards et à la tomate, riz complet.

Dessert : salade d'oranges à la cannelle, yaourt nature.

Le candidat réalise le plat et la salade d'oranges. Il présente aussi les adaptations pour Madame A. (grossesse) et pour Madame N. (diabète de type 2), et une version « à refaire à la maison » avec deux plaques et des produits de base.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pois chiches en conserve, poids égoutté (boîte de 265 g égouttés)	120 g	sans perte	2,20 € le kg égoutté

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Épinards en branches surgelés (sachet de 1 kg)	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Tomates pelées en conserve, égouttées	80 g	sans perte	1,60 € le kg
Oignons	30 g	10 %	1,80 € le kg
Huile d'olive vierge extra	6 g	sans perte	8,50 € le kg
Riz complet	60 g (cru)	sans perte	2,90 € le kg
Oranges	150 g	30 %	2,20 € le kg
Yaourt nature (pot de 125 g)	1 pot	sans perte	0,22 € le pot
Ail, cumin, curcuma, cannelle, citron, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pois chiche, appertisé, égoutté	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	1,15	0,1
Epinard, haché ou purée ou en branches, surgelé, cru	28	3,32	1	0,83	0,54	2,95	0,14	1,89	15,3
Tomate, pelée, appertisée, égouttée	16,4	0,9	1,61	1,6	0,28	1,27	0,33	0,57	12,6
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	traces	3,9
Huile d'olive vierge extra	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,05	0
Riz complet, cru	350	7,02	71,4	0	2,8	5	0,01	< 1	0
Orange, chair sans peau, sans pépins, crue	42	0,75	8,03	7,6	< 0,5	2,7	< 0,013	0,57	47,5
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	< 0,25	< 2

On calcule avec les poids nets (crus pour le riz, égouttés pour les conserves). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – La fiche recette utilisée jusqu'ici par le centre social (extrait)

« Émincer finement les oignons et l'ail, puis les faire revenir dans l'huile d'olive jusqu'à coloration légère avant d'incorporer les épices, qui seront torréfiées quelques instants afin de développer leurs arômes. Ajouter les tomates concassées, laisser compoter, puis incorporer les épinards préalablement décongelés et les pois chiches égouttés et rincés… » La fiche complète compte 150 mots, 6 phrases et 255 syllabes ; elle ne

comporte aucune image ; les quantités sont indiquées en grammes pour 10 personnes.

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Le Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l'Europe, 2001) décrit six niveaux, de A1 (utilisateur élémentaire, découverte) à C2 ; au niveau A1, une personne comprend des expressions familières et quotidiennes et des énoncés très simples.
- Les règles européennes du « Facile à lire et à comprendre » (Inclusion Europe, 2009) et le guide « Communiquer pour tous » (Santé publique France, 2018) recommandent des phrases courtes, des mots courants, une idée par phrase et des images qui disent la même chose que le texte.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour ; au moins cinq fruits et légumes par jour.
- Pendant la grossesse, les recommandations officielles conseillent notamment d'éviter les fromages au lait cru, les produits de la mer crus et la charcuterie à la coupe (prévention de la listériose et de la toxoplasmose), et de laver soigneusement les légumes et les fruits.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, y compris dans les denrées non préemballées.
- Indice de lisibilité de Kandel et Moles : L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins et les ressources de ce public (savoir-faire culinaires, langues, lecture, numératie, situations de santé) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, dont au moins un objectif de langue. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Calculez l'indice de lisibilité de la fiche du document 5 ; rédigez une fiche recette « facile à lire » en six étapes illustrées au plus, indiquez ce que montre chaque image, et vérifiez sa lisibilité si elle compte 84 mots, 14 phrases et 118 syllabes. Présentez les adaptations demandées et la version « à refaire à la maison ». (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas (plat, salade d'oranges et yaourt) en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame A. (2 pts)
5. Expliquez, avec les notions du chapitre (littératie fonctionnelle, interactive et critique, littératie alimentaire, numératie, précautions universelles), comment l'atelier développe à la fois le français et les compétences alimentaires, et pourquoi il ne faut pas confondre maîtrise du français et compétences culinaires. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant les binômes (langues, lecture) et les temps de langage. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (imagier des ingrédients et des gestes, objets réels, démonstration, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation utilisable sans lecture. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, lavage des fruits, conserves, riz cuit), la gestion des allergènes et les précautions pour Madame A., et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et la salade d'oranges ; dressez une assiette et un bol de dessert. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, mots appris, gestes et repères retenus, intention de refaire), sans recours à l'écrit pour les participants. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique à l'association « Regards partagés » de Valbonne-sur-Lize (structure fictive), qui accompagne 120 adhérents adultes aveugles ou malvoyants. Le président, lui-même malvoyant, vous explique : « Nous ne pouvons pas lire les dates, les prix, les tableaux nutritionnels. Beaucoup d'entre nous mangent des plats tout prêts, parce qu'ils ont peur de se brûler ou de se couper. Et les campagnes de santé, avec leurs affiches et leurs sites, ne sont pas faites pour nous. » L'association souhaite un projet « Bien manger en autonomie », comprenant un atelier culinaire adapté. Vous devez analyser la situation, concevoir le projet et animer un premier atelier.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Document 1 – Le public, la structure et les moyens

- 120 adhérents de 22 à 88 ans ; environ un tiers sont aveugles, deux tiers malvoyants (basse vision : lecture impossible ou très lente sans aide) ; 58 % vivent seuls.
- Outils utilisés par une partie des adhérents : lecteur d'écran sur smartphone, assistant vocal, loupe électronique, application de reconnaissance de texte ; quelques adhérents lisent le braille.
- Local : une cuisine pédagogique de 4 postes, plaques à induction, four à hauteur, contrastes de couleurs sur les plans de travail ; deux bénévoles formés à l'accompagnement.
- Partenaires : centre de rééducation basse vision (ergothérapeute, instructrice en autonomie dans la vie journalière), supermarché voisin, centre communal d'action sociale.
- Budget : 2 000 € pour l'année (hors salaires).

Document 2 – Enquête téléphonique auprès des adhérents (données fictives)

45 adhérents ont répondu à un questionnaire par téléphone (passation orale, 15 minutes).

Question	Réponses « oui » (n = 45)
Je ne peux pas lire les dates (DLC, DDM) sur les emballages	35
Je ne peux pas lire le tableau nutritionnel	39
J'utilise une application ou un assistant vocal pour lire les étiquettes	17
Je cuisine seul au moins 4 fois par semaine	28
Je me suis brûlé ou j'ai eu très peur de me brûler en cuisinant cette année	20
Je mange surtout des plats préparés	19
Je suis satisfait de mon alimentation	22

Croisement : parmi les 28 adhérents qui cuisinent seuls au moins 4 fois par semaine, 16 se sont brûlés ou ont eu très peur de se brûler ; parmi les 17 autres, 4.

Document 3 – Trois supports de prévention examinés (données fictives)

Support	Taille de police	Couleur du texte / du fond	Luminance relative du texte	Luminance relative du fond
A – Dépliant municipal « Manger mieux »	9 points	gris moyen sur blanc	0,216	1,000
B – Affiche d'un supermarché « Nos produits santé »	12 points	jaune pâle sur blanc	0,927	1,000
C – Fiche de l'association	16 points	noir sur blanc	0,000	1,000

Rapport de contraste selon les règles WCAG : (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance relative la plus claire et L2 la plus foncée. Seuil minimal (niveau AA) : 4,5 pour un texte courant, 3 pour un grand texte (18 points, ou 14 points en gras).

Audit du site internet de la mairie, page « Santé » : 5 critères d'accessibilité sur 12 sont respectés (les images n'ont pas de texte alternatif, la vidéo n'est pas sous-titrée ni audiodécrite, les liens « cliquez ici » ne disent pas où ils mènent).

Document 4 – Paroles d'adhérents

« Au magasin, je demande au caissier de me lire la date. Il est pressé, alors je n'ose plus. » (Mme G., 67 ans, malvoyante)

« Mon téléphone me lit l'étiquette, mais il me lit tout, même la publicité ; je m'y perds. » (M. T., 34 ans, aveugle)

« Je faisais très bien la cuisine. Depuis que je ne vois plus, je réchauffe des barquettes. » (Mme L., 79 ans)

« Les dépliants de la mairie, je les jette, je ne peux pas les lire. » (M. B., 58 ans)

« Ce qu'il me faudrait, c'est qu'on me montre, avec les mains. » (Mme R., 46 ans)

Document 5 – Deux situations rencontrées pendant le stage

Une entreprise propose de financer l'atelier si l'association recommande son application payante de lecture d'étiquettes dans sa lettre d'information. Un bénévole souhaite filmer l'atelier et diffuser la vidéo sur la page publique de l'association « pour montrer que c'est possible ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d'accessibilité, y compris des services de communication en ligne des organismes publics (article 47).
- Le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) s'appuie sur les règles internationales WCAG (W3C) ; la version 2.1 des WCAG date de 2018.
- La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), ratifiée par la France en 2010, reconnaît le droit à l'accès à l'information.
- La directive européenne 2019/882 sur les exigences d'accessibilité des produits et services (« Acte européen sur l'accessibilité ») s'applique depuis le 28 juin 2025 à certains produits et services, dont le commerce électronique.

Travail à faire – temps 1

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant ce qui relève des personnes, des produits (étiquetage) et de l'environnement (supports, magasins, sites). (2,5 pts)

2. Calculez le rapport de contraste des trois supports et le taux de conformité du site ; concluez sur leur accessibilité et proposez les corrections. Expliquez pourquoi une « bonne » lisibilité au sens de l'indice de Kandel et Moles ne suffit pas pour ce public. (2,5 pts)

3. Analysez la situation avec les notions du chapitre : dimensions de Sørensen, littératie alimentaire, littératie numérique et outils d'aide, littératie organisationnelle, précautions universelles. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels avec indicateurs ; présentez un plan d'action sur un an et un budget qui respecte les 2 000 €. (4 pts)

5. Calculez le risque relatif de brûlure ou de peur de se brûler selon la fréquence de cuisine solitaire et son intervalle de confiance à 95 % (même formule que dans les autres sujets). Concluez avec prudence. Calculez l'intervalle de confiance de la proportion d'adhérents qui ne peuvent pas lire le tableau nutritionnel, et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (population de 120). (3 pts)

6. Organisez une veille sur l'accessibilité de l'information alimentaire et sur la déficience visuelle (sources, outils, fréquence). (2 pts)

7. Analysez les deux situations du document 5 et rédigez vos réponses ; indiquez comment rendre accessibles votre exposé et vos supports. (2 pts)

Qualité de l'expression, vocabulaire et sources datées : 2 pts.

Temps 2 – L'atelier culinaire « Cuisiner en sécurité, sans voir ou en voyant peu »

Document 7 – Le groupe et les contraintes

- 6 adhérents de 34 à 79 ans : 2 aveugles, 4 malvoyants ; Mme L. (79 ans) a un diabète de type 2 ; M. B. (58 ans) a une hypertension artérielle ; personne ne signale d'allergie.
- 2 bénévoles formés et l'ergothérapeute du centre de rééducation sont présents ; 4 postes de travail.
- Budget denrées : au plus 2,50 € par portion ; 10 portions (6 adhérents, 2 bénévoles, l'ergothérapeute et vous).
- Durée avec le public : 2 h 30, repas compris.

Document 8 – Menu imposé et grammages (données construites pour le sujet)

Plat : poulet mariné au yaourt et au citron, cuit au four ; semoule ; carottes râpées au jus d'orange. Dessert : banane écrasée au fromage blanc et à la cannelle.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Filet de poulet sans peau	100 g	sans perte	11,50 € le kg
Yaourt nature (marinade)	30 g	sans perte	2,20 € le kg
Citron (jus)	5 g de jus	60 %	3,00 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Semoule de blé dur	60 g (crue)	sans perte	1,90 € le kg
Carottes	100 g	15 %	1,40 € le kg
Oranges à jus (jus)	30 g de jus	55 %	2,00 € le kg
Bananes	80 g	35 %	2,00 € le kg
Fromage blanc nature 2-3 % MG	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Ail, cumin, cannelle, persil, sel, poivre	–	–	forfait 0,90 € pour l'atelier

Document 9 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Yaourt ou lait fermenté, nature	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Jus de citron, pur jus	29,4	0,4	6,1	2,4	0,29	0,4	0,053
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Semoule de blé dur, crue	350	11,8	69,8	1	1,28	3,7	0,0025
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Jus d'orange, pur jus	45,4	0,61	9,61	9,61	0,11	0,28	0,012
Banane, chair sans peau, crue	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088

Travail à faire – temps 2

8. Identifiez les besoins du groupe et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

9. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; vérifiez le budget. Calculez l'apport d'une portion du repas et la répartition de l'énergie ; commentez pour Mme L. et M. B. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique du plat et une version accessible de la recette (audio, gros caractères à fort contraste, repères tactiles) ; présentez les adaptations du poste de travail et des gestes (couper, râper, verser un liquide chaud, utiliser le four) proposées avec l'ergothérapeute. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté des 3 heures, les méthodes d'animation (guidage verbal précis, main sur main avec accord, repères « en horloge » dans l'assiette, « faire dire » et « faire faire ») et une grille de dégustation orale. (4 pts)

12. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (volaille crue, cuisson à cœur, rangement constant des ustensiles, brûlures et coupures), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (3 pts)

13. Réalisez le plat et le dessert ; proposez l'évaluation de l'atelier (autonomie, sécurité, plaisir, intention de refaire). (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Les papiers, c'est ma fille qui les lit » : littératie en santé sur deux aires d'accueil des gens du voyage

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la capacité à décrire des difficultés de littératie sans juger les personnes, à repérer aussi leurs **ressources** (oral, entraide, smartphone, confiance dans la médiatrice), et à proposer des actions qui changent d'abord les **supports** et l'**organisation** plutôt que les personnes. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des notions (Sørensen, Nutbeam, numératie, illectronisme, précautions universelles, littératie organisationnelle) et le respect strict du secret professionnel. Il pénalise les jugements culturels (« ils ne s'intéressent pas à leur santé »), la confusion entre littératie et intelligence, et toute action qui désigne ou fiche des familles.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs, modèle de Sørensen et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire oral (n = 74)

- Comprendre la notice d'un médicament : 41 / 74 × 100 = **55,4 %** trouvent cela difficile.
- Remplir un formulaire administratif : 52 / 74 × 100 = **70,3 %**.
- Trouver une information de santé sur internet : 49 / 74 × 100 = **66,2 %**.
- Juger la fiabilité d'une information de santé vue dans les médias : 44 / 74 × 100 = **59,5 %**.
- Comprendre ce que dit le médecin : 18 / 74 × 100 = **24,3 %**.
- Comprendre les informations sur les emballages : 46 / 74 × 100 = **62,2 %**.
- Possède un smartphone : 68 / 74 × 100 = **91,9 %** ; sait utiliser une application de santé : 15 / 74 × 100 = **20,3 %** ; lit le français couramment : 30 / 74 × 100 = **40,5 %**.
- Parmi les possesseurs de smartphone, utilisateurs d'une application de santé : 15 / 68 × 100 = **22,1 %**.
- Niveaux : insuffisant 26 / 74 = **35,1 %** ; problématique 28 / 74 = **37,8 %** ; suffisant 20 / 74 = **27,0 %**. Littératie limitée : (26 + 28) / 74 × 100 = **73,0 %**, contre environ **44 %** en population générale (HLS19, 2021), soit 73,0 / 44 ≈ **1,7 fois** plus.
- Taux de participation : 74 / 140 × 100 = **52,9 %** des adultes.

Question	Compétence (Sørensen, 2012)	Domaine
Comprendre la notice d'un médicament	Comprendre	Soins
Remplir un formulaire administratif	Appliquer (agir, communiquer une information)	Soins et accès aux droits
Trouver une information sur internet	Accéder	Prévention, promotion de la santé
Juger la fiabilité d'une information des médias	Évaluer	Promotion de la santé
Comprendre le médecin	Comprendre	Soins
Comprendre les emballages	Comprendre et appliquer	Prévention (alimentation)

Diagnostic. Près des trois quarts des adultes interrogés (73,0 %) ont une littératie en santé limitée, une proportion bien supérieure à la moyenne nationale. Les difficultés portent surtout sur l'**écrit** (formulaires 70,3 %, notices 55,4 %, emballages 62,2 %) et sur le **numérique** (internet 66,2 % ; seulement 20,3 % savent utiliser une application de santé, alors que 91,9 % ont un smartphone). L'**évaluation** de l'information est difficile pour 59,5 %

: c'est la compétence la plus exigeante, et elle explique des croyances comme « le jus, c'est des fruits » (Mme D.). À l'inverse, l'**oral** fonctionne mieux : seuls 24,3 % ont du mal à comprendre le médecin, et les familles regardent volontiers des vidéos (Mme S.). Les ressources sont réelles : l'entraide familiale (même si faire lire les papiers par une enfant de 12 ans pose problème), la confiance dans la médiatrice, l'usage quotidien du smartphone pour la vidéo et la messagerie.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Caries fréquentes chez les enfants, consommation quotidienne de boissons sucrées (repères de l'OMS, 2015) ; littératie limitée bien au-dessus de la moyenne nationale
Ressenti	« Le docteur parle vite » ; peur ou gêne dans les bureaux ; douleur dentaire de l'enfant
Exprimé	Préférence pour la vidéo et pour la venue de la médiatrice sur l'aire
Comparatif	73,0 % de littératie limitée contre environ 44 % en France

Question 2 – Lisibilité et test de compréhension (2 pts)

Calcul posé – Indice de Kandel et Moles et test auprès de 20 mères

- Version actuelle : mots par phrase 180 / 7 = **25,71** ; syllabes par mot 324 / 180 = **1,80**. L = 207 − 1,015 × 25,71 − 73,6 × 1,80 = 207 − 26,10 − 132,48 = **48,42** : texte **difficile**.
- Version réécrite : mots par phrase 90 / 13 = **6,92** ; syllabes par mot 130 / 90 = **1,44**. L = 207 − 1,015 × 6,92 − 73,6 × 1,444 = 207 − 7,03 − 106,31 = **93,66** : texte **très facile**.
- Gain : 93,66 − 48,42 = **45,24 points**.
- Test : bonnes réponses 6 / 20 × 100 = **30 %** avec la version actuelle ; 16 / 20 × 100 = **80 %** avec la version réécrite, soit **+ 50 points**.

Interprétation. La réécriture fait passer le texte de « difficile » à « très facile » et multiplie par 80 / 30 ≈ **2,7** la proportion de bonnes réponses. Les deux mesures sont complémentaires. L'indice de lisibilité mesure seulement la **longueur** des phrases et des mots : il ne dit rien du sens, des sigles, de la taille de la police, des images, ni de la culture du public, et il ne s'applique pas à une personne qui ne lit pas. Le **test de compréhension** auprès de personnes du public mesure ce qui compte vraiment (le message est-il compris ?), mais sur un petit effectif (20 mères) et avec une seule question. Pour ce public, où 59,5 % des adultes ne lisent pas couramment le français, un dépliant même très lisible restera insuffisant : il doit être accompagné d'une **explication orale** et d'un **support visuel ou vidéo**.

Question 3 – Analyse avec les notions du chapitre (2 pts)

- **Niveaux de Nutbeam** : la littératie **fonctionnelle** (lire une notice, une étiquette) est limitée pour une majorité ; la littératie **interactive** est une force (échanger avec la médiatrice, demander à la pharmacienne) ; la littératie **critique** (juger la publicité « 100 % fruits ») est à développer, en groupe.
- **Littératie alimentaire** (Vidgen et Gallegos, 2014) : les compétences de **préparation** et de **partage** sont présentes ; la **sélection** (lire les emballages, repérer le sucre) est difficile.
- **Numératie** : les grammes de sucre pour 100 mL ne parlent pas ; les morceaux de sucre et les verres, oui.
- **Illectronisme** : avoir un smartphone ne suffit pas (20,3 % savent utiliser une application de santé) ; la dématérialisation des démarches (Mon espace santé, prise de rendez-vous) **exclut** une partie des familles.
- **Littératie organisationnelle** : les documents de la PMI, les formulaires et les bureaux ne sont pas adaptés ; la mobilité (départ au printemps) rompt le suivi ; la responsabilité est d'abord celle des institutions (« nos documents ne servent à rien »).
- **Inégalités sociales de santé** : faible scolarisation, conditions de vie sur les aires, discriminations et méfiance envers les institutions ; une communication écrite standard **creuse le gradient** (chapitre 2) ; l'**universalisme proportionné** justifie des moyens renforcés (médiation, oral, venue sur l'aire).

- **Enfant interprète** : faire lire les papiers par une enfant de 12 ans inverse les rôles et expose à des erreurs ; il faut proposer d'autres solutions (médiatrice, lecture à voix haute, interprétariat si besoin).

Problème central : les messages de santé bucco-dentaire et alimentaire destinés aux familles des aires d'accueil sont peu compris et peu utilisables, parce qu'ils reposent sur l'écrit et le numérique. Causes : supports écrits complexes, démarches en ligne, faible scolarisation, méfiance envers les institutions, publicité trompeuse, mobilité. Conséquences : consommation quotidienne de boissons sucrées, caries non soignées, douleurs, recours tardif aux soins, mauvaise compréhension des traitements chez les adultes diabétiques.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer la santé bucco-dentaire et nutritionnelle des enfants des aires d'accueil du Val de Sorne en rendant les informations de santé accessibles et utilisables par les familles, d'ici un an.

Objectif	Indicateur	Valeur de départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : réduire la consommation quotidienne de boissons sucrées des enfants de 3 à 11 ans	Part des enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours (déclaration des parents)	34 / 60 = 56,7 %	40 %	12 mois
Spécifique 2 : rendre les supports et les démarches de santé compréhensibles par les familles	Part de bonnes réponses aux tests de compréhension des supports	30 %	80 % au moins pour chaque support	6 mois
Opérationnel 1 : produire avec 6 mères trois vidéos de 2 minutes (boissons, brossage des dents, rendez-vous dentaire), diffusées par messagerie	Nombre de vidéos produites et nombre de familles destinataires	0	3 vidéos, 40 familles	4 mois
Opérationnel 2 : animer 6 ateliers « boissons et goûters » sur l'aire, avec morceaux de sucre et dégustation d'eaux aromatisées maison	Nombre d'ateliers et de participants ; « faire dire » réussi	0	6 ateliers, 30 participants, 80 % de « faire dire » réussis	Avant le départ d'avril
Opérationnel 3 : réécrire et tester les 4 documents de la PMI les plus utilisés	Indice de lisibilité et test de compréhension	L ≈ 48 ; 30 %	L ≥ 80 ; 80 % de bonnes réponses	3 mois
Opérationnel 4 : accompagner 20 familles dans la prise d'un rendez-vous dentaire avant le départ du printemps	Nombre de rendez-vous honorés	–	20	Mars

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Novembre-décembre	Formation courte des médiatrices et des professionnels de la PMI à l'écriture claire et au « faire dire » ; réécriture et test des documents	Littératie organisationnelle ; précautions universelles
Décembre-février	Tournage des vidéos avec les mères volontaires (elles choisissent les mots et les images)	Participation ; littératie interactive ; canal adapté (vidéo, messagerie)
Janvier-mars	Six ateliers « boissons et goûters » sur l'aire : morceaux de sucre, verres d'eau aromatisée, comparaison de briques de jus	Numératie (morceaux de sucre) ; littératie critique (« 100 % fruits » ne veut pas dire « sans sucre »)

Période	Action	Notion justifiant l'action
Février-mars	Rendez-vous dentaires accompagnés, avant le départ ; remise d'un carnet de santé enfant avec rappel illustré	Accès aux soins ; continuité malgré la mobilité
Avril-octobre	Pendant les voyages : rappels vidéo et vocaux par messagerie ; lien avec les associations des autres départements	Mobilité ; universalisme proportionné
Novembre suivant	Évaluation au retour des familles ; restitution collective sur l'aire	Évaluation participative

Poste	Coût
Réalisation et montage de 3 vidéos (location de matériel, sous-titrage)	350 €
Impression de supports illustrés et plastifiés (pictogrammes, calendrier de brossage)	200 €
Denrées pour 6 ateliers (60 € par atelier)	360 €
Matériel pédagogique (verres doseurs, morceaux de sucre, carafes, gobelets)	120 €
Kits de brossage (60 kits à 3 €)	180 €
Bons d'achat pour les mères relais (participation à la conception)	300 €
Jeux et outils pédagogiques (pédagothèque, imagiers)	150 €
Déplacements	140 €
Total	**1 800 €**

Vérification : 350 + 200 + 360 + 120 + 180 + 300 + 150 + 140 = **1 800 €** ✓.

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Prévalence, risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Caries et boissons sucrées (n = 60)

Notations : a = 21 (boissons quotidiennes et carie), a + b = 34 ; c = 6 (sans boissons quotidiennes et carie), c + d = 26.

- Prévalence des caries non soignées : (21 + 6) / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Risque chez les exposés : 21 / 34 = **61,8 %** ; chez les non-exposés : 6 / 26 = **23,1 %**.
- RR = 0,618 / 0,231 = **2,68**.
- ln RR = ln 2,68 = 0,984 ; erreur type = √(1/21 − 1/34 + 1/6 − 1/26) = √(0,0476 − 0,0294 + 0,1667 − 0,0385) = √0,1464 = **0,383**.
- IC 95 % = exp(0,984 ± 1,96 × 0,383) = exp(0,984 ± 0,750) = [exp(0,234) ; exp(1,734)] = **[1,26 ; 5,67]**.

Interprétation. Les enfants qui boivent des boissons sucrées tous les jours ont 2,7 fois plus souvent une carie non soignée que les autres ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. On ne peut pas conclure à une relation de cause à effet : l'étude est **transversale** (exposition et carie mesurées au même moment) ; d'autres facteurs peuvent intervenir (**brossage**, dentifrice fluoré, sucreries, accès au dentiste, âge de l'enfant), qui ne sont pas pris en compte ; la consommation est **déclarée** par les parents (biais de mémoire et de désirabilité) ; l'effectif est petit (intervalle large). La relation est cependant plausible et cohérente avec les connaissances (OMS, 2015) : elle justifie l'action.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites (1,5 pt)

Calcul posé – Proportion de littératie limitée

- p = 54 / 74 = **0,730**.

- Demi-largeur : 1,96 × √(0,730 × 0,270 / 74) = 1,96 × √0,002663 = 1,96 × 0,0516 = **0,101**.
- IC 95 % = 0,730 ± 0,101 = **[62,9 % ; 83,1 %]**.
- Taille d'échantillon pour ± 5 points : n0 = 1,96² × 0,730 × 0,270 / 0,05² = 3,8416 × 0,1971 / 0,0025 = **303** ; correction pour une population de 140 : n = 303 / (1 + (303 − 1) / 140) = 303 / 3,157 = **96** adultes.

Avec 74 répondants, la précision est d'environ ± 10 points ; il faudrait interroger 96 des 140 adultes pour atteindre ± 5 points. Mais même la borne basse de l'intervalle (62,9 %) reste bien au-dessus de la moyenne nationale : la conclusion du diagnostic ne change pas.

Limites d'un questionnaire administré par les médiatrices : **désirabilité sociale** (répondre ce qui plaît à une personne connue, ou au contraire minimiser ses difficultés par fierté) ; **biais de sélection** (volontaires, familles présentes en hiver, plus proches de l'association) ; **reformulation** variable des questions d'un entretien à l'autre (biais d'enquêteur) ; méthode de score **simplifiée**, non validée, qui ne permet qu'une comparaison prudente avec HLS19.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser la veille (2 pts)

Thème	Sources fiables	Outils	Fréquence
Littératie en santé	Santé publique France (« Communiquer pour tous », dossiers littératie) ; réseau M-POHL de l'OMS Europe (HLS19 et cycle suivant) ; HAS (fiche « Faire dire », 2015 ; référentiel de médiation, 2017)	Alertes sur les sites, lettres d'information	Mensuelle
Santé des gens du voyage	Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) ; ARS (programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des plus démunis, PRAPS) ; Défenseur des droits	Lettres d'information, rapports annuels	Trimestrielle
Santé bucco-dentaire et sucres	OMS ; Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) ; Assurance maladie (examen bucco-dentaire « M'T dents »)	Bases documentaires, alertes	Trimestrielle
Outils pédagogiques	Instances régionales d'éducation et de promotion de la santé (pédagothèques) ; SantéBD (FALC)	Catalogues en ligne	À chaque projet

Diffusion : une fiche de synthèse d'une page, datée, pour l'équipe et les médiatrices, et un point oral mensuel ; les sources sont classées par date et par fiabilité.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Trois situations (1,5 pt)

- **Liste des familles « négligentes »** : les données de santé recueillies par le cabinet dentaire et par l'association sont couvertes par le **secret professionnel** ; aucune liste nominative n'est transmise à la mairie. La demande est en outre **stigmatisante** : une carie n'est pas une preuve de négligence (accès aux soins, mobilité, information inadaptée). Réponse : « Je ne peux pas vous transmettre d'information sur la santé des enfants. Je peux en revanche vous présenter des résultats anonymes et collectifs, et vous proposer de travailler avec nous sur l'accès au dentiste pour toutes les familles de l'aire. » Si un enfant est réellement en danger, la procédure relève de l'information préoccupante, par les professionnels compétents, pas d'une liste.

- **Tablettes contre données** : les données d'utilisation d'une application de « coaching nutritionnel » sont des **données personnelles**, parfois de santé (RGPD) ; elles ne peuvent pas être une contrepartie commerciale. L'outil n'a pas été évalué, il est conçu pour l'écrit et risque de culpabiliser. Réponse : refus courtois ; un éventuel partenariat devrait être sans collecte de données, sans publicité, et validé par l'association.
- **Photos d'enfants pour un reportage « malbouffe »** : le **droit à l'image** des mineurs exige l'autorisation écrite des deux parents ; le titre envisagé est **stigmatisant** et risque de rompre la confiance des familles. Réponse : pas de photo pendant l'atelier ; proposition éventuelle d'un entretien avec l'association sur ce qui fonctionne (médiation, vidéos faites par les mères), avec l'accord des familles et sans enfants identifiables.

Question 10 – Supports adaptés, trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports : vidéos courtes (2 minutes), tournées avec les mères, en français simple, sous-titrées et doublées par la voix de la médiatrice ; messages vocaux par messagerie ; affiches à pictogrammes dans le local ; objets réels (bouteilles, morceaux de sucre, verres) ; carnet illustré de rendez-vous. Pas de dépliant seul : tout support écrit est remis **avec** une explication orale et un « faire dire ».

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte et demande ; 2 min, diagnostic chiffré (73,0 % de littératie limitée, lisibilité et test de compréhension, caries et boissons) ; 1 min 30, analyse (Sørensen, Nutbeam, illectronisme, littératie organisationnelle) ; 2 min, objectifs et plan d'action ; 1 min, ce que j'ai réalisé (réécriture testée, un atelier) ; 1 min 30, évaluation et limites ; 1 min, éthique et conclusion.

Questions probables du jury : 1. Qu'est-ce que la littératie en santé selon Sørensen ? 2. Pourquoi la littératie n'est-elle pas l'intelligence ? 3. Que sont les précautions universelles ? 4. Comment avez-vous évité de stigmatiser les familles ? 5. Pourquoi un dépliant très lisible ne suffit-il pas ? 6. Quelles limites a l'indice de Kandel et Moles ? 7. Comment avez-vous testé vos supports ? 8. Pourquoi la vidéo plutôt que l'écrit ? 9. Que pensez-vous des enfants qui lisent les papiers de leurs parents ? 10. Comment tenez-vous compte de la mobilité des familles ? 11. Votre RR prouve-t-il que les sodas causent les caries ? 12. Comment avez-vous travaillé avec les médiatrices ? 13. Comment protégez-vous les données recueillies ? 14. Qu'avez-vous répondu à la mairie ? 15. Comment évaluerez-vous l'action pendant les voyages ?

Barème – Barème du temps 1

Partie A : 9 points (indicateurs et diagnostic 2 ; lisibilité et test 2 ; analyse 2 ; objectifs 1,5 ; plan et budget 1,5). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Confondre littératie limitée, illettrisme et illectronisme, ou additionner leurs pourcentages ; conclure que les familles « ne s'intéressent pas à leur santé » ; s'arrêter à l'indice de lisibilité sans test auprès du public ; proposer un dépliant ou un site internet comme seule solution ; oublier la mobilité des familles ; présenter le RR comme une preuve de causalité ; accepter de transmettre une liste nominative ou des photos d'enfants.

Corrigé S2 – « Cuisiner pour apprendre le français » : un atelier avec un groupe d'apprenants en ateliers sociolinguistiques

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la capacité à concevoir un atelier qui part des **savoir-faire** des participants (ils savent cuisiner) et qui compense leurs difficultés d'**écrit** et de **langue** par l'image, l'objet, le geste et l'oral. Il valorise un bon de commande exact, une fiche recette réellement accessible (testable sans lecture), des calculs nutritionnels justes et commentés, la prise en compte de la grossesse et du diabète sans discours médicalisé, et une évaluation sans écrit. Il pénalise la confusion entre maîtrise du français et compétences culinaires, les consignes uniquement écrites et l'oubli des précautions d'hygiène.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins, ressources et objectifs (2 pts)

Domaine	Besoins	Ressources
Langue et écrit	Niveau A1-A2 à l'oral ; trois apprenants ne lisent pas l'alphabet latin, dont une personne jamais scolarisée ; vocabulaire de la cuisine et des courses en français à acquérir	Langues maternelles variées ; entraide entre apprenants ; présence de la formatrice
Alimentation	Comprendre les étiquettes et les conseils de la PMI ; repères sur les légumes secs, les céréales complètes, les fruits	Savoir-faire culinaires souvent élevés ; plats familiaux à base de légumineuses (houmous, dal, chorba)
Numératie	Passer des grammes aux mesures courantes ; comprendre un prix au kilo	Habitude de gérer un budget serré
Santé	Grossesse (Mme A.) ; diabète de type 2 (Mme N.) ; végétarisme (M. H.) ; pas de porc pour cinq personnes	Le menu imposé convient à tous : végétarien et sans porc

Objectif général : permettre aux apprenants de cuisiner et de nommer en français un repas équilibré et économique à base de légumes secs, et de comprendre des repères nutritionnels utiles à leur famille.

Objectifs opérationnels (à la fin de l'atelier, chaque apprenant sera capable de) :

1. **Langue** : nommer en français, à l'oral, au moins 8 des 12 mots de l'imagier (pois chiches, épinards, oignon, riz complet, orange, yaourt, éplucher, couper, rincer, cuire, mélanger, goûter).
2. **Gestes** : réaliser en binôme une étape de la recette à partir de la fiche en images, sans aide écrite.
3. **Repères** : montrer, avec les objets, la portion de légumes secs d'un repas et dire pourquoi l'orange est servie avec le plat (vitamine C et fer), en « faire dire ».

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Pois chiches égouttés	120 g	1 200 g	0 %	1 200 g	5 boîtes de 265 g égouttés (1 200 / 265 = 4,5)	1,200 × 2,20 = 2,64 €
Épinards surgelés	100 g	1 000 g	0 %	1 000 g	1 sachet de 1 kg	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Tomates pelées égouttées	80 g	800 g	0 %	800 g	2 boîtes de 400 g égouttés	0,800 × 1,60 = 1,28 €
Oignons	30 g	300 g	10 %	300 / 0,90 = 333 g	0,350 kg	0,333 × 1,80 = 0,60 €

Denrée	Net par portion	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Huile d'olive	6 g	60 g	0 %	60 g	Stock (bouteille entamée)	0,060 × 8,50 = 0,51 €
Riz complet	60 g	600 g	0 %	600 g	1 paquet de 1 kg	0,600 × 2,90 = 1,74 €
Oranges	150 g	1 500 g	30 %	1 500 / 0,70 = 2 143 g	2,2 kg (environ 9 oranges)	2,143 × 2,20 = 4,71 €
Yaourts nature	1 pot	10 pots	0 %	10 pots	10 pots de 125 g	10 × 0,22 = 2,20 €
Épices, ail, citron, sel	–	–	–	–	Forfait	0,80 €

Total : 2,64 + 2,60 + 1,28 + 0,60 + 0,51 + 1,74 + 4,71 + 2,20 + 0,80 = **17,08 €** ; coût par portion : 17,08 / 10 = **1,71 €**, inférieur au plafond de 2,00 € (marge de 2,92 € sur le budget de 20,00 €). Le coût est calculé sur les quantités utilisées ; la cinquième boîte de pois chiches entamée et le reste de riz restent au centre social. Remarque : les oranges représentent 4,71 / 17,08 × 100 = 27,6 % du coût ; en été, on les remplacerait par un fruit de saison moins cher.

Question 3 – Fiche technique, fiche « facile à lire », adaptations (3 pts)

Modèle – Fiche technique : pois chiches mijotés aux épinards et à la tomate, riz complet (10 portions)

Ingrédients : pois chiches égouttés 1 200 g ; épinards surgelés 1 000 g ; tomates pelées 800 g ; oignons 333 g bruts ; huile d'olive 60 g ; ail 2 gousses ; cumin 2 cuillères à café ; curcuma 1 cuillère à café ; jus d'un demi-citron ; sel, poivre ; riz complet 600 g.

Matériel : 2 faitouts, 1 casserole pour le riz, planches et couteaux d'office, passoire, cuillères en bois, balance, verre doseur, thermomètre à sonde.

Étapes : 1. Rincer le riz, le cuire 25 à 30 minutes dans 2,5 fois son volume d'eau bouillante. 2. Éplucher et émincer les oignons et l'ail ; les faire revenir 5 minutes dans l'huile. 3. Ajouter les épices, remuer 30 secondes. 4. Ajouter les tomates, cuire 5 minutes. 5. Ajouter les épinards encore surgelés, couvrir 8 à 10 minutes. 6. Ajouter les pois chiches rincés, mijoter 10 minutes ; ajouter le citron, goûter, saler peu. 7. Servir avec le riz.

Points critiques : lavage des mains et des plans de travail ; boîtes de conserve propres, bombées refusées ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C jusqu'au service ; riz cuit refroidi en moins de 2 heures s'il est conservé (risque lié à *Bacillus cereus*) ; ustensiles coupants rangés à plat, pointe vers l'intérieur.

Calcul posé – Lisibilité de la fiche actuelle et de la fiche « facile à lire »

- Fiche actuelle : 150 / 6 = **25** mots par phrase ; 255 / 150 = **1,70** syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 25 − 73,6 × 1,70 = 207 − 25,38 − 125,12 = **56,50** : « assez difficile ».
- Fiche réécrite : 84 / 14 = **6** mots par phrase ; 118 / 84 = **1,405** ; L = 207 − 1,015 × 6 − 73,6 × 1,405 = 207 − 6,09 − 103,40 = **97,51** : « très facile ».

La fiche réécrite remplace les verbes techniques (émincer, faire revenir, déglacer, compoter) par des verbes courants (couper, cuire, mélanger) et chaque étape par **une photo**. Mais l'indice ne vaut que pour les lecteurs : pour les trois apprenants qui ne lisent pas l'alphabet latin, ce sont les **images**, les **objets** et la **démonstration** qui portent le message.

Étape	Ce que montre la photo	Texte court (une phrase)
1	Mains sous le robinet, savon	Je lave mes mains.
2	Couteau qui coupe un oignon sur une planche	Je coupe l'oignon.
3	Oignon dans la casserole avec l'huile, cuillère en bois	Je cuis l'oignon avec l'huile.

Étape	Ce que montre la photo	Texte court (une phrase)
4	Tomates, puis épinards dans la casserole	J'ajoute les tomates et les épinards.
5	Pois chiches dans la passoire sous l'eau, puis dans la casserole	Je rince les pois chiches. Je mélange.
6	Assiette avec riz, pois chiches et une orange à côté	Je sers avec le riz. Je mange l'orange.

Les quantités sont données en **objets** (1 boîte, 1 sachet, 1 oignon, 1 verre de riz pour 2 personnes) ; chaque apprenant peut écrire ou faire écrire, à côté de chaque mot, le mot dans sa langue (lexique personnel).

Adaptations. **Mme A. (grossesse)** : le repas lui convient très bien (fer, vitamine C, fibres) ; laver les oranges avant de les éplucher ; yaourt pasteurisé du commerce (pas de fromage au lait cru au menu) ; cuire les épinards à cœur ; rappeler, sans dramatiser, les aliments à éviter (fromages au lait cru, charcuterie à la coupe, produits de la mer crus) avec des photos. **Mme N. (diabète de type 2)** : garder le riz complet et la portion de 60 g crus, ne pas ajouter de sucre à la salade d'oranges (la cannelle suffit), manger le fruit entier plutôt qu'un jus, servir l'orange à la fin du repas ; pas d'interdit. **Version « à refaire à la maison »** : deux plaques suffisent (une pour le riz, une pour le plat) ; pois chiches en conserve, épinards surgelés et tomates en boîte se gardent longtemps ; le plat se congèle en portions ; variante avec des lentilles corail ou des haricots rouges selon les habitudes de chacun.

Question 4 – Apports d'une portion et commentaire (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (poids nets, Ciqual 2025)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vit. C (mg)
Pois chiches (120 g)	146,4	8,09	18,00	0,60	3,22	6,54	0,65	1,38	0,12
Épinards (100 g)	28,0	3,32	1,00	0,83	0,54	2,95	0,14	1,89	15,30
Tomates (80 g)	13,1	0,72	1,29	1,28	0,22	1,02	0,26	0,46	10,08
Oignon (30 g)	11,7	0,33	1,88	1,44	0,19	0,51	0,03	0	1,17
Huile d'olive (6 g)	53,9	0,01	0	0	5,99	0	0	0	0
Riz complet cru (60 g)	210,0	4,21	42,84	0	1,68	3,00	0,01	0	0
Orange (150 g)	63,0	1,12	12,04	11,40	0	4,05	0	0,85	71,25
Yaourt nature (125 g)	62,6	4,79	5,33	5,00	2,10	0	0,12	0	0
Total	**588,8**	**22,60**	**82,37**	**20,55**	**13,94**	**18,07**	**1,21**	**4,58**	**97,92**

Répartition de l'énergie : protéines 22,60 × 4 / 588,8 × 100 = **15,4 %** ; glucides 82,37 × 4 / 588,8 × 100 = **56,0 %** ; lipides 13,94 × 9 / 588,8 × 100 = **21,3 %** ; les fibres (2 kcal par gramme dans le calcul réglementaire) apportent 18,07 × 2 / 588,8 × 100 = **6,1 %**.

Commentaire. Le repas est rassasiant et économique (1,71 €), riche en **fibres** (18,1 g, soit plus de la moitié des 30 g conseillés par jour), pauvre en **sel** (1,2 g) et en lipides. Les sucres (20,6 g) viennent presque entièrement de l'orange, du yaourt et des légumes : il n'y a pas de sucre ajouté. Les protéines (22,6 g) associent légumineuses, céréale et produit laitier. Pour **Mme A.**, le repas apporte **4,6 mg de fer**, d'origine végétale (non héminique), mieux absorbé grâce aux **98 mg de vitamine C** de l'orange et des légumes servis au même repas ; les épinards et les pois chiches apportent aussi des folates (non chiffrés ici, car absents de l'extrait). Pour **Mme N.**, les glucides (82 g) sont surtout des glucides complexes accompagnés de beaucoup de fibres, ce qui limite l'élévation de la glycémie ; la portion de riz peut être adaptée avec elle.

Question 5 – Littératie, langue et compétences alimentaires (2 pts)

L'atelier développe la **littératie fonctionnelle** (reconnaître des mots, une boîte, une date sur un emballage, avec l'aide des images), la **littératie interactive** (demander, expliquer à son binôme, « faire dire ») et une première **littératie critique** (comparer deux conserves de pois chiches au prix au kilo, se demander si un produit « spécial santé » est utile). Il travaille plusieurs domaines de la **littératie alimentaire** (Vidgen et Gallegos, 2014) : **sélectionner** (lire une conserve), **préparer** (cuire des légumes secs, hygiène), **manger** (repères, partage) et **planifier** (une recette économique à refaire). La **numératie** est abordée par les mesures en objets (un verre, une boîte) et le coût par portion (1,71 €), mieux compris qu'un prix au kilo. Selon les **précautions universelles**, toutes les consignes sont données à l'oral, montrées et illustrées, pour tout le groupe, sans désigner ceux qui ne lisent pas.

Ne pas confondre maîtrise du français et compétences culinaires : ces apprenants savent souvent très bien cuisiner, gérer un budget et nourrir une famille ; leur difficulté porte sur la **langue** et l'**écrit**, pas sur l'alimentation. Les traiter comme des débutants en cuisine serait vexant et ferait perdre une ressource précieuse : on leur demande au contraire de montrer leurs gestes et de raconter leurs plats, ce qui crée du langage.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 15	Mise en place : vérification des denrées et des températures, installation des 4 postes, imagier affiché, objets réels sur une table, riz rincé	–
9 h 15 – 9 h 30	Accueil, prénoms, présentation de l'atelier avec les objets (boîte de pois chiches, sachet d'épinards, orange) ; consignes d'hygiène montrées	Lavage des mains, tablier ; chacun dit comment il cuisine les pois chiches chez lui
9 h 30 – 9 h 45	Imagier : 12 mots et gestes, répétés à voix haute	Répètent, montrent l'objet, disent le mot dans leur langue
9 h 45 – 9 h 55	Démonstration lente : couper l'oignon, rincer les pois chiches	Regardent, un apprenant refait le geste
9 h 55 – 10 h 40	Circule entre les postes, reformule, montre ; lance la cuisson du riz	En binômes (un lecteur et un non-lecteur, langues différentes), réalisent le plat avec la fiche en images
10 h 40 – 10 h 55	Salade d'oranges : montre comment éplucher à vif	Épluchent et coupent les oranges, ajoutent la cannelle
10 h 55 – 11 h 15	Dégustation, grille à smileys, échanges sur les repères (légumes secs, orange et fer)	Goûtent, notent avec les smileys, racontent
11 h 15 – 11 h 30	« Faire dire » et évaluation : chaque binôme montre une étape et nomme 3 mots	Montrent, nomment ; reçoivent la fiche en images
11 h 30 – 11 h 45	Remise en état, plonge, tri des déchets	Participent selon leur envie

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes : démonstration avant l'action ; **apprentissage par le faire** ; répétition des mots en situation (« Je coupe l'oignon ») ; binômes mixtes ; **faire dire** et **faire montrer** plutôt que « Vous avez compris ? ». Outils : imagier de 12 photos (ingrédients et gestes) avec le mot écrit en grand ; objets réels (boîtes, sachets, verres doseurs, morceaux de sucre pour comparer un soda et l'orange) ; fiche recette en 6 photos ; prix par portion affiché en euros. Grille de dégustation sans lecture : pour chaque plat, trois smileys (j'aime, un peu, je n'aime pas) à entourer ou à montrer du doigt, et une question orale « Qu'est-ce que tu changerais ? » ; la formatrice note les réponses.

Question 8 – Hygiène, allergènes, grossesse, éco-gestes (1,5 pt)

Hygiène (méthode des 5 M) : **main-d'œuvre** (lavage des mains montré, cheveux attachés, tablier) ; **milieu** (plans de travail nettoyés et désinfectés) ; **matériel** (planches propres, couteaux rangés) ; **matière** (conserves non

bombées, rinçage des pois chiches, oranges lavées avant épluchage, épinards cuits à cœur) ; **méthode** (marche en avant, riz servi aussitôt ou refroidi rapidement). Allergènes : le yaourt contient du **lait** (affiché par un pictogramme) ; vérifier l'étiquette des épices et de la conserve de pois chiches (traces éventuelles) ; demander oralement à chacun s'il a une allergie. Grossesse : aucune préparation à risque au menu ; on en profite pour montrer les photos des aliments à éviter. Éco-gestes : produits secs et surgelés sans gaspillage, eau de rinçage des légumes réutilisée pour la plonge, épluchures d'orange et d'oignon au compost, cuisson couverte.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Plat : oignons fondants non brûlés, épices torréfiées sans amertume, épinards bien cuits et égouttés, pois chiches entiers et chauds, assaisonnement mesuré ; riz complet tendre et égrené. Salade d'oranges : suprêmes ou rondelles sans peau blanche, cannelle légère. Dressage : assiette avec le riz d'un côté, les pois chiches de l'autre, un peu de persil ; bol d'oranges et yaourt à part.

Question 10 – Évaluation sans écrit (1 pt)

Satisfaction : smileys montrés du doigt. Mots appris : l'imagier présenté au début et à la fin (nombre de mots nommés sur 12) ; exemple de calcul si le groupe nomme en moyenne 36 mots au total au début (36 / 8 = 4,5 mots par personne, 37,5 %) et 75 à la fin (75 / 8 = 9,4 mots, 78,1 %). Gestes et repères : « faire montrer » une étape et « faire dire » pourquoi l'orange accompagne le plat. Intention de refaire : « Tu vas cuisiner ce plat chez toi ? » ; à la séance suivante d'ASL, la formatrice demande qui l'a refait.

Barème – Barème du sujet

Partie 1 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, fiche accessible, lisibilité et adaptations 3 ; apports 2 ; analyse 2. Partie 2 : déroulé 2 ; méthodes et outils 1,5 ; hygiène 1,5. Partie 3 : réalisation 3 ; évaluation 1. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des oranges et des oignons ; calculer le riz avec le poids cuit ; donner une fiche recette seulement écrite ; s'arrêter à l'indice de lisibilité pour un public qui ne lit pas ; traiter les apprenants comme des débutants en cuisine ; donner à Mme N. une liste d'interdits ; ajouter du sucre à la salade d'oranges ; évaluer avec un questionnaire écrit.

Corrigé S3 – « Voir avec les mains » : alimentation, information et autonomie de personnes déficientes visuelles

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à comprendre qu'une difficulté d'accès à l'information n'est pas toujours liée à la lecture ou à la langue : ici, elle tient au **handicap visuel** et à l'**inaccessibilité** des supports, des produits et des lieux. Il valorise le calcul juste du rapport de contraste et sa lecture critique, la distinction entre ce qui relève des personnes et ce qui relève de l'environnement, des adaptations construites avec des professionnels de la basse vision, et un atelier où la sécurité et l'autonomie sont travaillées sans infantiliser. Il pénalise les supports seulement visuels, les gestes faits « à la place » des personnes et la conclusion abusive d'un risque relatif non significatif.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2,5 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête téléphonique (n = 45)

- Ne peut pas lire les dates : 35 / 45 × 100 = **77,8 %**.
- Ne peut pas lire le tableau nutritionnel : 39 / 45 × 100 = **86,7 %**.
- Utilise une application ou un assistant vocal : 17 / 45 × 100 = **37,8 %**.
- Cuisine seul au moins 4 fois par semaine : 28 / 45 × 100 = **62,2 %**.
- Brûlure ou forte peur de se brûler dans l'année : 20 / 45 × 100 = **44,4 %**.
- Mange surtout des plats préparés : 19 / 45 × 100 = **42,2 %**.
- Satisfait de son alimentation : 22 / 45 × 100 = **48,9 %**.
- Taux de participation : 45 / 120 × 100 = **37,5 %**.

Niveau	Constats
Personnes	Impossibilité de lire l'écrit imprimé pour la plupart (77,8 % ne lisent pas les dates) ; perte de confiance en cuisine (44,4 % de brûlures ou de peur) ; repli sur les plats préparés (42,2 %) ; compétences anciennes à réactiver (Mme L.) ; usage partiel d'outils numériques (37,8 %)
Produits	Dates, prix et tableaux imprimés en petits caractères, souvent sans contraste ; applications de lecture qui lisent tout l'emballage sans hiérarchie (M. T.)
Environnement	Supports de prévention illisibles (dépliant, affiche, site) ; aide en magasin dépendante de la bonne volonté du personnel (Mme G.) ; isolement (58 % vivent seuls)

Diagnostic. L'information alimentaire est **inaccessible** pour la grande majorité des adhérents, non par manque de compétences mais parce que les supports ne sont pas conçus pour eux. Cette inaccessibilité, associée à la peur de se blesser, conduit près d'un adhérent sur deux à se replier sur des plats préparés et à se dire peu satisfait de son alimentation. Le taux de participation (37,5 %) invite à la prudence : les répondants sont peut-être les adhérents les plus actifs.

Question 2 – Contraste et accessibilité des supports (2,5 pts)

Calcul posé – Rapport de contraste (WCAG)

- Support A : (1,000 + 0,05) / (0,216 + 0,05) = 1,05 / 0,266 = **3,95** : inférieur à 4,5, **non conforme** pour un texte courant ; la police de 9 points aggrave le problème.
- Support B : (1,000 + 0,05) / (0,927 + 0,05) = 1,05 / 0,977 = **1,07** : contraste presque nul, **non conforme**, même pour un grand texte (seuil 3).
- Support C : (1,000 + 0,05) / (0,000 + 0,05) = 1,05 / 0,05 = **21,0** : contraste maximal, **conforme** ; police de 16

points.
- Site de la mairie : 5 / 12 × 100 = **41,7 %** des critères respectés ; en ajoutant les textes alternatifs, des liens explicites, les sous-titres et l'audiodescription de la vidéo, et une police agrandissable, on atteindrait par exemple 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.

Corrections : texte noir (ou très foncé) sur fond clair uni, ou l'inverse ; police sans empattement de 16 points au moins ; pas d'information donnée seulement par la couleur ; version numérique accessible au lecteur d'écran (titres structurés, textes alternatifs) ; version audio ; pour l'association, version en braille pour les adhérents qui le lisent. L'**indice de Kandel et Moles** mesure la longueur des phrases et des mots : un texte « très facile » au sens de cet indice reste **illisible** s'il est imprimé en gris pâle de 9 points, ou s'il n'existe qu'en image. Pour ce public, l'accessibilité passe par le **format** (contraste, taille, audio, braille, compatibilité avec le lecteur d'écran) autant que par la clarté du texte.

Question 3 – Analyse avec les notions du chapitre (2 pts)

- **Modèle de Sørensen** : la difficulté se situe surtout à l'étape **accéder** (l'information est là, mais impossible à percevoir) ; **comprendre** et **évaluer** sont peu touchés quand l'information est rendue audible ; **appliquer** est freiné par la peur de se blesser.
- **Littératie alimentaire** : les compétences de **préparation** existent ou ont existé (Mme L.) ; la **sélection** (dates, prix, composition) est empêchée par l'étiquetage ; la **planification** est compliquée par la difficulté à faire ses courses seul.
- **Littératie numérique** : les outils (lecteur d'écran, reconnaissance de texte) sont de vraies aides, mais ils demandent un apprentissage et lisent tout sans hiérarchie : il faut apprendre à les utiliser et à chercher l'information utile (date, allergènes).
- **Littératie organisationnelle** : la mairie, le supermarché et les fabricants ont la responsabilité de rendre l'information accessible (loi de 2005, RGAA, Acte européen sur l'accessibilité depuis 2025).
- **Précautions universelles** : un support conçu pour être lisible par des personnes malvoyantes (contraste, taille, audio) est plus lisible pour tous, en particulier pour les personnes âgées.

Question 4 – Objectifs, plan d'action et budget (4 pts)

Objectif général : améliorer l'autonomie alimentaire et la sécurité en cuisine des adhérents de l'association, en un an.

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Échéance
Spécifique 1 : permettre aux adhérents de lire les informations utiles des emballages (dates, allergènes, prix)	Part des adhérents qui déclarent pouvoir lire les dates (avec ou sans outil)	22,2 %	50 %	12 mois
Spécifique 2 : renforcer la sécurité et la confiance en cuisine	Part des adhérents qui déclarent une brûlure ou une forte peur de se brûler	44,4 %	30 %	12 mois
Opérationnel 1 : animer 8 ateliers culinaires adaptés de 6 personnes avec l'ergothérapeute	Nombre d'ateliers et de participants	0	8 ateliers, 30 adhérents différents	10 mois
Opérationnel 2 : organiser 4 sessions d'apprentissage d'une application de lecture d'étiquettes gratuite	Nombre de participants capables de lire une date avec l'application	0	20	6 mois
Opérationnel 3 : produire 10 recettes en version audio et en gros caractères à fort contraste	Nombre de recettes ; contraste ≥ 4,5 ; test auprès de 5 adhérents	0	10 recettes testées	8 mois
Opérationnel 4 : obtenir du supermarché une aide aux courses sur rendez-vous et du centre communal d'action sociale une version accessible de ses supports	Conventions ou engagements signés	0	2	12 mois

Poste	Coût
Denrées pour 8 ateliers (environ 25 € par atelier, plus 300 € pour les repas partagés)	500 €
Matériel adapté (gants anti-chaleur longs, planches contrastées, couteaux protégés, détecteur de niveau de liquide, minuteurs parlants, étiquettes en relief)	300 €
Enregistrement audio et impression en gros caractères des recettes	240 €
Transcription en braille (prestataire)	280 €
Sessions d'apprentissage numérique (bénévoles formés, matériel de démonstration)	200 €
Transport accompagné pour les participants isolés	180 €
Formation courte des bénévoles au guidage	150 €
Communication et événement de restitution	150 €
Total	**2 000 €**

Vérification : 500 + 300 + 240 + 280 + 200 + 180 + 150 + 150 = **2 000 €** ✓.

Question 5 – Risque relatif, intervalle de confiance et taille d'échantillon (3 pts)

Calcul posé – Brûlures selon la cuisine solitaire

Notations : a = 16, a + b = 28 ; c = 4, c + d = 17.

- Risque chez ceux qui cuisinent seuls au moins 4 fois par semaine : 16 / 28 = **57,1 %** ; chez les autres : 4 / 17 = **23,5 %**.
- RR = 0,571 / 0,235 = **2,43**.
- ln RR = 0,887 ; erreur type = √(1/16 − 1/28 + 1/4 − 1/17) = √0,2180 = **0,467**.
- IC 95 % = exp(0,887 ± 1,96 × 0,467) = exp(0,887 ± 0,915) = [exp(− 0,028) ; exp(1,802)] = **[0,97 ; 6,06]**.

Le risque est 2,4 fois plus élevé chez les adhérents qui cuisinent souvent seuls, mais l'intervalle de confiance **contient 1** : l'association n'est **pas statistiquement significative** au seuil de 5 % avec seulement 45 répondants. On ne peut donc ni conclure à un lien ni l'exclure. Interprétation logique : plus on cuisine, plus on s'expose au risque ; cela ne veut pas dire qu'il faut cuisiner moins, mais qu'il faut cuisiner **en sécurité**.

Calcul posé – Proportion d'adhérents qui ne peuvent pas lire le tableau nutritionnel

- p = 39 / 45 = **0,867** ; demi-largeur = 1,96 × √(0,867 × 0,133 / 45) = 1,96 × √0,002567 = 1,96 × 0,0507 = **0,099**.
- IC 95 % = **[76,7 % ; 96,6 %]**.
- n0 = 1,96² × 0,867 × 0,133 / 0,05² = **178** ; correction pour 120 adhérents : n = 178 / (1 + 177 / 120) = 178 / 2,475 = **72** adhérents.

Question 6 – Veille (2 pts)

Sources : Fédération des aveugles et amblyopes de France et grandes associations nationales de la déficience visuelle (guides d'accessibilité) ; direction interministérielle du numérique (RGAA) ; W3C (WCAG) ; Défenseur des droits ; Santé publique France (« Communiquer pour tous ») ; Haute Autorité de santé ; centres de rééducation basse vision ; textes européens sur l'accessibilité. Outils : lettres d'information, alertes, flux RSS **compatibles avec le lecteur d'écran**. Fréquence : mensuelle pour les textes et les outils ; à chaque projet pour les guides. Diffusion : synthèse audio et en gros caractères pour le bureau de l'association.

Question 7 – Situations éthiques et accessibilité de l'exposé (2 pts)

- **Financement contre recommandation d'une application payante** : conflit d'intérêts ; l'association ne peut pas recommander un produit en échange d'un financement ; il existe des applications gratuites, et le choix

doit se faire selon les besoins de chacun. Réponse : refus du financement conditionnel ; un partenariat serait possible sans contrepartie publicitaire, avec une information sur plusieurs outils.

- **Vidéo diffusée publiquement** : **droit à l'image** ; il faut l'autorisation écrite de chaque personne filmée, après une information claire (et accessible : lue à voix haute) sur la diffusion ; le respect de la dignité exclut les images de gestes maladroits ou d'accidents. On peut proposer une vidéo centrée sur les mains et les ustensiles, avec audiodescription, validée par les participants.
- **Exposé accessible** : diaporama à fort contraste, police de grande taille, chaque visuel **décrit oralement** ; documents remis en version numérique accessible au lecteur d'écran ; présence possible d'un adhérent pour témoigner.

Temps 2 – L'atelier culinaire

Question 8 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : retrouver la confiance et la sécurité pour cuisiner ; recevoir l'information sous une forme accessible (orale, tactile, gros caractères) ; partager un repas (isolement) ; tenir compte du diabète de Mme L. et de l'hypertension de M. B. Objectif général : permettre aux participants de réaliser en sécurité un repas complet et simple, qu'ils pourront refaire seuls chez eux. Objectifs opérationnels : 1. chaque participant utilise au moins deux aides techniques (gant long, détecteur de niveau, minuteur parlant) ; 2. chaque participant réalise seul, après démonstration tactile, une étape de la recette (râper, mesurer la semoule, verser l'eau chaude, enfourner) ; 3. chaque participant décrit à l'oral la composition de son assiette en se repérant « en horloge ».

Question 9 – Bon de commande, coût et apports (4 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Coût
Filet de poulet	1 000 g	0 %	1 000 g	1,000 × 11,50 = 11,50 €
Yaourt nature	300 g	0 %	300 g (3 pots de 100 g ou 2,4 pots de 125 g)	0,300 × 2,20 = 0,66 €
Citron (jus)	50 g	60 %	50 / 0,40 = 125 g (1 citron)	0,125 × 3,00 = 0,38 €
Huile de colza	50 g	0 %	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Semoule	600 g	0 %	600 g	0,600 × 1,90 = 1,14 €
Carottes	1 000 g	15 %	1 000 / 0,85 = 1 176 g	1,176 × 1,40 = 1,65 €
Oranges à jus (jus)	300 g	55 %	300 / 0,45 = 667 g	0,667 × 2,00 = 1,33 €
Bananes	800 g	35 %	800 / 0,65 = 1 231 g	1,231 × 2,00 = 2,46 €
Fromage blanc 2-3 %	1 000 g	0 %	1 000 g	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Ail, épices, persil, sel	–	–	–	0,90 €

Total : 11,50 + 0,66 + 0,38 + 0,16 + 1,14 + 1,65 + 1,33 + 2,46 + 2,60 + 0,90 = **22,78 €** ; par portion : **2,28 €**, sous le plafond de 2,50 €.

Calcul posé – Apport d'une portion (Ciqual 2025)

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet (100 g)	110,0	23,40	0	0	1,50	0	0,11
Yaourt (30 g)	15,0	1,15	1,28	1,20	0,50	0	0,03
Jus de citron (5 g)	1,5	0,02	0,30	0,12	0,01	0,02	0
Huile de colza (5 g)	45,0	0	0	0	5,00	0	0
Semoule crue (60 g)	210,0	7,08	41,88	0,60	0,77	2,22	0
Carotte (100 g)	30,2	0,78	5,16	4,85	0	2,90	0,12

Aliment (quantité)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Jus d'orange (30 g)	13,6	0,18	2,88	2,88	0,03	0,08	0
Banane (80 g)	70,1	0,85	15,76	12,48	0	2,16	0
Fromage blanc (100 g)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,02	0,09
Total	**571,1**	**40,74**	**71,13**	**25,99**	**11,05**	**7,40**	**0,36**

Répartition : protéines 40,74 × 4 / 571,1 × 100 = **28,5 %** ; glucides 71,13 × 4 / 571,1 × 100 = **49,8 %** ; lipides 11,05 × 9 / 571,1 × 100 = **17,4 %.**

Commentaire : repas riche en protéines (poulet et fromage blanc), pauvre en lipides et très pauvre en sel (0,36 g sans sel ajouté), avec des fibres modérées (7,4 g) qu'on pourrait augmenter avec une semoule complète ou des pois chiches dans la semoule. Les sucres (26 g) viennent de la banane, des carottes, du jus d'orange et du fromage blanc : aucun sucre ajouté. Pour **Mme L.** (diabète), le dessert ne contient pas de sucre ajouté ; la banane bien mûre élève plus la glycémie qu'une banane juste mûre ; la portion de semoule peut être ajustée avec elle. Pour **M. B.** (hypertension), le repas est un bon exemple de plat savoureux sans sel ajouté grâce au citron, à l'ail, au cumin et au persil : on sale à table, avec modération, après avoir goûté.

Question 10 – Fiche technique, recette accessible, adaptations (4 pts)

Modèle – Fiche technique : poulet mariné au yaourt et au citron, semoule, carottes râpées à l'orange (10 portions)

Ingrédients : 1 kg de filets de poulet ; 300 g de yaourt ; jus d'un citron ; 2 gousses d'ail ; 2 cuillères à café de cumin ; 50 g d'huile ; 600 g de semoule ; 600 mL d'eau bouillante ; 1,2 kg de carottes ; jus de 3 oranges ; persil ; 1 kg de fromage blanc ; 1,2 kg de bananes ; cannelle.

Étapes : 1. Couper le poulet en lanières (fait par le candidat ou un bénévole avant l'atelier, ou par un participant avec un couteau à garde et une planche contrastée). 2. Mélanger yaourt, citron, ail, cumin ; enrober le poulet ; laisser mariner 30 minutes au réfrigérateur. 3. Cuire au four à 200 °C pendant 18 à 20 minutes ; vérifier 75 °C à cœur avec un thermomètre parlant. 4. Verser l'eau bouillante sur la semoule avec l'huile, couvrir 5 minutes, égrener à la fourchette. 5. Râper les carottes avec une râpe à réservoir, arroser de jus d'orange. 6. Écraser les bananes à la fourchette, mélanger au fromage blanc, saupoudrer de cannelle.

Points critiques : volaille crue séparée et ustensiles dédiés ; cuisson à cœur ; liquide bouillant ; four chaud ; lames.

Version accessible de la recette : **audio** (enregistrement de 3 minutes, une étape par piste, phrases courtes, quantités en objets : « un pot de yaourt », « un verre de semoule par personne ») ; **gros caractères** (police sans empattement de 18 points, noir sur jaune pâle ou blanc sur noir, une étape par page) ; **braille** pour les adhérents qui le lisent ; **repères tactiles** (gommettes en relief sur le bouton du four à 200 °C, élastique sur le flacon de cumin).

Adaptations proposées avec l'ergothérapeute : poste toujours organisé de la même façon (ingrédients à gauche, outils à droite, « ce qui est utilisé retourne à sa place ») ; plateau à rebords pour contenir les débordements ; planche de couleur contrastée (blanche pour les carottes, noire pour l'oignon) ; **râpe à réservoir** et gant anti-coupure ; **détecteur de niveau de liquide** sur la tasse pour verser l'eau bouillante, bouilloire posée sur un plateau ; **gants longs** pour le four, grille sortie avant de saisir le plat ; minuteur parlant ; doigt guide et gestes « main sur main » proposés seulement avec l'accord de la personne.

Question 11 – Déroulé, méthodes et dégustation (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
8 h 30 – 9 h 15	Mise en place : postes identiques, ustensiles alignés, détecteurs et minuteurs testés, poulet découpé si besoin	–
9 h 15 – 9 h 35	Accueil, présentation orale de chacun ; visite tactile du poste (« la planche est devant vous, le couteau à droite, pointe vers le mur »)	Explorent le poste avec les mains
9 h 35 – 9 h 50	Marinade : description précise des gestes, démonstration tactile	Mélangent la marinade, enrobent le poulet
9 h 50 – 10 h 20	Carottes et bananes : utilisation de la râpe à réservoir et du gant	Râpent, écrasent, mélangent
10 h 20 – 10 h 45	Four : enfourner avec l'ergothérapeute ; semoule avec le détecteur de niveau	Enfournent à tour de rôle, versent l'eau chaude
10 h 45 – 11 h 05	Pendant la cuisson : échange sur les applications de lecture d'étiquettes (démonstration sur une boîte de semoule)	Lisent une date avec l'application
11 h 05 – 11 h 45	Service, repérage de l'assiette « en horloge » (poulet à midi, semoule à 4 h, carottes à 8 h), repas partagé, dégustation orale	Décrivent, goûtent, commentent
11 h 45 – 12 h 00	« Faire dire » et « faire faire » : chacun explique une astuce de sécurité	Expliquent ; reçoivent la recette audio
12 h 00 – 12 h 15	Remise en état	Participent

Méthodes : **guidage verbal précis** (positions, distances, « à votre droite », jamais « là ») ; démonstration tactile ; **main sur main** seulement avec accord ; « faire dire » (« Comment allez-vous savoir que le poulet est cuit ? ») et « faire faire ». Grille de dégustation orale : pour chaque plat, une note de 1 à 5 dite à voix haute, et deux questions (« Qu'avez-vous aimé ? » ; « Que changeriez-vous ? »), notées par un bénévole.

Question 12 – Hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes (3 pts)

Hygiène : lavage des mains guidé (savon et serviette toujours au même endroit) ; volaille crue sur une planche dédiée, puis lavage des mains ; marinade au réfrigérateur ; cuisson à cœur (75 °C) vérifiée au thermomètre parlant ; produits laitiers au froid. Sécurité : rangement constant ; couteaux rangés à plat dans un bac ; jamais de liquide chaud porté à bout de bras ; poignées des casseroles tournées vers l'intérieur ; four ouvert par l'animateur ou avec l'ergothérapeute ; annonce orale de chaque déplacement (« Je passe derrière vous avec le plat chaud »). Allergènes : **lait** (yaourt, fromage blanc), **gluten** (semoule de blé) ; signalés oralement et en gros caractères. Éco-gestes : carottes et bananes de saison ou de proximité si possible ; épluchures au compost ; four utilisé à pleine charge ; restes répartis en boîtes pour les participants.

Question 13 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation : poulet doré, tendre et cuit à cœur ; semoule égrenée ; carottes finement râpées, juteuses ; dessert onctueux, banane non oxydée (préparée au dernier moment ou citronnée). Évaluation : nombre d'aides techniques utilisées par chaque participant ; nombre d'étapes réalisées seul ; incidents (brûlure, coupure : objectif zéro) ; notes de dégustation ; question « Pensez-vous refaire une partie de ce repas chez vous ? » ; appel téléphonique trois semaines plus tard : « L'avez-vous refait ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? ».

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs et diagnostic 2,5 ; contraste et accessibilité 2,5 ; analyse 2 ; objectifs, plan et budget 4 ; statistiques 3 ; veille 2 ; éthique et exposé 2 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et objectifs 2 ; bon de commande et apports 4 ; fiche technique, recette accessible et adaptations 4 ; déroulé, méthodes et dégustation 4 ; hygiène et sécurité 3 ; réalisation et évaluation 3 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Inverser L1 et L2 dans le calcul du contraste ; conclure que le support A est « presque conforme » ; s'arrêter à la lisibilité du texte sans regarder le format ; conclure à un lien significatif alors que l'intervalle contient 1 ; faire les gestes à la place des participants ; guider avec des mots comme « ici » ou « là » ; oublier les pertes du citron, des oranges et des bananes ; oublier le gluten de la semoule ; accepter une recommandation commerciale en échange d'un financement.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des indicateurs de littératie et d'accès à l'information ; comparer avec HLS19	S1, S3			
C3.1	Classer des difficultés selon le modèle de Sørensen et les niveaux de Nutbeam	S1, S3			
C3.1	Calculer un indice de lisibilité et l'interpréter avec un test de compréhension	S1, S2			
C3.1	Calculer un rapport de contraste et un taux de conformité d'accessibilité	S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 (dont fer et vitamine C) et les commenter	S2, S3			
C3.2	Concevoir une fiche recette accessible (images, objets, audio, gros caractères, braille)	S2, S3			
C3.2	Adapter un atelier à des apprenants allophones et à des personnes déficientes visuelles	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène et la sécurité (conserves, riz cuit, volaille, brûlures, coupures)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; distinguer significatif et non significatif	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille sur la littératie, l'accessibilité et un public spécifique	S1, S3			
C3.5	Choisir des supports et des canaux adaptés (oral, vidéo, audio, pictogrammes, médiation)	S1, S2, S3			
C3.6	Respecter le secret professionnel, les données personnelles, le droit à l'image ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.